

第三版说明

《百病良方》第一集自1981年初版、1983年再版以来，虽经多次重印，仍满足不了读者的需要。现经编著者修改补充，增加了近三万字的内容，以飨读者。

1989年5月

内 容 提 要

《百病良方》第一集（增订本）集中介绍了中医治疗内科、妇产科、儿科、外科（包括皮肤科）的一百种病症的新鲜经验，并附方剂近700首，为中医临床工作提供极大的方便。并结合现代医学知识，对诊断、护理、预防等作了介绍。本书适合于中医人员、基层医务人员、中医业余爱好者以及一百种病症中的任何一种疾病的病员阅读、参考。

目 录

内 科

1. 扁桃腺炎..... (1)	22. 肾结石..... (73)
2. 肺脓肿..... (3)	23. 遗精..... (77)
3. 肺结核..... (5)	24. 男性性功能障
4. 支气管扩张..... (10)	 (78)
5. 急性细菌性痢疾... (11)	25. 尿崩症..... (81)
6. 慢性细菌性痢疾... (14)	26. 甲状腺机能亢进
7. 甲型肝炎..... (15)	症..... (83)
8. 急性阑尾炎..... (22)	27. 甲状腺功能减退
9. 溃疡病..... (25)	症..... (86)
10. 胃下垂..... (31)	28. 头痛..... (87)
11. 顽固性呃逆..... (23)	29. 内耳眩晕病..... (90)
12. 腹泻..... (36)	30. 记忆力减退..... (92)
13. 便秘..... (41)	31. 失眠..... (97)
14. 胆道蛔虫病..... (43)	32. 嗜睡..... (102)
15. 过早搏动..... (45)	33. 癫痫..... (103)
16. 高血压病..... (47)	34. 坐骨神经痛..... (107)
17. 低血压..... (52)	35. 梦游症..... (109)
18. 冠状动脉粥样硬化	36. 小舞蹈病..... (110)
性心脏病..... (55)	37. 重症肌无力..... (111)
19. 急性肾炎..... (58)	38. 多汗症..... (113)
20. 慢性肾炎..... (60)	39. 闭汗症..... (116)
附：蛋白尿..... (65)	40. 贫血..... (116)
21. 肾盂肾炎..... (70)	

41. 缺铁性贫血…… (119)
 42. 再生障碍性贫血… (122)
 43. 血小板减少性紫
 癜…………… (125)

44. 糖尿病…………… (127)
 45. 低热…………… (132)

妇 产 科

46. 功能性子宫出血… (134)
 47. 痛经…………… (137)
 48. 闭经…………… (141)
 49. 代偿性月经 (倒
 经) …………… (144)
 50. 更年期综合征…… (145)
 51. 霉菌性阴道炎…… (146)
 52. 滴虫性阴道炎…… (148)
 53. 女阴瘙痒症…… (150)
 54. 女阴白斑症…… (152)
 55. 子宫颈糜烂…… (154)
 56. 盆腔炎…………… (157)
 57. 子宫脱垂…………… (160)

58. 女子不孕症…… (163)
 59. 习惯性流产…… (166)
 60. 胎位不正…………… (167)
 61. 先兆子痫·子痫… (168)
 62. 产后小便失禁…… (169)
 63. 产后乳汁过少…… (170)
 附：断乳的方
 法…………… (173)
 64. 产后脑垂体前叶机
 能减退症…… (174)
 65. 急性乳腺炎…… (175)
 66. 乳腺增生…………… (177)

儿 科

67. 麻疹…………… (179)
 68. 猩红热…………… (184)
 69. 百日咳…………… (186)
 70. 流行性腮腺炎…… (190)
 71. 小儿夏季热…… (192)
 72. 小儿营养不良…… (194)

73. 蛔虫性肠梗阻…… (195)
 74. 脱肛…………… (197)
 75. 遗尿…………… (199)
 76. 小儿流涎…………… (202)
 77. 小儿误吞金属异
 物…………… (204)

外科·皮肤科

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 78. 骨质增生..... (205) | 90. 皮肤癣病..... (228) |
| 79. 毛囊炎·疖·痈..... (206) | 91. 湿疹..... (232) |
| 80. 丹毒..... (211) | 92. 荨麻疹..... (233) |
| 81. 破伤风..... (212) | 93. 神经性皮炎..... (241) |
| 82. 水火烫伤..... (214) | 94. 银屑病..... (242) |
| 83. 冻疮..... (217) | 95. 痤疮 (青春刺) ... (243) |
| 84. 皲裂..... (219) | 96. 酒渣鼻..... (246) |
| 85. 毒蛇咬伤..... (220) | 97. 脂溢性皮炎、脂溢
性脱发..... (248) |
| 86. 下肢慢性溃疡..... (222) | 98. 白癜风..... (250) |
| 87. 带状疱疹..... (223) | 99. 斑秃..... (252) |
| 88. 寻常疣..... (225) | 100. 腋臭 (狐臭、汗臭症) (255) |
| 89. 扁平疣..... (227) | |

内 科

1. 扁 桃 体 炎

扁桃体（又称扁桃腺）是咽部较大的淋巴组织，位于咽部两侧，是人体防御病菌入侵的“前哨”之一。当人体抵抗力减弱、遭受细菌和病毒感染时，扁桃体首当其冲，首先引起扁桃体炎，这时如果能及时予以治疗及其他的处理，则炎症局限在扁桃体；如果人们对于扁桃体的报警不予重视，不积极的给以治疗及其他处理，则可致人体抗病能力低下，不足以战胜病邪，那么，病原微生物或其毒素则可能长驱直入，使炎症播散和引起病理反应，引起远隔部位脏器组织的病变，如肾炎、风湿病等。

扁桃体发炎的原因是由于细菌和病毒的感染，细菌感染更多见。引起扁桃体炎的病原菌多为溶血性链球菌、葡萄球菌、肺炎球菌等。这些细菌平时就存在于人的咽部和扁桃体隐窝内，在正常情况下，由于扁桃体表面上皮完整和粘液腺的不断分泌，可将细菌随同脱落上皮细胞从隐窝口排出，因此保持着机体的健康，但当机体因过度疲劳、吸烟、饮酒、睡眠不足、受凉或其他原因而致抵抗力减弱时，扁桃体的血运减少，腺体分泌机能下降，上皮防御能力降低，细菌即乘虚而入，滋生繁殖，致使扁桃体发炎。

急性扁桃体炎有些什么症状表现呢？

1.起病急骤，突然咽痛，吞咽困难，畏寒发热，头痛，身疼痛。有时伴有呕吐、腹泻。

2.两侧腭扁桃体充血肿大；前后腭、弓、软腭和悬壅垂充血水肿；两侧扁桃体表面可看到淡黄色或白色的脓点。

3.颈部和下颌角淋巴结肿大，并有触痛。

4.血液检查，白细胞总数和中性粒细胞增多。

急性扁桃体炎，祖国医学称为“喉蛾”，“乳蛾”，认为由于机体反应性失调和抵抗力降低，风毒之邪，乘虚而入。治宜清热解毒，佐以活血化瘀。

基本方：蒲公英30克，大青叶30克，黄芩15克，赤芍12克，丹皮12克，水煎服（以上为一日量，小儿酌减）。

急性扁桃体炎，发病急，表现高热、咽痛，舌红、脉数等一派温热病状，中药治疗应抓住“热邪”这一主要矛盾，不一定用疏风解表药，而应重用清热解毒药，使“热邪”得以顿挫，才能使疾病较快地得到痊愈。

急性扁桃体炎还有咽腔充血、疼痛，扁桃体红肿，淋巴结肿大等表现，中医称之为“瘀热壅滞”，治疗上还需要清热解毒药物与活血化瘀药物同时应用，才能使红肿的扁桃体或淋巴结较快地缩小，咽部脓性分泌物较快地消失。上面介绍的基本方中的赤芍、丹皮既有清热作用又有活血作用，与蒲公英、大青叶、黄芩等清热药同用，能加速血液循环，加快炎性分泌物的清除，促进炎症的吸收。

有些病人，咽痛较甚，扁桃体明显红肿，脓性分泌物较多，在这种情况下，可用锡类散或冰硼散或珠珀散吹喉，常可缩短疗程，提高疗效。

治疗急性扁桃体炎的单方验方：

1.蒲公英、野菊花各30克，水煎服，每日一剂。

2. 山豆根30克、银花15克，水煎服，每日一剂。

急性扁桃体炎病人，还应卧床休息，多喝水，吃富于营养、易于消化的饮食，忌食辛辣及厚味油腻之品，注意口腔清洁。

2. 肺 脓 肿

肺脓肿是由于各种病原菌引起的肺部感染，早期为化脓性炎症，继而形成脓肿。中医称为“肺痈”。它的特征是高烧、咳嗽、咳大量脓臭痰。

肺脓肿分为吸入性肺脓肿和血源性肺脓肿两种。吸入性肺脓肿是由于扁桃体炎、鼻旁窦炎，齿槽脓溢或龋齿等的脓性分泌物，上呼吸道手术后的血块，齿垢或各种异物，经支气管进入肺内，随着细菌繁殖，引起化脓性炎症，导致肺组织坏死和脓肿形成。血源性肺脓肿是由于皮肤创伤、感染、疖痈和骨髓炎等，病原菌侵入血流，发生脓毒血症。脓毒栓子经血流到肺，形成脓肿。

肺脓肿早期见恶寒发热，咳嗽胸痛，咯痰白粘或黄粘，约十天左右形成脓肿时，咳出大量脓性有恶臭痰液（似臭鸡蛋样），放置后可分三层（泡沫，浆液，脓液或破坏的肺组织），亦可有少量或大量咯血。

有以上这些症状，并经叩诊、听诊、血液检查、放射线检查后可以确诊。

肺脓肿的急性阶段若能及时充分治疗，数周后病情可逐渐好转。若治疗不彻底，或支气管引流不畅，病变可转入慢性，病程就比较长了。

中医认为肺痈系外感风热熏蒸于肺，蓄热内蒸，肺受热

灼，气失清肃，热壅血瘀，郁结成痈。

中药治疗肺脓肿的原则是“有脓必排”，排除脓痰是首要措施。中药桔梗和前胡是强有力的祛痰药，肺脓肿形成后，可用桔梗15克，前胡15克，甘草6克，鱼腥草30克，鸭跖草30克，半枝莲30克，以消除肺部炎症。

服上方后，病人可以咯出大量脓痰。当热退、X线上脓腔液平面消失时，可停用桔梗、前胡，加用桃仁10克，冬瓜子30克，苡仁30克，以化痰散结。在恢复期可于上述处方中加黄精15克、白芨15克，以助正气恢复。

中医治疗小儿肺脓肿常用的活血化瘀、清热解毒、软坚散结、托里排脓的方法也是效果比较好的。对早期、中期的小儿肺脓肿，可用青黛3克，乳香6克，寒水石10克，紫草10克，牙皂6克，天竺黄10克，水煎服，每日一剂。若高热不退加地骨皮、五倍子；咳甚加瓜蒌、银杏；咳痰脓血多加白芨、五倍子、白芷；胸痛加瓜蒌、枳壳。小儿肺脓肿后期，热退或低热多汗、食欲差，此时治疗以调气血、扶正祛邪为主。可用：青黛3克，银杏10克，黄精10克，山楂10克，草薢10克，儿茶6克（体虚加百合、木瓜）。

对慢性肺脓肿，病灶吸收缓慢，脓血内停，又有出血倾向的病人，用活血化瘀法治疗，常能取得较好效果。处方：甘草18克，丹参30克，没药10克，生熟蒲黄各15克，三七粉（冲服）6克，血竭6克，黄芪30克，桔梗15克，浙贝12克。水煎服，每日一剂。一般服15~40剂，可促使病灶吸收。

慢性肺脓肿治疗时间较长，下面介绍几个辅助治疗方法，对缩短疗程很有帮助。

①百合120克，白芨60克，共研细粉，瘦猪肉适量，切

碎，和药粉10克，水调为糊状，煮熟服，每日服二次。

②苡仁90克，桃仁10克，共煮成粥状，加白糖适量，一次顿服，或分二次服下，每日一剂。

③松香粉，开水吞服，每次服3克，一日二次。松香粉有润心肺、拔毒排脓、生肌止痛等作用，无毒性反应，可大胆服用。近代名医张锡纯用此法治愈“肺痈”（肺脓肿）病人不胜枚举。少数病人服松香后，可引起浮肿或咽干，一般不需处理，会自行消退，不必停药。

④大蒜500克，白蔹30克，白芨30克。将上药同时放入壶内，加水3000毫升，用武火煮沸后继用文火煎之，然后取一条2~3尺长的硬橡皮管，一头紧接在壶嘴上，另一头对着患者的口，缓慢吮吸其蒸气。每日或隔日一剂，每次治疗1~2小时，吮吸后去渣，吃大蒜。

3. 肺 结 核

肺结核病是城乡多见、分布最广的一种慢性传染病。过去，结核病死亡率很高，有“十痨九死”的传说。现在，治愈率已有了显著提高。

肺结核病的治疗在于控制疾病、促使病灶愈合、消除症状和防止复发。抗结核药物固然有制菌作用，但在药物治疗结束后，保持病灶愈合，防止复发，人体的抵抗力无疑地起着更重要的作用。

中药不论对抗痨解毒，抑或在改善或消除肺结核病的症状，增强人体抵抗力方面有着不可忽视的作用。

肺结核，中医学称为“肺痨”或“癆瘵”。本病常因体质虚弱或精气耗损过甚，痨虫乘机侵袭肺部引起。其病变部位虽

然在肺，但因脾为生化之源，脾虚则水谷精气不能上输于肺，肺津不足，无以自养，肺阴日虚；肾为先天之本，肾精亏损，则虚火上扰，肺部津液受灼，也可使肺气化源不足。因此，本病的发生、发展与脾肾两脏的关系极为密切。临床以阴虚为多见，在整个疾病演变过程中，并可出现气阴亏耗、阴虚火旺等证候。

治疗以养阴清火、扶正杀虫为基本原则。

1. 气阴亏耗：干咳少痰，声音发嘶，痰唾粘白，咳血时作，痰中夹血，或有潮热，手足心热，胸痛，口燥咽干，饮食减少，舌边尖红，脉细数。治宜滋阴润肺，止咳杀虫。

处方：天冬20克，麦冬20克，生地20克，熟地20克，百部12克，夏枯草30克，阿胶10克，白芨10克，茵灵芝30克（先熬）。水煎服。

2. 阴虚火旺：咳呛痰少，或咳血反复时作，量多色鲜，混有泡沫，胸胁掣痛，颧红盗汗，骨蒸潮热，心烦失眠，性躁善怒，男子可见梦遗，女子可见月经不调，舌质红绛，脉细数。治宜滋阴，清火，润肺。

处方：生熟地各30克，沙参20克，麦冬20克，黄精20克，羊胆一只（取汁兑药液服），马齿苋30克。水煎服。

辅助治疗肺结核的验方：

百部50克，天冬50克，仙鹤草50克，羊胆汁500毫升，蜂蜜500毫升。前三味药用水2000毫升煎1小时，过滤，去渣。药液以文火煎熬至较浓后，掺入羊胆汁和蜂蜜，搅匀，使成膏状，俟其冷透，贮藏于瓷质器皿中。每日服3次，每次服15毫升，饭后用开水冲服。

介绍几种对肺结核有效的中药及用法

①白芨：白芨有补肺、收敛、止血、消肿、生肌的作用，止肺出血功效尤为显著。科学研究表明，白芨对肺结核的病灶吸收，空洞闭合及痰菌转阴等方面均有肯定疗效。每天服白芨粉18克（一天三次，每次6克），方便经济，没有毒性反应，对人体有益无害。据临床报道，经抗痨药治疗无效或疗效缓慢的各型肺结核，加用白芨后能收到较好效果。据观察，60例久治不愈患者，用药三个月后，42例临床治愈，X线显示病灶完全吸收或纤维化，空洞闭合，血沉正常，痰菌阴性，临床症状消失；13例显著进步；2例无改变。

②百部：百部温润肺气，止咳，杀虫。治肺结核、百日咳、风寒咳嗽等，均有很好的疗效。用于治疗肺结核，可将百部晒干研粉，以童雌鸡（未产卵的）加水煨汁，调和为丸（每斤百部粉约需净鸡一斤煨成鸡汁375克），每次服丸子10克，早晚各服一次，30天为一疗程。视病情需要可以继续再服。此方用于慢性发作的肺结核效果较好，对长期应用抗痨药物效果不明显的病例，有时疗效尤为显著。据153例的观察，多数服药一、二疗程后症状改善，食欲增进，体重增加，X线复查也有不同程度的进步。

③马齿苋：马齿苋药源广泛，价廉易得，是肺结核辅助治疗的一种好药。肺结核潮热吐血期，取鲜马齿苋，冷开水洗净，榨汁，加50%的开水，得100毫升，每日服三次。如咳痰、潮热、消化不良、便秘等，可用鲜马齿苋30~60克煎汁服。或用马齿苋、大蒜佐餐。或用面粉拌马齿苋蒸熟，加大蒜、酱油、麻油伴食。这个方法简便易行，对改善肺结核的症状大有帮助。

④大蒜，大蒜是大家喜欢吃的。治疗肺结核，用新鲜大

蒜，每次1~2头，捣碎后以深呼吸吸其挥发气，每日二次，每次1~3小时。或用生紫皮蒜30克，去皮放入沸水中煮一分钟捞出（表面熟，里面生为合适，过熟则有效成份被破坏，过生，不能坚持服用），再取粳米30克，放入煮蒜水中煮成稀粥，待粥成，再将蒜放入粥内，另用白芨粉3克和入蒜粥同吃。以上为一次量，每天早晚各一次。平均疗程为三个月。病灶吸收时间最短为一个月，最长四个月。

⑤羊胆：其治疗肺结核，简便验廉。有液剂、丸剂及胶囊剂等不同剂型。液剂：将新鲜羊胆的胆囊口用线扎紧（如胆汁过多可挤出若干，以能一口吞食为度），用清水洗净后隔水蒸1~2小时，于早晨空腹或临睡时吞服，每天一只。如整只吞服困难，可取胆汁分次服。服后吃点糕饼。丸剂：取新鲜胆汁置砂锅内，用文火煎熬成流浸膏状时加入等量乳糖拌匀，做成0.5或1克重之药丸，放在石灰缸内继续收燥。胶囊（粉剂）：熬成的流浸膏放在烘箱中烘干后磨粉，装入胶囊。或以新鲜羊胆汁加防腐剂，对水浴锅上蒸发浓缩，置120℃以下烘箱内2小时，移于除湿器内放冷后研粉。剂量：一般每天用羊胆干燥粉1~1.5克，一次顿服或分二至三次服。

羊胆清火明目解毒，可治肺癆吐血等症。羊胆液无毒，每天服用不超过2只（过量易引起腹泻）。服后食欲旺盛，消化力强，配合适当营养及休息，体重增加，有助于肺结核的治愈。

⑥蜈蚣：治疗肺结核也有较好疗效。取蜈蚣去头足焙干研末内服，每次量约为3~5条，每日2~3次。曾有人治疗7例不同类型的结核病（肺结核、肋骨结核、乳腺结核、颈淋巴结结核、结核性胸膜炎、结核性肋膜炎、散发性结核），均治愈。服药二周后，首先见到食欲增加、面色转红，以后体

重、体力亦见增加。服药期间未发现毒性反应。

科学实验研究证明，蜈蚣对结核杆菌确有杀灭力。蜈蚣服后，有促进新陈代谢功能。服用时，最好将蜈蚣研末，和蜂蜜捏成药丸，不使病人知道。

⑦夏枯草：夏枯草对浸润型、慢性纤维空洞型、血型播散型肺结核，均有一定疗效。取夏枯草60克，水煎分三次口服；或用夏枯草20斤加水煎至5000毫升时，加红糖1000克收膏，早晚各服一次，每次15毫升，一个月为一疗程。服药后咳嗽胸痛、咯痰、发烧、咯血等症状均见消失或减轻，病灶亦见不同程度的吸收好转。

⑧黄精：黄精有显著的抑制结核杆菌的作用，且能改善健康状况，治疗肺结核有较好的疗效。取黄精经蒸晒干燥，洗净，切碎，加水5倍，用文火煎熬24小时，滤去渣，再将滤液用文火煎熬，不断搅拌，待熬成浸膏状，冷却，装瓶备用。一般5斤黄精可制黄精膏一斤，每毫升相当于黄精5克。剂量：每日服四次，每次服10毫升。临床观察19例，均属浸润型肺结核，经单独内服黄精膏2个月后，病灶完全吸收者4例，吸收好转者12例，无改变者3例。痰集菌检查多数转阴；血沉绝大部分均恢复正常值，体重及临床症状也有所改善。

此外，还有一些中药，如茵灵芝、黄芪有增强抵抗力、增强网状内皮系统功能作用，茵灵芝、黄芪与抗痨药合用，能提高疗效。

近来还有用活血祛瘀药物如丹参、桃仁、红花等与白芨、夏枯草、百部、黄精等具有抗结核杆菌作用的中药同用，治疗对于抗痨药物已产生耐药性的空洞型肺结核，取得较好疗效。

4. 支气管扩张

支气管扩张是一种继发的病症。患者过去多曾患过麻疹、百日咳、支气管肺炎等疾病，以后又经常有呼吸道感染的反复发作。支气管及其周围肺组织的慢性炎症损坏了支气管的管壁，削弱了它的弹性，最后形成支气管的扩张和变形。

得了支气管扩张，有些什么症状呢？典型症状是长期咳嗽，咳大量的脓性痰，反复咯血。如果把全天的痰液收集起来，放入玻璃瓶中，不去动它，静置几个小时以后，痰就分为三层：上层是泡沫，中层是混浊粘液，下层是坏死组织沉淀物。

支气管扩张病人还有一些全身性症状，如发热、盗汗、食欲减退、消瘦、贫血等。

支气管扩张病人在体位改变时，如刚刚起床的时候或刚刚睡下的时候，痰量最多。吐痰通畅的时候，病人自己感到轻松一些，如果痰咳不出，就感到胸部憋闷难受，全身性症状也就比较明显地表现出来。

积极防治呼吸道感染，对预防支气管扩张的发生具有重要的意义。支气管扩张的治疗原则是祛痰，促进痰液的引流，控制感染。

长期吃中药可使病情稳定，症状改善或症状痊愈。支气管扩张病人，支气管已经变形和扩张，弹性减弱，要使它恢复原来的形状和弹性是困难的，但通过长期的服中药治疗，可使症状消失，有的还可以上班工作。

祖国医学没有“支气管扩张”的病名，其症状表现类似于“肺痿”、“咯血”。其病因由于肺热气燥，清肃之气不行，脾胃上输之津液转从热化，煎熬而成痰沫；外邪侵袭，肺气壅遏不宣，因而咳嗽；肺有燥热，伤及肺系之脉络，而致咯血。治宜养阴润肺，止咳止血。

方一：百合60克，白芨120克，南沙参30克，百部30克，仙鹤草60克，三七30克，共研成细粉，压成片子或加蜂蜜做成丸子，每次服10克，一天三次，开水吞服。

方二：黄芪120克，沙参120克，川贝15克，杏仁30克，蒲黄炭30克，橘络30克，白芨120克，海蛤粉30克，款冬花15克，桔梗60克，前胡60克，共研成极细粉末，每次服10克，一天三次，开水吞服。

方三：生地120克，苧苈石90克，青黛60克，海蛤粉60克，麦冬120克，五味子60克，仙灵脾120克，百合120克，仙鹤草120克，藕节120克。以上诸药，加水浓煎二次，去滓，将两次浓煎的药液合并，加阿胶120克，三七粉30克，冰糖250克，盛于清洁的瓷罐内，放阴凉处，每日早晚饭后，服二匙，开水化服。

以上三个处方，可以任选一方长期服用，没有副作用。常服以上处方的中药，不仅可以达到止咳止血，润肺化痰的效果，而且还可以增加体重，增强对疾病的抵抗力。

如系支气管扩张并发大量咯血或急性感染，则应及时到医院诊治，或进行相应的急症治疗处理。

5. 急性细菌性痢疾

细菌性痢疾多发生于夏秋季节，是痢疾杆菌引起的一种

肠道传染病。主要症状是发烧、腹痛、腹泻、里急后重、大便中有粘液脓血。痢疾杆菌随着病人及带菌者的粪便排出体外，通过苍蝇、手、水、食物、食具、用具等由口腔进入人体，经过1~7天的潜伏期而发病。

侵入人体的痢疾杆菌能否引起疾病，主要决定于人体抵抗力的强弱和细菌的数量、毒力等。如果少量的痢疾杆菌侵入健康人的胃肠时，可被胃酸和肠液中的溶菌酶所杀灭。如果人体健康情况较差，而侵入人体的病菌又多时，痢疾杆菌就在碱性环境的肠道内很快生长繁殖，引起疾病。

细菌性痢疾，病变主要在大肠，以直肠、乙状结肠部更为严重。由于直肠肠壁和肛门括约肌不断受到炎症的刺激，通过排便反射，使病人总想解大便，同时伴有坠胀感，一天几次、十几次甚至几十次排出粘液脓血便，有时只有想解大便的急迫感觉而无大便排出，这种现象就叫做里急后重（肠炎的腹泻多数没有这种里急后重的感觉）。

中医治疗急性菌痢分为“湿热痢”和“疫毒痢”两种类型。

湿热痢：由湿热之邪壅滞肠中，气血阻滞，传导失司所致。疫毒痢：由疫毒侵入肠中，壅滞肠道，气血受损所致。

①“湿热痢”（这是最常见的一种类型）：症状有发热恶寒，全身不适，胸脘痞闷，食少，腹痛，里急后重，大便带粘液、脓血，一日十余次，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。

处方：葛根30克，黄芩10克，黄连10克，广木香10克，槟榔10克，白芍20克，丹皮10克。水煎服，每日一剂。

②“疫毒痢”：症状有：突然发病，在胃肠道症状出现前，就有高烧，谵妄，惊厥，昏迷，甚至面色青灰，四肢厥

冷、然后出现呕吐咖啡状液，便脓血，次数很多，剧烈腹痛，舌苔黄厚、舌质红绛，脉细数。

处方：黄连10克，黄柏10克，黄芩12克，大黄10克，连翘12克，秦皮12克，丹皮10克，白头翁15克，赤芍12克，槟榔10克，木香10克。水煎服。同时兑服安宫牛黄丸（成药）或神犀丹（成药），中毒症状严重者，应立即采取中西医结合的抢救措施。

治疗急性菌痢的单方验方：

1.旱莲草120克，糖30克（白痢用红糖，赤痢用白糖，赤白痢兼下则红白糖对半），水煎服。一般服一剂后开始见效，继服3~4剂，多可痊愈，而且无副作用。

2.苦参30克，加水200毫升煎至100毫升，每次服50毫升，一天二次。

3.山楂、红糖各60克，白酒30毫升，文火将山楂炒至略焦时，离火加酒搅拌，再置火炉上炒至酒干即可。服时将焦楂加水200毫升，煎15分钟，去渣加入红糖再煎至沸，趁温一次服下，每日一剂。

4.篇蓄30克，水煎服，每日一剂。

5.鲜马齿苋100克，冷开水洗净，切碎，加白糖20克、大蒜泥20克，和匀，一次服下。一日二次。

6.辣蓼草（新鲜全草）90克，加水500毫升，煎至200毫升，于空腹时分三次服，每日一剂。

7.苍耳（全株鲜品，根、茎、叶俱全）30克，白糖10克。水煎服，服时加白糖。每日一剂，分三次服。

6. 慢性细菌性痢疾

细菌性痢疾在急性期治疗不彻底，可成为慢性菌痢。如果人体抵抗力明显减低，营养不良或合并其他慢性疾病如胃炎、胃溃疡、胆囊炎、慢性阑尾炎、肠道寄生虫病等，也能使急性细菌性痢疾转为慢性菌痢。

中医认为慢性菌痢多由外受暑湿疫毒之气，内伤饮食生冷，损伤肠胃而成。但二者互相影响，往往内外交感而发病。

中医治疗慢性菌痢分为“休息痢”和“虚寒痢”两种类型。痢疾迁延，邪恋正衰，脾气更虚，则成久痢，或为时愈时发的休息痢。痢久不愈，或反复发作，则不但伤及脾胃，更能影响到肾，使肾气虚衰，而成为虚寒痢。

(一)“休息痢”：下利日久，时作时止，积年累月，难以根治。平时倦怠无力，常因受凉、劳累或饮食不节而发作。发作时肠鸣腹痛，大便稀，多夹粘液而少脓血。

处方：党参30克，茯苓10克，白术10克，车前仁10克，广木香10克，肉豆蔻10克，干姜10克，乌梅10克，白芍30克。水煎服。或研末为丸，每次服10克，一日三次。

(二)“虚寒痢”：久痢不复，面色无华，精神倦怠，腰膝酸软，形寒畏冷，四肢欠温，食少便溏，甚至滑脱不禁。苔白，脉沉弱。

处方：干姜10克，附片20克（先熬），白术10克，肉桂6克，补骨脂10克，赤石脂10克，肉豆蔻10克，诃子10克，党参20克。水煎服，每日一剂。

治疗慢性菌痢的单方验方：

1.车前草（鲜品100克，干品40克），加水150毫升，煎至80毫升，一次服下，一天二次。连服7~10天，如未痊愈，可连服一个月。

2.用20%诃子液作保留灌肠，每日二次，每次10~40毫升，同时口服诃子胶囊，每次一粒，每日3~4次，饭前二小时服，症状好转后剂量减半。

3.龙井茶60克，独蒜1个。大蒜捣成泥，与茶叶同时放入茶壶，用沸水泡开，当茶饮。

7. 甲 型 肝 炎

甲型肝炎是病毒性肝炎的一种，是一种常见的传染病。肝炎病毒可经消化道传播，健康人与病人接触，吃了被病毒污染的食物和水（例如吃了未煮透的水产品——被肝炎病毒污染的毛蚶等），都可引起甲型肝炎。

甲型肝炎在临床上可以出现黄疸，也可以不出现黄疸。黄疸出现与否，一方面与感染病毒量大小有关，另一方面也与人体抵抗力强弱有关。黄疸型肝炎与无黄疸型肝炎是一种疾病的两种表现，只是感染程度和肝脏受损轻重不同。无黄疸型肝炎患者如果过度疲劳或合并其他感染，身体抵抗力降低时，也可出现黄疸，转变成黄疸型。

甲型肝炎有些什么症状？

主要症状为乏力、上腹饱闷、胀痛，不愿吃油腻食物，恶心，呕吐，并可兼有发热。急性黄疸型肝炎除了上述症状

外，一周左右出现皮肤和巩膜发黄，皮肤瘙痒，小便呈茶红色。体格检查时，肝脏肿大（肝脏肿大是肝炎的重要体征之一，但并非所有的肝脏肿大都是肝炎），肝区有压痛及叩击痛。检查肝功能不正常。

甲型肝炎多数能在三个月内恢复健康。如果在发病半年后病情仍不见明显好转的，称为迁延型肝炎，持续一年以上不见痊愈的，称为慢性肝炎（检查肝功能，麝浊和锌浊常增高），少数病人并可发展为肝硬化。少数的暴发型肝炎病人可在发病十天左右，病情突然恶化，黄疸显著加深，恶心呕吐加重，全身皮下和粘膜出血，腹水，浮肿，烦躁，嗜睡，最后陷入昏迷而死亡。

甲型肝炎属于中医“黄疸”和“胁痛”范畴。一般认为多由湿热蕴蒸脾胃，肝气失于疏泄所致。或因七情内伤，饮食不节，以致肝失条达，脾失健运，湿热毒邪，乘虚入侵肝胆，胆汁外溢，郁于血分而发黄疸；也有因脾阳不运，湿邪内阻而发黄疸的。无黄疸型肝炎，主要是由肝脾不和所引起。如肝气郁结而化热，脾失健运而停湿，以致湿热内蕴而发病；亦有因气郁伤肝，劳倦伤脾，气虚血少，或气滞血瘀而致的。中医把甲型肝炎分为“湿热交阻”、“热毒内陷”、“肝郁气滞”、“肝脾不和”四种类型。

1. 湿热交阻：肌肤发黄，黄色鲜明，目黄，胸脘痞闷，腹胀，右胁或有胀痛，恶心甚至呕吐，不欲食，乏力，小便深黄，或有恶寒，发热，口苦苔腻，脉濡数（多属黄疸型肝炎）。

处方：茵陈15克，黑山栀10克，大黄10克，茯苓15克，车前草30克，板蓝根30克。水煎服。

2. 热毒内陷：病势迅猛，黄疸迅速加深，高热，烦躁，

谵妄，神昏，或有痉厥，容易出血或身发斑疹，腹胀满或有腹水，舌红绛，苔黄燥，脉数（多属暴发型肝炎）。

处方：黄连10克，板蓝根30克，山梔12克，郁金10克，茅根30克，茵陈30克，大黄10克，蒲公英30克，水煎服。另用安宫牛黄丸一粒化服。

3. 肝郁气滞：胁肋胀痛，胸闷，暖气，腹胀，或有低热，口苦，舌苔薄白，脉弦（多见于无黄疸型肝炎）。

处方：柴胡15克，白芍10克，香附10克，郁金10克，川楝子10克，枳壳10克，青皮6克，陈皮10克，板蓝根30克，甘草10克。水煎服。

4. 肝脾不和：胸膈痞闷，腹胀，食少，倦怠乏力，或便溏，苔厚或腻，脉濡（多见于急性肝炎恢复期）。

处方：白术10克，枳壳10克，陈皮10克，砂仁6克，木香10克，苡仁20克，茯苓20克，山楂20克，神曲10克。水煎服。

中医把迁延型肝炎或慢性肝炎分为“肝经湿热”、“气滞血瘀”、“肝阴不足”、“脾胃失调”四个类型：

（一）肝经湿热：口苦，胁肋疼痛拒按，心烦易怒，食欲不振，喜呕，肝脏肿大，尿黄，苔黄，脉弦数。

处方：龙胆草10克，黄芩10克，山梔10克，柴胡10克，泽泻10克，木通6克，川楝子10克，麦芽30克。水煎服。

（二）气滞血瘀：肝脾肿大，右肋刺痛不移，面色晦暗，腹胀满，干呕，食少，舌有瘀点或瘀斑，脉弦。患者颈部、面部、前臂、手背及胸上部或可见到蜘蛛痣（蜘蛛痣是由一支中央小动脉及许多向外辐射的细小血管所组成，外形象蜘蛛。大的蜘蛛痣用细棒压迫中心点可使整个痣消失），有的病人可有肝掌（手掌的大鱼际、小鱼际和指尖红如朱砂）。

处方：柴胡10克，赤芍12克，桃仁10克，红花10克，丹参30克，延胡索10克，台乌10克，归尾12克，香附12克，鳖甲30克，三棱10克，莪术10克，水煎服。

(三)肝阴不足：胁肋隐痛，头晕心烦，乏力，手脚心热，食欲不振，舌红无苔，脉细数。

处方：北沙参10克，生地10克，当归12克，枸杞15克，川楝子10克，白芍15克，山药15克。水煎服。

(四)脾胃失调：胁痛不甚，脘腹胀闷，纳少，稍吃油腻大便即溏，倦怠无力，舌苔薄白，脉缓。

处方：木香10克，白术10克，砂仁6克，陈皮10克，山楂30克，茯苓10克。水煎服。

有的慢性肝炎患者病情缠绵难愈，检查肝功能时麀浊和锌浊长期偏高，不能降至正常，患者思想负担很重。在这种情况下，可用下列方药：

芦荟3~6克（研末吞服），赤芍30克，枸杞15克，黄精30克，丹参30克，黄芪30克，当归30克，白芍30克。水煎服，每日一剂。

一般服用此方10天左右，麀浊、锌浊可降至正常，患者思想负担大为减轻，有利于继续治疗。服用芦荟有轻泻的副反应，不需处理，如轻泻次数较多（一天6次以上），可减量为每日3克甚至1.5克，但仍应坚持服药，以便使麀浊、锌浊迅速降至正常。肝功能正常后，仍应继续服药（上方去芦荟），巩固疗效，其疗程不限。

慢性肝炎患者由于肝脏曾受损害，病情常有反复，不必忧虑，当肝功能复查发现麀浊、锌浊再次升高时，仍可服用芦荟。芦荟在国外被用作美容药，长期服用无副作用。

肝炎患者除了服药治疗外，还须注意以下几点：

1.应保持乐观情绪。因为情绪乐观可促使患者康复；反之，情绪紧张，忧郁不乐，疑虑重重，害怕肝炎医不好转成肝癌，坐卧不安，将会直接影响肝炎的治疗效果。

对待肝炎的正确态度应该是：战略上藐视肝炎，肝炎不是不治之症，树立起战胜疾病的信心和勇气。战术上重视肝炎，要遵守医生的嘱咐，定时服药，多吃新鲜水果和蔬菜以及易于消化、富含蛋白质的食品，勿过度疲劳。如能做到以上这些，肝炎的痊愈指日可待。

2.应重视饮食调理。因为肝脏是人体的一个非常重要的解毒器官。人体在正常代谢过程中产生许多有毒物质，有毒物质产生后被肠管吸收入血，由于肝脏的解毒作用，而不造成对人体的毒害。肝脏内保存糖元可以增强解毒机能，所以肝炎患者应补充适量的糖类，以保护肝脏，减轻肝脏解毒的负担。

甲型肝炎的急性期，消化不好，故饮食宜清淡，应多吃水果蔬菜，补充维生素B、C，因为维生素B、C在蛋白质、糖、脂肪的代谢及生物氧化作用中起重要作用，有利于肝功能的恢复。肝炎患者应常吃蘑菇。蘑菇营养丰富，味道鲜美，能增进食欲，有益胃气。所含氨基酸、维生素甚多。临床报道，鲜蘑菇水煎浸膏片治疗肝炎，有效率达73%。

下列食疗验方可选用（辅助治疗）：

①湿热型：患者面目周身俱黄，胸闷腹胀，纳呆，恶心，口淡，身重，尿赤，便结。

食疗方一：瘦猪肉100克，红枣10枚，茵陈60克，板蓝根30克。加水适量煎煮，放盐少许，去药渣，喝汤吃肉，每天一剂。

食疗方二：猪肝100克，红枣20枚，田基黄30克，猪肝

切碎，用清水适量煎煮，放盐少许调味，去药渣，喝汤吃猪肝。

②肝肾亏损型：胁痛隐隐，低热，口干，舌燥，手足心热。

食疗方一：荸荠100克，瘦猪肉100克，梨100克。荸荠、梨去皮，猪肉切片，加水同煮熟，放盐，吃肉吃梨吃荸荠，喝汤。

食疗方二：西瓜汁、蕃茄汁适量，和匀，加白糖少许，随意饮用。

3.应避免使用损害肝脏的药物。如抗生素中的四环素、红霉素；磺胺类；抗痨药如异烟肼、对氨基水杨酸钠、乙硫异烟胺、利福平等；镇静安眠药氯丙嗪、苯巴比妥、苯妥英钠、利眠灵、安定等；抗血吸虫药酒石酸锑钾等；治“甲亢”药甲基硫氧嘧啶、他巴唑等；口服避孕药甲地孕酮、炔诺酮、炔雌酮、甲基睾丸酮等；抗癌药6-巯基嘌呤、瘤可宁、光辉霉素、丝裂霉素、放线霉素D、环磷酰胺等；解热止痛药水杨酸类、扑热息痛、非那西汀、消炎痛、保泰松等；抗霉菌药灰黄霉素；中药斑蝥、红娘子、苍耳子、黄药子、乌头、附子等等均可引起肝脏损害（能引起肝脏损害的药物还不止以上这些），应禁用或慎用。

4.应控制高糖、高脂肪膳食。肝炎患者要适当补充糖、蛋白质、脂肪、维生素等营养物质。但是，如糖（包括其他的碳水化合物）和脂肪补充过多，反而有害，甚至由肝炎转变成“脂肪肝”。

5.患者应戒酒。因为酒可以造成对肝脏的损害。肝炎患者，肝细胞已受损伤，肝功能不正常，特别是乙醇代谢所需的各种酶活性减低，分泌减少，解毒功能大大下降，即使少量饮

酒，也会加重肝脏负担，影响肝功能恢复，甚至导致肝坏死。

6.应常吃蜂乳和蜂蜜。因为蜂乳能促进损伤组织（包括肝细胞损害）的再生修复过程，有利于肝炎的治疗，缩短疗程，提高身体抵抗力。

肝炎患者还应避免过度疲劳。静卧可减轻肝脏负担，促进肝细胞再生和修复。

肝炎患者忌性生活过度。因为性生活过程消耗能量较多，心搏、呼吸加快，肝脾收缩引起缺血、缺氧、肝糖元消耗。这对肝炎病人是十分不利的。

肝炎患者忌喝酒又同时喝汽水。许多人认为喝点白酒又喝汽水，可以解酒，又可清热。实则适得其反。科学研究证明，白酒与汽水同饮后会很快使酒精在全身挥发，并产生大量的一氧化碳，会对肝脏造成严重损害。因此，肝炎患者既忌喝酒，更忌白酒与汽水同饮。

甲型肝炎的预防：

病毒性肝炎传播较广，危害较大，为保障人民身体健康，应采取综合性预防措施，控制这种病的传播。

①早期发现病人，尽快隔离治疗。

②大搞爱国卫生运动，搞好粪便管理，搞好饮水卫生，养成良好的卫生习惯，做好病人食具、用具、排泄物及医疗用品（注射器等）的消毒处理。

③加强体育锻炼，增强抵抗力。

肝炎流行区的居民可适当服用预防肝炎的中草药如大青叶、蒲公英、板蓝根等。

3. 急性阑尾炎

急性阑尾炎是城乡最常见的疾病之一。我国古代把阑尾炎叫做“肠痈”。汉代名医张仲景在《金匱要略》里已系统地描绘了它的症状和治疗方法，这种治法一直传到今天还在应用，而且疗效很好。

阑尾炎过去曾误称为盲肠炎，可能现在还有一部分人还习惯于引用这个错误的名称。其实，阑尾和盲肠完全是两回事，在急性阑尾炎时盲肠并不发炎。

阑尾为什么容易发炎呢？

阑尾是一条又细又长的盲管，容易造成曲折或扭转，也容易被肠道里的粪块、异物、寄生虫等阻塞。阻塞后，阑尾供血不良，管腔内细菌乘机繁殖而侵入管壁引起炎症。

阑尾炎有哪些症状？

典型症状：先有恶心、呕吐、食欲不振等一般肠胃道症状，同时伴有上腹部或脐周围的隐痛。不久，肠胃道症状逐渐减轻或消失，腹痛逐渐向右下腹转移，以后腹痛就一直固定在那个地方。

急性阑尾炎病人体温一般不高，但当炎症发展扩散时，体温亦可升高。大多数病人白细胞计数增加到10,000~20,000（正常人在6,000~7,000之间），中性白细胞的比例也会超过80%以上。这都表示人体内有炎症存在。

压痛是诊断急性阑尾炎的最主要的依据。

当你用手轻轻的按在病人右下腹部的某一点时，病人会告诉你腹痛得厉害，这就叫做“压痛”。阑尾点是压痛最多见

的部位。

大约70~80%的急性阑尾炎病人，都有典型的“转移性腹痛”和明显的压痛。

当阑尾炎化脓坏死时，压痛范围扩大，并且出现腹肌紧张（腹肌变得强直起来）、反跳痛（当摸病变部腹壁的手压下去后突然抬起时，疼痛突然加剧）。

如有阑尾脓肿形成时可触到痛性包块，腹膜炎时包块触痛更明显，在足部阑尾穴处（足三里穴下约二寸处）常可出现压痛点。

急性阑尾炎属于中医的“肠痈”，认为多由饮食不节，或饭后急暴奔跃，或寒温失调，以致影响肠胃运化，引起湿热积滞，肠府壅热，气血瘀阻而成。

中医治疗可分“瘀滞型”、“湿热型”、“热毒型”三种类型：

（一）瘀滞型：发热不明显，右下腹有压痛或轻度反跳痛，腹肌紧张不明显，白细胞总数在10,000左右。

处方：生大黄10~15克，丹皮10克，红藤30克，厚朴10克，败酱草30克，川楝子10克，桃仁10克。水煎服。

（二）湿热型：发热，厌食，右下腹压痛明显，有腹肌紧张及反跳痛，体温在38℃以上，白细胞总数在10,000~15,000。口干渴，尿黄，头昏重，胸闷，舌苔黄腻，脉数。

处方：生大黄15克，丹皮10克，红藤30克，冬瓜仁30克，败酱草30克，厚朴10克，蒲公英30克，银花30克，苡仁30克。水煎服。

（三）热毒型：高烧，面红目赤，唇干舌燥，口干渴，右下腹压痛显著，反跳痛及腹肌紧张都很明显，大便秘结，尿赤，舌红，苔黄燥，白细胞总数在15,000以上。

处方：生大黄15克，丹皮12克，红藤30克，冬瓜仁30克，败酱草30克，厚朴15克，白花蛇舌草30克，苡仁30克，黄连10克，黄芩10克，黄柏10克，山栀12克。水煎服。

中药对阑尾炎的作用是：抗菌，促进肠蠕动以利解除阑尾梗阻，排空潴留物，改善阑尾壁的血液循环。

急性阑尾炎也可以用复方大蒜糊外敷治疗：芒硝30克、熟大黄30克、大蒜120克。先将大蒜去皮捣烂，加入芒硝，共捣烂如泥，敷腹部最痛处。一般敷2小时去药。再将熟大黄研粉，用醋调成糊状，敷6~8小时，此为一个疗程。必要时隔数小时后可重复使用。敷药的局部要先用凡士林纱布保护皮肤，以免起泡。

针灸治疗是以足三里（膝眼下三寸）及阑尾穴（足三里穴下二寸）为主，一般认为留针时间长，经常加强捻转，则效果比较好。现已证明针刺有增强阑尾蠕动和加强身体防御能力的作用。

中药、针灸对绝大多数单纯性阑尾炎均有显著疗效，一般在24小时内腹痛就可以减轻或消失，白细胞计数下降，体温恢复正常。缺点是复发率较高，复发时再用针灸或中药治疗，仍然有效。

在用针灸、中药治疗过程中，应严密观察病情变化。万一出现腹痛加重，疼痛范围或肿块不断加大，压痛与腹肌紧张加重，体温上升，白细胞总数及中性粒细胞比例上升等现象，表示病情加重，应将病人送往有条件的医院作手术治疗。

9. 溃 疡 病

胃或十二指肠粘膜被腐蚀，形成疮面，就是胃溃疡或十二指肠溃疡。由于胃溃疡和十二指肠溃疡的发病原因和症状差不多，所以医学上把胃溃疡和十二指肠溃疡通称为溃疡病。

溃疡病是一种很常见的疾病。溃疡病发生的原因与高级神经活动的关系十分密切。我们知道，人体的一切器官，都是受大脑管理的，胃和十二指肠当然也不例外。如果大脑皮层受到某种有害的刺激，如忧愁、恐惧、愤怒、精神紧张、过度疲劳等，都会使大脑皮层的机能降低。在大脑皮层机能降低的同时，比较低级的神经中枢的机能反而亢进，结果就引起胃和十二指肠的功能不正常，引起胃酸分泌增多，胃部肌肉紧张性加强，胃蠕动增加，供应胃和十二指肠血液的血管痉挛等等，导致部分的胃粘膜或十二指肠粘膜被消化而形成溃疡病。

当胃或十二指肠形成溃疡以后，它不象其他的皮肤破损或粘膜破损那么容易愈合；由于胃液的消化与刺激，溃疡多半变成慢性。溃疡病的疼痛等症状对大脑皮层来说也是一种不良的刺激，它可以影响并加重大脑皮层的功能紊乱，进一步加重溃疡病的症状，形成“恶性循环”。这就是溃疡病之所以会反复发作、不易愈合的道理。

溃疡病的发作或复发，还有一些诱因，如饮食不节，暴饮暴食，等等。还有一些药物如阿斯匹林、保泰松、辛可芬、利血平、考的松、强的松等，都能使溃疡病复发或恶化，因此，溃疡病人不宜用这些药物。

溃疡病最常见的症状是疼痛。痛的部位是在上腹部正中或略偏左侧。疼痛的特点和饮食有密切关系，可分为“早发的疼痛”与“迟发的疼痛”两种。

早发的疼痛，在进食后半小时到一个半小时出现，疼痛持续1~2个小时才逐渐消失。直到下次进食以后，疼痛又再度出现。

迟发的疼痛，在进食后2~4小时出现，又可分为“夜间痛”和“饥饿性疼痛”两种。“饥饿性疼痛”就是一饿就要痛，吃一点东西疼痛就可以减轻或消失。“夜间痛”是指病人吃了晚饭入睡后被疼痛惊醒。“夜间痛”吃点东西也可减轻疼痛。

一般的说，“早发的疼痛”是胃溃疡的特征，“迟发的疼痛”是十二指肠溃疡的特征。

溃疡病在疼痛时吃一点小苏打，就可以减轻疼痛。如果不是溃疡病引起的疼痛，吃小苏打，止痛的效果就不明显。

溃疡病的疼痛即使不经任何治疗，也会自然缓解，逐渐不痛（缓解期可达4~5个月或更长），但以后症状又可出现。这种疼痛的周期性，是溃疡病的又一特点。随着病程进展，疼痛的周期愈来愈短。如果有了合并症，这种疼痛的周期性就完全消失了。

溃疡病疼痛的发作还有一定的季节性。

溃疡病人疼痛的感觉各有不同，有的是胀痛、有的是烧灼痛，有的是钝痛，有的是刺痛，有的是锥痛。还有一种濒死性剧痛，应赶快送到医院抢救。

溃疡病还有一些症状如暖气，吐酸水，常有饥饿感（嘈杂感），便秘等。

要诊断溃疡病，可通过作胃液分析、大便隐血试验、X线钡餐检查、胃镜检查等以明确诊断。

溃疡病属于祖国医学的“胃脘痛”范畴。发病原因多为长期的精神刺激，情志不调，饮食不节，以致肝胃不和，脾胃不健，胃气郁滞而发生疼痛。

临床常见证候有“肝胃不和”、“脾胃虚寒”两大类。

(一)“肝胃不和”：症状有胃脘胀痛，攻窜不定，痛连胁肋背后，食后痛甚，胸闷，暖气，泛酸，口苦，舌苔薄白，脉细弦。

处方：柴胡10克，枳壳10克，白芍15克，延胡索10克，香附12克，甘草6克，乌贼骨10克，生蒲黄10克，五灵脂10克。水煎服。

(二)“脾胃虚寒”：症状有胃部隐痛，时轻时重，胃部觉冷，喜暖喜按，空腹时痛甚，食后疼痛减轻，多食又胀，或吐清水，大便溏，怕冷，精神疲倦，舌苔淡白，脉细。

处方：黄芪30克，白芍30克，桂枝10克，炙甘草10克，干姜6克，大枣20克。水煎服。(胃部冷痛明显者加高良姜10克，大便发黑，去桂枝、干姜，加炮姜炭10克，白芨10克、乌贼骨10克)。

近年来有用黄芪建中汤(黄芪、白芍、桂枝、炙甘草、大枣、生姜，水煎服)加服痢特灵(100毫克，一日三次)治疗溃疡病，效果较满意，可以消除疼痛，促进溃疡愈合。

单方验方：

①乌贼骨85%，浙贝母15%（无浙贝母，也可用大黄，其比例也是15%）加少量生甘草，一同研成细末，每次服6克，一天服三次，在两餐饭的中间服，也可在胃痛发作时服。这个验方有很高的疗效，而且没有副作用。本方主药乌贼骨（又叫海螵蛸）含有磷酸钙、碳酸钙、胶质、有机物和氯化钠等，有止痛、止血、制酸、收敛溃疡创面等作用。

②延胡索30克，枯矾60克，乌贼骨60克，共研细末，用蜂蜜（熬熟）150克和匀作成药丸（每丸重10克左右），每次服10克，一天服三次。连服半个月至三个月。这个验方能止痛，中和胃酸，驱气，改善局部及全身血液循环，促进炎症吸收，促进溃疡愈合，本方主药枯矾，有很强的收敛性，可抑制炎症，在炎症表面形成蛋白质保护膜，止痛，促进溃疡愈合。内服相当安全，无副作用。

③白芨120克，甘草60克，茯苓皮30克，牡蛎120克，共研细末，加熟蜜（蜂蜜）330克，调匀，做成丸药，每丸重10克左右，每次服10克，一天三至四次，开水送服。

④五倍子6克，瓦楞子12克，白芨10克，鸡内金15克，水煎服，若加蜂蜜30克调服，则效果更好。

⑤猪肚1个，小茴香（炒）30克，何首乌（生熟均可）60克。小茴香、何首乌用纱布装好扎口，加水适量，与猪肚（洗净）同煮，煮至猪肚熟烂为度。取出纱布药袋，将猪肚连汤分三份，1日服3次，1次服1份。连服12个猪肚为一疗程。

溃疡病人的注意事项：

1.应力戒忧愁、恐惧、愤怒。因为忧愁、恐惧、愤怒这些精神因素均可导致溃疡病的发生，或使溃疡病加重。这些不良的精神因素，会使大脑皮层的机能降低，而使比较低级的神经中枢的机能亢进，结果就引起胃和十二指肠的功能不正常，胃酸分泌过多，胃平滑肌痉挛，粘膜抵抗力减弱，在胃酸的作用下发生溃疡或使溃疡加重。

2.应按时服药。溃疡病患者的最佳服药时间为饭后1~2小时。

3.应重视饮食调理。溃疡病人的食物，既要营养丰富，又要容易消化。过去强调少吃多餐。现在看来，少吃多餐并

不适合溃疡病的调理。因为，食物进入胃内，除了能一定程度中和胃酸外，同时更强烈地刺激胃酸分泌。每次用餐所引起的胃酸分泌要持续三小时左右，多餐就意味着不断刺激胃酸分泌，使溃疡面不断受到酸的侵蚀，这不利于慢性溃疡的愈合。有些十二指肠溃疡病人，饥饿时疼痛，进食后即好转。于是以为“食能止痛”，患者平时也带着干粮，一旦饿痛就以食止痛。这种不规则的零星进食，使胃酸分泌处于活跃状态，不利于溃疡愈合。因溃疡病人应定时进食，一日三餐。

溃疡病人的饮食最好以面食（带碱面）为主，低脂肪，蛋白质适量。面食柔软，还可稀释胃酸，中和胃酸。不爱吃面食者可吃粥。高脂肪饮食可刺激胃酸分泌，对溃疡病患者是不适宜的。蛋白质也能强烈刺激胃酸分泌，因此，鸡、鸭、鱼、肉、蛋等，只能适量食用，不可过量。

下列食疗方，可供选用：

①寒凝型：胃脘痛暴作，得热痛缓，遇冷加剧，喜热饮热食。

方一：良姜粥：良姜15克切细末，大米100克，共煮成粥，随意食用。

方二：花椒10克，研细末，白面120克，和匀，入盐与豆豉少许，煮羹食用。

方三：韭菜250克，切碎绞汁，生姜25克洗净切碎捣烂，绞汁。取韭汁、姜汁放锅内，再加牛奶250克，煮沸，乘热服食。

②食滞型：胃脘饱胀痛，恶心，呕吐，吐后疼痛缓解，暖气（鸡矢臭）。

方一：莱菔子15克，炒后研末，与大米100克同煮成粥。

方二：莱菔子（即萝卜子）6克，研细末，加开水调服。

③气滞型：胃脘胀痛，攻窜两胁，气怒加重。

方一：橘皮适量切碎，与大米同煮成粥食用。

方二：薤白10克，大米100克，同煮粥食用。

④郁热型：胃脘灼痛，口苦口渴，大便干，小便黄赤。

方一：西瓜瓤，挤汁饮用。

方二：新鲜卷心菜，洗净切碎，用干净纱布包扎绞汁，加温服用200毫升，每日2次。

⑤阴虚型：胃脘隐痛，并有灼热，口干唇燥，舌红并有裂纹。

方一：蜂蜜30克，温水冲后，睡前服用。

方二：牛奶或羊奶1~2杯，煮沸后乘温饮用。

⑥淤血型：痛有定处，如刺如割，拒按，呕血，黑便。

方一：小白菜250克，洗净切碎，用盐少许腌拌10分钟，用干净纱布绞汁，加白糖适量，每天分3次饮用。

方二：鲜藕汁一小杯，加水适量煮沸，加三七粉1~3克，加盐少许，佐餐，每天2次。

⑦虚寒型：胃脘冷痛，喜暖喜按，倦怠腹胀。

方一：糯米100克，红枣20克，同煮粥食用。

方二：新鲜土豆250克，洗净，切碎，加开水，捣烂，用清洁纱布包扎绞汁，每次服一匙，酌加蜂蜜。连服2~3周。

方三：猪肚250克，生姜30克，肉桂3克，共炖烂熟后分2次服用。

溃疡病患者还宜常吃香蕉和蜂蜜。动物试验证明，香蕉对胃溃疡有保护作用。蜂蜜对胃粘膜的溃疡面也有保护作用。据临床报道，溃疡病患者每天吃新鲜蜂蜜100克，早中晚分三次服，第10天后，每日增至160克，治疗20例，其中15例壁龛消失（痊愈），3例有进步，2例胃痛减轻。

4. 溃疡病患者宜戒烟。因为吸烟可引起胃酸及胃泌素分泌增多，使胃粘膜血循环异常，并降低胃粘膜的抵抗力。吸烟愈多，血液中尼古丁浓度愈高，十二指肠球部的酸度也愈高，胃酸刺激粘膜持续时间也更长。吸烟还可以抑制胆汁（碱性液体）的分泌，降低对胃酸的中和作用，从而影响溃疡病的愈合。

5. 溃疡病患者切忌喝浓茶；忌喝酒；忌吃过冷、过热、过酸、过硬的食物；忌吃辛辣、油炸的食物；忌长期服用甲氰脒胍；忌常服小苏打及汽水；忌久服氢氧化铝凝胶及胃舒平；忌用肾上腺皮质激素；忌服阿斯匹林、保泰松、利血平等能使溃疡病恶化的药物。

10. 胃下垂

胃下垂是指胃全部（包括胃大弯和胃小弯）下降至不正常的位置。这种病多由腹壁的紧张度发生变化、腹壁脂肪缺乏和肌肉松弛、腹压减低所引起。平素身体瘦弱、胸廓狭长的人容易得胃下垂；经常压迫胸部和上腹部，也容易得胃下垂；平时身体肥胖但因某种原因骤然消瘦，妇女生育过多，也容易得胃下垂。

胃下垂要到医院作X线检查才能确定诊断，但是胃下垂却有一些症状可引起人们的注意。

胃下垂的临床表现：消瘦，乏力，胃口不好，食纳减少，胸脘胀闷不舒适（这种症状在饭后更加明显），也有在吃东西后产生腹下坠的感觉以及腰痛，或者呕吐、暖气、大便不正常。胃下垂的病人在平卧时症状就减轻。

胃下垂的病人在平时作弯腰动作常可引起疼痛。

中医认为胃下垂多由脾胃虚弱、中气下陷所造成的。脾主肌肉而司运化，脾虚则运化失常，中气升举无力，因而发生胃下垂。

胃下垂用针灸治疗有很好的疗效。

常用穴位：

胃上、关元、气海、足三里。

针刺方法：

针刺胃上穴时，用5寸长针（针灸针），透过肌层，针尖刺向气海或关元穴。如胃下垂不到6公分者，取气海穴；超过6公分者，取关元穴。在这两个穴位针刺后，再作“托胃”手法，以助胃上提，间日一次，20次为一疗程。

“托胃”手法是：医生用右手虎口托住胃底部，用力缓缓向上推移，反复操作几次。

不愿用针灸疗法治病的病人，也可用中药治疗。

方一：枳实20克，加水浓煎，每日一剂，分三次服（饭前一小时服）。

方二：黄芪500克，研成细末，每次服10克，一天三次，开水吞服，饭前一小时服。

方三：补中益气丸（成药），照说明服。

方四：蓖麻子仁98%，五倍子2%，将蓖麻子外壳剥去，选饱满洁白的蓖麻子仁（灰的、干瘪的不要），与五倍子一同研成细粉，混匀，打成烂糊，制成每颗重约12克、直径1.5公分的药饼，备用。

用法：在头顶部（百会穴）剃去一块头发，将药饼紧贴在百会穴上，外用纱布绷带固定，不要让药饼移动或脱落。每日早晚各贴一个药饼（换药一次）。药饼贴上后，立刻用搪瓷

杯盛开水在药饼上面热熨，每次熨10分钟。熨时病人有温热的感觉。熨完后，药饼仍固定在百会穴上。

方五：鲜仙人球60克。洗净切碎。瘦猪肉30克，剁成肉饼，与仙人球一起煮熟，晚上睡前顿服，每日1剂，30天为一疗程，连服3个疗程。

方六：肉桂1克(刮去粗皮生用)，五倍子2克(炒)，何首乌3克(炒)。上药分研和匀，每日1剂，用凉开水1次送服。20天为一疗程，连用2个疗程。

胃下垂的病人，平时不宜吃得过饱，少喝汤水。食物宜选择营养较好，容易消化而体积又比较小的东西，可用少吃多餐的方法，以减轻胃的负担。吃东西后最好平起睡一段时间，并要避免暴饮暴食。

胃下垂的病人，平时不要过度疲劳。

胃下垂的病人腹肌多半不发达，应参加一定的体育锻炼(但要避免剧烈的运动)，使腹肌能保持一定的紧张力。

能做到以上所说的各条，胃下垂是可以治好的，胃下垂是能够升提起来的。

这里介绍的治疗方法，对肝、脾、肾下垂也适用。

11. 顽固性呃逆

呃逆是气逆上冲，喉间呃呃连声，声音短促，但较频繁，自己往往不能控制的一种病症。如果偶然发作，大多数症状轻微，能够自行痊愈。但如果连续不断的呃逆，就需要吃药才能慢慢的平息下来。在一些慢性疾病的过程中，或者在手术以后，或者是服了某些药物过量(如服了使君子过量)，都

可出现呃逆这种症状。顽固性呃逆可持续几天、十几天、几个月甚至几年而不能控制。

中医认为呃逆的病因病机为：①饮食不节，如过食生冷或寒凉药物，寒凉蕴蓄中焦，胃阳被遏，或过食辛热炙煨，燥热内盛，阳明腑实，气不顺行，均可导致呃逆。②情怀不畅，气郁化火，肝火犯胃，或痰滞郁久化热，也可引起胃气不降，上逆而成本病。③劳累太过，耗伤中气，或年高体弱，久病久痢，以致脾胃阳衰，清气不升，浊气不降；或热病伤津，及汗吐下太过，耗损胃液，虚火上逆，均可发生呃逆。

中医历来把呃逆分为“胃中寒冷”、“胃火上逆”、“脾肾阳虚”、“胃阴不足”，四个类型。

属于“胃中寒冷”的呃逆，表现为呃声沉缓有力，胃里不舒服，遇热则呃逆减轻，遇寒则呃逆加重，舌苔白润，脉象迟缓。这种情况，用丁香散治疗效果较好。

处方：丁香6克，柿蒂10克，良姜10克，炙甘草6克，水煎服，每日一剂。

属于“胃火上逆”的呃逆，表现为呃声洪亮，冲口而出，口臭，口渴，心烦，小便短赤，大便难，舌苔黄，脉象滑数。这种情况，用竹叶石膏汤治疗，有一定的效果。

处方：竹叶10克，生石膏30克，麦冬12克，党参15克，法半夏10克，甘草6克，粳米10克，水煎服，每日一剂。

属于“脾肾阳虚”的呃逆，表现为呃声低弱，上气不接下气，面色苍白，手足不温，疲倦，食纳减少，腰膝无力，舌质淡，脉沉细。这种情况，用旋覆代赭石汤治疗较为合适，

处方：旋覆花10克，代赭石30克，党参15克，法半夏12克，生姜10克，大枣15克，水煎服，每日一剂。

属于“胃阴不足”的呃逆，表现为呃声急促而不连续，口

干舌燥，烦渴不安，舌质红绛，脉细数。这种情况，用益胃汤治疗较为适宜。

处方：沙参15~20克，麦冬15克，生地12克，玉竹12克，冰糖15克，水煎服，每日一剂。

还有一些顽固性呃逆，反复发作已有好几年，用上面的方剂治疗，仍然容易复发。这种情况，属于“久病多瘀”，用血府逐瘀汤治疗，往往能奏效。

处方：桃仁10克，红花10克，当归12克，川芎10克，熟地10克，白芍20克，柴胡12克，枳实10克，甘草10克，桔梗10克，牛膝10克。水煎服，每日一剂。

手术后顽固性呃逆是一种严重的并发症，可考虑用下面的方剂治疗。

处方：附片（先熬一小时）10克，葛根10克，白蔻10克，旋覆花10克，法半夏10克，茯苓10克，党参12克，丁香6克，枳实6克，甘草6克，炮姜三片。水煎服，每日一剂。

有的呃逆不分昼夜，影响谈话和睡眠，同时还有腹胀、面色苍黄、食欲不振等症状，中医认为是“湿重”的表现，用平胃散加味治疗，疗效较好。

处方：厚朴10克，苍术10克，陈皮10克，甘草6克，生姜三片，大枣10克，丁香6克，法半夏10克，茯苓12克，茵陈30克。水煎服，每日一剂。

有的呃逆，用针灸治疗能取得良好疗效。

主穴：天突。

配穴：内关、足三里、太冲。

方法：天突进针二寸。配穴任选一个，得气后，接6.26治疗机，或不断催针，保持良好得气。

用指压穴位治疗呃逆，也有一定疗效。取穴：眉棱骨下

眼窝之上（即攒竹穴稍下处），左右共二穴。按压此穴时患者有显著的疼痛感。操作：医生用双手拇指分别放在两侧穴位上，用力逐渐加重，患者有一般特殊感觉传至胸内，呃逆即可消失。如呃逆消失较慢，可加大按压力量和延长按压时间。

治疗呃逆的单方验方：

①韭菜子研末，^①开水吞服，每次服10~15克，一天服二次。没有不良反应。

②灯草烧灰，开水冲服，每次服6克，一天服二次。本方对顽固性呃逆有较好疗效。

③黄杨木30克，水煎服。不论虚证、实证均适用。

④构树枝（楮树枝），以手指一样粗细的为好，去掉树叶，洗干净，切成片，构树枝60克加水500毫升，煎至100毫升，加白糖服，每日一剂。本方对流行性出血热病人出现的顽固性呃逆，疗效较好。服2~3剂，呃逆即能中止发作。

⑤黑芝麻、白砂糖各适量。将黑芝麻炒熟，杵碎，拌入白砂糖，每次服数匙。

⑥威灵仙30克，蜂蜜30克。煎水内服。

12. 腹 泻

腹泻是排便次数比正常增多（在正常情况下，成人每天解1~2次成形的褐黄色大便），大便稀薄，甚至如水样，或大便中夹有粘液、脓血者，称为腹泻。如果仅仅是排便次数增多，粪便仍然成形，就不能称作腹泻。

引起腹泻的原因很多，如胃、肠、胰、胆等的疾病都可引起腹泻，其中以肠道感染为最常见。精神紧张、情绪激动

以及内分泌紊乱等全身疾病也可引起腹泻。

腹泻的原因虽然很多，但主要原因是由于肠道运动和分泌机能失调所致。肠蠕动增强，粪便通过结肠的速度加快，水分不能被充分吸收，或肠道炎症等其他因素致使水分吸收减少，都可引起排便次数增多，粪便稀薄。

严重腹泻可造成胃肠分泌液的大量丢失，产生水与电解质平衡的紊乱以及营养物质的缺乏所带来的种种后果。

中医认为感受外邪、饮食不节，可引起急性腹泻，脾胃虚弱、肾阳虚衰、情志失调可引起慢性腹泻。急性腹泻和慢性腹泻可相互转化。

现谈谈几种常见的腹泻的中药治疗。

一、急性腹泻：

（一）感受外邪

1. 风寒挟湿引起的腹泻：泻清稀大便，肠鸣腹痛，胸痞食少，或兼恶寒发热头痛，小便短少，舌苔白，脉浮。

处方：藿香10克，厚朴10克，紫苏10克，陈皮10克，大腹皮10克，茯苓10克，白芷10克，法半夏10克，生姜10克，甘草10克，桔梗10克。水煎服。或服藿香正气丸、藿香正气水（均为成药）。

2. 暑湿引起的腹泻：泻水样便，心烦口渴，自汗，面垢或转筋，小便短黄而热，舌苔黄腻，脉濡数。

处方：蚕沙10克，木瓜10克，豆卷10克，苡仁20克，吴茱萸10克，黄连10克，法半夏10克，炒栀子10克，黄芩10克。水煎服。

3. 热泻：泻下呈喷射状，便稀黄臭，肛门灼热，腹痛。腹痛即泻，心烦口渴，小便短黄，苔黄脉数。

处方：葛根30克，黄芩10克，黄连10克，银花10克，竹

叶10克，车前草30克，广木香10克。水煎服。

（二）饮食不节

腹痛肠鸣，大便酸臭，泻后痛减，脘腹胀满，暖气，不思饮食，舌苔厚腻，脉滑数。

处方：山楂30克，神曲15克，苍术10克，厚朴10克，陈皮10克，麦芽20克，甘草6克，水煎服。或服保和丸（成药）、枳实导滞丸（成药）。

二、慢性腹泻：

（一）脾胃虚弱

大便时溏时泻，不思饮食，食后脘闷不舒，面色萎黄，疲倦乏力，舌苔淡白，脉浮。

处方：党参30克，白术10克，茯苓10克，陈皮10克，扁豆20克，山药20克，桔梗10克，砂仁6克，苡仁30克，大枣15克，甘草6克，水煎服。

（二）肾阳虚衰

黎明之前，脐下作痛，腹鸣即泻，腹部怕冷，下肢觉冷，舌苔淡白，脉沉细。

处方：补骨脂10克，五味子15克，吴茱萸10克，肉豆蔻10克，山药30克，茯苓10克，肉桂6克，炮姜10克。水煎服。或服四神丸（成药）。

（三）情志失调（肝气乘脾）

每因情绪变化发生腹痛，腹痛即泻，平时胸胁胀闷，食少，暖气。舌质淡红少苔，脉弦。

处方：陈皮10克，白芍30克，白术10克，防风10克，广木香10克。水煎服，每日一剂。

腹泻患者的注意事项：

1. 慢性腹泻患者宜坚持作抬腿健身活动。这是因为，活

动下肢可以增强胃肠功能，帮助消化。抬腿可以健脾胃止腹泻。具体方法如下：

(1) 直立，两手自然下垂，或交叉于背后，年老体弱者，可用拐杖等物作为辅助支撑物。先调匀呼吸，再做动作。

(2) 吸气时，右腿屈膝上提，小腿下垂，大腿抬平，与躯干成 90° ，如金鸡独立状，然后呼气，缓缓将腿放下，但腿不要着地。随着吸气再抬腿。如此反复做15次至30次。换左腿，动作与右腿相同。每日进行2~3次，应循序渐进，逐渐增加次数，坚持不懈。

2. 慢性腹泻患者应重视饮食调理。多喝淡盐开水、菜汤、热茶水、淡果汁、浓米汤等。还宜常吃生苹果泥或煮熟的苹果，因为苹果中富含鞣酸，有收敛止泻作用。

饮食不节引起的腹泻，宜吃山楂粥。大米50克，山楂20克，生姜3片，共煮成粥，可连服3~5天。

脾胃虚弱引起的慢性腹泻，宜常吃红枣山药粥。大米30克，山药30克，苡仁30克，红枣10克，生姜3片，红糖或白糖适量，共煮成粥，一天分2~3次吃完，连服半个月。

因受寒湿而引起的腹泻，宜吃花椒糯米粥。糯米30克，花椒适量，干姜6克，共煮成粥，一天内分2~3次服完，连服1~2周。

因年老体弱、肾虚而引起的久泻，宜常吃骨碎补煮猪腰。骨碎补15克，洗净，先熬成浓缩的药汁，去骨碎补。然后将去掉白筋膜的猪腰切薄片，放入煮开的药汁中略煮（可放盐），即可喝汤吃猪腰。

3. 婴幼儿腹泻脱水可饮米汤。有的腹泻脱水的婴幼儿。一般补液无效时，喂米汤每每奏效。熬米汤既方便又卫生。用米汤治腹泻脱水好处很多。

4. 婴幼儿腹泻可常吃胡萝卜汤。胡萝卜是一种碱性食物，富含果胶。果胶可使大便成形。并吸附肠道内的细菌和毒素。给腹泻的婴幼儿吃胡萝卜汤，能减轻患儿的胃肠道负担，帮助患儿及早恢复消化功能，并利用胡萝卜中的果胶起到止泻的功效。

胡萝卜汤的制作方法：将胡萝卜切开，剔除中心白茎，再切成丝，放锅内加水煮烂，用纱布挤压过滤，去掉纤维等残渣，然后将胡萝卜泥状物加米汤（按一斤胡萝卜加二斤米汤的比例），放糖再煮沸，即成胡萝卜汤，装入奶瓶即可食用。

食用方法：轻度腹泻，可在两餐之间喂胡萝卜汤，每天3~4次，每次100~150毫升（按年龄不同适当增减）。中度腹泻，胡萝卜汤与奶（人奶或牛奶）交叉食用，即隔顿喂用胡萝卜汤。重度腹泻，在结合药物治疗的同时，给孩子喂胡萝卜汤。病儿应在1~2日内停止食用其他食物，全部用胡萝卜汤代替。

5. 腹泻患者忌吃油腻食物（包括肥肉、油炸食物等）。忌吃牛奶、羊奶和大量的蔗糖。因为这些食物进入肠道后容易发酵，产生大量气体，引起腹胀腹痛。增加患者痛苦。

6. 腹泻患者在没有搞清楚病因时忌盲目使用止泻药。腹泻是一个症状。首先应搞清楚发生腹泻的原因，再找医生根据不同的病因给以治疗，不宜简单地一律使用止泻药。如食物中毒时发生的腹泻，对人体反而有一定的保护作用，通过腹泻可以把细菌毒素和毒物排出体外。

7. 腹泻患者忌滥用氯霉素。氯霉素治疗痢疾（具有腹泻症状）有效，如果是消化不良引起的腹泻，滥用氯霉素则是危险的。氯霉素治疗菌痢及肠伤寒有特效，但是，氯霉素在杀灭细菌的同时，会对人体造成危害，千万不可滥用。

13. 便秘

便秘是由于大肠运动缓慢，水分吸收过多，干而硬的粪块堆积在大肠，不容易排出。便秘的特征是排便次数减少，粪便量少，排出困难。在正常情况下，食物经过胃肠道的消化吸收，而最后排出糟粕(粪便)约需20~40小时，如隔48小时无粪便排出，一般可视为便秘。但也有习惯于2~3天排便一次，而无便秘症状，不能视为便秘。反之，有时因排便困难，以致一日排便数次，但每次量少，部分粪便仍留滞肠内者，仍应视为便秘。

便秘的原因很多，如膈肌、腹肌、提肛门肌、肠平滑肌衰弱造成的排便动力缺乏，肠道反射能力减弱，神经精神紊乱，部分性肠梗阻，直肠肛门疾患，溃疡病，腹腔肿瘤，子宫肌瘤，卵巢囊肿，慢性铅中毒，某些药物的副作用等均可引起便秘。但是便秘最常见的原因是由于不规则的排便习惯。如果每当有便意的时候，经常抑制排便，可以使直肠感受充胀刺激的敏感性逐渐减低，从而使粪便在直肠内停留较久，因其中的水分被肠壁吸收而干涸。这种情况在医学上叫做习惯性便秘。

如果没有器质性病变，只是单纯的便秘，一般对身体健康的影响还不是太大，只是感觉腹痛，下腹膨胀或引起痔疮。慢性便秘特别是习惯用泻药或灌肠的患者，往往影响肠功能，可出现肠道性自体中毒。

为了避免慢性便秘病人发生自体中毒，首先要探求便秘的原因，并针对病因来解决便秘，改变经常用泻药或灌肠代

替生理性排便的不良习惯，养成定时排便习惯，多吃蔬菜等含纤维素较多的食物，多喝水，这样可以防止便秘。如果全身衰弱或腹肌衰弱，应加强劳动锻炼及体育锻炼，锻炼提肛肌的张力，这样也可以防止便秘。有的病人，因有便秘而自服泻药，虽可一时通便，但基本病因未得解除，反而因服泻药使肠功能减弱而加重便秘，这也应该加以注意。

现谈谈便秘的中药治疗(由其他疾病引起的便秘，应针对病因来治疗)。

中医把便秘分为“燥热内结”、“气滞不行”、“血虚肠燥”、“气虚不运”、“阴寒凝结”五个类型。

(一)属于“燥热内结”：腹部胀痛，口臭或口唇生疮，面赤身热，小便短赤，口渴，舌苔黄燥，脉滑实。

处方：火麻仁10克，杏仁10克，白芍12克，枳实10克，厚朴10克，生地15克，玄参12克，麦冬10克，生大黄10克。水煎服。

(二)属于“气滞不行”：大便滞涩不畅或干结，胸膈不适，暖气，食纳减少，苔薄脉弦。

处方：木香10克，槟榔10克，乌药10克，枳实10克，大黄10克。水煎服。

(三)属于“血虚肠燥”：大便结燥难下，面色萎黄，时觉头晕，心悸，舌质淡，脉细涩。

处方：桃仁10克，杏仁10克，柏子仁10克，松子仁10克，郁李仁10克，首乌30克，当归10克。水煎服。

(四)属于“气虚不运”：面色苍白，疲倦，虽有便意，但用力排便仍排不出，用力则汗出，气短，或肛门坠胀，排便困难，舌淡脉虚。

处方：黄芪30克，陈皮10克，火麻仁10克，白蜜20毫升

(兑服)。

(五)属于“阴寒凝结”：大便艰涩，面色青白，腹胀或腹痛，小便清长，四肢不温，喜热怕冷，舌质淡，舌苔白薄，脉沉迟。

方一：肉桂6克，附子15克(先熬)，党参20克，白术30克，干姜10克，厚朴10克，当归10克，水煎服。

方二：附片15克(先熬)，大黄12克，细辛6克。水煎服。本方对顽固的阴寒凝结(阳虚)便秘，有良好疗效。

治疗单纯性便秘的单方验方：

1.更衣丸(成药)，每日服3克，开水吞服。

2.番泻叶3~6克，开水泡服，每日服一次。作用缓和，剂量可根据大便情况加减。

3.蜂蜜30克，麻油15毫升，开水冲服。

4.首乌30克，泡开水服。

5.莱菔子10~15克，研末，糖开水调服。

6.鲜甘薯叶1斤，花生油15克，将甘薯叶炒熟当菜吃，可加盐适量。忌食辣椒等刺激性食物。一般便秘每日服1次，习惯性便秘每天服2次。

7.针灸：取支沟、天枢为主穴，阳陵泉、气海为配穴，每日针一次。

14. 胆道蛔虫病

胆道蛔虫病是一种常见病，以儿童、青少年为多见。

蛔虫是人体肠道内最常见的寄生虫，它不但消耗一些营养物，而且还在肠内不断窜动，具有钻孔的习性，如在发烧、

饥饿或肠道功能紊乱等情况下，可上窜到十二指肠，可能钻入胆道，造成胆道蛔虫病。蛔虫将肠内细菌带入胆道，还可引起胆道感染。大量的蛔虫卵和死去的蛔虫又是常见的胆石核心，所以胆道蛔虫又是引起胆石症的常见原因之一。

胆道的下口乳头壶腹部若被蛔虫钻入，立即引起括约肌痉挛收缩，发生剧烈的上腹痛，痛的性质是一阵一阵的，称为胆绞痛。

胆道蛔虫病的症状：突然发生上腹部绞痛，偏于右侧，绞痛剧烈，如物钻顶心口，痛时捧腹屈膝，满床打滚，手足发冷，或满头大汗，痛苦不安，有的恶心呕吐，有的恶寒发热。

体征：发作时剑突右下方可有轻度压痛和反跳痛，待发作过后则体征减轻甚至消失。故腹痛很剧烈，体征较轻微，是诊断胆道蛔虫病的主要特征。

发作时还可有吐蛔虫的现象。

胆道蛔虫病与祖国医学的“蛔厥”相似，中医认为多因饮食不节，或驱蛔不当等原因而诱发，即所谓“藏寒，蚘（蛔）上入膈”。蛔虫钻入胆道，引起痉挛性绞痛，若阻塞胆管可出现黄疸。治宜安蛔止痛。

方一：乌梅30克，胡黄连10克，黄柏10克，川椒10克，细辛6克，苦楝皮10克，延胡索10克，白芍12克，使君子15克，槟榔15克。水煎服。

方二：茵陈60克，生大黄30克，木香15克，枳实10克，水煎服。此方剂量大，效果好。若将此方剂量减小，通下力小，则剧痛缓解较慢，因此，最好保持此方的剂量，便通则腹痛减。

若胆道蛔虫病继发感染，除上述症状外，伴有发烧，严

重时可出现黄疸，白血球增高。治宜清热利胆驱蛔。

处方：茵陈30克，黄芩10克，银花30克，柴胡10克，白芍16克，延胡索10克，槟榔10克，苦楝皮10克，板蓝根30克，黄连10克。水煎服。

治疗胆道蛔虫病的单方验方：

①花椒10克，麻油50克。将麻油放入锅内熬至冒烟，放入花椒煎熬，待花椒变黑出味，取出，待油凉温顿服。

②生姜150~200克，生蜂蜜60~100克。生姜去皮洗净捣烂取汁，倒入蜂蜜内搅拌均匀，顿服。小儿酌减。1剂不愈，可每日服2~3剂。

15. 过早搏动

过早搏动，亦称期前收缩、期外收缩或额外收缩。患者可无症状，亦可有心前区突然跳动或心跳似乎暂停的感觉。频发的过早搏动可由于心排血量减少而引起全身乏力、心悸及头晕等症状。原有心脏病如冠心病或心力衰竭的患者，可因过早搏动而引起心绞痛或使心力衰竭加重。

过早搏动可发生于正常人，更常见于心脏神经官能症与器质性心脏病患者。情绪激动、神经紧张、疲劳、消化不良、过度吸烟、饮酒或喝浓茶等可引起发作。

过早搏动属于祖国医学的“结代脉”的范畴。“结脉”系指脉来迟缓而有不规则的间歇，常见于寒凝气滞、症瘕积聚或心血管系统的疾病。“代脉”系指脉来缓弱而有规则的间歇，间歇的时间较长，主脏气衰微，多见于心脏病（如冠心病、风心病）。中医临床上常把“结脉”和“代脉”通称“结代脉”。

结代脉可用下列方剂治疗：

1.炙甘草 12克，大枣30克，阿胶6克，生姜10克，党参10克，生地30克，桂枝10克，麦冬10克，麻仁10克。水煎服。

2.生脉散：人参10克(党参代30克)，麦冬10克，五味子10克。水煎服。

3.苦参30克，红花12克。水煎服。

笔者治疗一例顽固的“结代脉”患者(原有风心病)，用炙甘草汤、生脉散等仅能使结代脉有所减轻，但不能彻底控制其发作。经反复考虑，用滋养强壮的菌灵芝、祛风除湿壮阳的淫羊藿、补血行血的鸡血藤及炙甘草汤等合方化裁，终于取得良效。以后又用这个方剂为十余例频发过早搏动的患者(每分钟出现结代脉十五次)进行治疗，均取得良好效果。兹将这个方剂介绍如下：

处方：菌灵芝30克(先熬二小时)，淫羊藿30克，鸡血藤30克，党参30克，麦冬12克，五味子10克，桂枝10克，生地12克，阿胶10克，红花10克。水煎服。

治疗过早搏动的验方：

①丹参30克，党参30克，紫石英30克，生地30克，麦冬20克，川芎15克，炙甘草10克，连翘10克，桂枝10克。水煎服，每日1剂。

②葛根60克，郁金15克，泽兰15克，全瓜蒌30克，灵磁石30克，珍珠母30克(先煎)，刘寄奴10克，当归10克，炙甘草10克。水煎服，每日1剂。

16. 高血压病

高血压是一种以动脉血压升高为主要表现的疾患，多见于中年及老年。一般40岁以上的成人收缩压应在140毫米汞柱，舒张压应在90毫米汞柱以内。但是，收缩压的标准可随年龄增大而增高(年龄增长10岁，收缩压应增高10毫米汞柱)，而舒张压的正常标准则不随年龄而变异(凡舒张压持续超过90毫米汞柱，不论他的收缩压多少，均应列为高血压)。

高血压有两种，一种是原发性高血压，即高血压病，是一种独立的疾病；另一种是继发性高血压，即症状性高血压。继发性高血压是其他疾病引起的高血压症状，而不是一种独立的疾病。症状性高血压可由内分泌病(如甲状腺机能亢进、肾上腺肿瘤等)、脑内疾病(如脑瘤、脑创伤等)、血管疾病(如主动脉缩窄症等)、肾脏疾病(如肾炎、慢性肾盂肾炎、肾动脉狭窄症)等所引起。

高血压病多因精神刺激，情绪波动，使高级神经机能活动紊乱，皮层下部的血管舒张收缩中枢形成固定兴奋灶，全身小动脉持久痉挛，各器官缺血，尤其是肾脏缺血，引起一系列体液变化，以及小动脉硬化等因素，使血压恒定性增高。

高血压病属于祖国医学的头痛、眩晕等范畴。祖国医学认为高血压与肝肾的阴阳平衡失调或痰湿壅盛有密切关系。“肝为刚脏”，主升主动，如忧郁恼怒，肝阴暗耗，郁结化热，热冲于上，而为风阳上扰；肝肾两脏，相互资生，肾水干乏，不能养肝，而致阴虚阳亢；阴虚过极，可以及阳，而致阴阳俱虚。

高血压病主要表现为血压在140/90毫米汞柱以上，同时伴有眩晕、头痛、耳鸣、心慌、手指发麻、面红、烦躁、失眠等症状。

中医治疗高血压病，一般可分以下三型：

(一)风阳上扰：头痛眩晕，面赤目红，烦躁多怒，口苦咽干，小便黄少，舌质红，脉弦数有力。治宜清泻肝热。

处方：龙胆草12克，栀子10克，草决明30克，白芍30克，生地20克，泽泻20克，白术20克。水煎服。

(二)阴虚阳亢：眩晕耳鸣，失眠多梦，烦躁易怒，腰膝酸软，遗精，舌质暗红，脉弦细。治宜育阴潜阳。

处方：生牡蛎30克，怀牛膝15克，桑椹30克，白芍30克，玄参15克，珍珠母30克，丹参30克，麦冬20克，天麻10克，钩藤20克(后下)。水煎服。

(三)阴阳俱虚：头痛眩晕，目糊耳鸣，口干，失眠，自汗，肢冷，腰腿酸软，夜间多尿，舌暗红，脉弦细。治宜滋肾阴，补肾阳。

处方：附片15克(先熬)，熟地30克，泽泻20克，山萸肉12克，丹皮10克，山药20克，黄芩15克。水煎服。

单方验方：

①杞菊地黄丸，每次服10克，每日服2次。

②罗布麻叶30克，煎水代茶饮(一日量)。

③菊花30克(一日量)，煎水代茶饮。

④龙胆泻肝片，每次服10克，日服二次。

⑤丹参片，每次服10克，日服二次。

⑥向日葵盘(去籽)，水煮成膏，制成蜜丸，每丸重10克，每次服2丸，每日服3次。

⑦杜仲皮15克，水煎服。

⑧芹菜汁、蜂蜜各等量。上药混合，口服，每次服40毫升，每日服3次。

⑨海蜇124克，荸荠372克。将海蜇洗漂，荸荠洗净不去皮，用水1000毫升，煎煮至250毫升左右，空腹顿服或分2次服。

⑩桑叶15克，菊花15克，地龙15克，钩藤45克，草决明30克，川牛膝30克，桑寄生30克。水煎服。

高血压患者的注意事项：

1.宜练太极拳。科学研究表明，长期进行太极拳锻炼，对高血压病有显著的改善作用。

太极拳是在气功的基础上，结合不同流派的拳术演化而来的。它巧妙地融合了气功与拳术的长处，动静结合，刚柔相济，是我国独特的养生方法之一，尤其适合中老年人特别是高血压病患者锻炼。

高血压患者不宜进行大运动量锻炼或剧烈运动，因为剧烈运动会使血压骤然增高，不利于高血压的治疗，而练太极拳对高血压病患者却是非常适宜的。太极拳的具体锻炼方法请参考有关专门书籍。

2.应常作“气健运动”。什么叫“气健运动”？就是指一些促进人类机体使用氧气的运动，包括各级轻量的健身运动，如慢跑、踩“静止脚踏车”，原地跑步等。轻度高血压患者，如能有规律的持之以恒地从事气健运动，偏高的血压就会下降而恢复正常（注：高血压病情严重者则不宜作气健运动）。

3.高血压患者宜制怒。人在愤怒时，舒张压明显升高，多次反复，正常人也会导致高血压，如果原来就有高血压，则会使病情加重。因此，高血压患者宜制怒。制怒的方法有以下几种：

①转移：怒气上涌时，有意识地转移话题或做点别的事

情或离开现场，以分散注意力，使愤怒的情绪得到缓解。有的人生气时拼命地干活或拼命地写作，也是一种转移、发泄的方法。

②释放：心中有不平事，要让它吐露出来，要开诚布公地说出来，采取合理的宣泄方法。与人闹矛盾后和对方交换意见，找老朋友吐露一番，这些都是释放、宣泄的较好方法，不得已时，即使大哭一场，心中郁结也可以得到及时的宣泄，比闷在心中痛快得多。

③升华：将怒气转变成具有社会文化价值的行动，以此来消除紧张情绪，叫做升华。

④克制：即用理智驾驭愤怒这匹“野马”。从生理角度讲，理智可降低外界刺激在大脑中引起的兴奋程度，但这需要有意识的锻炼，亦即加强修养才能做到。

⑤遗忘：高血压患者对某些使自己愤怒的事情，尽量不去追想，这样，久而久之便可淡漠。

⑥躲避：高血压患者在日常生活中遇到可能引起愤怒的刺激，最好迅速避开，以防止发怒。

⑦宽心：高血压患者在日常待人处事要宽宏豁达，不计较小事，不苛求于人。在家庭生活中，争取有一个比较稳定而和谐的气氛，以创造遇事莫愁的主客观条件。

4.高血压患者宜常在雨中散步。雨中散步，有许多晴天所无可比拟的健身作用。濛濛细雨降落大地，可洗涤尘埃污物，净化空气，使路面更清静，空气更清新。降雨时所产生的大量负离子，享有“空气维生素”的美誉，有利于雨中散步者安神逸志，降低血压。

5.高血压患者应坚持吃低盐、高蛋白饮食。动物实验证明，低盐高蛋白饮食能防治高血压所致的脑溢血。

6.高血压患者应常吃含钙食物。高血压与缺钙的关系比较密切。用钙治疗高血压有较好效果。如果饮食中每日增加1000毫克钙，则高血压的发病率可以降低。含钙丰富的食物有：黄豆及豆制品、牛奶、鱼、虾、红枣、柿子、韭菜、芹菜、蒜苗等。

7.高血压患者宜常吃食用菌。食用菌包括平菇、蘑菇、香菇、草菇、黑木耳、白木耳等。这些食用菌对防治高血压有一定疗效。

8.高血压患者应常吃矿泉水、冰化水。矿泉水的治病作用历来为人们所重视，因其含多种无机盐和微量元素。冰化水对高血压也有一定的疗效。冰化水很容易制得：把凉开水放到冰箱里冻成冰，再拿出来溶化就可以了。在凉开水里事先加入适量的鲜果汁放入冰箱冻成冰，再溶化成冰化水，治疗高血压的效果就更好。

9.高血压患者应常吃富含维生素C的蔬菜和水果，特别是苹果。苹果不仅含有丰富的维生素C、苹果酸等营养物质，能使人体迅速吸收，促进新陈代谢，消除疲劳，更重要的是，苹果内富含钾元素，钾能促进体内的钠盐排出，有利于降低血压。

10.高血压患者应戒烟酒，睡眠要充足，还要保持大便通畅。

11.高血压患者忌看惊险、凶杀的电视或电影，以免情绪波动，使高级神经机能活动紊乱，导致血压升高。

12.高血压患者忌长期、大量吃含胆固醇高的食物（如羊脑、猪脑、鱼肝油、鳝鱼、动物内脏、肥猪肉、蛋黄、香肠、全脂奶粉等）。因为长期摄入高胆固醇食物，可引起血脂升高，血脂升高则导致动脉弹性减低，引起舒张压升高。

13. 高血压患者忌受寒。受寒能使人体的交感神经兴奋性增高，心跳加快，血管收缩紧张，血压升高。高血压患者发生脑溢血也与受寒密切相关。

14. 高血压患者忌服消炎痛(抗风湿药)。因为人体的前列腺素具有舒张周围血管及冠状动脉的作用，而消炎痛能抑制前列腺素的合成，使体内的前列腺素低于正常水平，因而使血管发生痉挛收缩，外周阻力增高，血压也会随之上升。前列腺素中有一种物质能增加肾血流量，促使体内水钠排出。因消炎痛不仅能抑制前列腺素的合成，又能降低肾血流量及水钠的排泄，也可引起血压升高。所以，高血压患者忌服消炎痛。

17. 低 血 压

低血压，是指血压经常在90/60毫米汞柱以下，同时有头晕、乏力、眼发黑等自觉症状。

在医学上，低血压可分急性低血压与慢性低血压两种。急性低血压是指血压由正常或较高的水平突然明显下降，多见于晕厥和休克。慢性低血压多见于慢性肾上腺皮质功能减退症、垂体前叶功能减退症、慢性消耗性疾病及营养不良、心血管疾病。平原居民进入海拔3500公尺以上高原地区，也可出现血压偏低。

血压是循环着的血液在血管内流动时对血管壁所产生的一种压力，它主要来源于心脏收缩等动力。

血液凭借着一定高度的血压，在血管中流动，从而保证血液和全身组织间通过毛细血管进行的氧和营养物质的交换

过程。同时，还从全身各组织回收代谢产物及二氧化碳等废物。理解血液循环，就好象自来水系统对各地建筑物供水那样，没有一定的压力，供水就得不到保证。

血压的重要性在于保持血液流动，血压不足，血液无力循环，在极其广阔的毛细血管处也不能进行有效的物质交换。因此，对低血压不应忽视，而应该积极加以治疗。

用中药治疗低血压，没有副作用，方法简便，效果也比较满意。

方一：肉桂、桂枝、甘草各10克，每日一剂，泡开水代茶饮。

方二：茯苓15克，五味子、甘草各12克，每日一剂，水煎服，或泡开水代茶饮。

方三：陈皮、枳实、五味子各12克，水煎服，每日一剂。

方四：菌灵芝(先熬二小时)15克，黄芪15克，干姜10克，水煎服，每日一剂(黄芪用量大则降血压)。

方五：党参15克，黄精12克，肉桂10克，大枣10枚，甘草10克。水煎服，每日一剂。

低血压患者的注意事项：

1.宜重视饮食调理。常吃生姜对治疗低血压有好处。健康人口嚼生姜一克(不咽下)，可使收缩压平均升高11.2毫米汞柱，舒张压升高14毫米汞柱。

吃生姜的方式可多种多样，例如在菜汤、豆腐汤、肉汤、鸡汤中多放些姜末，平时用姜末泡开水当茶饮等等。

低血压患者还宜采用以下食疗方：

①桂圆肉3~9克，每日服之有效。

②红枣，每次吃7~15枚，每日2次。

③核桃，每次吃5枚，每日3次，久服有效。

④人参酒(白参50克泡入500毫升白酒中), 适量饮用。
参茸酒也可饮用。

⑤红枣20枚, 党参15克, 煮汤, 喝汤食枣。

⑥五味子酒(五味子50克泡入500毫升白酒中), 适量饮用。

⑦铁强化酱油: 由大豆制的酱油再加入硫酸亚铁、维生素C配制而成。低血压由缺铁性贫血引起者服之有效。每日于菜肴中加入15~20毫升即可。

2. 低血压患者应注意休息。笔者在临床实践中发现, 低血压患者每当休息不好(过于劳累、睡眠不足)时, 其血压更低。因此, 低血压患者宜劳逸结合, 保证充足的睡眠, 注意休息。

3. 低血压患者应增加营养。具有低血压倾向的人, 当其营养欠佳时, 血压更为低下, 一旦补充了营养, 测量其血压, 有时可上升至接近正常的水平, 且无头昏、乏力、眼黑等伴随症状出现。

4. 低血压患者应积极治疗原发疾病如风湿性心脏病、慢性肾上腺皮质功能减退症、垂体前叶功能减退症以及其他慢性消耗性疾病等。因为低血压常是以上这些疾病的症状。积极治疗原发疾病, 对改善低血压症状, 大有好处。

5. 低血压患者忌吃降压食物如芹菜、冬瓜、赤小豆、山楂等。

前面已经讲过, 晕厥和休克, 血压可急骤下降, 应争分夺秒进行抢救。这里介绍的方剂, 对晕厥和休克均不适用。

18. 冠状动脉粥样硬化性心脏病

冠状动脉粥样硬化性心脏病，简称“冠心病”，系指冠状动脉病变而引起心肌缺血、缺氧的一种心脏病。动脉粥样硬化的病因与发病原理，至今尚未完全阐明，一般认为主要与脂质代谢紊乱和动脉壁的机能障碍有关。由于脂质代谢紊乱，引起血液内胆固醇、脂蛋白等脂质过多在动脉内膜中沉积，形成斑块，使动脉壁失去弹性而变硬，以后在其深部发生崩溃，软化形成粥样物，冠脉管腔狭窄甚至闭塞。

由于冠状血管阻塞发展缓慢，建立了充分的侧支循环，所以一般不会对身体发生不良影响，但在冠状动脉痉挛、急性阻塞、侧支循环尚未能充分建立的情况下，则可引起心绞痛、心肌梗塞、心肌纤维化等后果。

冠心病，属于祖国医学的“真心痛”、“胸痹”、“厥心痛”等范畴。以胸骨后、心前区出现发作性或持续性疼痛或憋闷，疼痛常放射至颈、臂或上腹部为特征。祖国医学认为，本病多因思虑过度，劳伤心脾；饮食不节，痰饮内生；情志不畅，肝郁阴伤等引起，而以年高肾气日虚者为多见。心阳不振、痰瘀阻络为其主要矛盾。

中医治疗本病一般分为以下四型：

(一)心阳不振：胸闷憋气，阵发性心痛，心悸，失眠，气短，自汗，面色苍白，畏寒肢冷，小便清长，舌淡胖嫩，苔白润，脉沉缓或结代。治宜温心阳，通脉络。

处方：瓜蒌30克，薤白20克，桂枝10克，枳实10克，丹参30克，党参30克，甘草10克，水煎服。

(二)痰瘀阻络：心胸绞痛时作，痛引肩背，胸闷气短，舌质暗，舌边舌尖有瘀点，脉沉涩或结代。治宜活血化瘀，涤痰通络。

处方：川芎10克，生地12克，当归12克，赤芍12克，桃仁12克，红花12克，枳壳10克，桔梗10克，柴胡10克，川牛膝15克，甘草10克，水煎服。

(三)阴虚阳亢：胸部憋闷疼痛，头晕痛，心烦易怒，口干目眩，舌红少苔，脉细数。治宜平肝潜阳，活络通脉。

处方：天麻10克，钩藤30克，石决明30克，寄生30克，当归12克，生地12克，桃仁10克，红花10克，丹参30克。水煎服。

(四)气阴两虚：胸闷心痛，有时夜间憋醒，心悸气短，腰腿酸软。食少眠差，舌紫暗，苔白少津，脉细弱或结代。治宜益气养阴，生血活血。

处方：党参30克，麦冬20克，五味子15克，丹参30克，当归12克，黄芪30克，三七粉6克，阿胶12克，延胡索6克。水煎服。

单方验方：

①三七粉3克，肉桂粉1.5克，当归30克。当归煎汤冲服三七粉、肉桂粉，一日分三次服。

②苏合冠心病片(成药)，照说明服。

③复方丹参片(成药)，照说明服。

④葛根30克，红花15克，郁金10克，桃仁10克，水煎服。

⑤首乌30克，黄芪30克，当归12克，丹参30克，乳香10克，没药10克。水煎服。

⑥毛冬青片(成药)，照说明服。

⑦灵芝酊或灵芝糖浆，每次服5毫升，一日三次。

冠心病患者的注意事项：

1.生活应有规律。不应熬夜，工作时间不宜过长，也不宜长时间看电视。心情要开朗，避免情绪激动，避免疾走或快速奔跑。应定期作心电图检查、血液检查及其他有关的体格检查，发现问题，及时治疗。

2.坚持慢跑。这是治疗冠心病的最佳措施。但要循序渐进、量力而行、持之以恒。坚持慢跑是最好的“强心剂”。锻炼有素的人，心脏有力，每次搏动，可以打出足够的血液至全身，充分满足人体需要。

3.要戒烟。吸烟易促使冠心病和急性心肌梗塞的发作。香烟中的尼古丁和一氧化碳对管状动脉的血管壁和心肌细胞具有毒性和致炎症的作用，同时使血小板易于聚集成血栓，堵塞小动脉。一氧化碳使动脉壁缺氧，促进动脉壁合成脂肪酸，使血清胆固醇含量升高，加速动脉粥样硬化的形成。

4.宜多吃水溶性纤维素食品如柠檬、大麦、燕麦、大豆、豌豆和大豆制品，因为这些食品能降低胆固醇。水溶性纤维素能促进胆酸(合成胆固醇的重要成份之一)从粪便中排出。另一方面，水溶性纤维素在结肠中几乎全部发酵，发酵后形成的物质吸收入血后，可抑制胆固醇的合成，同时还会促进低密度脂蛋白(形成冠心病的危险因素)的清除。

5.应适当吃些含铜食物如牡蛎、坚果(包括核桃等)和果仁等。为什么缺铜会引起冠心病呢？这是由于保持心脏和血管正常代谢功能需要一些酶，而铜正是这些生物酶不可缺少的物质。当铜的摄入量减少时，酶的功能受到影响，导致心血管代谢的异常，从而产生冠心病的一系列症状。

动物实验也证明，如果在动物饲料中减少铜的含量，可使动物产生冠心病的一些症状，增加冠心病发作的危险性。

6.宜少量饮酒(品酒)。少量饮酒(品酒)对人体心脏有益,可以降低冠心病的发病率。为什么少量饮酒(品酒)有利于心脏保健?这是由于少量饮酒可以升高体内高密度脂蛋白,同时降低低密度脂蛋白。人体血液高密度脂蛋白能降低血管壁上胆固醇的积聚,能预防冠心病;而低密度脂蛋白却能促进胆固醇沉积,增加冠心病的发病率。

当然,大量饮酒对冠心病患者是十分危险的,能诱发心肌梗塞而导致死亡。

少量饮酒也不是防治冠心病的唯一措施,还要配合其他措施如长跑运动等等。

7.冠心病患者进餐不能吃得过饱,以免影响消化,增加心脏负担。过多的食物进入胃肠道,全身血液势必较多地集中在胃肠道以助消化,这样可使冠状动脉供血不足,对冠心病患者是不利的。

8.冠心病忌多吃香蕉。冠心病病人不能吃得过咸,这是大家都理解的。为什么冠心病病人忌多吃香蕉呢?这是因为,香蕉中含有较多的钠盐,冠心病病人如果大量吃香蕉,就等于大量吃盐一样,会导致水肿,加重心脏的负担。

9.冠心病病人忌睡眠不足,忌忧愁焦虑。

19. 急性肾炎

弥漫性肾小球性肾炎,简称肾炎,是临床上常见的疾病。这种病变开始主要在肾小球,而且是弥漫性的,许多肾小球都被侵犯到,因此叫它弥漫性肾小球性肾炎。根据病程的不同,临床上分为急性肾炎和慢性肾炎两种类型。急性肾炎

70%左右发生在20岁以下的青少年，当然老年人也可以得急性肾炎，但较为少见。慢性肾炎大多见于成年人，但儿童也可以得慢性肾炎。

肾炎是怎样发生的？

肾炎的发病与链球菌感染有关。大多数急性肾炎患者在发病前有过急性溶血性链球菌感染的病史，如急性咽炎、扁桃体炎、猩红热、副鼻窦炎、中耳炎、脓疱疮等。但肾炎的发病和其他炎症不同，它不是由链球菌直接侵犯肾脏而引起发炎，而是人体由于链球菌及其产物的作用而引起的一种不正常的免疫反应的表现。

急性肾炎如果经过适当的休息和治疗，免疫反应不再进行下去，就可逐渐治愈。假如治疗不恰当、不彻底，或者患者体质高度过敏，免疫反应反复循环，长期不愈，就发展成为慢性肾炎了。

急性肾炎属于中医的“水肿”病范畴。祖国医学认为本病病因不离于“湿”，由于外感风邪水湿或疮毒入内，使肺气不宣，脾气失运，肾失蒸化，影响水液的“通调”、“转输”和“气化”功能，而致水液排泄障碍，潴留肌表形成水肿。急性肾炎多由外邪诱发，致使三焦阻滞，其病变部位，偏在于肺卫。

急性肾炎有哪些症状？

急性肾炎病人往往先有上呼吸道感染，如咽喉痛、扁桃体炎、感冒等。在1~3周之后，上呼吸道感染常已痊愈，而突然出现血尿，小便量少而色深，有的象红茶，有的象葡萄酒，也偶有鲜红色。一般的人发现这种现象都会到医院去看病，但也有少数人忽略了，直到变成慢性肾炎才发现。

急性肾炎病人还有一种典型的症状是突然出现眼皮浮肿，或头面部浮肿，到午后或傍晚面部浮肿可逐渐消退，而

下肢却浮肿了。病情较重的往往全身浮肿，甚至有胸水和腹水，因此感到气急、腹胀。约有三分之一病人血压升高，可有头痛等症状。如果化验一下小便，常可发现很多变化。如果把尿加热、加酸之后，就会出现云雾样的混浊，这就是蛋白质的沉淀，称为蛋白尿。另外把小使用离心机旋转后，把尿的沉淀拿到显微镜下检查，可以发现有很多红细胞、白细胞和管型。

大多数急性肾炎病人的症状比较轻微，一般经过几天到几个星期，浮肿逐渐消退，进入恢复阶段，大多数病人可完全恢复而痊愈。有少数病人症状较重，可以发生一些并发症，如并发心力衰竭、高血压脑病、尿毒症等。

急性肾炎的中药治疗：

急性肾炎如果没有严重的并发症，可用清热、解毒、利尿的中草药治疗：

处方：银花15克，连翘15克，白茅根30克，蒲公英30克，野菊花20克，紫花地丁20克，生地12克，木通6克，车前草30克，小蓟12克，水煎服。每日一剂。

急性肾炎一般经过2—4个星期的治疗，血压下降，浮肿逐渐消退，最后小便恢复正常，但有些人小便中的少量蛋白和红细胞可持续存在2~3个月或更长时间，一般不超过半年。

治疗急性肾炎的验方：

冬瓜皮30克，蝉蜕6克，玉米须30克，赤小豆20克，浮萍10克，银花30克，连翘30克，益母草30克。水煎服。

20. 慢性肾炎

慢性肾炎多由急性肾炎转变而来，也有因内伤而发，其

病变部位，偏在于脾肾。若脾气亏虚，后天失养，气血因而亦亏；肾气失固，精气外泄，肾阴更虚，损及肝阴，肝阴不足，肝阳上亢，或阴阳两虚，虚阳上越。若清阳不升，浊阴不降，冲上犯胃，蒙蔽清窍，则可出现尿毒症昏迷的危候。急性肾炎经过治疗，半年后小便中的蛋白质、红细胞、管型等仍存在，那多数已转变成慢性肾炎了。”

根据慢性肾炎在发病时的不同表现，可分成以下各种类型：

（一）无症状型或称隐匿型肾炎：

这种类型的病人，可毫无症状，或仅仅感到稍有乏力、腿酸，在疲劳或感冒后发生轻度浮肿。病人自己也不知道是否得过急性肾炎，仅在检查小便时才被发现，发现时已经是慢性肾炎了。这种类型的病人经常有蛋白尿或有反复性血尿。

隐匿型肾炎可维持很久，甚至10~25年以上。有一部分病人可在急性咽炎或其他感染后诱发类似急性肾炎的症状，很容易误认为是急性肾炎，但实际上是慢性肾炎的急性发作。经过适当治疗后，又可转入无症状期，也可转化成为慢性肾炎的其他类型。

这类病人无自觉症状，若尿常规变化轻微，不须特殊治疗，但每年应到医院去检查几次，注意水肿、血压、心脏、尿常规及肾功能，如有新的症状出现，须及早治疗。

部分病人尿中红细胞持续存在，可用生地20克、木通6克、竹叶10克、白茅根30克、小蓟10克，水煎服，每日一剂。

部分病人蛋白尿迁延不愈，可参考中药治疗蛋白尿（本书第65页）的办法进行治疗。

（二）水肿型肾炎：

这类慢性肾炎是最常见的，病人显著浮肿，开始时只是下肢肿和早晨眼皮肿，以后全身出现水肿。下肢和会阴部的皮肤可因水肿变成透光发亮，最严重时可出现水泡，水泡破裂就流水。这类病人的水肿，用手指一压，可压出一个凹陷来。胸腹常有大量水分积聚。这类病人的小便中排出大量蛋白和管型。

水肿反复发作，抵抗力降低，容易发生各种感染，而感染又往往使浮肿加剧。这类病人经过治疗，一部分可痊愈，有一部分病人对药物不敏感(药物对这部分病人起不了好大作用)，最后肾功能日益减退，出现高血压、尿毒症。这时治疗就比较困难了。

水肿型肾炎病人，常有怕冷，舌质淡，脉沉等表现，因此可用温肾利水的中药治疗。

处方：制附片10—30克(先熬二小时)，仙茅15克，仙灵脾15克，车前仁10—20克，连皮茯苓15克，泽泻10克，怀牛膝15克，菟丝子10克。水煎服。每日一剂。

水肿型肾炎病人，长期浮肿不退，且有腰痛，尿中蛋白和红血球长久不消失，可用补气利水、活血化瘀法治疗：

处方：黄芪30克，当归15克，赤芍15克，枸杞15克，怀牛膝15克，桃仁10克，红花10克，车前子15克，益母草30克，丹参30克，白茅根30克。水煎服，每日一剂(急性发作合并上呼吸道感染、皮肤感染者，本方加银花30克，紫花地丁30克，板蓝根30克)。

(三)高血压型肾炎：

这类病人主要表现是高血压和心脏病变，水肿不明显。血压常在200/100毫米汞柱左右，病人常有头痛、头昏、视物模糊等自觉症状，病人心脏扩大，心跳气急，呼吸困难。

这类病人最后也可发展成为尿毒症。

由于慢性肾炎高血压的病人，其肾血流量已经有所降低，所以用药最好选择既能降血压又能增加肾血流量的药物，而且不要一下子把血压降得过低，不能操之过急（过快地降低血压会使肾血流量骤减）。

处方：益母草30克，赤芍10克，丹皮10克，泽泻10克，寄生30克，怀牛膝10克，黄芪30克，丹参30克。水煎服。每日一剂或两天服完一剂。

（四）尿毒症：

慢性肾炎如果得不到适当的治疗，肾功能越来越坏，最后发展成为尿毒症（慢性肾功能衰竭）。

身体内代谢所产生的废物不能自尿中排出体外，使血液内废物大量积留而产生全身中毒情况，这种在肾功能衰竭基础上出现的综合病症，称为尿毒症。

引起尿毒症的疾病很多，如慢性肾炎、慢性肾盂肾炎、肾结核、肾血管硬化、多囊肾、系统性红斑狼疮等，还有由于严重失水、失血、休克等原因引起的急性肾功能衰竭，演变成慢性肾功能衰竭而导致尿毒症。此外，尿路结石、前列腺肥大、肿瘤等导致泌尿道梗阻，也可以引起尿毒症。在以上这些疾病中，以慢性肾炎引起尿毒症最为多见。

尿毒症可以突然起病，病情很急，来势很凶，也可以缓慢起病，逐渐出现衰竭症状。

尿毒症早期出现疲乏无力，食欲减退，头晕，头痛，恶心，呕吐，小便量或多或少，甚至尿闭。

尿毒症晚期出现的症状多种多样，常见的有：呼吸急促深大，口腔发炎，口中有尿臭味，呕吐，腹泻，皮肤瘙痒（皮肤上出现尿素霜），鼻衄，齿衄，或消化道出血，甚至昏迷

抽搐，亦可出现纤维性心包炎、高血压性心脏病、高血压脑病。血液化验有严重贫血。尿常规检查可有蛋白质、红细胞及管型，尿比重低而且固定在1.010左右。血液生化检查血中非蛋白氮升高，二氧化碳结合力下降。

尿毒症病情危重，应送到医院抢救治疗。

中医治疗尿毒症，分“阳虚而致湿浊中阻”，“阴虚而致风阳痰火上扰”，“阴阳离决而致虚脱”三种类型。

①阳虚而致湿浊中阻：症状有恶心呕吐，食少或得食即吐，胸闷腹胀，畏寒，口中有尿臭味，尿少或尿闭，大便不爽，或大便青绿稀溏，面色灰暗，面浮肢肿，疲乏嗜睡，苔白腻，舌质淡而胖，脉细。

处方：制附片15克(先煎二小时)，大黄10克，红参10克(嚼服)，陈皮10克，法半夏10克，生姜10克，白术10克，茯苓10克。水煎服。

②阴虚而致风阳痰火上扰：头昏胀痛，目眩，手足颤动，抽搐或肢体拘急，心烦不安，或神昏狂躁，恶心呕吐，唇干齿垢，舌苔淡黄，脉细数。

处方：菖蒲10克，郁金10克，炒山栀10克，黄连10克，钩藤15克，龙胆草10克，石决明30克，胆南星6克，水煎服。

神志昏迷者，另用至宝丹一粒化服。

③阴阳离决而致虚脱：面色苍白，目合口开，鼻鼾，手撒，遗尿，汗多，心悸，怔忡，呼吸低微，手足逆冷，舌质淡，脉微细。

处方：制附片15克(先煎二小时)，红参10克，麦冬10克，五味子10克，炙甘草10克，煅龙骨30克，煅牡蛎30克，山茱萸10克，水煎服。

尿毒症时的饮食要限制蛋白质，必要时要完全素食，还

要忌食蚕豆、黄豆及各种豆制品。但应补充葡萄糖，以保证营养需要。

治疗慢性肾炎的验方：

①蜈蚣1条，生鸡蛋1个。蜈蚣去头足，焙干研末，纳入鸡蛋(先敲一个小孔)内搅匀，蒸熟(外用湿纸包裹)，每日吃1个，7天为1疗程，可服数个疗程，两疗程之间相隔3天。

②鲜羊奶。每日服500~800克，分2次服完。

附：蛋 白 尿

正常人尿液中蛋白质含量极微(每日排出量约40~100毫克)，作尿常规检查常不能测出。当有病时尿中蛋白质含量增多，可用常规尿蛋白定性试验方法测出尿中的蛋白，这种尿称为蛋白尿。

医学上的蛋白尿分为功能性蛋白尿、体位性蛋白尿、病理性蛋白尿三种。

功能性蛋白尿见于剧烈体力劳动或运动后，长途行军期间，高温作业或严重受寒，精神紧张等。高烧病人、心力衰竭病人、健康人进食高蛋白饮食后也可出现这种功能性蛋白尿。

体位性蛋白尿的发生与体位改变有密切关系，其特点是：清晨尿无蛋白质，起床活动后渐出现蛋白尿。长时间直立、行走或脊柱前凸姿势(腹部向前突出)时，尿蛋白含量增多，平卧休息一小时后，尿蛋白含量减少或消失。

功能性蛋白尿和体位性蛋白尿，不需要作专门的治疗。

病理性蛋白尿见于急、慢性肾小球肾炎，肾病综合

征，肾盂肾炎，妊娠中毒症，系统性红斑狼疮等疾病。特别是慢性肾炎、肾病综合征的尿蛋白比较顽固，不易消失(持久性蛋白尿)。

慢性肾炎的持久性蛋白尿成了医务人员和病人普遍关心的问题。

中药治疗蛋白尿有较好的疗效，现作一简要介绍。

(一)治疗蛋白尿的中药

治疗蛋白尿的中药基本上可分为补益气血(黄芪、党参、当归)，健脾和中(白术、茯苓、山药)、补益肝肾(山茱萸、枸杞子、怀牛膝、杜仲、补骨脂、菟丝子、女贞子)，益肾固精(芡实、金樱子、桑螵蛸)，滋阴，生津(鳖甲胶、生地、玄参、麦冬)，利尿(石苇、干蟾)，清热解毒(土茯苓)，活血祛瘀(山楂、半枝莲)，止痒(蝉衣)等几类。这些中药除土茯苓、干蟾、蝉衣不宜久服外，其余均可长期服用，无副作用。

黄芪：补气固表，托疮生肌。治体虚自汗，久泻，脱肛，子宫脱垂，慢性肾炎，体虚浮肿，慢性溃疡，疮口久不愈合。用于治疗蛋白尿每日剂量不得少于30克。

党参：益气，补脾，生津。治脾虚，食少便溏，四肢无力，心悸气短，口干，自汗，脱肛，子宫脱垂。用于治疗蛋白尿每日剂量不得少于30克，而且最好与黄芪同用。

当归：补血调经，润燥滑肠。治月经不调，功能性子宫出血，血虚闭经，痛经，慢性盆腔炎，贫血，血虚头痛，脱发等。用于治疗蛋白尿，每日剂量为10~15克。

白术：健脾，燥湿，和中。治脾虚食少，消化不良，水肿，自汗等症。用于治疗蛋白尿，每日用量为10~20克。

茯苓：健脾补中，利水渗湿，宁心安神。治脾虚湿盛，小便不利，食少脘闷，心悸失眠。用于治疗蛋白尿，每日用

量为10~20克。

山药：健脾止泻，补肺益肾。治脾虚久泻，慢性肠炎，肺虚喘咳，慢性肾炎，糖尿病，遗精，遗尿，白带。用于治疗蛋白尿，每日用量为20~30克。

山茱萸：补益肝肾，涩精止汗。治头晕目眩，耳聋，自汗，腰膝酸软，阳痿，遗精，尿频。用于治疗蛋白尿，每日用量为15~20克。

枸杞子：滋补肝肾，益精明目。治肾虚，精血不足，腰脊酸痛，性神经衰弱，头目眩晕，视力减退。用于治疗蛋白尿，每日用量为20~30克。

怀牛膝(酒制)：补肝肾，强筋骨。治肝肾不足，腰膝酸痛，四肢不利，风湿痹痛。用于治疗蛋白尿，每日用量为10~15克。

杜仲：补肝肾，强筋骨，安胎。治高血压，头晕目眩，腰膝酸痛，筋骨痿软，肾虚尿频，妊娠胎漏，胎动不安。用于治疗蛋白尿，每日用量为10~15克。

补骨脂：温肾壮阳。治腰膝酸痛，老年遗尿，尿频，五更泻，性神经衰弱，遗精。用于治疗蛋白尿，每日用量为10~15克。

菟丝子：补养肝肾，益精明目。治腰膝酸软，阳痿遗精，尿频，头晕目眩，视力减退，胎动不安。用于治疗蛋白尿，每日用量为30克。

芡实：益肾涩精，补脾止泻。治脾虚腹泻，遗精滑精，尿频，遗尿，白带。用于治疗蛋白尿，每日用量为20~30克。

女贞子：滋补肝肾，乌发明目。治肝肾阴虚，头晕目眩，头发早白，腰膝酸软。用于治疗蛋白尿，每日用量为30克。

金樱子：补肾固精，治性神经衰弱，高血压，神经性头

痛，慢性肾炎，遗精，遗尿，自汗，盗汗，白带，崩漏。用于治疗蛋白尿，每日用量为20~30克。

桑螵蛸：益肾固精，缩尿止带。治遗精，遗尿，尿频，白带。用于治疗蛋白尿，每日用量为15~20克。

鳖甲胶：滋阴退热，软坚散结。治阴虚潮热，肝脾肿大。用于治疗蛋白尿，每日用量为15~20克。

生地：清热生津，润燥，凉血止血。治阴虚发热，津伤口渴，血热吐血等。用于治疗蛋白尿，每日用量为15~20克。

玄参：滋阴，生津，降火，解毒。治热病烦渴，痈肿，咽喉炎，扁桃炎，淋巴结结核等。用于治疗蛋白尿，每日用量为10~15克。

麦冬：滋阴生津，润肺止咳，清心除烦。治热病伤津，心烦口渴，肺热燥咳，咯血等。用于治疗蛋白尿，每日用量为15~20克。

石苇：利尿排石，清肺泻热，止血。治肾炎水肿，膀胱炎，泌尿系结石，慢性气管炎，哮喘，尿血，咯血等。实验证明，石苇能增强机体抗病能力。用于治疗蛋白尿，每日用量为12~15克。有一慢性肾炎病人，每日服石苇12克(水煎服)，连服一半年，尿蛋白由卅降到完全阴性。

干蟾(蟾蜍皮)：利尿消肿，解毒，止痛。治慢性气管炎，痈疖疔疮，咽喉肿痛，水肿，小便不利。孕妇忌服。用于治疗蛋白尿，用量为6~10克。

土茯苓：清热解毒，利湿。治关节痛，梅毒，痈疖肿毒，湿疹，皮炎等。用于治疗蛋白尿，用量为10~15克。

山楂：散瘀止痛，消食化滞，还有强心、收缩子宫等作用。用于治疗蛋白尿，每日用量为20~30克。

半枝莲：活血祛瘀，消肿止痛，清热解毒，抗癌。用于治疗蛋白尿，每日用量为20~30克。

蝉衣，止痉，疏风散热，透疹，退翳。治感冒发热，咳嗽，失音，咽喉肿痛，角膜云翳，小儿夜啼，惊风，破伤风。用于治疗蛋白尿，用量为15~30克，并配用苏叶10克、益母草30克。

（二）治疗蛋白尿的方剂

这类中药方剂经临床应用，对于消除尿蛋白、缓解慢性肾炎症状，有一定疗效。

①益肾汤：当归、赤芍、川芎、红花、丹参各15克，桃仁10克、益母草、银花、白茅根、板蓝根、紫花地丁各30克。水煎服，每日一剂。

②固肾方：蝉衣15~30克，益母草30克，小蓟30克，首乌15克，杜仲12克，核桃仁30克，补骨脂12克，复盆子12克，细辛6克。水煎服。

③固肾益血方：党参30克，茯苓20克，白术15克，芡实30克，菟丝子10克，泽泻10克，山药30克。水煎服，每日一剂。

④培补脾肾方：黄芪30克，党参30克，生地15克，山茱萸15克，山药30克，萆薢10克，菟丝子10克，补骨脂10克，芡实30克。水煎服，两天服完一剂。

⑤乌龟三只，放水中数天，吐出泥土，和猪肚用文火炖成糊状，不放盐，早晚各服一次。同时服壮腰健肾丸（成药），每次服一丸（约10克），一日二次，服二周为一疗程。

⑥菟丝子30克，山茱萸30克，淫羊藿30克，益智仁15克，金樱子30克，芡实30克，莲米30克，泽泻15克。水煎服。

21. 肾盂肾炎

肾盂肾炎是一种由细菌侵入到肾盂及肾间质而引起发炎的常见疾病，炎症有时只侵犯单侧肾脏，有时双侧肾脏都侵犯，炎症有的是局限的，有的是比较广泛的，炎症主要在肾盂与其邻近的肾间质部分，病变分布是不均匀的。肾盂肾炎与肾炎（弥漫性肾小球肾炎）不同，这两种病在发病原因、症状表现和治疗方面都是截然不同的，切勿混为一谈。

肾盂肾炎任何年龄均可发病，有急性肾盂肾炎及慢性肾盂肾炎之分。急性肾盂肾炎没有得到彻底治疗，常可转为慢性。慢性肾盂肾炎每易反复发作，影响健康。应引起大家重视，积极加以防治。

肾盂肾炎是在人体抵抗力减弱或泌尿系统局部缺陷的情况下发生的，外来细菌或体内其他部分的细菌得以乘虚而入，引起肾盂肾炎。

致病的细菌大都从尿道上升经膀胱输尿管而达肾脏，也可由身体其他部位如皮肤、盆腔、肠道，经血液或淋巴系统到达肾脏，或由肾脏邻近组织发炎而直接波及肾脏而发病。

常见的致病菌有大肠杆菌、链球菌、葡萄球菌等。

泌尿道梗阻如尿路结石、尿路先天畸形、膀胱癌、前列腺肥大等，均易导致排尿不畅，尿流缓慢而致细菌大量繁殖，引起肾盂肾炎。

全身或局部抵抗力减弱，例如患有慢性肾炎、糖尿病、脑膜炎或长期卧床不起、排尿无力的病人，也常常容易得肾

盂肾炎。尿路外伤、安插导尿管等也常会局部带入细菌而引起肾盂肾炎。

女性的尿道短而宽，盆浴洗澡时，污水容易倒流入尿道，而且女性尿道口与阴道、肛门很靠近，在白带多的情况下，或大便后容易污染尿道，在性生活时也可能把尿道外的细菌引入膀胱。妊娠期子宫长大，有时压迫输尿管，易致尿道不畅，甚至肾盂积水，易使细菌繁殖。这些均使女性患肾盂肾炎的机会多于男性。

急性肾盂肾炎发病较急，开始即表现发冷、发抖、高烧（39～40℃），也可仅有低热，或不发热，同时伴有乏力，全身软弱，头痛，腰部酸痛，病人随时都想小便，但尿量不一定多，有时伴有尿痛。这种尿频、尿急、尿痛的现象，称为尿路刺激症状。小便带血或浑浊，严重时小便浑浊得象脓液一样。

体格检查时病人有肾区叩击痛及肋脊角压痛。尿常规检查有蛋白质、红细胞、大量脓细胞。

祖国医学认为肾气不足，湿热蕴结于下焦，是引起急性肾盂肾炎的主要原因。而湿热的产生却是多方面的，如过食肥甘厚味，嗜酒，致脾失健运；肝气郁结，气郁化火，脾受肝制，湿浊内蕴；劳伤过度，脾肾两亏，皆可导致此病。治疗以清热利湿解毒为主。

处方：柴胡25克，黄芩15克，滑石30克，车前草30克，银花藤30克，猪苓12克，泽泻12克，白茅根30克。水煎服，每日一剂。

病人应坚持服药，在症状消失后，仍应检查小便，直至小便培养数次阴性才能停药。

急性肾盂肾炎诊断比较容易，治疗方法也很多，但是彻

底根治却比较困难，很多病人往往经过初次治疗症状就消失了，但小便培养并未转为阴性，治疗并未彻底，疗效没有巩固，过了几个月又复发了。以后时发时愈，就转变成了慢性肾盂肾炎。

慢性肾盂肾炎大部分由急性肾盂肾炎转变而成，表现有尿路刺激症状，伴有腰酸痛、低热或高热。部分病人患急性肾盂肾炎时由于症状不明显，没有被发现，直至到了晚期，肾脏实质受损而引起高血压贫血，甚至尿毒症时才被医生检查出来。

慢性肾盂肾炎的中药治疗：

①肾阴虚兼湿热：病程较长，反复发作，腰痛，尿频，尿急，尿痛，手足心热，口干，舌质红，苔黄腻，脉细数。

处方：知母10克，黄柏12克，生地12克，山茱萸10克，山药30克，丹皮10克，茯苓12克，泽泻12克，续断20克，野菊花30克。水煎服（或服成药知柏地黄丸）。

②气阴两虚：气短倦怠、心悸，头晕，耳鸣，腰酸，尿路刺激症状不明显，舌质红，苔少，脉弱。

处方：黄芪30克，党参30克，莲米30克，山药30克，山茱萸12克，熟地20克，茯苓30克，玉竹15克。水煎服。

③脾肾两虚：气短倦怠，食少使溏，肢体浮肿，腰痛，怕冷，尿频尿急，舌质淡，苔白，脉沉细无力。

处方：菟丝子12克，狗脊20克，杜仲10克，枸杞20克，山药30克，茯苓12克，莲米30克，补骨脂12克，续断80克，黄芪30克。水煎服。

治疗肾盂肾炎的验方：

①白花蛇舌草30克，车前草30克，败酱草30克，茯苓30克，大蓟10克，小蓟10克，茅根30克，茜草根10克。水煎服。

②鹿含草30克,马鞭草30克,金钱草30克,夏枯草30克,益母草30克,旱莲草30克,车前草30克,黄芪30克。水煎服。

预防:

1.在得了急性肾盂肾炎以后,应耐心治疗,不要吃了几天药症状减轻了就自动停药,这样容易复发。应在症状消失后坚持服药,直至小便培养数次阴性才停药。

2.预防性服药:女病人,慢性肾盂肾炎反复发作如果与性生活有关,可于性生活后,排完小便,再用车前草30克煎水送服穿心连片8粒,以预防发作。月经期、妊娠期、过度疲劳的时候(都容易诱发肾盂肾炎),都可用车前草煎水当茶喝,并服穿心连片以预防发作。

3.婴儿期要注意尿布和会阴部清洁。

4.肾盂肾炎治愈后一年内不宜妊娠,以免复发。

5.注意个人卫生,勤洗澡,勤换衣,注意阴部清洁,尤其在月经期、新婚期应注意卫生,防止尿道上行感染。

6.去除慢性感染病灶,有妇科病、慢性结肠炎、糖尿病等应积极治疗。因为这些病与肾盂肾炎的发病关系密切。

22. 肾 结 石

肾结石由多种原因引起肾脏内尿液晶体物质的沉淀而成。大多数肾结石的成份是尿中固有的晶体物质,这些晶体物质在正常情况下处于溶解状态,但是为什么某些人尿内的晶体物质会沉淀而成结石,这个原因目前尚未完全清楚。

目前认为肾结石形成的常见因素有:

①尿路梗阻:因为尿液排出不畅,尿液中的晶体物质过度

饱和，与尿液中的胶体物质结合造成沉淀。

②感染：肾脏细菌感染后，尿中细菌和炎性渗出物质（脓液）积聚成团，可成为晶体物质的沉淀核心。

③营养障碍：食物中缺乏维生素A可使肾盂上皮细胞角化和脱落，这些脱落的角化上皮聚集成团，可成为结石的核心。

④内分泌系统疾病如甲状旁腺功能亢进时，分泌过多的甲状旁腺激素，造成血液钙大量增高，肾脏排出尿钙、尿磷酸盐过多，增加尿晶体浓度，容易并发结石。

⑤长期卧床：如骨折、骨结核、脊髓损伤、脊髓炎，造成肢体瘫痪，长期卧床，产生骨质疏松，骨骼大量脱钙，增加尿钙和磷的排泄。同时由于久病卧床，活动减少，尿液郁积，尿内晶体物质在肾盂肾盏内留滞，增加肾结石形成的机会。

肾结石表现的症状

1.血尿：多数肾结石病人有肉眼可见的血尿，小便颜色象红茶或酱油一样，有的血尿要在显微镜下检查才能发现。

2.疼痛：肾结石移动时，病人常有阵发性的剧烈疼痛和放射痛，疼痛先在腰部，然后沿输尿管向膀胱、外生殖器、大腿内侧等处放射，称为肾绞痛。绞痛时病人坐立不安，面色苍白，恶心呕吐，冷汗淋漓。每次发作几分钟到几小时不等。当结石停止移动或进入膀胱后，疼痛突然消失，结石有时可随尿排出。

3.排尿异常：肾结石病人还有尿急、尿频、尿痛等症状。

肾结石的主要表现为腰部疼痛、血尿、脓尿。很多病人

是因为腰部剧烈绞痛后才被发现的。

肾结石属于中医的“石淋”、“沙淋”范畴。祖国医学认为湿热蕴结下焦，肾和膀胱气化不利，尿液受其煎熬，而致结成砂石。治疗以清热利湿，化石通淋为主。

处方：金钱草30克，海金砂25克，滑石25克，木通10克，车前子10克，篇蓄10克，炮山甲10克，牛膝10克。水煎服，每日一剂。

小便不利或尿痛者，加黄柏10克、瞿麦10克。

尿血，加小蓟15克、血余炭10克、生地10克、丹皮10克。

腰胁少腹疼痛较甚者，加续断20克、台乌10克。

剧烈肾绞痛，加乳香10克、没药10克、生蒲黄10克、五灵脂10克，必要时可服苏合香丸一粒以止痛。

针灸疗法的止痛效果也比较好。取穴：肾俞，足三里，关元。腰部剧痛时选肾俞、足三里加刺腰俞。

局部热敷、拔火罐等也可以止痛。

肾结石病人应该多喝水，多服用利尿剂。因为多喝水或服利尿药，造成大量稀释尿，可以冲淡尿结晶浓度，减少沉淀机会，又能冲洗尿路，使较小结石从小便中冲出。这是治疗结石的有效措施。

当然，利尿、排石的中药久服也可导致肾虚，影响脾胃功能，这是临床上常见的。因此，在用利尿、排石的中药方剂的同时，最好加服六味地黄丸等扶正方药。

肾结石病人还要多活动，多跳跃，促进排石。

据近年来报道，冰糖120克，香油炸核桃仁120克，共研细末，每次服60克，每日服四次，开水送下，可以软化结石。这个方剂与排石方剂（金钱草30克、冬葵子30克、石苇30

克、芦根30克，水煎服）交替服用，往往能收到排石的良效，而且没有副作用。

下列处方能够溶解泌尿系的各种结石，似无选择性。

处方：鳖甲15克，金钱草30，海金沙15克，生苡仁30克，滑石30克，琥珀10克，石苇30克，核桃仁30克，鸡内金15克。水煎服。

对于肾结石病人，保护肾功能非常重要。因此，肾结石病人应常服下列保护肾功能的方剂。

处方：黄芪30克，生地15克，菟丝子10克，黄精15克，怀牛膝12克，白茅根30克，首乌12克，防己10克。水煎服。

预防

①多饮水是日常生活中预防结石的最好方法。尤其是在炎热地区，夏季和夜间要避免过分尿浓缩，就要多喝水。长期卧床病人也要大量喝水，防止尿液浓缩。

②控制尿路感染，也是防止结石形成或结石复发的重要措施之一。控制尿路感染可用中药（详见本书第70页《肾盂肾炎的中药治疗》），也可用抗菌素。

③缺乏维生素A的病人应多吃鸡蛋、猪肝等维生素A含量高的食物。这也是预防肾结石的措施之一。

④长期卧床的病人，应经常移动体位，有利尿液排出，在可能的情况下应尽量早日恢复活动，避免骨骼疏松脱钙。

⑤有尿路梗阻的症状，应积极加以治疗。

以上所谈的治疗肾结石的治疗原则、方剂、药物及预防措施等，也适用于治疗输尿管结石、膀胱结石。

23. 遗 精

遗精是男性成年人多见的一种症候。凡在不是性生活的状况下发生的射精，称为遗精。在睡眠中发生的遗精称为梦遗，在清醒的状态发生的遗精称为滑精。有时在性冲动时，阴茎流出少量的粘滑液体，那是尿道球腺分泌出的液体；有时没有性冲动也可能有粘液流出，多半是前列腺液，这些都不是遗精。

一个月左右发生一次遗精，不算病态，其原因可能由于膀胱或直肠因排泄不畅所引起的充胀，睡眠时阴茎受压或受被服摩擦，以及性欲冲动等引起。遗精次数太多（一、两天一次）或者异常的性冲动并有精液排出，则属病态。

遗精的病因是性生活过度和手淫。此外，包皮过长、包皮垢刺激、包皮或阴茎发炎、前列腺炎、肛门瘙痒等也可引起遗精。

中医认为遗精多由肾虚不能固摄、君火或相火亢盛，扰动精室而致遗精。

遗精的中药治药：

①梦中遗精，伴头昏头晕，心悸，精神不振，体倦无力，小便短黄而灼热，舌质红，脉细数。

处方：知柏地黄丸（成药），每次服10克，一天三次，开水吞服。

②遗精，伴耳鸣腰酸，形体消瘦，舌红少津，脉弦细。

处方：芡实90克，莲须30克，潼蒺藜90克，龙骨60克，牡蛎60克，共研细末，用莲子粉糊丸，每次服10克，一天三

次，开水吞服。

③滑精频繁，面色晄白，精神萎靡，舌质淡，苔白，脉沉弱。

处方：菟丝子10克，韭菜子10克，龙骨30克，牡蛎30克，五味子12克，桑螵蛸20克，白石脂20克，茯苓10克，水煎服，每日一剂。

④顽固遗精，用一般药物效果不明显者，可用刺猬皮60克、五倍子15克、益智仁15克，共研成细末，每次服10克，早晚各服一次，开水吞服。

单方验方：

1) 五倍子研细末，用患者自己的唾液调成糊状，贴敷脐中，每日换药一次，每次约6克。

2) 金樱子30克，扁蓄30克，水煎服，每剂服二天。

3) 刺猬皮1具，用两块新瓦合覆，外用泥封，火灼，研成细面，于每日睡前服6克，黄酒送服。

附带谈一下，青年人犯手淫是不好的习惯，应该坚决戒除。

24. 男性性功能障碍（阳萎、早泄）

阳萎是指阴茎不能勃起或勃起不坚。其发病原因，除了生殖器官的器质性病变（如生殖器官的畸形、神经损害、海绵体肌损害等）之外，多数处于大脑皮质对勃起的抑制加强或脊髓中枢机能紊乱所致。大多数阳萎是精神因素造成的，过于紧张、恐惧、极度兴奋等都可以引起阳萎。由于以上原因偶尔有几次性生活中出现阳萎不算病态。只有长期的、经常的阳萎才算病态，才需要找出原因，加以治疗。

祖国医学认为阳萎多由恣情纵欲，或少年误犯手淫，致命门火衰，肾阳衰微，并与肝肾二经有密切关系，以肝主筋，其筋经绕于阴器。或由于思虑忧郁损伤心脾，以致前阴不能勃起而成本病。

辨证施治：

1.命门火衰：阴茎萎而不起，面色晄白，精神萎靡，腰膝酸软，四肢不温，滑精早泄。治宜温肾扶阳。

处方：枸杞15克，复盆子10克，菟丝子10克，五味子12克，车前子10克，巴戟12克，锁阳12克，胡芦巴10克。水煎服。

如阳萎日久，肾阳衰微，可用鹿茸粉3克，紫河车粉6克，肉苁蓉粉10克，白酒或开水吞服，每日一次。

2.思虑伤脾：阴茎举而不坚，食少神疲，寐不安宁，舌淡脉沉细，治宜补益心脾。

处方：党参30克，黄芪30克，白术10克，当归10克，龙眼肉12克，远志10克，炙甘草10克，巴戟10克，淫羊藿30克，仙茅15克。水煎服。

治疗阳萎的单方验方：

1.红参6克（空腹嚼服），蜂乳1支（空腹开水冲服），胡桃仁30克（嚼服）。每日1次。

2.鹿含草30克，补骨脂12克，枸杞20克，黄芪30克，制附子（先熬）30克，菟丝子10克，川芎10克，赤芍10克，鹿角霜6克，韭菜子6克。水煎服。

3.红参20克，淫羊藿30克，蛇床子30克，仙茅30克，巴戟30克，沙苑蒺藜30克，胡芦巴30克，川牛膝20克，共研细末。羊腰子一对，水内烫硬不煮熟，剥去外皮，晒干研成细粉，与上列药粉和匀，炼蜜为丸，每丸重10克，早晚各服二

丸，热开水送服。

4.大蚂蚁蛋，或蚂蚁，焙干，研粉，内服，每次服6克，或将蚂蚁、蚂蚁蛋150克，泡酒一斤，泡七天，每次服10毫升，一天两次。

5.针灸：取穴气海、关元、肾俞、命门、三阴交。温针灸，每日一次，每次灸30分钟。

6.新鲜狗睾丸10克（不去血）。切成薄片，温开水送服，早晚各1次。并配合按摩脚心及加强体育锻炼。按摩脚心于每日起床、临睡前各行1次，用左手心按摩右脚心100下，再用右手心按摩左脚心100下，动作要缓和、连贯。体育锻炼宜每天早晨先练太极拳或气功，然后慢跑15分钟，快走25分钟，晚饭后散步30分钟。

特别需要指出，阳萎患者宜戒烟。因阳萎与抽烟关系密切。科学调查表明，烟瘾者在阳萎患者中几乎占三分之二。抽烟会影响阴茎的血液循环，久而久之，导致阳萎。当然，吸烟的人不会在一夜之间发生阳萎，但是，抽烟的阳萎患者自己也会感觉到，他的阴茎的坚硬度逐渐比往常弱，持续下去，终于会在某一天，完全失去使性器官坚挺的能力。

阳萎患者忌喝酒。饮酒会加重阳萎。科学研究认为，酒是一种性腺毒素。饮酒过多可使性腺中毒，特别是男子，表现为血中睾丸酮水平降低，有70~80%的男子出现阳萎或不育。

平时不喜欢喝酒的人，猛喝一次烈性酒，也能引起睾丸酮水平降低，出现阳萎。如果平时每天喝半斤烈性酒，连续2~5年可导致完全阳萎而根本不能从事性生活。

阳萎患者忌长期服用能引起阳萎的药物，如利血平、甲基多巴、胍乙啶（治高血压药）、速尿、安体舒通（利尿药）、

阿托品、普鲁本辛（治胃痛、腹痛药）、甲 氰 咪 呱（治胃十二指肠溃疡药）、吗啡、度冷丁（止痛药）、利眠宁、安眠酮（安眠药）、乙 蔗 酚、安宫黄体酮（雌性激素类药）等等。

早泄是指成年男性在性交时，阴茎尚未进入阴道或接触阴道不久便已射精。这是男子性功能障碍的一种表现。若夫妻久别重逢，男子精满则溢，偶尔出现早泄也不是病态。

身体虚弱，神经衰弱，全身性疾病，恐惧，体力劳动和脑力劳动过于紧张和疲劳，房事过度，尿道慢性炎症、龟头炎等，都可以引起早泄。早泄病久失治，就会形成阳萎。

祖国医学认为早泄主要是下元虚惫，精室失固所致。治宜滋补固涩。

方一：五味子30克，金樱子30克，女贞子30克，黄精20克，补骨脂12克，益智仁12克，桑螵蛸30克，牡蛎30克。水煎服。

方二：山茱萸12克，山药30克，五倍子10克，复盆子12克，枸杞30克，芡实30克，莲米30克。水煎服

方三：五味子糖浆，每次服20毫升，一日服两次。

方四：五倍子30克，水煎，乘热熏龟头，水温降后，浸龟头10分钟，每晚一次。

早泄的治疗，除了药物以外，还应注意营养，保持阴茎的清洁卫生，避免过度疲劳和紧张。

25. 尿 崩 症

尿崩症是因下丘脑—神经脑垂体机能减退、抗利尿激素分泌过少所引起的一种疾病，也叫神经垂体功能减退症。

抗利尿素的作用是增加肾脏远曲小管和集合管对水的通透性，从而促进水的重吸收。当抗利尿素生成不足时，尿量就会极度增多，严重者每天排尿可达30~48升，比正常人的每天排尿量增加几十倍，所以叫尿崩症。

尿崩症可分为原发性和继发性两类。原发性尿崩症原因不明，有遗传性，这种情况较少见。继发性尿崩症多与外伤（脑震荡、颅骨骨折）、炎症（脑炎、脑膜炎、上呼吸道感染等）、肿瘤、手术损伤、颅内出血等原因有关。

尿崩症发病以20~40岁为多，男性稍多于女性。起病有缓有急，基本症状为多尿，每日排尿量可达5~10升或更多。因为排尿特别多，所以病人感到口渴难忍，大量喝水。如果限制病人喝水，尿量也不见减少，结果可造成严重失水。病人感到极度口渴，伴有头痛、疲乏、肌肉痛、体重减轻、体温降低、心动过速及便秘等。如果再不给病人喝水，可引起精神失常，循环障碍，甚至虚脱。但如饮水过量，可引起水中毒，出现头痛、恶心、呕吐、体温下降、精神错乱，甚至惊厥，昏迷。久病者常因口渴、多尿而发生失眠、焦虑、烦躁等症状。

中医认为尿崩症为燥热伤阴，但久病可以伤阳，而致下元虚寒，蒸腾无权。治宜养阴生津，引火归源。

方一：甘草30克，煎水分三次吞服六味地黄丸（成药）20克，每日服三次（每日服六味地黄丸总量为60克）。同时口含乌梅以生津止渴。

方二：龙骨30克，五味子30克，煎水分三次吞服桂附地黄丸（成药）10克，一日服三次（每日服桂附地黄丸总量为30克）。

方三：桑螵蛸30克，巴戟天10克，黄芪10克，党参15

克，山药30克，莲米20克，龟版15克，甘草20克，益智仁10克，牡蛎30克，水煎服，每日一剂。尿量正常后再服补中益气丸（成药）、十全大补丸（成药）调理。

方四：生地30克，熟地30克，山药30克，龟版30克，甘草30克，葛根12克，黄连6克，黄柏6克，羚羊角粉1克（兑服），火麻仁10克。水煎服，每日一剂。本方对严重尿崩症出现精神失常及虚脱者有效。

针灸疗法可作为辅助治疗：

常用穴：命门、肾俞、三阴交、关元、气海、中极、金津、玉液。每次选用四穴，每天一次。其中命门、肾俞、三阴交用弱刺激加艾灸。关元、气海、中极，针尖向下斜刺，进针2~2.5寸，使针感向外生殖器放射。金津、玉液针刺放血，每天一次。症状消失后隔天一次，巩固疗效3~5天即可。

耳穴：肺、肾、膀胱、内分泌、皮质下。每次选用2穴。每天一次，留针30分钟。

26. 甲状腺机能亢进症

甲状腺机能亢进症（简称甲亢）是一种内分泌疾患。这种病在临床上较为常见，女性发病较男性为多，以二十至四十岁发病较多。起病大多缓慢。

甲亢的致病原因，是病人受到严重的精神创伤（如长期的忧虑、悲伤、惊恐等）以及发育、月经、妊娠、感染性疾病等因素，引起大脑皮层机能紊乱，产生病理性兴奋，导致甲状腺素分泌过多、甲状腺机能亢进、腺体增生和肥大。

甲亢由于甲状腺素分泌过多。大量的甲状腺素进入血液，引起全身细胞、组织的物质氧化过程加速，新陈代谢旺盛，但过多的能量并不能被机体利用，从而引起甲亢的一系列典型症状。

甲亢病人食欲明显亢进而体重反而减轻，消瘦，皮肤潮湿，多汗，喜冷怕热。

甲亢病人情绪容易激动，性情急躁，常常有紧张、多语、失眠、思想不集中等症状，病人两手平伸，手指张开常表现震颤。

甲亢病人还有心慌、心动过速(每分钟100~120次)等症状。测量血压，收缩压升高，舒张压降低(或者正常)，脉压差加大。

不少病人甲状腺肿大，肿大的甲状腺能随吞咽动作上下移动。

约有半数病人，眼球突出，眼裂加宽，两眼直瞪，瞬眼(眨眼)减少。

甲亢病人还有肌肉无力、容易疲倦、大便次数增多、腹泻、呕吐、下腹部不适等症状，女性患者可有闭经或月经不调，男性患者可有阳痿。

甲亢的简易检查法：

甲亢患者的基础代谢率一般均高于正常(正常值为 $\pm 15\%$)，在没有基础代谢测定器的情况下，可用下列公式计算作参考：

公式一： $(0.75 \times \text{每分钟脉搏数}) + (0.74 \times \text{脉压}) - 72 = \pm \% \text{基础代谢率}$ 。

注：“脉压”即收缩压-舒张压(例如血压为150/70毫米汞柱，脉压即 $150 - 70 = 80$)。

公式二：(每分钟搏数+脉压)-110=±%基础代谢率。

上面这两个公式中的血压及脉搏数必须在病人清晨刚睡醒而未起床时测定。

对甲亢病人，精神上应尽量安慰，避免情绪波动，这对于甲亢病人的治疗是十分重要的。甲亢病人的饮食宜具有高热能，足量的醣类和蛋白质、维生素C、维生素B族等，使能满足机体因代谢亢进而引起的消耗。早期病人及严重病例均应休息。

甲亢，属于祖国医学“中消”“瘰病”的范围。中医认为本病的发生，原因是多方面的，有些可由于饮食五味的偏嗜，胃内郁热，痰火积聚；或精神刺激，情绪郁结，肝脾之气失于条畅，郁而化火，心阴耗伤，痰瘀内结，凝滞于颈部经络而发生本病。

甲亢的中药治疗：

①属于“心肝火旺，胃热炽盛”的，症状有：脖颈肿大，眼突怕光，烦躁易怒，舌及手指颤动，多汗，多食易饥，口干，心悸，舌质红，脉弦数有力。

处方：沙参10克，天花粉30克，麦冬15克，生地15克，黄连6克，黄药子30克，玄参15克，牡蛎30克（先熬），丹皮10克，白芍15克，甘草10克。水煎服，每日一剂。

②属于“肝肾不足，心营内耗”的，症状有：心悸气促，失眠，多汗，头眩晕，脖颈肿大，眼突，五心烦热，多食易饥，形体消瘦，舌质淡红，脉细数。

处方：黄药子30克，制首乌12克，枸杞12克，天冬12克，麦冬12克，五味子15克，天花粉20克，牡蛎30克，酸枣仁10克，生地12克，熟地12克。水煎服，每日一剂。

注：黄药子又名黄独，性味苦辛凉，能解毒消肿，化痰

散结，凉血止血。用于治疗甲亢，有较好疗效。但对于肝功能不良的病人，应禁用。

针灸治疗甲亢亦有效，但疗程较长，应坚持治疗。

常用穴：间使、三阴交、气瘰、颈3~5夹脊穴。备用穴：阴郄、复溜、上天柱、内关、合谷、太冲、神门、安眠、攒竹、四白、风池。

方法：先针间使穴，轻捻数十次，再针三阴交，平刺法，留针卅分钟。气瘰穴轻透不留针（避开血管），若气瘰穴不适宜多刺时，可针颈3~5夹脊穴，每次选用一对，多捻转。

27. 甲状腺功能减退症

甲状腺功能减退症是由于甲状腺激素分泌不足而引起。

甲状腺功能减退症有呆小病和粘液性水肿两种类型。

（一）呆小病（克汀病）：见于新生儿。由于甲状腺发育不全，或有先天性甲状腺激素合成障碍而致血液中甲状腺素低于正常。病儿生长发育迟缓，起坐、行走、说话都开始得比较晚，乳齿发生也迟，身材矮小，大脑发育不全，智力低下，反应迟钝，外貌改变（头大、前囟关闭迟，眼睑肿胀，舌大而且常常拖出口外，嘴唇肥厚等等），皮肤干燥增厚，体温及基础代谢率低于正常。此类病人现已少见。

此类病人属于中医的“五迟”范畴（立迟、行迟、发迟、齿迟、语迟等发育迟缓的证候），中药治疗可用熟地6克、山药6克、枸杞6克、山萸6克、鹿角霜6克、当归6克、白芍6克、菖蒲3克、远志3克、胡麻仁（芝麻）6克、补骨脂6克，加水浓煎，一剂分两天服完。

(二)粘液性水肿：甲状腺机能减退引起的这种水肿与其他疾病所致的指凹性水肿不同，用手指按压不凹陷，皮肤苍白或蜡黄、粗糙、厚而干、多脱屑，毛发稀少或脱落，四肢冷，理解力和记忆力均减退，反应迟钝，语言不利，嗜睡，体温低，心动过缓，腹胀，厌食，便秘，基础代谢率常在-20%以下。

此类病人属于中医的“脾肾阳虚”范畴。中药治疗可用：淫羊藿30克、仙茅15克、巴戟天15克、苁蓉15克、附子20克(先熬)、党参30克、茯苓10克、大腹皮12克、桑白皮12克、黄芪30克、肉桂6克、白术10克。水煎服，每日一剂。

28. 头 痛

头痛是许多疾病的常见症状。现在来谈谈几种常见的头痛的中药治疗。

(一)偏头痛：多见于女性，常于青春期起病，呈周期发作(有部分病人头痛发作与月经周期有密切关系)。

典型发作前病人常常先有嗜睡、倦怠、忧郁感，并可能在眼前出现闪光、暗点，还可出现面唇、肢体麻木，失语等。这些先兆症状大约经过20~30分钟后消退，然后开始出现剧烈头痛，痛得好象钻子钻或针刺一样。这种头痛常常偏于一侧，常从眼眶或前额部开始，向半侧头部扩展，也可遍及整个头部。头痛发作持续数小时或数日后逐渐减轻，常常在入睡后完全缓解。

偏头痛可用下列方药治疗：

1.葛根片(每片含葛根素100毫克)，每次5片，一日三

次，开水吞服，连服两个月以上。2.柴胡12克，白芍30克，川芎30克，白芷12克，香附10克，白芥子10克，杏仁10克，细辛6克，水煎服，每日一剂。3.防风通圣丸（成药），照说明服用。4.山羊角（刮屑）20克，川芎6克，制川乌3克，白芷6克，水煎服，每日一剂。5.萝卜汁（加少量冰片）滴鼻。

（二）高血压头痛：这种头痛是高血压病人的常见症状。头痛常为深部搏动样钝痛，有时伴有头部紧压感。痛的部位常在额部或枕部。头痛程度常与血压突然升高有关。对高血压头痛可用天麻钩藤饮（天麻10克，钩藤20克，夜交藤30克，石决明30克，炒山栀10克，黄芩10克，牛膝10克，杜仲12克，益母草30克，寄生30克，茯神10克）治疗。

（三）头部器官及邻近组织病变所致的头痛：

1. 眼源性头痛：青光眼引起的头痛可用下列方剂治疗：

方药：①羌活12克，防风12克，黄芩10克，甘草10克，白芷10克，藁本10克，水煎服，每日一剂。②龙胆草10克，蔓荆子10克，牛膝10克，香附12克，茺蔚子10克，赤芍10克，水煎服，每日一剂。③生石决明30克，白术20克，泽泻20克，苍术10克，楮实子10克，桂枝10克，菊花15克，水煎服，每日一剂。

眼部炎症引起的头痛可用下列方剂治疗：

方药：①川芎12克，桑叶20克，菊花20克，决明子30克，牛蒡子20克，茺蔚子10克，蒲公英15克，银花12克，谷精珠10克，车前草30克，水煎服，每日一剂。②赤芍12克，黄芩10克，青蒿10克，山栀10克，乳香10克，没药10克，败酱草30克，水煎服，每日一剂。

2. 耳源性头痛：耳部炎症引起的头痛，可用下列方剂治疗：葛根30克，菖蒲10克，龙胆草10克，升麻6克，柴胡6

克，山梔10克，黄芩10克，木通10克，野菊花20克，蚤休10克，白芍12克，细辛6克。水煎服，每日一剂。

3. 鼻、副鼻窦炎症引起头痛，可用下列方剂治疗：辛夷12克，苍耳子10克，黄柏10克，桑叶15克，菊花15克，蔓荆子10克，露蜂房10克，菖蒲12克，白芷10克。水煎服，每日一剂。

4. 齿源性头痛：牙髓炎、牙周炎、牙龈炎等炎症引起的头痛可用下列方剂治疗：①银花10克，生地15克，玄参30克，砂仁6克，生石膏30克，细辛6克，川芎10克。水煎服，每日一剂。②升麻20克，白芷10克，荆芥10克，防风10克，薄荷（后下）10克，苍耳子12克，乳香10克，没药10克。水煎服。每日一剂。

5. 颈椎病引起的头痛，服中药可以使疼痛缓解：鹿含草30克，仙灵脾30克，苁蓉12克，骨碎补10克，海桐皮20克，羌活10克，独活10克，木瓜15克，鸡血藤30克，茜草根10克，玄胡10克，郁金10克。水煎服，每日一剂。

（四）三叉神经痛：多见于40岁以上患者。疼痛部位限于三叉神经分布区。疼痛呈突然阵发性闪电样剧痛，如刀割、钻刺、火烫一样。每次疼痛时间很短，从数秒钟至数分钟，突然发作，突然停止。发作时可引起同侧面部肌肉抽搐、眼结膜充血、流泪或流涎等症状。三叉神经痛可由说话、吃饭、刷牙、洗脸、吹风等诱发，因而患者不敢说话、洗脸或吃东西。三叉神经痛常呈周期性发作，病程初期发作较少，间歇期较长。随着病程进展，发作频繁，间歇期愈短。

方剂：①生石膏30克，生地15克，玄参20克，延胡索6克，白芷10克，细辛6克，防风10克，牛膝12克，麦冬12克，三七3克，水煎服，每日一剂。

②守宫(壁虎),文火炕干,研成细末,干燥消毒,分装密封备用,每次服2克,一天三次,开水吞服,连服15天为一疗程。

③川芎12克,防风10克,桃仁10克,红花10克,地龙10克,水蛭6克,姜黄10克。水煎服,每日一剂。

(五)头颅外伤后慢性头痛:患者有头颅外伤史。这种头痛多伴有头晕、乏力、失眠、易激动、思想不集中。在情绪紧张、用力、弯腰的时候,可使头痛加重。

治疗方剂:

①黄芪30克,当归10克,桑枝30克,桃仁10克,红花10克,地龙10克,全蝎6克。水煎服,每日一剂。

②当归10克,白芍30克,土鳖虫10克,蜈蚣6克,磁石30克,夜交藤30克,琥珀粉6克,菖蒲10克,远志10克。水煎服,每日一剂。

③骨碎补10克,川断30克,菊花15克,红花10克,丹参30克,钩藤15克,血竭6克,延胡索6克。水煎服,每日一剂。

以上谈的是几种常见的头痛的中药治疗。至于急性感染性疾病、颅内炎症引起的头痛,应抓紧时机,积极治疗原发疾病,随着原发疾病的治愈或好转,头痛症状也会消失或减轻。

29. 内耳眩晕病

眩晕是身体几个系统发生病变的时候所引起的一种平衡感觉障碍。病人感到周围景物向一定的方向移动。感到天旋地转。病情轻的,闭上眼睛,一会儿眩晕即停止,病情重

的，感到周围景物旋转不停，病人站立不稳，甚至跌倒，同时还有恶心、呕吐、出汗等症状发生。

眩晕主要由迷路神经、前庭神经、小脑等的病变以及其他全身性疾病所引起。由迷路神经、前庭神经等病变引起的，有周围景物旋转或自身旋转的感觉，称为真性眩晕；由某些全身性疾病引起的，仅有头晕或站立不稳，而没有天旋地转的感觉，称为一般性眩晕。

人们能够保持身体的平衡，保持身体处在空间的定向功能，前庭神经和小脑起着主要的作用。如果上述组织有了病变，就容易引起眩晕（真性眩晕）。

真性眩晕包括耳源性眩晕（见于内耳眩晕病、迷路炎、晕动病、药物中毒等）、眼源性眩晕（注视飞快行车或站立高崖往下看悬崖峭壁，均可引起眩晕）、脑源性眩晕（多由颅内肿瘤、炎症及血管性病变所引起）。

临床上最多见的是耳源性眩晕当中的内耳眩晕病（美尼尔氏综合征）。这里着重谈谈内耳眩晕病的中药治疗。

内耳眩晕病的临床表现：多数于中午起病，男性患病的略多。典型病状是阵发性眩晕，伴有耳鸣及听觉障碍。

眩晕常突然发作，四周景物旋转，严重时伴有恶心、呕吐、面色苍白，出汗等症状，有的可出现短暂的眼球震颤。病人在眩晕发作时多闭目卧床，不敢睁眼，不敢转动头部，唯恐眩晕加剧。

内耳眩晕病常常是一侧听力减退，但在早期因其障碍程度较轻而未被注意。每次眩晕发作都可使听力进一步减退，难以恢复原有水平。也有少数病人患侧听力完全丧失。

内耳眩晕病，常伴有高音调的持续性耳鸣，发生于患侧，常与耳聋同时发生，这种耳鸣多在眩晕发作前加剧。

中医认为内耳眩晕病多由郁怒思虑太过，或饮食不节，伤及肝脾。郁怒则伤肝，思虑太过，饮食不节则伤脾。脾伤运化失调，痰湿内生，痰湿中阻，清阳不升，可以发生眩晕。肝郁化火生风，风痰上窜也能发生眩晕。

中药治疗：

①泽泻30克，白术30克，党参15克，茯苓10克，牛膝10克。水煎服，每日一剂。本方对内耳眩晕病兼有高血压患者最为适宜。

②党参15克，吴茱萸10克，大枣15克，生姜15克，代赭石30克，法半夏10克，夏枯草20克，车前草20克。水煎服，每日一剂。本方治内耳眩晕病呕吐症状明显者，收效较满意。

③五味子15克，酸枣仁10克，山药30克，当归10克，龙眼肉15克。水煎服，每日一剂。本方防治内耳眩晕病的听力减退有较好效果。

④竹茹10克，枳实10克，法半夏12克，陈皮10克，茯苓15克，甘草10克，葛根30克，丹参30克，磁石30克，钩藤20克。水煎服，每日一剂。本方不仅对内耳眩晕病有效，而且对于椎一基底动脉供血不足引起的反复发作性眩晕也有疗效。

⑤炒苡仁30克，泽泻60克，白术30克，葛根60克。水煎服。

30. 记忆力减退(健忘症)

记忆力减退属于神经衰弱中的一种常见症状，中医称为“健忘”或“善忘”。有这种症状的人，工作效率降低，注意力

不易集中，时间稍长，即感到头昏脑胀，疲乏无力，无法坚持工作或学习。记忆力减退的人，遇事善忘，特别以近事记忆减退最为明显，记不住数字，记不住人的名字。中医认为这种健忘与生性迟钝、天资不足者不同，它多由“心脾不足，肾精虚衰”而引起，也即是指思虑过度伤及心脾，或房事不节（性生活过度），肾精亏损，造成脑力衰弱，产生健忘这种症状。

得了健忘症，思想上不必紧张，这种症状是可以治好的，它的预后是良好的。

得了健忘症，该怎么办呢？

1.保持良好的睡眠，是预防和治疗健忘症的关键。健忘常与失眠并见，二者在病因、治疗方面均有密切的联系。如果出现了失眠症状，首先应把它治好，才能保持良好的记忆力。

人们白天进行工作或学习，中枢神经一直处于高度的兴奋状态中，但是这种高度兴奋的状态是不可能永远保持下去的，到了一定的程度，中枢神经就会产生疲劳。这时就需要用休息来消除疲劳。睡眠是消除中枢神经疲劳的有效的休息方式之一。

治疗失眠可用刺五加、五味子、合欢皮、夜交藤各15—30克，熬水服。每日一剂。分三次服。也可用琥珀粉冲开水服，临睡时一次服下。或用成药刺五加糖浆、五味子糖浆，照说明服。

2.讲究用脑卫生，也是防治健忘症的有效措施。大脑的正常活动规律是：一定部位处于兴奋状态，另一部位就处于抑制状态。大脑神经细胞互相交替地兴奋和抑制，轮流工作和休息，人们在工作或学习时才能做到注意力高度集中。人

们的记忆力是通过大脑神经细胞的反复兴奋（多次重复）而产生的，而不是一次兴奋就能获得的。因此，对脑力活动要作适当安排，让大脑皮质上的各个神经细胞群得以轮流工作和休息，该兴奋的部位高效率的兴奋，该抑制的部位高效率的抑制，避免长时间的过度疲劳，也即是中医所说的不要思虑过度，这是保持良好记忆力的有效措施之一。

如果不顾大脑活动的规律，一天到晚处于焦虑之中，大脑处于持续的、普遍的紧张状态，就可能出现整天昏昏沉沉、头痛、困倦、心悸、吃不好、睡不安等症状。有了这些症状，除了自己注意纠正“思虑过度”的不良习惯以外，还可服中药归脾汤（黄芪、党参、白术、茯神、炙甘草、当归、龙眼肉、酸枣仁、远志、木香、生姜、大枣），以助于消除这些症状。

3. 中医认为疲劳过度，造成肾精亏耗，出现腰酸乏力，甚则滑精早泄等症状，也可引起记忆力减退。如果已经出现“肾精亏耗”症状，而且记忆力明显减退者，可用下列方剂治疗：①舌红、脉细数者，用六味地黄丸（成药）加酸枣仁、五味子、远志、菖蒲各10克（熬水吞服六味地黄丸）。②舌质淡、脉沉细者，上方再加鹿角胶、苁蓉、巴戟、紫河车等。

4. 适当参加体力劳动及体育活动，不但有助于正常大脑神经活动的恢复，而且能增强体质。实践证明，体力劳动或体育活动对记忆力减退的患者是十分有益的，许多人参加一定的体力劳动锻炼或体育活动后，记忆力减退等症状都有显著好转或痊愈。

总的说来，记忆力减退是可以治好的。中药菌灵芝，每日30克，加冷水500毫升煎熬二小时，煎三次，饭前服。成

药脑灵素，都可以作为常服药品。其中以菌灵芝的疗效比较突出。针灸疗法（针刺足三里、内关、神门、三阴交等）、耳针疗法（耳穴：皮质下、神门、心、肾、内分泌、交感等）对记忆减退的疗效也比较好。

记忆力减退症患者的注意事项：

1.要科学用脑。这对于改善记忆力有着决定性的作用。

科学家用老鼠作过有趣的实验。首先训练小白鼠如何逃脱电击。不久所有的小白鼠均熟练地掌握了这种技巧。但是当人为地使一部分小白鼠处于人工控制的亮光和黑暗环境，使之昼夜颠倒，这些小白鼠便丧失了记忆力，遗忘了已经掌握的逃避电击的技巧。相反，处于正常环境的小白鼠，对学到的逃避电击的技巧一直记忆犹新。科学家认为，动物之所以能有记忆力，是因为有一种具有记忆功能的蛋白质的合成和激素的分泌，在24小时内周期地出现高峰和低潮。一旦打乱了这种周期，记忆力就会消失。昼夜颠倒之所以使小白鼠很快忘记了逃避电击的技巧（丧失了记忆力），就是因为“拨”乱了它们赖以保持记忆的生物钟。

科学研究发现，在一天内，人的大脑存在着4个变化周期。清晨6~7点，大脑已经通过睡眠做完了对头一天所输入信息的整编工作，加上一早起来没有识记材料的干扰，此时看书学习，背诵课文，识记印象比较清晰。这是生物钟赋予人们用脑的第一个“黄金时间”。上午8~10点，经过几个小时的活動，精力已升至旺盛期，此时大脑具有严谨、周密的思考能力，是用脑的第二个好时辰。下午1点，生理机能进入了一天中的一个低潮，生物钟便“响”起了午睡的“钟声”，您应该顺其自然，稍事午休。从下午2时起，第三个良辰又接踵而至，这段时间思维能力最敏捷，人们最善于“检索”贮

存于大脑的信息，能以较短时间进行加工整理，形成结论，但其记忆力不如清晨那么好。傍晚6~8点，睡前10~11点，这是识记效果特别好的又一个“黄金时间”，此时记忆力好。利用这个“黄金时间”记忆单词、数据、公式等难以记忆的东西，效果最好，请君一试。

有的人不懂科学用脑，把“凿壁偷光”、“头悬梁”、“锥刺股”的精神，作为用脑的途径加以借鉴，这种“拔”乱生物钟的疲劳战术，实在是劳而无“术”，不宜提倡。

提高记忆力的方法还有“单侧体操法”。

科学研究认为，根据左右脑的不同功能，实行“单侧体操法”，可增强记忆力。从大脑分工看，左脑掌握语言、逻辑、计算等高级精神活动，右脑掌握空间识别能力。若左脑过于疲劳，就会出现全身无力、记忆力减退等症状，此时就应暂时停止计算、语言、逻辑等高级精神活动。还有，手的活动与记忆力紧密相连，而大部分人习惯于用右手。为了提高记忆力，应加强左手的活动和左半身的活动。把左右两个半球脑都利用起来，可以使记忆力得到改善。

提高记忆力还有一个方法，就是：在念书后立即吃饭。人们不妨一试。

记忆力减退患者还应常喝面汤，常吃鸡蛋。

乙酰胆碱是人体神经系统的一种重要物质，它有助于加强人体的多种生理功能如记忆功能。若大脑中乙酰胆碱不足，记忆力就会大大减弱。

补充脑内乙酰胆碱最好的方法是多吃含卵磷脂的食物。卵磷脂极易与水结合，标准面粉的面汤中卵磷脂含量极高。因此，吃完面条再喝面汤的作用，就不仅仅限于人们常说的“原汤化原食”了，更大的好处是能提高人们的记忆力。

鸡蛋黄也含有丰富的卵磷脂，常吃鸡蛋也能提高人的记忆力。

记忆力减退患者宜戒酒。这是因为，酒精能顺利进入人的血液，也很容易进入人的大脑，损害脑细胞，影响人的记忆力。

记忆力减退患者忌饭后即用脑（看书、读报、演算、写作等等）。因为饭后大量血液集中在胃肠道帮助消化，脑部血液供应相对减少，如果饭后立即用脑，会感到头昏，效果不好，久之还会得消化不良。

31. 失 眠(不寐)

失眠，又称不寐、失寐，是指难以入睡，或多梦，容易惊醒，醒后不能再睡，甚至彻夜不得眠等等。现代医学认为，失眠是指睡眠时间不足，或睡得不深、不熟。可分为起始失眠、间断失眠、终点失眠三种。起始失眠，是入睡困难，要到后半夜才能睡着，多由于精神紧张、焦虑、恐惧等引起；间断失眠，是睡不宁静，容易惊醒，常有恶梦，中年人消化不良的，容易发生这种情况；终点失眠，是入睡并不困难，但持续时间不长，后半夜醒后即不能再入睡，老年人高血压、动脉硬化、精神抑郁症患者，常有这类失眠。

人们白天进行工作或学习，中枢神经一直处于高度的兴奋状态中。但是这种高度的兴奋状态是不可能永远保持下去的，到了一定程度的时候，中枢神经就会产生疲劳，这时就需要用休息来消除疲劳。睡眠是消除中枢神经疲劳的最好的休息方式。白天工作，中枢神经高度兴奋，晚上睡觉，中枢

神经处于抑制状态。白天有足够的清醒活动，晚上才会有正常的睡眠；晚上有足够的睡眠，白天才会有清醒的头脑、充沛的精力。失眠的发生，就在于大脑的兴奋和抑制过程的平衡失调，破坏了高级神经活动的正常规律，以致白天该兴奋的时候不能很好的兴奋，晚上该抑制的时候不能很好的抑制，就形成失眠。

中医治疗失眠分下面几种情况：

1.“心脾血亏”：劳倦思虑太过，损伤心脾。伤于心则阴血暗耗，神不守舍，伤于脾则食少形瘦，血虚难复，由于血不养心，故成不寐。具体症状是：多梦易醒，心悸健忘，体倦神疲，饮食无味，面色少华，舌淡苔薄，脉细弱，用归脾丸（成药）治疗，效果较好。

2.“阴亏火旺”：肾水不足，真阴不升，阴虚则志不宁，心火独亢，心火盛则神不安，心肾失交，形成不寐。其症状有：心烦不寐，头晕耳鸣，口干津少，五心烦热，舌质红，脉细数，用朱砂安神丸（成药）或天王补心丹（成药）治疗，较为适当。

3.“心胆气虚”：体质柔弱，心胆素虚，遇事易惊，故夜寐不安，或暴受惊骇渐致胆怯，心虚而不寐。具体症状有：心悸多梦，易惊醒，舌质淡，脉弦细。用酸枣仁汤（酸枣仁10克，知母10克，茯苓12克，川芎10克，甘草6克）治疗，常能取得较为满意的疗效。

4.“胃中不和”：饮食、痰火导致胃气不和而不寐。具体症状有：胸闷暖气，腹中不舒，苔腻脉滑。先服保和丸（成药），待消化稍好后，再服温胆汤（橘红10克，法半夏10克，枳实10克，竹茹10克，茯苓10克，甘草6克，水煎服，每日一剂），效果亦较好。

失眠除用上述药物治疗外，配合用针灸疗法，则效果更好。

针刺常用穴：内关、神门、安眠、足三里、后溪。备用穴：风池、百会、丝竹空，中脘，脾俞，肝俞，三阴交，心俞，肾俞，命门，关元，气海，行间，郄门。上述穴位可交替选用，每次选2~5穴即可，均用轻刺激，留针10分钟左右。关元、命门、气海、足三里等穴，并可用灸法。

耳针穴：皮质下，交感，心，肾，脾，内分泌，神门。每次选用2~4穴，留针约20分钟。

有些病人的失眠症很顽固，彻夜不眠，乱梦纷纭，往往面部黧黑，肌肤甲错，舌有瘀点。对这类病人，用血府逐瘀汤（桃仁10克、红花6克、当归12克、川芎10克、赤芍10克、熟地12克、柴胡10克、枳实10克、甘草6克、桔梗10克、牛膝10克，水煎服，每日一剂）治疗，往往能见效。

用交泰丸（肉桂二份，黄连三份，和匀研末，每次服3克，一日二次）治疗失眠，效果比较满意。这个方剂治疗失眠的作用机理怎样，目前还不能用科学道理来解释它。

菌灵芝、刺五加、五味子这三味药，不仅有治疗失眠的良好效果，而且还能增强身体的抵抗疾病的能力，有滋补强壮的作用。

菌灵芝能治疗失眠、神经衰弱、头晕、虚劳、益精气，坚筋骨，增进食欲。还有保护肝脏，降低血压，降低血胆固醇等作用。治疗慢性气管炎、支气管哮喘、白细胞减少、冠心病、肝炎、肝硬化、贫血、心律失常、智力低下等，均有较好疗效。实验证明：灵芝能使小白鼠耐寒及耐缺氧能力提高，并能推迟其死亡时间。过去传说，久服菌灵芝能长生不老，这话虽然是夸张，但菌灵芝确有滋补强壮作用，能治疗

多种疾病，特别是失眠。由于菌灵芝有保肝作用，还能增进脑细胞代谢及能量供应，改善脑组织的血液和氧的供应，促进氨基酸代谢，使脑组织发生再生作用，调整植物神经紊乱，有增强网状内皮系统吞噬功能的作用，久服益寿延年，似无疑问。

刺五加治失眠效果较好，有镇静、降血压、扶正固本、增强机体防御能力等作用。科学研究认为刺五加有跟人参一样的强壮滋补作用。

五味子不仅能治失眠、神经衰弱、而且能治咳喘、自汗盗汗、遗精、久泻等，有滋肾涩精、保肝敛肺等作用，能增强中枢神经的兴奋性，提高机体的工作效能，减轻疲劳。

菌灵芝须先用冷水浸泡，然后加热煎熬二小时，每日用量为15~30克。

刺五加每日用量为20~30克，五味子每日用量为15~20克，水煎服。

菌灵芝、刺五加、五味子可合并一起煎服，也可分别煎服。

其他治疗失眠的中药，如夜交藤、琥珀粉、合欢皮等，已为大家所熟悉，不再细谈。

失眠患者的注意事项：

1. 应在睡前用温热水洗脚，然后喝一杯牛奶。
2. 平时练健身球，有促进睡眠之功效。每日练2~3次，每次约20~30分钟，左右手交替，可玩双球，也可玩三球（无健身球可用核桃代替），球在手掌中滚动的频率，以每分钟60次左右为宜。
3. 睡前听听乐曲，如《二泉映月》、《平湖秋月》、《军港之夜》、《烛影摇红》等乐曲。

4. 卧室宜挂深色窗帘，使室内控制一定的黑暗度，可促使入睡。

5. 经常梳头。祖国医学认为，头为诸阳之会，与百脉相通。头部有百会、四神聪、上星、太阳、率谷、风池、哑门、翳明、翳风、印堂、攒竹等几十个穴位，经常梳头，可对这些穴位起到按摩作用，对于改善大脑皮层的兴奋与抑制过程，调节中枢神经系统的功能，促进血液循环，增加头发根部的血流量，消除失眠都有积极的作用。

6. 失眠患者宜调整生物钟。大部分失眠是因中枢神经系统生物钟运转异常所致。怎样才能拨正人体内的“生物钟”呢？

①清晨迎着朝阳至少活动20分钟。因晨光可使人体生物钟提前，使人上午更有精神。

②早餐及中餐不要吃得太过饱，最好适当少吃点，因轻微的饥饿可使人白天少打瞌睡，使晚上的睡眠香甜。失眠患者应将晚餐作为主餐（冠心病患者则不能这样作）。在睡前4小时进餐，并于临睡前再吃些点心。因睡前进餐，可使消化系统占去机体的不少血液，使人睡前的脑供血减少而起到催眠作用。

③睡前2小时外出适当运动15至20分钟，因运动会使睡眠中枢休息得更好，入睡更会顺利。

④积极调整睡眠时间，如失眠者每天只能睡6小时，就只躺在床上6小时。这样，失眠者上床后就会更加珍惜睡眠时间，集中精力睡眠，从而提高睡眠质量。

附注：“生物钟”的含义：人体内有一座“生物钟”，控制着人体复杂的生理功能活动，保持着人体每个系统的节律。这种“生物钟”的活动与地球自转周期基本一致。“生物钟”是

人类对大自然作出的一种适应性选择，也是一切生物在进化的漫长过程中获得的适应环境的一种手段。顺应人体生物钟，会使人健康长寿，拨乱了生物钟则会引起疾病。

正常人每分钟心跳为72次左右，呼吸每分钟为16次左右，正常人的体温凌晨偏低，傍晚偏高，血压昼高夜低，妇女28天来一次月经，等等，都证明人体内有生物钟的存在。长期进食不规律，长期睡眠缺乏规律，都可以使人引起疾病。

拨准体内生物钟，起居有常，生活有规律，眠食定时，对维护健康，具有十分重要的意义。

32. 嗜 睡(多寐)

嗜睡(多寐)的特点是不分昼夜，时时欲睡，喊之即醒，醒后又睡，甚至在正常人不易入睡的场合下，如走路，骑自行车、工作、吃饭时都能出现难以控制的睡眠，就好象健康人晚上睡觉(生理性睡眠)一样，可以持续数分钟至数小时，但可以唤醒。

中医认为“多寐”是由于①脾气虚；②湿胜；③病后或老年人阳气虚弱。

治疗：

1.脾虚的，由于中气不足，脾弱，所以食后困倦多寐，没有其他的症状。处方：六君子汤（党参20克，白术15克，茯苓12克，甘草10克，陈皮10克，法半夏10克）加石菖蒲12克、山楂30克、神曲15克，水煎服，每日一剂。

2.湿胜的，多发于雨湿之季，或见于体质肥胖的人，症状有胸闷、身重、嗜睡、舌苔白腻、脉缓。

处方：苍术10克，厚朴10克，陈皮10克，甘草6克，藿香10克，佩兰10克，苡仁30克，法半夏10克，胆南星6克，水煎服，每日一剂。

3.病后或老年人阳气虚弱，嗜睡疲倦，容易出汗，懒于说话，食纳减少，畏寒肢冷，脉弱。

处方：补中益气丸（成药）或理中丸（成药）每次服10克，一天三次。

还有一种多寐见于脑震荡后遗症，多寐与失眠交替出现，一睡就睡20~30天，饮食由家属唤醒喂饲，一醒就十多天不睡。平时腰酸怕冷，面色晦暗。对于这种情况的“多寐”，中医认为是痰蒙于内所致，治宜涤痰为主。

处方：白金丸（白矾、郁金等量研末为丸）4.5克，蒙石滚痰丸（成药）9克，胆南星10克，法半夏10克，菖蒲10克，陈皮10克，附片（先熬）10克，桃仁10克，茯苓15克，桂枝10克，水煎服，每日一剂。

33. 癲 癇

癲癇俗称“羊癲风”、“母猪风”，是一种常见的疾病。其特征为发作时突然跌倒，昏不知人，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐，或口中作如猪羊叫声，不久渐渐苏醒，醒后一如常人。癲癇的发作具有突然性、暂时性与反复性三个特点。有的患者脑电图检查可有异常。

癲癇可分两大类：

（一）原发性癲癇，又称功能性癲癇。发病原因尚不明了，往往在儿童期发病，与遗传因素可能有一定的关系。脑部检

查一般无明显的病理改变。这类患者受各种因素的影响（情绪波动，饥饿，发热，强烈的声、光刺激）容易诱发癫痫。

（二）继发性癫痫，又称器质性癫痫。这类癫痫常继发于各种疾病，癫痫发作只是这些疾病的一个症状或后遗症。例如颅内肿瘤、脑血管畸形、脑动脉硬化、脑血栓形成、脑缺血、脑缺氧、脑炎、脑膜炎、脑寄生虫病、颅脑外伤、子痫、尿毒症、血糖过低、血钙减少、维生素B₆缺乏等都可引起癫痫的发作。

癫痫的临床表现多种多样，最常见的有“大发作”、“小发作”、“精神运动性发作”、“局限性发作”等四种类型，其中以“大发作”较为常见。

1.“大发作”：多数有先兆。发作前病人有头昏、上腹部不适、恐惧、心慌及感觉（嗅觉、听觉、视觉）异常，随即突然跌倒、昏迷、喉头痉挛发出异常叫声（如猪、羊叫声），呼吸停顿，全身肌肉强直痉挛，面色苍白，瞳孔散大，头和眼转向一侧，牙关紧闭，甚至咬破舌尖，口吐白沫，二便失禁，历时数十分钟后转入阵挛，肌肉变为一紧一松，经数分钟后，抽搐停止，病者进入昏睡状态，约半小时至数小时后逐渐清醒。

2.“小发作”：一时性的意识障碍，无全身性抽搐，多见于儿童。有的可有节律性瞬眼，低头，两目直视，躯干前屈，约十多秒钟意识即恢复。如果是婴幼儿，发作数秒钟即止，但往往每日多次发作。

3.“精神运动性发作”：多发于成年人，突然意识模糊，往往在工作时或睡眠中突然起立、徘徊、奔走，可持续数分钟至数小时。也有表现为恐惧，愤怒，凭空咀嚼、吞咽等反常动作。发作过后完全不自知（自己没有印象）。

4. “局限性发作”：局部肌肉抽搐，例如颜面的一侧或身体的一侧抽搐，但病人并不跌倒或昏迷，没有意识障碍。这种“局限性发作”也可转变为“大发作”。

癫痫属于祖国医学的“痫证”范畴，认为病在肝、脾、肾三脏，因脾肾两虚，肝失濡养，而肝风内动，引起抽搐。风、火与痰相结，上扰心窍，故意识丧失。

中药治疗原则，在发作时以豁痰开窍、息风定痫为主，平时则以培补脾肾为主。

发作时要使病人平卧在地上或床上，防止跌伤和骨折，迅速松解衣扣和裤带，头偏向一侧。迅速用手帕包裹筷子或竹片、木片，放入病人口中，以防咬伤舌尖。并立即针刺人中、涌泉、百会、内关、足三里等穴（强刺激）。

癫痫病一般初发者，以治标（豁痰开窍、息风定痫）为主。

处方：胆南星20克，法半夏30克，陈皮30克，浙贝母30克，菖蒲30克，远志30克，茯神30克，钩藤60克，僵蚕30克，全蝎20克，郁金30克，丹参60克，共研细末。另外用姜汁、竹沥各30克，甘草60克加水浓煎取汁，和药为丸，每丸重10克左右。发作时用开水化药丸二粒，灌服。也可于发作前有预兆时服药丸二粒。

如癫痫发作频繁，苏醒后精神萎靡，头晕心悸，腰酸肢软，食少痰多，或智力减退，言语不清，舌淡苔白，脉细。可于发作间歇期服培补脾肾之药。

处方：紫河车20克（研末冲服），党参30克，丹参30克，怀牛膝10克，茯神10克，远志10克，白术15克，枸杞20克，杜仲10克，山茱萸10克，熟地15克，水煎服。

单方验方（间歇期服用）：

① 白矾90克，郁金200克，共研细末，水泛为丸，每次服6克，菖蒲30克煎汤送服，每天服二次至三次。

② 僵蚕、蝉蜕、全蝎、蜈蚣各等分，共研细末，每次服4.5克，一天服二次，开水送服，连服半个月。

③ 蒙石滚痰丸（成药），照说明服用。

④ 蚕蛹（或柞蚕蛹）研成细末，每次服6克，一天三次，开水送服，连服三个月以上。

⑤ 蜂蛆100~200粒，油炸，一次服下，每年服2~6次。夏秋季采集露蜂房（野蜂窝），内藏幼虫，用开水烫死，晒干取出，用植物油将蜂蛆（幼虫）炸黄，一次食完。

⑥ 硼砂、黑丑、白丑各等分，共研细末，加蜂蜜制成药丸，每丸重6克，每次服一丸，一天服三次。如在夜间发作者，可在睡前一次服三丸（白天不服药）。连服三个月以上，直至痊愈。服本方可有轻微腹泻等反应，不需处理，应坚持服药。

⑦ 羌活10克，防风10克，白矾15克，郁金20克，大黄10克，牙皂1克，水煎服，每日一剂。

注意事项：

（1）癫痫病人要正确对待疾病，合理安排工作和学习，树立战胜疾病的坚强信心，克服自卑感和消极情绪。但病人不宜游泳、驾车，不要参加水上、高空、高速、高温作业，不要参加机械操作，以免在突然发病时发生危险。

（2）已查明有原发疾病（如脑肿瘤、脑寄生虫病等等）的患者，要积极治疗原发疾病，以减少或避免癫痫的发作。

（3）在间歇期要坚持服药。一般要坚持半年以上的治疗可获疗效。

（4）癫痫患者宜多吃酸性食物。科学研究表明，食物对

原发性癫痫有一定的影响。碱性食物能诱发癫痫,酸性食物则能抑制癫痫发作(指原发性癫痫)。因此,原发性癫痫患者宜多吃酸性食物。酸性食物有:花生、核桃、瘦猪肉、牛肉、羊肉、鸡、鸭、鹅、鱼、虾、蛋类等。以鸡蛋为例,鸡蛋既是营养丰富的副食佳品,亦为用途广泛的治病良药。每天用鸡蛋两个,煮熟后去壳,早晨空腹服,连服25天,可减少癫痫发作。

(5)碱性食物包括蔬菜、海带等。海带是碱性食物之王,故癫痫患者忌吃海带,也忌多吃蔬菜。

(6)癫痫患者还宜控制饮水。因为刺激间脑可引起癫痫发作。而间脑是人体水液的调节中枢,如果水喝得多,大量的液体进入体内,会加重间脑的负担,导致癫痫发作。

(7)癫痫患者还应少吃盐。有一种学说认为癫痫是神经元的过度放电而引起的。人体如果在短时间内摄入过量的食盐,钠离子可导致神经元过度放电,从而诱发癫痫。

(8)癫痫患者如果已经服用西药治疗,则不宜轻易停药。

34. 坐骨神经痛

坐骨神经痛是指坐骨神经通路及其分布区的疼痛,可分原发性、继发性两类。原发性坐骨神经痛即坐骨神经炎,是坐骨神经本身发生的病变,多与感染有关,受冷常为诱发因素。继发性坐骨神经痛主要是由其邻近组织病变(如腰椎间盘突出症、脊椎关节炎、椎管内肿瘤以及骶髂关节骨盆等部位病变)所引起。

本病的临床表现:单侧或双侧的起自腰部、臀部或大腿

后侧放射到下肢远端的疼痛。疼痛呈阵发性或持续性，可以是放射性、烧灼样或刀割样疼痛。疼痛常因行走、咳嗽、喷嚏、弯腰、排便而加剧。沿坐骨神经通路（腰、臀、大腿后侧、小腿外后侧、足背），均可有压痛点。凡牵拉坐骨神经的动作，如患肢伸直抬高，或患肢伸直足背屈，均可使疼痛加重。

坐骨神经痛，属祖国医学的“痹症”（筋痹）范畴。认为由于风寒或风湿之邪客于经络，经气阻滞，不通则痛。如迁延日久，气滞血瘀，缠绵难愈。治宜活血祛瘀止痛。

（一）气滞血瘀型：痛有定处，痛如针刺，舌质紫暗，舌有瘀点或瘀斑。

处方：当归15克，丹参30克，乳香10克，没药10克，黄芪30克，牛膝12克，鸡血藤30克，蜈蚣2条，全蝎6克，桃仁10克，水煎服。

（二）风湿阻络型：腰腿痛呈游走性，关节屈伸不利。

处方：川芎10克，红花10克，肉桂6克，独活12克，防风12克，木瓜20克，炮山甲15克，苡仁60克，桑枝30克，地龙12克，水煎服。

（三）寒湿内闭型：腰腿冷痛，麻木沉重。

处方：麻黄10克，熟地30克，鹿角霜15克，干姜12克，白芍30克，甘草10克，制川乌15克（先熬），黄芪30克，白芥子10克，水煎服。

针刺疗法对本病有较好疗效。主穴：肾俞，白环俞，环跳，承扶，殷门，委中，阳陵泉。针后配合用膏药敷贴，疗效更佳。膏药制法：生乌头半斤，醋调为糊状，入砂锅内熬至酱色为度（即熬至100℃后2分钟），摊于布上，0.5厘米厚，贴于疼痛部位，每日换药一次。

35. 梦游症

梦游症患者常在入睡1~3小时后，开门外出，从事简单的和复杂的活动等，次日醒来，对昨夜的所作所为不能回忆。

现代医学认为梦游症是在睡眠过程中出现的无意识活动，是睡眠障碍的一种表现，是由于大脑皮层兴奋过程与抑制过程彼此间的失调造成皮层与皮层下中枢相互作用失调，产生从睡眠状态进入一种意识障碍状态的表现。“梦游症”类似于祖国医学的“心神不宁”、“神不守舍”。祖国医学认为，心是精神所藏之处，《灵枢·邪客篇》：“心者，……精神之所舍也……”，病邪犯心或精神刺激过度而出现的神志异常，均可称为“神不守舍”。

中医对于梦游症的治疗，着重在于重镇安神。

处方：制首乌45克，夜交藤45克，磁石30克，代赭石30克，生牡蛎30克，刺五加30克，五味子15克，琥珀粉10克。水煎服，每日一剂（此为成人剂量，儿童酌减）。

方中首乌有轻泻作用，服药后患者有轻泻的反应，不需处理。

方中首乌、夜交藤，均能补肝肾、益精血、养心安神；磁石安神潜阳；代赭石平肝降逆；牡蛎养阴潜阳；琥珀镇静活血，五味子能减轻疲劳，提高机体的工作效能，动物实验证明，一定剂量的五味子可增加动物的兴奋与抑制过程并能促使相互间的平衡；刺五加有促进机体防御能力，增加机体对

外界有害刺激因素的抵抗能力，并有镇静、降压等作用，无毒性反应，国外研究认为本品有与人参类同的强壮补益作用。以上诸药合用，有镇静安神、养阴潜阳的作用，并能提高机体的抗病能力，是治疗梦游症的有效方剂。

针灸治疗梦游症也有效果。

体针：风池，人中，大椎，合谷，内关，通里，神门，足三里，三阴交，太冲。交替使用，每日一次。

耳针：心，交感，神门，脑。每日一次。

36. 小舞蹈病

急性风湿病以心脏、关节受累为主，神经系统亦可发生病变。小舞蹈病即是急性风湿病累及神经系统的一种表现，故又称风湿性舞蹈病或风湿性脑病。

小舞蹈病多见于5—12岁儿童，女孩发病较多。病因与风湿有关。

小舞蹈病起病较缓慢，早期症状不甚明显，患儿注意力分散，学业退步，肢体动作笨拙，字迹歪斜，手中拿的物体如钢笔、筷子等常失落。过一段时期之后，即出现舞蹈动作，肢体不自主的、不规则的运动，头部扭动，颜面肌肉抽搐，也可引起奇异面容和语言障碍。还可以有急性风湿病的其他表现如发热，周围血象的白细胞增多，血沉增快，血清抗链球菌溶血素“O”滴定度增加等。

祖国医学认为小舞蹈病系风邪外受，引动肝风所致。“诸风掉眩，皆属于肝”，“风胜则动”，小舞蹈病这种振掉多动的现象，为风之征象，为肝之证候，治以散风平肝为主。

处方：羌活10克，菊花10克，钩藤10克，白芍15克，白附子10克，天南星6克，白芷10克，天麻10克，珍珠母20克，生石决明20克，水煎服。

有的病人体质虚弱，气血不足，有风湿病史，四肢不自主运动，摇头眨眼，伸舌耸肩，不能穿衣吃饭，属虚风内生，又当治以补气益血，祛风除湿。

处方：黄芪30克，党参30克，当归10克，川芎10克，赤芍10克，熟地12克，茯苓10克，白术10克，桂枝10克，钩藤10克，桑枝30克，水煎服。

病久挟瘀者，可见舌有瘀点或瘀斑，酌加桃仁、红花。湿热偏重者，伴有胸闷，头重如裹，舌红，苔黄，脉数，加龙胆草、黄芩。

针灸治疗小舞蹈病也有较好疗效。取穴：百会、风池、大椎、哑门、肩贞、环跳、曲池、外关、合谷。

37. 重症肌无力

重症肌无力是由于神经与横纹肌之间传导障碍的一种慢性疾患。这种病多发生于15~35岁的女性。最突出的症状是受累的横纹肌活动后疲乏无力，而休息后又有程度不等的恢复。病人早晨起床时情况较好，到了夜晚，肌肉无力的情况就加重。横纹肌长期异常疲乏无力，不能随意运动。各个病人受累的肌肉不同，同一病人不同时期受累的肌肉也不同。最多见的是眼肌无力（眼睑下垂）或肢体无力。具体症状有：眼睑下垂，眼球歪斜，转动障碍，复视，面肌无力，说话无力，闭目无力，咀嚼、吞咽均无力（吞咽困难），下颌下垂无

力闭合，颈项抬不起，喝的水可从鼻孔中流出。呼吸道的分泌物无力咳出，可引起窒息。四肢无力的症状最早表现为上肢疲乏无力，如洗脸无力，梳头无力，继后又感到下肢无力，步行艰难。

多数患者的病情时轻时重。少数患者病情逐渐发展，可导致全身肌肉无力。如果延髓肌和呼吸肌受累(呼吸困难)也可危及生命。

重症肌无力的发病原理，至今尚未完全研究清楚。病人常伴有全身性红斑狼疮或硬皮病、类风湿性关节炎等疾病。此外，感染、情绪刺激、过度疲劳、创伤、分娩、应用某些药物(奎宁、奎尼丁、巴比妥类等)也可以诱发重症肌无力，或促使病情加重(应用氯丙嗪、链霉素、新霉素、卡那霉素等，均能使病情加重)。

在临床工作中，对重症肌无力病人要注意护理，嘱病人要避免疲劳，并要预防和及时治疗各种感染。病人的生活环境要稳定，平时应注意保持身体健康，培养革命乐观主义精神和战胜疾病的坚强信心。

重症肌无力属于祖国医学的“痿症”范畴，认为元气败伤，精虚血虚，导致“痿瘳”。临床上分为“脾气虚弱”、“肝肾阴虚”、“脾肾阳虚”等几种类型。

1. 脾气虚弱型：除了具有上面所说的“重症肌无力”的典型症状外，还有食欲不振等脾胃虚弱的表现。

处方：黄芪30克，人参30克(嚼服)，白术20克，升麻10克，柴胡10克，陈皮10克。水煎服。

2. 肝肾阴虚型：除了重症肌无力的症状外，还有头昏、目眩、遗精等表现。

处方：人参30克(嚼服)，胎盘粉20克(冲服)，熟地30

克，山药30克，枸杞30克，龟版30克，山茱萸12克，白术20克。水煎服，

3. 脾肾阳虚型：除了重症肌无力的症状外，还有怕冷，性欲减退，阴茎及龟头冰凉等表现。

处方：人参30克（嚼服），胎盘粉20克（冲服），鹿角胶30克（兑服），附片30克（先熬二小时），山茱萸15克，肉桂6克，山药30克，枸杞30克，黄芪30克。水煎服。

中医治疗重症肌无力，重点在于培补脾肾，认为“先天之本在肾，后天之本在脾”。培补脾肾的药物如人参、黄芪、鹿角胶、熟地、枸杞、胎盘粉等，均有一定的免疫作用。

单方验方：

1. 熟地60克，当归30克，黄芪60克，党参30克，炖羊肉服之。

2. 全鹿丸（成药），照说明服用。

3. 鹿茸精（成药），照说明服用。

4. 全鸽汤：鸽子一个，宰杀后去毛及内脏（内脏可炒食），整个鸽子放砂锅内加水炖熟，吃时可加盐、味精、胡椒粉等调料。

5. 虾子50克，洗净，锅中放菜油，虾炒至呈红色，烹以料酒、酱油，加葱即可食用。此为一日量。

38. 多汗症

出汗过多是一种症状，许多疾病，如风湿病，风湿性心脏病、细菌性心内膜炎、心包炎、克山病、心脏神经官能症、结核病、维生素D缺乏病、慢性白血病、粒细胞缺乏症、白

细胞减少症、某些金属中毒、某些药物中毒以及一些神经系统疾病等等，都有出汗的症状。高烧病人热骤退时常伴有大量的出汗。疼痛、精神紧张、休克均可出汗（出冷汗）。

对于上面所说的出汗症状，首先要积极治疗这些原发疾病，原发疾病治愈或好转了，出汗症状也就随之而消失或减轻。

医学上还有一种原发性多汗症，通常对称地在身体两侧比较局限的部位如手、脚、面颊出汗。在受热、精神紧张、情绪兴奋或吃刺激性食物的时候，出汗更为明显。

中医把多汗分为自汗和盗汗两种。白天出汗或睡在床上醒着的时候出汗，称为自汗；晚上睡着了的时候出汗，称为盗汗。

中医认为自汗是表虚，由于阳气虚弱，卫外功能不固，肌腠不密，因而出汗不止。治疗当以敛汗固表为主。

处方：

①黄芪120克，白术80克，防风60克，共研细末，每次服10克，早晚各服一次，开水吞服。连服一个月。如果平时怕冷的，还可加制附片40克，沙炒后研成细末，与上药和匀，同服。

②党参10克，麦冬10克，五味子10克，牡蛎30克，浮小麦30克，大枣30克，甘草10克，糯稻根30克，水煎服，每日一剂，分三次服。

③黄芪20克，白芍20克，桂枝10克，生姜10克，大枣10克，甘草10克，水煎服，每日一剂。市上有黄芪建中丸（成药）出售，每次服一丸（重约10克），一天服三次。

④平时怕冷，阳虚自汗者，可用黄芪30克，制附片20克（先熬二小时）水煎服，每日一剂。

⑤自汗不止，气短，处于休克状态者，可用红参10~30克，嚼服。或用人参30克，制附片30克（先熬）水煎服，亦可静脉注射中药参附针。

⑥用针灸疗法治疗多汗症（可调整植物神经功能），常能取得很好的疗效。取穴：合谷、后溪、复溜、大椎、内关、劳宫。留针15分钟。每次任选三穴，每日针刺一次，两周为一疗程。每疗程之间间歇二天。

平时没有表虚自汗的症状，而在感冒伤风的时候出现自汗、怕风等症状（这种情况很常见），中医认为这种自汗不是表虚，而是邪实，不应采用以上办法治疗，而应该用专门治疗伤风自汗的桂枝汤（桂枝10克，白芍10克，生姜10克，大枣12克，甘草10克）治疗。

中医认为盗汗是阴虚，由于阴液被火蒸越外出，而成盗汗。治疗当以养阴清火为主。

方一：当归、生地、熟地、黄芩、黄连、黄柏各10克，黄芪20克，水煎服，每日一剂。

方二：牡蛎30克，黄芪、麻黄根各20克，水煎服，每日一剂（注：中药房配药时应注意，麻黄根不能误配为麻黄，因麻黄的作用是发汗，而麻黄根的作用是止汗）这个方剂既可用于阴虚盗汗，又可用于表虚自汗。

这里需要说明一下：如果检查不出有原发疾病，但有多汗（包括自汗和盗汗）症状，或虽已查出原发疾病，但多汗症状十分突出，在这种情况下，均可用上面介绍的方法治疗。

39. 闭汗症

闭汗症可分全身性与局限性两种。全身性闭汗症多由神经系统疾病引起，局限性闭汗症多由皮肤病引起。在这种情况下，应该首先治疗原发疾病。

也有一些人，检查不出来有全身性疾病和局限性疾病，但是，闭汗症状却很明显，即使在烈日下曝晒、作剧烈的运动或重体力劳动，都不出汗。在这种情况下，可选用下列方剂治疗。

①有肾阳虚症状的，平时怕冷，舌质淡，舌胖嫩，脉缓，可用：制附片（先熬二小时）20克，肉桂6克，女贞子20克，山药20克，熟地20克，丹皮10克，茯苓10克，泽泻10克，党参30克，水煎服，每日一剂。

②有肺阴不足症状的，平时乏力，口干，烦躁，舌多裂纹，舌苔花剥，可用：生石膏30克，玄参、生地、太子参、桑白皮各12克，阿胶、山药、葛根、知母、滑石、甘草、薄荷各10克，水煎服，每日一剂。

40. 贫血

医学上的贫血，并不是象一般人所理解的只是身体里面血液的贫乏或缺少，而是指血液中缺少红血球或红血球的主要成份血红蛋白。当然，在血液缺少（失血）的情况下，红血球及血红蛋白都要减少，可以列入贫血的范围。在某些情

况下，虽然血液总量没有显著减少，但是其中红血球的数量减少了，或者红血球的主要成份血红蛋白减少了，也都算是贫血。红血球的数量在正常人每一立方毫米的血液中有450万个，血红蛋白的含量在正常人每一百毫升血液中有13~14克，若明显低于这些标准，就可算成贫血。

贫血的原因虽多，但从发病的机理来说，主要有造血不良、红血球过度破坏、失血（外伤、胃肠溃疡、痔疮便血、月经过多等失血）等三种类型。

任何原因引起的贫血都有其共同的症状，大家比较熟悉的是较重的贫血，出现面色苍白，指甲苍白，但更重要的是全身组织因缺氧而发生的变化。

人们由鼻吸进的氧气到肺后就进入血液循环，由红血球将氧气带到全身各组织细胞去，以供给这些细胞的新陈代谢之用。当贫血时，红血球数和血红蛋白量减少了，带氧的能力就小了，全身组织就产生缺氧情况，症状也由此而产生。当脑细胞缺氧时，就觉得头晕，记忆力减退，注意力较难集中；当肌肉细胞缺氧时，就感觉全身乏力或疲倦；胃肠道细胞缺氧时就出现胃肠道功能紊乱，如食欲不振、恶心、腹胀、腹泻等现象；肾脏缺氧时可出现肾功能异常。当活动量增加时，全身组织对氧的需要更多了，故更显得缺氧，这时病人就表现出气急现象。在严重贫血时，就是活动量不增加，也会有气急表现。

一般轻度贫血时对心脏影响不大，中度贫血时可出现心跳加快，病人觉得心慌，心脏搏动很强，在心尖区用听诊器可闻及杂音。在严重贫血时，心脏缺氧明显，可出现心电图的不正常，最后导致全心扩大，心力衰竭。

以上是所有贫血都可出现的共同症状，但由于引起贫血

的原因不同，还可有其特殊的表现。如缺铁性贫血可有反甲（手指甲反卷起来）；巨幼红细胞贫血可有舌炎、周围神经炎等现象；溶血性贫血可有黄疸、酱油色尿、关节酸痛等表现；由肿瘤引起的贫血还可有原发疾病（肿瘤）的一些表现。

贫血的治疗一定要针对病因，如因失血引起的贫血首先要止血，钩虫病引起的贫血首先要驱钩虫，感染引起的贫血首先要控制感染，造血物质缺乏引起的贫血就要补充造血物质，等等。

中医治疗血虚有“心肝血虚”、“脾气虚衰”、“肾阳虚衰”、“肝肾阴虚”的区别。

1. 心肝血虚：面色苍白，心悸，怔忡，失眠，健忘，眩晕，耳鸣，舌质淡红，脉细数。

处方：党参30克，黄芪30克，白术10克，茯神10克，远志10克，酸枣仁10克，龙眼肉12克，木香10克，生姜10克，大枣30克，炙甘草10克，当归12克，熟地12克，白芍12克，川芎10克。水煎服。

2. 脾气虚衰：食少便溏，腹胀，神疲，乏力，舌质胖淡，苔白腻，脉濡。

处方：陈皮10克，党参30克，茯苓12克，白术12克，甘草10克。水煎服。

3. 肾阳虚衰：畏冷，四肢凉，头晕，耳鸣，腰腿酸，阳萎早泄，性欲减退，面色晄白，舌胖苔白，脉沉细。

处方：桂附地黄丸（成药），照说明服。

4. 肝肾阴虚：眩晕，耳鸣，眼花，腰腿无力，筋骨酸软，心烦失眠，潮热，口干，尿黄，大便结燥，舌质红，脉细数。

处方：龟版30克（醋炙，先熬），白芍20克，生地15克。

阿胶12克（冲服），当归12克，玄参12克，紫河车12克（研末，兑服），杜仲10克，淮牛膝10克。水煎服。

上面已经谈过，贫血是一种症状，而不是具体的疾病，但是许多原因不同的贫血常有类似的特殊临床表现，所以也可以归纳为一种综合病征，例如缺铁性贫血、再生障碍性贫血等。下面再分别叙述。

41. 缺铁性贫血

缺铁性贫血是体内存铁量减少，不能满足正常造血需要所引起的贫血。这是最常见的一种贫血。

铁为形成血红蛋白所必需的原料，缺铁可使血红蛋白的合成减少，引起贫血。缺铁性贫血的特点是血液中的血红蛋白含量明显的减少。引起缺铁性贫血的常见病因是：

1. 铁的摄入不足或吸收障碍：哺乳期婴儿、生长期儿童，铁的需要量增加，如不及时补充含铁较多的副食品，很容易发生缺铁性贫血。妇女孕期内约有400~500毫克铁输入胎儿体内。分娩期及哺乳期铁耗损也大，都容易造成铁的缺乏。

萎缩性胃炎、胃癌、胃肠手术后，由于胃酸缺乏，影响食物中铁的游离及转化；慢性腹泻及肠道功能紊乱等都可影响铁的吸收。

2. 铁丧失过多：慢性反复失血（胃肠溃疡、鼻衄血、功能性子宫出血、痔疮出血等），由于铁的长期损失，以致发生缺铁性贫血。

钩虫病是农村中缺铁性贫血患者的重要病因。

缺铁性贫血的临床表现：与其他贫血大致相似，常见面色苍白、无力、倦怠、心悸、气急、头昏、眼花、耳鸣、食欲减退，反甲（手指甲反卷过来）、下肢轻度浮肿、心尖区可闻收缩期杂音。

方一：黄芪30克，党参30克，白术12克，当归12克，丹参15克，熟地20克。水煎服。本方适用于气血不足的缺铁性贫血患者。

方二：党参30克，白术12克，茯苓12克，陈皮10克，法半夏10克。水煎服。本方适用于脾胃虚弱的缺铁性贫血患者。

方三：熟地12克，当归12克，女贞子30克，旱莲草30克，煅磁石30克，生铁落30克，党参20克，白术12克，茯苓10克，炙甘草10克。水煎服。本方适用于肝阴不足（眩晕、心悸）的缺铁性贫血患者。

治疗缺铁性贫血的单方验方：

①鸡血藤60克，水煎服，每日一剂。

②皂矾粉0.1克，开水吞服，饭后服，一日三次。

③猪肝250克，剁成泥状，加调料炒熟食用，此为一日量。

④猪血100克，豆腐50克，加调料，共炒熟佐餐。猪血中含有容易被人体吸收的血红素型铁，防治缺铁性贫血有较好疗效，并且营养丰富，还含有钾、钙、磷、镁、锌、铜等10余种微量元素，含有人体必需的优质蛋白质。吃猪血后，大便呈黑色，这是正常现象，不必惊慌。因为猪血中所含的铁质，与人体肠道内硫化氢气体发生化学反应后变成硫化铁，粪便就变成黑色粘稠发光，如柏油样。

缺铁性贫血患者的注意事项：

患者需要补充铁质。但怎样才能促进人体对铁的吸收？

这中间还有学问。

一般的说，鱼、瘦肉、动物肝脏中的铁容易被人体直接吸收和利用。缺铁性贫血患者宜常吃这些食物。高蛋白饮食可促进铁的吸收。胃肠道在酸性环境下，对铁的吸收、利用较多。动植物食品混合食用可提高铁的吸收率。大米中铁的吸收率仅1%，与肉、肝、绿叶蔬菜同食，吸收率可提高到10%以上。鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸽蛋、鹌鹑蛋与绿叶蔬菜、桔子汁同食，其铁的吸收率也可大大提高。

缺铁性贫血患者宜动植物食品混合食用。瘦肉、猪肝、菠菜、油菜、冬苋菜、黑木耳等含铁丰富的食物混合食用（交替食用），对患缺铁性贫血病人的治疗是大有好处的。

缺铁性贫血患者还应常吃含维生素C的食物和醋。维生素C和食用醋均能促进食物中铁的吸收。含铁较多的食物有动物肝、心，瘦肉，蛋黄，鱼，虾，淡菜，桂圆，芝麻酱，黄豆，黑豆，芹菜，油菜，杏，桃，李，葡萄干，红枣，橘子，柚子，无花果等。

含维生素C较丰富的食物有：橘子，广柑，酸枣，猕猴桃，蕃茄，红枣以及新鲜蔬菜等。缺铁性贫血患者宜常吃这些富含维生素C的食物，以促进铁的吸收。

缺铁性贫血患者忌偏食。儿童偏食常易导致缺铁性贫血。很多含铁丰富的食物特别是绿叶蔬菜，常因偏食而不吃，造成铁的摄入量不足。这是需要纠正的。

缺铁性贫血患者忌喝浓茶，因为茶叶中含有鞣酸，会使铁变成不溶性的铁，从而影响铁的吸收。

缺铁性贫血患者还应积极治疗胃病、鼻出血、功能性子宫出血、痔疮、钩虫病等能引起缺铁性贫血的原发疾病。

42. 再生障碍性贫血

成年人，在正常情况下，血是由骨髓和淋巴组织等造血器官制造转化而来。

再生障碍性贫血是由于骨髓造血功能减退或衰竭，以致全血细胞（红细胞、白细胞、血小板）减少，引起贫血。

再生障碍性贫血的病因，有些至今仍未阐明，已查明的发病因素有下列几种：

1. 化学因素：接触或服用苯类、重金属类（砷、汞、镉、铊等）、抗菌素类（氯霉素、合霉素、金霉素等）、磺胺类、镇静类（巴比妥类、氯丙嗪）、抗肿瘤类药物等。

2. 物理因素：各种电离辐射，如X线、放射性同位素、镭等，长期过量接触和应用，可以抑制骨髓造血功能。

3. 生物性因素：严重细菌感染（如粟粒性结核、肺炎、伤寒等）时的细菌毒素可抑制骨髓的造血。病毒感染（如传染性肝炎）、原虫感染（如黑热病）等偶可引起再生障碍性贫血。

4. 由于骨髓本身的疾患，骨髓造血组织遭到排挤或破坏。

5. 某些疾病的晚期，如长期未经彻底治疗的贫血、慢性肾功能衰竭等。

再生障碍性贫血的临床表现具有三个主要特点，即贫血、出血和反复感染。造血功能障碍是最根本的问题，也是引起出血和感染的重要环节。

再生障碍性贫血分急性型和慢性型两种。

急性型较少见，起病急，发展快，在短期内贫血、出血和感染三方面的症状可以发展得很严重，往往在数月内死亡。

慢性型：起病缓慢，常见症状有疲倦乏力、气急、面色苍白等。病人常有出血症状，如皮肤粘膜瘀点，鼻衄，牙龈出血，月经过多等。如果颅内出血，往往危及生命。病人身体内的防御机能减退，容易有各种感染和发热，如口腔炎、齿龈炎、扁桃体炎和溃疡等。

再生障碍性贫血病人要注意避免应用任何能损伤骨髓造血功能的药物。有病因的要去除病因。

再生障碍性贫血的治疗，难度较大。中药对再生障碍性贫血有一定疗效，各地实行中西医结合治疗本病，在提高疗效方面已取得了可喜的成绩。

祖国医学认为本病属“虚劳”、“血证”范畴。脾为生化之源，后天之本，有生血、统血功能。肾为先天之本，主骨生髓。脾肾虚弱，可使骨髓不足，造血障碍。而且脾虚之后，肾的精气得不到补充，以致肾阳虚衰；而肾阳不足，不能温煦脾阳，使脾阳更虚，两者互为因果。因此，在治疗方面应从脾肾着手，气血、阴阳并补。

中医治疗再生障碍性贫血一般分为“气血双亏”、“肝肾阴虚”、“脾肾阳虚”等类型。

1. 气血双亏型：这种类型的病人病情比较稳定，病情较轻。具体症状有：气短乏力，动则气促，面色淡白，食少，脘闷，舌质淡，苔白，脉虚无力。

处方：黄芪30克，党参30克，白芍15克，当归12克，阿胶12克，熟地15克，龙眼肉12克，大枣30克，陈皮10克，甘草10克。水煎服每日一剂。或服成药归脾丸（照说明服）。

2.肝肾阴虚型：见于病情较重的病人。症状有：眩晕，耳鸣，面色苍白，心悸气急，腰痛，腿酸，足膝无力，或有口干，咽痛，手足心热，舌苔少，脉细数。

处方：女贞子30克，旱莲草30克，生地15克，熟地15克，枸杞15克，山茱萸12克，桑椹子30克，黄精12克，菟丝子12克，首乌15克。水煎服，每日一剂。或配合服成药二至丸、河车大造丸。

3.脾肾阳虚型：见于病情严重患者。症状：怕冷，四肢不温，面色苍白，头晕，眼花，耳鸣，精神萎靡，心悸气急，舌质淡胖，舌边有齿痕，脉细弱或浮大无力。

处方：熟地15克，鹿角胶15克，补骨脂12克，肉桂6克，肉苁蓉12克，巴戟天12克，黄芪30克，当归12克。水煎服，每日一剂。或服成药右归丸（照说明服）。

有出血症状者，可加服成药十灰丸或加用生地15克，白茅根30克，藕节20克，仙鹤草30克，三七粉3~6克。

伴有感染发热者，可在补气血补脾肾的基础上，加用清热解毒药物如银花15克，连翘15克，蒲公英20克，大青叶20克。

再生障碍性贫血是一种慢性病，可将下列中药加工制成蜜丸常服。

处方：生地100克，熟地100克，黄芪100克，党参100克，当归60克，首乌100克，枸杞100克，女贞子100克，旱莲草100克，胎盘粉200克，巴戟60克，仙鹤草100克，赤芍60克，三七粉30克，共研细末，加牛骨髓1000克及炼蜜为丸，每丸重10克，早中晚各服2丸。

值得提出的是，牛骨髓和胎盘粉治疗再生障碍性贫血有良好疗效。牛骨髓能促进红细胞生成，补肾益气，填骨髓，

治精血亏损，虚劳羸瘦等症。紫河车能增强机体抵抗力，增加白细胞，还有免疫及抗感染、抗过敏等作用，大补元气，补血益精，治诸虚百损，体瘦血枯，均有良效。

再生障碍性贫血患者，要长期坚持服药，还要保持乐观主义情绪，从事适当的体育锻炼，如太极拳、气功等。这对疾病的治疗，有重要意义。

治疗再生障碍性贫血的单方验方（最好能长期服用）：

①鲜胎盘一个，生姜20克，炖瘦猪肉吃，每周一剂。

②鸡蛋3个，牛骨髓30克，阿胶30克，大枣60克，煮服，每日一剂。

③鸡血藤100克（加水浓煎），鸡蛋4个，共煮服，每日一剂。

④鱼鳔胶50克，动物骨250克。动物骨先熬汤，汤熟后加入鱼鳔胶再煮，喝汤吃鱼鳔胶。

43. 血小板减少性紫癜

血小板减少性紫癜是出血性疾病中常见的一种。临床表现为皮肤出现瘀点或瘀斑，粘膜及其他器官出血，血小板大量减少（5万以下），多发生于儿童及青年人，女性较多。临床上有原发、继发之分。原发性者其病因至今尚未阐明（一般认为与免疫因素、脾脏对血小板的破坏及毛细血管的缺陷有关）；继发性者多由再生障碍性贫血，白血病，急性感染性疾患，脾机能亢进及药物、化学物品中毒所致。

本病属于中医“发斑”的范畴。祖国医学认为本病可因外感邪气，络脉受伤，致血不循经；或热邪传里，胃热熏蒸，

以及过食辛辣酒浆，致胃中伏热，热邪扰动阴血，血液溢于肌肤；亦可因劳倦内伤，病后体虚而脾气受伤，血失统摄，溢于络脉之外。

辨证施治：

1. 血热妄行：皮肤出现瘀点、瘀斑或皮下青紫，或伴鼻衄、齿衄、便血、尿血，或有发热，口渴，便秘舌红，苔黄，脉弦数。治宜清热解毒，凉血止血。

处方：犀角3克（水牛角屑30克代），生地30克，赤芍10克，丹皮10克，侧柏炭10克，山栀10克，紫草30克，连翘10克，小蓟10克，水煎服。

2. 阴虚火旺：紫癜较多，色鲜红，时发时止，伴有鼻衄，齿衄或月经过多，颧红，心烦，口渴，手足心热，或有潮热，盗汗，舌质红绛，少苔，脉细数。治宜滋阴降火止血。

处方：生地20克，阿胶10克，玄参15克，女贞子30克，旱莲草30克，丹皮10克，知母10克，茜草10克，侧柏叶10克。水煎服。

3. 气不摄血：反复出血，神疲乏力，头晕，目眩，食欲不振，面色苍白，舌质淡胖，脉虚细。治宜补气摄血。

处方：黄芪30克，党参30克，白术10克，熟地20克，当归12克，陈棕炭10克，血余炭10克，炙甘草10克，大枣30克，水煎服。

治疗血小板减少性紫癜的单方验方：

1. 花生米外衣30克，大枣30克，水煎，加红糖服。每日一剂。

2. 生地30克，鸡血藤45克，水煎，加紫河车粉15克冲服，每日一剂。

3. 水牛角片，每次4—8片，饭后服，每日三次，三个

月为一疗程。

4.仙鹤草30克，白茅根30克，水煎，加三七粉3克冲服。

5.黑芝麻30克，捣碎，加鸡蛋2只同煮熟，加白糖少许，一次吃下，每日一剂，连服20天。

44. 糖 尿 病

糖尿病是由于身体胰岛素分泌减少，引起糖、脂肪、蛋白质、水和无机盐代谢紊乱，而致血糖增高和排泄糖尿（尿中含有糖分）的一种慢性疾病。中年以上的人较为多见。主要临床表现有“三多一少”（多饮、多食、多尿以及体重减少）。

糖尿病发生的直接原因是胰岛素分泌减少。如果情绪不好，精神受到刺激，或因脑振荡、脑炎、脑溢血等疾病，均可引起高级神经活动功能障碍，乃至影响脑垂体、肾上腺、胰腺等，产生神经体液调节功能失常而发生糖代谢紊乱。其他，如感染、妊娠等凡能使代谢增加的因素，均使身体对胰岛素的需要量增加，使胰岛素分泌呈现相对不足，影响体内糖分的利用，使血中糖量增加，当血糖浓度升高到超过肾阈时（即肾保留葡萄糖的界限值，一般当血糖浓度超过160~180毫克%时，葡萄糖可从尿中排出），出现糖尿，而成糖尿病。

糖尿病还有遗传倾向。

糖尿病患者往往容易出现化脓性感染，肺结核，动脉硬化，神经、肾、眼部病变等并发症，严重时可发生酮症酸中毒而危及生命。

糖尿病早期常无明显自觉症状，往往在出现并发症而到

医院就医时才被发现。糖尿病一般症状表现为软弱无力，头昏嗜睡，腰酸腿痛，皮肤干燥或瘙痒，男子阳痿，女子月经不调。主要症状是“三多一少”。

糖尿病是慢性病，治疗时间较长，病人应掌握治疗知识，树立革命乐观主义的精神，增强与疾病作斗争的信心。

饮食疗法是治疗糖尿病的重要一环。关键是要适当控制主食（米、面或杂粮）的定量，每天吃主食不超过半斤，多吃蔬菜，吃适量的蛋白质（豆制品、鸡蛋、瘦肉等），忌吃糖，以减轻胰岛负担，使胰岛功能逐渐恢复，以后逐渐增加食量，以锻炼胰岛功能。

糖尿病属于祖国医学的“消渴”范围。中医认为本病多由于嗜酒厚味，损伤脾胃，运化失职，酿成内热，蕴结化燥，消谷耗津；或纵欲伤阴，肝郁化火，消烁津液，致使肺、胃、肾阴虚燥热，发为消渴。

中医治疗糖尿病（消渴），分上消（多饮为主）、中消（多食为主）、下消（多尿为主）。

上消：烦渴多饮，口干舌燥，大便如常，小便次数多，舌尖红，苔薄黄，脉洪数。

处方：黄连10克，花粉30克，生地30克，藕汁30克（兑服），地骨皮10克，玄参20克，水煎服，每日一剂。

中消：消谷善饥（吃得多），形体反瘦，大便干燥，舌苔黄燥，脉实有力。

处方：生石膏30克，生地30克，麦冬10克，知母10克，玄参20克，黄芩10克，黄连6克，沙参15克，黄精10克（大便秘结加大黄10克）。水煎服，每日一剂。

下消：①小便频数量多，尿如脂膏，或尿甜，口干舌红，脉沉细数。

处方：生地20克，山药30克，枸杞15克，黄芩10克，山茱萸12克，黄精10克，水煎服，每日一剂。

②小便频数量多，饮一溲一，形体消瘦，阳萎（女子月经不调），耳轮焦干，四肢欠温，腰膝酸软，脉沉细无力。

处方：鹿茸粉6克（兑服），生地10克，黄芪20克，五味子15克，肉苁蓉10克，山茱萸12克，红参6克（嚼服），补骨脂10克，玄参10克。水煎服，每日一剂或隔日一剂。

近代著名医家张锡纯用“滋腴饮”治疗糖尿病，每获良效。

他的处方是：黄芪15克，生地30克，山药30克，山萸肉15克，生猪胰子10克（切碎），将前四味煎汤吞服生猪胰子。

现代科学研究表明：猪胰含胰岛素，但必须在动物宰杀后30分钟内放入零下20℃急冻，才不致破坏。

黄芪、生地、山药、山茱萸均能降低血糖。

据报道，能降血糖的中药除上述四种外，尚有：天花粉、旋覆花、桑白皮、地骨皮、白芍、苍术、枸杞、黄精、泽泻、葛根、人参等。

六味地黄丸（成药）降血糖尿糖均有较好疗效。

国外研究认为葱能降血糖，对糖尿病有好处。笔者治疗五例顽固的糖尿病，均用葱作为辅助治疗，取得良效。

中医的活血祛瘀疗法治疗糖尿病（这类糖尿病患者常有舌质紫暗、舌有瘀点或瘀斑等瘀血征象），也显示了较好疗效。

处方：木香10克，当归15克，益母草30克，川芎15克，葛根30克，丹参30克，赤芍12克，黄芪30克，山药30克，苍术12克。水煎服，每日一剂。

现代医学研究，发现糖尿病患者胰腺内约有二分之一没有病理解剖上的变化，而在有变化的病例中，可以见到胰岛组

纤维增生，或由动脉硬化而造成胰腺组织有瘀血的现象。活血化瘀法有改善循环、增加血流量、软化纤维组织等作用，这些都从现代医学角度，为应用活血化瘀法治疗糖尿病提供了科学依据。

治疗糖尿病最好能做到“七宜”，“八忌”。

“七宜”是：

1. 宜戒烟酒。因为香烟里含的尼古丁和酒里含的酒精，会使血糖升高，尿糖增加，并能引起或加重并发症如心血管并发症、阳痿等等。

2. 宜穿跑鞋。因为穿柔软的跑鞋能预防糖尿病的并发症——胼胝的发生。一般说来，糖尿病患者代谢障碍，机体抵抗力较差，万一发生胼胝，很可能成为引起感染的“导火线”。糖尿病患者穿上柔软的跑鞋或旅游鞋，发生胼胝的机会大大减少。已经患有胼胝的糖尿病患者，只要穿上6个月的跑鞋，其胼胝可以缩小、变薄，甚至消失。

3. 宜喝冷开水泡的茶。这是因为茶叶中含有一种较理想的降血糖的物质，但其耐热性不强，常在开水浸泡的过程中遭到破坏。糖尿病人要用茶叶降血糖，可用冷开水泡茶喝。用冷开水泡茶，只要时间久，一样能泡出茶“味”，而且茶叶中的维生素C等物质不会被破坏，值得提倡。

4. 宜选择低糖、低脂肪、高蛋白、高纤维食品。肥胖者易患糖尿病，而体重增加会使糖尿病恶化。因此，糖尿病患者宜选择低糖、低脂肪、高蛋白、高纤维食品。尽量不吃糕点糖果，炒菜宜用植物油，宜常吃豆制品、鱼、瘦肉、花生米、大蒜、芹菜、魔芋等等。

5. 宜常吃桃、梨、菠萝、杨梅、樱桃等水果。因为这些水果中含有果胶，果胶能改变胰岛素的分泌量，可使血糖明

显下降。水果中的纤维素还可以延缓胃的排空时间，使食糜在小肠内停留较长时间，阻止食糜向消化道粘膜扩散，延缓葡萄糖的吸收。同时，糖尿病患者因多尿而丧失的维生素，也可以从水果中得到补充。

6. 宜常吃黑芝麻、葱、胡萝卜。因为常吃黑芝麻、胡萝卜可改善糖尿病患者因少吃淀粉食物而造成的乏力等症状，并能降血糖。葱，不仅能降血糖，而且能增强人体对蛋白质的利用，对糖尿病很有好处。

7. 宜常吃苦瓜、柚子、薤菜。因为这三种食物均含有胰岛素样成分，能降血糖，且营养丰富，是糖尿病人的理想食物。

“八忌”是：

1. 忌食后即躺下。食后即躺下易造成肥胖，肥胖会加重病情。

2. 忌终日久坐不活动。终日久坐不活动，易发生呼吸道感染、动脉硬化、眼部病变等并发症，故列为禁忌。

3. 忌性生活过度。糖尿病患者房事过度会使症状加重，病情缠绵不愈，形成恶性循环。

4. 忌忧郁悲哀。终日闷闷不乐，焦虑不安，势必加重病情。

5. 忌主食（米、面）过量。

6. 忌过多地摄入动物脂肪。

7. 忌进食高胆固醇食品，如动物内脏、蛋黄、肥肉、鳝鱼等。

8. 忌病情稍好立即停药。

45. 低 热

发热口温在 $37.5\sim 38.2^{\circ}\text{C}$ 者称为低热。如发热时间持续在一个月以上，称为长期低热。长期低热的病因以感染为常见，如结核病、风湿热、胆道感染、尿路感染、局部病灶感染、慢性支气管炎、慢性活动期肝炎、血吸虫病等，此外，严重贫血、恶性肿瘤、慢性白血病、胶原性疾病、甲状腺机能亢进、肝硬化等均可出现长期低热。医学上还有一种叫“功能性低热”（包括神经功能性低热、夏季低热、感染后低热）。

在某种情况下，往往对低热一时不能查明病因，必要时还需要予以治疗试验。

中医认为，低热是由外感、内伤使脏腑气血阴阳失调所致。由于感受的外邪的不同，因此有邪入少阳、湿热伤表等不同证候。内伤发热，由于五志动火，房劳伤肾，劳倦伤脾，以致脏腑气血、阴阳虚损，因此有阴虚阳扰、血虚气越、气虚阳浮等不同证候。此外，瘀血内停，阻碍气血之正常运行，使体内阴阳失调，也能导致发热。

辨证施治：

1. 邪入少阳：低热，口苦，心烦，呕吐，食纳减少。治宜和解少阳，祛邪扶正。

处方：柴胡15克，党参30克，法半夏10克，黄芩10克，甘草10克，生姜10克，大枣30克，陈皮10克。水煎服。

2. 湿热伤表：低热，胸闷腹胀，倦怠懒言，嗜睡，四肢疼痛。治宜清热化湿。

处方：茵陈30克，藿香12克，白蔻10克，连翘10克，滑石30克，佩兰10克，射干10克，黄芩10克，菖蒲10克。水煎服。

3. 阴虚阳扰：低热，眩晕颧红，午后潮热，盗汗，心悸。治宜滋阴，清降虚热。

处方：地骨皮15克，糯稻根30克，玄参20克，生地12克，秦艽12克，知母12克，水煎服。

4. 血虚气越：低热缠绵，头晕眼花，面色不华，心悸怔忡。月经涩少或闭经，舌质淡，脉沉细。治宜补血益气。

处方：熟地20克，当归12克，白芍10克，党参20克，黄芪20克，五味子12克，川芎10克，葛根15克。水煎服。

5. 气虚阳浮：长期低热，少气懒言，四肢无力，食少腹胀。治宜补中益气，甘温除热。

处方：黄芪20克，党参20克，升麻6克，柴胡6克，白术10克，生姜10克，大枣20克，陈皮10克，当归10克。水煎服。

6. 瘀血内停：低热缠绵数月或数年，乏力，口干，口唇青紫，肌肤甲错，面部黧黑，消瘦，舌有瘀点，脉多弦涩。治宜活血化瘀，调和营卫。

处方：桃仁10克，红花10克，当归12克，熟地12克，川芎10克，赤芍10克，枳壳10克，桔梗10克，牛膝12克，柴胡15克，马鞭草20克。水煎服。

妇 产 科

46. 功能性子宫出血

功能性子宫出血，又称功能失调性子宫出血，简称“功血”，是由于卵巢功能失调引起子宫内膜过度增殖或剥脱不全，造成月经不调、大出血或出血淋漓不断的一种疾病，但生殖器没有器质性病变。

功能性子宫出血可分为“无排卵型”和“有排卵型”两大类型。

1. “无排卵型”：卵巢不发生排卵，出现月经紊乱，周期缩短或延长，经血过多或淋漓不断，甚至大出血，患者往往不能怀孕。这种类型的功能性子宫出血多见于青春期或更年期妇女。

2. “有排卵型”（又称黄体功能障碍型子宫出血）：如因黄体发育不全，可出现月经提前来潮，经期延长，经血多少不一，亦可连绵不绝，常有不孕或流产的病史，如因黄体萎缩不全，可出现经期延长，经量或多或少但月经周期尚可正常。

功能性子宫出血患者的主要症状是子宫出血和贫血。子宫出血表现为：①月经过频（不到20天就来一次月经）。②月经过多（一次月经出血量达500~600毫升）。③子宫不规则的出血（月经周期紊乱，经期延长，血量增多，流血的时间、

出血量和出血间隔时间都不规律)。⑤绝经一年后又发生了子宫出血。

长期的子宫出血或子宫出血量大，可引起贫血。而贫血又进一步加重子宫出血，造成恶性循环。

流产、宫外孕、肿瘤及血液病等也有子宫出血现象，应注意鉴别。

功能性子宫出血属于祖国医学的崩漏范畴。但崩漏包括的范围更为广泛。经血暴下称为“崩”（崩中），经血淋漓不断称为“漏”（漏下），“崩”和“漏”可互相转化。功能性子宫出血发病的主要机理是由于冲任损伤，不能固摄经血所致。导致冲任损伤的原因，可分为血热、血瘀气滞、气虚等。

崩漏有虚实之分。虚证以气虚为主，实证以血热、血瘀气滞为多见。在治疗中应掌握“塞流”（即止血，这是治疗“崩中”首用之法）、“澄源”（清除病因，这是治疗崩漏的根本法则）、“端本”（又称“复旧”，即正本复元的意思，重在调理脾胃。这是防止复发的治法）等方法。治崩多宜固涩升提，不宜辛温行血；治漏多宜养血调气，不可偏于固摄。

1. 气虚型：骤然大量下血，或淋漓不止，时多时少，血色淡红而质稀薄，面色苍白，心悸气短，倦怠乏力，食少便溏，或腰酸腹痛，有坠胀感，舌淡苔白，脉细无力。治宜补气摄血。

处方：党参30克，黄芪30克，白术15克，棕榈炭15克，阿胶12克，当归12克，续断15克，乌贼骨30克。水煎服。如患者子宫大出血，出冷汗，四肢冰冷，脉微欲绝，宜立即嚼服红参30克，并应立即作中西医结合抢救治疗。

2. 血热型：子宫大量下血，或出血时多时少，持续不断，血色鲜红或紫红，或伴有面色潮红，口干，烦躁，睡眠

不安，午后潮热，舌红苔少，脉细数。治宜清热凉血止血，

处方：丹皮12克，生地15克，仙鹤草30克，地骨皮12克，旱莲草30克，地榆炭30克，白芍15克，茜草根炭12克，小蓟12克。水煎服。

3.血瘀气滞型：突然大量下血或出血淋漓不止，血色紫红或紫黑，有血块，下腹疼痛拒按，血块排出后腹痛可暂时缓解。舌有瘀点，脉沉涩。治宜化瘀止血。

处方：当归15克，赤芍12克，桃仁10克，红花10克，炒香附12克，山楂炭20克，血余炭10克，藕节炭10克，蒲黄炭10克，三七粉3克，乌梅20克。水煎服。

崩漏流血停止后，还应继续服药调理脾肾，巩固疗效，避免复发。特别是生育期妇女，有脾肾阳虚症状的（腰酸腿软，怕冷，疲倦，食少，等等），应服补肾药巩固疗效。

处方：补骨脂15克，仙茅15克，仙灵脾30克，枸杞20克，山萸15克，牡蛎30克，当归12克，天冬12克，艾绒炭10克，续断20克，水煎服。

治疗功能性子宫出血的单方验方：

①猪皮500克，加酱油红烧，当菜吃。

②乌梅三斤，加水浓煎，过滤去渣，装瓶备用（久贮不坏），用时加白糖适量，每次服10毫升，开水冲服，每日三次。

③补骨脂20克，天冬30克，柳枝60克，置砂锅内加水浓煎，服时加红糖适量，每日一剂，分三次服。

④贯众炭30克，蒲黄炭30克，藕节炭30克，莲房炭30克，陈棕榈炭30克，共研细末，泡开水服，每次用10克泡开水，一天三次。

⑤三七粉3克（另包），杜仲炭6克，荆芥炭6克，艾叶炭6

克，侧柏炭6克，地榆炭6克。共研细末，每次服3克，每日服2次，用米汤送服。

功能性子宫出血患者应树立革命的乐观主义情绪，对战胜疾病要有足够的信心，坚持服药（尽快止血，调整月经，纠正贫血）。出血期间精神不要紧张，应避免过度疲劳或剧烈运动，保证充分休息和睡眠，增加营养。

采取以上措施，轻症患者可加速恢复，对重症患者也可提高治疗效果。

笔者治疗数例功能性子宫出血患者，在即将治愈时，患者忽视休息，病情即出现反复。因此，避免疲劳，保证充分休息，是治疗功能性子宫出血的重要环节，应引起医生和病员的高度重视。

47. 痛 经

女子月经来潮的前后几天或月经期中，发生下腹部疼痛或其他不适，影响日常生活和劳动的，叫“痛经”，常伴有头晕、恶心、呕吐、腰骶酸痛、全身无力等。多数妇女在行经时有不同程度的盆腔不适的感觉，如果腹痛不影响日常生活和劳动的，不能一概称为痛经。

痛经可分为原发性痛经和继发性痛经两种类型。

原发性痛经多见于未生育过的年轻女子，体质衰弱或对疼痛敏感的人更易发生。于月经前一两天就出现症状：一阵阵的下腹胀痛或腰酸，严重的可牵涉到外阴、肛门等部位，持续时间可长可短，一般在经血流畅后，疼痛就逐渐消失。

原发性痛经的病因还不十分明了，精神因素可能有很大

影响。对月经现象抱有羞涩、恐惧、厌恶等心理的，痛经的就较多。内分泌失调、子宫发育不良、子宫颈狭窄、子宫位置过度前屈或后屈，都可引起痛经。有些病人的子宫内膜不成碎片而成整片排出，引起子宫肌肉强烈收缩，产生痛经，待整片内膜排出后痛经也即好转，这叫做膜样痛经，也属于原发性痛经。

继发性痛经多见于已生育过的妇女或中年妇女，一般经检查可找到发生痛经的原因如盆腔炎症、子宫内膜异位、子宫肌瘤等疾病。这种痛经常常在月经来潮之前开始，持续整个月经期间，到月经干净，盆腔充血解除，腹痛及其他症状才逐渐消退。原发疾病治愈后，这种痛经即可消失。

祖国医学认为痛经(又称经行腹痛)主要是气血运行不畅所致，即所谓“不通则痛”。导致气血运行不畅的主要原因是情志不舒，肝气郁结，气滞血瘀，或感受寒凉，瘀阻经络，(寒湿凝滞)，或体质虚弱，气血不足(气血虚弱)。

(一)气滞血瘀型：由于经期劳累过度，或精神不愉快，以致肝气郁结，气机不畅，瘀血停留，月经排出困难，“不通则痛”。表现为下腹胀痛，连及胸胁，疼痛拒按，经色紫黑有块。舌质暗红有瘀点，脉沉涩。治宜疏利肝气，活血逐瘀。

处方：当归12克，川芎10克，赤芍10克，桃仁10克，红花10克，生蒲黄10克，五灵脂10克，枳壳10克，青皮10克，柴胡10克，香附15克。水煎服。

(二)寒湿凝滞型：经期涉水、淋雨、游泳、坐卧湿地或过食生冷等，使寒湿聚积于胞宫，血得寒则凝而不畅，经血流通受阻滞而腹痛。表现为血经前或月经期中下腹冷痛，得热痛减，月经量少色暗或混有血块，面色青白，舌边紫暗，脉沉紧。治宜温经散寒，活血止痛。

处方：当归12克，赤芍12克，延胡索10克，生蒲黄10克，五灵脂10克，川芎10克，干姜10克，小茴香10克，肉桂6克，吴茱萸6克。水煎服。

(三)气血虚弱型：体质虚弱，气血不足，或大病久病之后，气血两亏。症状有：经期或行经后下腹隐隐作痛，缠绵不休，按压下腹则痛减。经色淡红，量少质稀，面色苍白或萎黄，舌色淡，脉细弱。治宜补益气血。

处方：党参30克，黄芪30克，熟地20克，首乌15克，茯苓10克，白术10克，当归12克，白芍12克，延胡索10克，郁金10克。水煎服。

单方验方：

1.生姜10克，捣烂加红糖30克，内服(本方适用于寒湿凝滞的痛经)。

2.益母草30克，香附10克，水煎服(本方适用于气滞血瘀型痛经)。

3.延胡索粉12克，每次服6克，一日两次，开水吞服。(各种类型的痛经均适用)。

4.用艾卷灸关元穴，每次灸20分钟，每日一次。(各种类型的痛经均适用)。

5.针灸：患者俯卧，用6寸毫针针刺双侧承山穴，徐徐捻转进针，以有强烈针感为度，留针15~30分钟。

痛经患者还宜采用食物疗法。兹介绍如下：

①气滞血瘀型：经期或经前小腹胀痛，月经量少，色紫暗有瘀块，块下痛减，乳房胀。

食疗方一：鸡蛋2个，川芎6克，黄酒适量。加水300毫升，同煮。鸡蛋熟后去壳再煮，再加黄酒适量同煮。吃蛋喝汤。经前三天开始服，每日一剂，连服5~7剂。

食疗方二：金橘饼150克，山楂糕500克，以上两种食品同时服。以上为5天量，于经前三天开始服用。

②寒湿凝滞型：经前或经期小腹冷痛，得热则舒，月经量少，色黑有瘀块，形寒畏冷。

食疗方一：红枣30克，干姜30克，加水煎汤，煮沸后加花椒10克，再用文火煮。每日1剂，5剂为一疗程。行经前三天开始服用。

食疗方二：鸡蛋2个，艾叶10克，生姜15克，加水同煮，蛋熟后去壳又煮5分钟，趁热喝汤吃蛋。每日一剂，5剂为一疗程，行经前三天开始服。

③气血虚弱型：行经或经净以后，小腹绵绵作痛，按之则痛减，月经量少而稀薄，神倦乏力，面色苍白。

食疗方一：乌骨鸡一只(重约1000~1500克)，去毛及内脏，洗净。黄芪150克，洗净，置鸡腹中，将鸡放入砂锅内，加水1000毫升，煮沸后，改用文火炖熟烂，放盐及味精等调料即可食用。

食疗方二：红枣100克，桂圆肉50克，当归30克，共煎水(煎30分钟)，弃去当归药渣，打入鸡蛋两个，喝汤，吃蛋、枣、桂圆。每日一剂，5剂为一疗程。行经前三天开始服。

④肝肾亏损型：经净腰酸，小腹隐痛，月经量少，色淡，头晕耳鸣。

食疗方一：韭菜150克，羊肝200克，洗净切小，铁锅急火炒熟后佐餐食用。连吃一周为一疗程。行经前五天开始服。

食疗方二：胡桃肉300克，枸杞150克，栗子150克，大米适量，共煮成粥，随意食用(枸杞须待粥煮熟后才放，不宜久煮)。行经前5天开始服用。

痛经患者应注意经期卫生：①月经期不宜过累，尽量避

免剧烈运动；②月经期应注意保暖，不下冷水，以免受寒而减低身体的抵抗力；③月经期应保持局部清洁，勤换月经带和内裤，以免细菌滋生，引起生殖器炎症；④月经期饮食宜选择新鲜而易于消化的食品，不宜吃得过饱，禁止饮酒。要多喝开水，保持大便通畅；⑤已婚女子，在月经期间应避免性生活，以免细菌侵入阴道而引起感染。

痛经患者还要正确的认识月经的生理现象，纠正对月经现象抱有羞涩、恐惧、厌恶等心理，保持乐观主义情绪；平时（指月经未来潮时）要适当参加体育锻炼和体力劳动，增强体质；适当控制性生活，以减少盆腔充血；生育不应过多过密。痛经患者不应盲目服用止痛片

48. 闭 经

闭经可分为生理性闭经和病理性闭经两种。

病理性闭经又分为原发性闭经和继发性闭经两种。

女子一般14岁来月经，如果18岁以后还没有来月经，叫原发性闭经。如果月经已经来过，中途又三个月或三个月以上不来月经，叫继发性闭经。

女子在青春期以前、绝经期以后、妊娠期及哺乳期，月经不来潮，都是正常现象，叫生理性闭经。

闭经不是一种独立的病，而是某些疾病的常见症状。

病理性闭经还可分为假性闭经和真性闭经两大类型。

假性闭经也叫隐性闭经，患者实际上有月经来潮，但因下生殖道某部（如处女膜、阴道、宫颈）有先天性缺陷或后天性损伤，使经血不能外流。

真性闭经的原因很多：

①精神因素：任何精神刺激，如恐惧、忧虑、悲哀、愤怒以及精神紧张，都可引起闭经。外界环境和生活上的改变，如旅行、迁居，也可造成暂时性的闭经。有时渴望怀孕，也能使月经暂停来潮，甚至会发生腹部膨出和早晨呕吐等假孕现象。

②子宫本身的疾病：如没有子宫，子宫发育不良，子宫内膜结核，手术或放射性物质损伤等，都可使子宫内膜遭受破坏，不能产生月经。

③卵巢和垂体的疾病：如卵巢功能不足，手术切除，放射性物质损伤，垂体坏死，或肿瘤等，都可造成闭经。

④内科疾病：一些急性、慢性病影响身体健康的，如结核病，严重的心脏病，伤寒，疟疾，贫血，长期营养不良等，都可引起闭经。甲状腺、肾上腺的一些疾患，也可引起闭经。

⑤产后大出血或产后哺乳过久，多次人工流产，子宫内膜被刮过甚，也都可以造成闭经。

一些严重疾病引起的闭经，其后果自然比较严重。闭经这种症状对健康的影响还不是太大，主要是影响生育机能。

闭经患者应尽早设法找出发病原因(到医院检查)，及时进行治疗，方能使月经恢复。如果是由于恐惧、紧张等精神因素引起的闭经，当思想负担解除后，月经也往往能自然恢复。闭经患者要适当锻炼身体，合理安排工作和生活，增加营养，哺乳不宜过久(不超过12个月)。

祖国医学把闭经分为虚(血虚)实(气滞血瘀)两大类型。虚者多为阴血亏损，血海空虚，无血可下，或肝肾两亏，精血不足，实者多因气血郁滞，瘀血内阻，胞脉不通，血不下

行。总之，这些因素是通过机体本身而引起的脏腑功能障碍，气血不足，冲任失调，造成闭经。

(一)血虚型：闭经，面色苍白，唇、指甲色淡，心悸，头晕眼花，体弱乏力，舌质淡，少苔，脉细弱。

对血虚型闭经患者的治疗应先补后攻。补血用四物汤加减。

处方：熟地15克，当归12克，白芍12克，川芎10克。脾虚气弱(食少、疲卷、气短)加党参30克，黄芪30克，肾气亏损(腰酸腿软)加菟丝子10克、怀牛膝15克、枸杞15克。水煎服，每日一剂。

补益到一定时期(相当于月经期后半期)，可在处方中加用益母草30克、丹参15克、泽兰10克、红花10克、桃仁10克，促使行经。

(二)血瘀气滞型：闭经，精神郁闷，烦躁易怒，小腹胀痛，两胁及两乳亦感胀痛，舌有紫色斑点，脉沉弦涩。

处方：当归12克，生地15克，红花10克，川牛膝12克，桃仁10克，枳壳10克，赤芍12克，桔梗10克，川芎10克，甘草6克，柴胡10克，香附10克。水煎服。

治疗闭经的单方验方：

1.鸡血藤90克，加水浓煎，加红糖适量，一日分三次内服。或服成药鸡血藤膏(照说明的剂量加倍服用)。

2.益母草30克，加水浓煎，加红糖20克，一日分三次内服，或服成药益母草膏(照说明服用)。

以上验方适用于血虚型闭经。

3.山楂60克，加水浓煎，加红糖30克，分两次服(早晚饭前空腹服)。

4.水蛭1.5克，生山药30克，加水浓煎，加红糖20克，

一日分三次服。

以上单方适用于血瘀型闭经。

49. 代偿性月经(倒经)

妇女在生殖道以外的组织和器官，由于卵巢激素的影响而发生周期性的出血，同时月经量减少甚至没有月经，称为代偿性月经(或称替代性月经)。临床上最常见的是鼻出血。现代医学认为鼻粘膜与女性生殖器官两者之间有着生理的联系，在雌激素的影响下可发生鼻粘膜周期性的出血现象。

代偿性月经，也可发生在下述部位：皮肤、痣、眼睑、外耳道、乳头、脐孔、消化道及肺、肾等处。

祖国医学对于这种代偿性月经的现象，如鼻衄、吐血等，称为逆经(又称“经行吐衄”)，俗称倒经。认为倒经的主要原因是由于肝经郁热，迫血上行，或由于肺肾阴虚，虚火燥伤血络所致。中医中药治疗倒经有明显的疗效。中医把倒经分为“肝经郁热型”和“肺肾阴虚型”两种类型：

(一)肝经郁热型：每次月经期或月经前鼻出血、吐血，出血量多，血色鲜红，伴有心烦不舒，两胁胀痛，口苦咽干，舌红苔黄，脉弦数。

处方：丹皮12克，栀子10克，白茅根30克，茜草根10克，柴胡10克，当归12克，川牛膝12克，白术10克，茯苓10克，甘草6克。水煎服。

(二)肺肾阴虚型：每次月经期或月经前出现吐血、衄血，量少，血色暗红，伴有头晕耳鸣，两颧潮红，口干却不想喝水，舌红，无苔，脉细数。

处方：熟地12克，沙参12克，白芍12克，黑荆芥10克，茯苓10克，丹皮10克，女贞子30克，旱莲草30克，当归12克，水煎服。

单方验方：

①小蓟60克，灶心土15克。水煎服

②韭菜汁一杯，童便半杯。每日服一次。连服七天。

50. 更年期综合征

妇女在自然绝经前后(称更年期)，因卵巢功能减退而出现月经不调以及情绪不安，烦躁或忧郁，阵发性面部潮红，心悸，头痛，失眠，出汗，肢麻，腹胀，便秘等一系列的植物神经系统功能紊乱症状，称之为“更年期综合征”。本病的轻重和久暂不一，严重的可影响工作与健康。

祖国医学无“更年期综合征”的病名，在“月经不调”、“眩晕”、“心悸”、“脏躁”等病症的记载中，有类似描述。祖国医学认为妇女至绝经期，肾气衰弱，冲任功能减退，发生月经由失调而断绝的自然生理变化。肾为先天之本，真阴真阳之所在，肾虚则阴阳失调，必然影响其他脏腑。若素体较弱，又兼有精神或其他因素影响，一时不能适应这种变化时，就可出现一系列阴阳平衡失调的证候。

更年期综合征的主要病理变化是肾虚，故治疗以补肾为主，随证施治。

(一)肝肾阴虚型：月经量少，面部潮红，手足心热，头晕，头痛，口干，忧郁易怒，腰酸，大便干，舌红，少苔，脉细数。

处方：生地30克，熟地30克，泽泻10克，茯苓10克，山药15克，首乌15克，枸杞15克，女贞子30克，元参10克，麦冬10克，水煎服。

汗多加浮小麦，失眠加夜交藤，腰痛加续断、寄生、补骨脂，心悸加服补心丹。

(二)脾肾阳虚型：月经量多，色淡，精神不振，怕冷，腰酸无力，食少，大便溏，大便多，舌淡苔薄，脉沉细无力。

处方：熟地30克，山药30克，山茱萸12克，白术12克，党参30克，仙茅20克，仙灵脾30克，肉桂6克。水煎服。

治疗更年期综合征的单方验方：

①仙灵脾30克，当归12克，紫草15克，栀子10克，珍珠母30克，水煎服（本方适用于下寒上热，阴阳失调的患者）。

②浮小麦30~90克，大枣30~90克，甘草10克，加水浓煎后，去掉甘草（药渣），一次服下，并淡食大枣及浮小麦（本方适用于以忧郁、烦躁为主要表现的更年期综合征患者）。

③五味子、酸枣仁、百合、当归各15克，龟版、磁石各30克，柴胡10克，甘草10克，大枣30克，水煎服（本方适用于以失眠、心悸为主要表现的更年期综合征患者）。

④针灸：主穴：大椎、关元、气海、肾俞、合谷、足三里（交替选用）。配穴：印堂，内关。每日一次，每次留针30分钟。

51. 霉菌性阴道炎

自然界的霉菌种类很多，寄生在人体里的霉菌最主要的

是白色念珠菌，它寄生在正常人体的皮肤、粘膜、消化道或其他脏器中，也在阴道中寄生但不发生危害。当人体抵抗力减弱的情况下，阴道中的霉菌大量繁殖，引起炎症，即霉菌性阴道炎。

霉菌性阴道炎多见于幼女、孕妇、患糖尿病的妇女及绝经后曾用过较大剂量的雌激素治疗的妇女。大量用抗菌素及肾上腺皮质激素治病的妇女也容易得霉菌性阴道炎。维生素B缺乏、严重的传染性疾病及其他消耗性疾病的女性患者也容易得霉菌性阴道炎。

霉菌性阴道炎的主要症状是外阴、阴道奇痒，严重时可使患者坐立不安，影响工作和睡眠。还有一个突出的症状是白带增多，白带呈乳白色凝块状(象豆渣样)。

霉菌性阴道炎病人阴道粘膜充血，有时覆盖一层小片状膜样分泌物，不易擦掉，剥掉后见粘膜发红出血。

取患者的白带少许放玻片上，在显微镜下检查可找到霉菌。

霉菌性阴道炎属于祖国医学的“阴痒”、“带下症”范畴，多因外阴不洁，湿热湿毒之邪内侵，或湿热下注、肝肾阴虚而致。治宜祛湿清热，解毒杀虫，多采用外治法。

①千里光片(或胶囊)放入阴道内，每日一次，每次三片，也可用纱布或棉球蘸浓缩药液塞入阴道内，每天换药一次，七天为一疗程。

②黄连、青黛、芒硝各等份，共研细末，加甘油少许搅匀，涂外阴和阴道，每日早晚各涂药一次，七天为一疗程。

③苦参30克，蛇床子30克，龙胆草20克，川椒10克，黄芩15克，加水浓煎，一日分二次内服，同时用此药液涂擦外阴和阴道。

④黄柏30克，贯众30克，苦参30克，羌薺20克，加水浓煎，用棉签蘸药液涂搽外阴及阴道，每日二次。也可用带线棉球蘸药液塞入阴道内，每天换药一次。

霉菌性阴道炎的预防：

注意合理应用广谱抗菌素及激素类药物。糖尿病患者应特别注意皮肤及外阴的清洁。

霉菌性阴道炎还可通过性交互相传染，所以，在治疗期间应避免性生活，而且夫妇双方应同时进行治疗。

52. 滴虫性阴道炎

滴虫性阴道炎是由一种叫滴虫的原虫所引起的一种阴道炎症，是一种常见的妇科病。滴虫要在显微镜下才能看到。滴虫在温暖、潮湿的环境下，可以活得很久，接触到它的人很容易受感染。所以，滴虫性阴道炎还是一种传染病。

滴虫性阴道炎的传染方式有直接传染和间接传染两种。

(一)直接传染：通过性交，男女互相传染。

(二)间接传染：主要通过公共浴池、浴盆、公用马桶而互相传染，或通过带滴虫者的内裤、月经带而传染，或与带滴虫者同床，或因大小便后肠道滴虫进入阴道，或用含有滴虫的生水冲洗阴道或擦洗外阴而传染。有时作妇科检查，医务人员消毒不严也可引起交叉感染。

得了滴虫性阴道炎有些什么症状呢？

1.主要症状是白带增多，阴道有刺痛和烧灼感。由于阴道分泌物增多，刺激外阴，可引起外阴瘙痒。

2.白带的特点是泡沫样，也有水样或稀脓样的，有时呈

黄绿色，有时呈乳白色，有时带粉红色，有腥臭味。

3.阴道粘膜发红，有红色小斑点。

4.当尿道、膀胱合并感染时，有尿痛、尿频等症状。

5.滴虫感染严重的，可引起不孕。

6.用棉签取白带少许，放在滴有生理盐水的玻片上，在显微镜下观察，可看到活动的滴虫。

祖国医学无“滴虫性阴道炎”的病名，其症状表现类似于“阴痒”。多因外阴不洁，虫蚀感染，或湿热蕴结流注于下所致。治宜祛湿杀虫。

1.黄连10克，黄柏10克，地肤子10克，水煎，用棉球蘸药液塞入阴道，12小时后取出，每日一次，10次为一疗程。

2.雄黄10克，蛇床子30克，共研细末，蜜制为丸，每丸重3克，用纱布包好，留线半尺，睡前塞入阴道内，第二天早晨取出，连用六天为一疗程。

3.五倍子40克，蛇床子10克，黄柏10克，冰片1克，共研细末，用糯米纸包好，每包3克，睡前塞入阴道内，连用六天为一疗程。

4.苦参60克，白头翁60克，加水1000毫升，煎成700毫升，冲洗阴道，每日一次，六次为一疗程。

5.萝葡汁5毫升，食醋5毫升，混合，睡前用带线棉球蘸萝葡汁食醋混合液塞入阴道，第二天早晨取出，六次为一疗程。

6.桃树叶一斤，水煎坐浴，同时用带线棉球蘸桃树叶液塞入阴道内，每日换一次，连用15天。

中药治疗滴虫性阴道炎的方法虽多，但由于阴道壁有很多皱褶，隐藏在皱褶里的滴虫，常因接触不到药液而未被消灭，到了月经期就可复发。因此，治疗后即使症状消失了，

每次月经后仍要继续用药5—10天，这样连续用药三个月，才能彻底治愈。而且，在治疗期间要避免性交，患者的丈夫也要同时治疗。

滴虫性阴道炎的预防：

注意个人卫生和公共卫生，公共浴室要采用淋浴，公用毛巾应煮沸消毒，公共厕所应采用蹲式，不借用别人的内裤、月经带、洗澡毛巾及脚盆等。母亲患有滴虫性阴道炎，最好不要与女儿同床共被，也不能共用一个脚盆洗下身。

53. 女阴瘙痒症

女阴瘙痒症虽然不是一种严重危害身体健康的疾病，但是这种症状给患者的思想负担、精神痛苦是十分严重的。瘙痒往往是持续不断的，但时轻时重，夜晚加重，常常影响睡眠。瘙痒严重的时候，坐卧不安，影响工作。患者精神痛苦，性情变得急躁。局部因搔抓而形成抓痕，皮肤粗糙，甚至造成感染。

引起女阴瘙痒症的原因有：

1. 局部原因：①各种女阴炎症如皮炎、女阴毛囊炎、女阴湿疹、女阴白斑等，都能使阴部刺痒。②不注意经期卫生和局部清洁，用不干净的水洗阴部都能引起外阴刺痒。③阴道炎症和宫颈炎症，使白带增多，造成刺激，引起外阴瘙痒（特别是滴虫性阴道炎和霉菌性阴道炎，局部奇痒是主要症状）。④女阴周围有寄生虫感染，如蛲虫、阴虱，引起瘙痒。

2. 全身原因：糖尿病、绝经后的卵巢内分泌功能减退、慢性药物中毒、过敏反应等均可出现女阴瘙痒的症状。

3.精神因素：有时由于上面所说的某种原因产生外阴瘙痒，但在疾病治好後，有些精神紧张的患者，往往仍有瘙痒的感觉。

祖国医学认为女阴瘙痒(阴痒，又称阴蜇)有“湿热下注”和“肝肾阴虚”两种类型。“湿热下注”，多因忽视卫生，感染虫病，或肝经湿热，挟湿下注所致。在治疗上，以清热解毒、化湿、杀虫为主，再配合熏洗等外治法，则效果更好。肝肾阴虚由于久病或年老体弱，肝肾不足，精血两亏，血虚生风化燥，致令阴痒。

湿热下注型：阴痒甚则疼痛，带下多色黄如脓或呈泡沫状，心烦少寐，口苦而腻，胸闷不适，食少，小便黄，舌苔黄腻，脉滑数。

(一) 内服药

方一：苍术12克，黄柏12克，川牛膝12克，白芷10克，苦参20克，赤芍10克，土茯苓30克，银花30克(无银花，可用银花藤60克代替)。水煎服。

方二：当归15克，白芍15克，生地12克，荆芥12克，防风12克，白花蛇舌草30克，半枝莲30克，半边莲30克，水煎服。

(二) 外用药

①苍耳子，千里光各60克，煎汤坐浴。每日1~2次。

②鹤虱30克，蛇床子30克，百部30克，苦参30克。煎汤熏洗，每日1—2次。

③枯矾30克，花椒10克，土槿皮20克，煎汤熏洗，每日1—2次。

④狼毒10克，威灵仙15克，龙胆草10克，白藓皮15克，鱼腥草15克，煎汤熏洗，每日1—2次。

⑤防风12克，荆芥12克，透骨草15克，银花18克，煎水熏洗，每日早晚各一次。

⑥鸦胆子15克，加水浓煎，熏洗患处，每日早晚各一次。

肝肾阴虚型：阴部干涩灼热或瘙痒，五心烦热，头晕目眩，时有烘热汗出，口干，耳鸣，腰酸，舌质红，少苔，脉细数。治宜滋阴降火，调补肝肾。

处方：生地20克，泽泻10克，丹皮10克，山茱萸10克，山药30克，茯苓10克，知母10克，黄柏10克，水煎服。

⑦杏仁50个，枯矾末3克，硫磺末3克，雄黄末1.5克，白芨末适量。杏仁捣泥，加入硫磺、枯矾、白芨末水泛为丸，雄黄末为衣，调糊外搽。

注意事项：

- 1.得了外阴瘙痒症，要积极寻找原因，去除病根。
- 2.养成讲卫生、爱清洁的良好习惯，注意局部清洁。农村中如果河水，塘水较脏，最好用井水或其他清洁的水清洗外阴，或将河水，塘水烧开后清洗外阴。
- 3.保持外阴干燥，得了外阴瘙痒症后不要用热水和肥皂水烫擦，尽量避免搔抓，还要勤换内裤。

54. 女阴白斑症

妇女外阴部皮肤发白、干燥、肥厚，并且失去弹性，这种病叫“女阴白斑症”。一般多局限于外阴部，严重时也会蔓延到会阴部，甚至肛门周围。

女阴白斑症多发生于40岁以上的妇女。开始时阴部出现红肿，以后皮肤变白、变厚（皮肤微隆起发硬，不易推动）、

变干，小阴唇反而缩小。主要症状是瘙痒。这种瘙痒常常难以忍耐，严重时皮肤可以发生裂纹和溃疡，并有隐痛或剧痛。

女阴白斑症必须与白癜风相区别。白癜风不痒，皮肤的弹性和厚度没有变化，而且身体其他部位也有白斑(白癩)。

女阴白斑症与早期女阴癌就不那么容易区别了，所以，得了女阴白斑症的病人应及早到医院检查治疗。

女阴白斑症的发病原因尚不明了，据研究，某种营养缺乏(如缺乏盐酸，铁质，核黄素，叶酸，维生素A、D、B₁等)，局部血管改变，雌激素缺乏，慢性刺激及搔伤等，均可成为女阴白斑症的发病因素。但是，针对这些因素予以治疗，女阴白斑症并不见好转。所以，女阴白斑症的发病原因尚待进一步研究。

女阴白斑症属于中医“妇人阴疮”、“阴痒”、“阴蚀”范畴。“诸痛痒疮，皆属于心”。心经有热，或心血亏虚不能荣润皮肤；肝脾郁热，肾阴亏虚，冲任失调，引起阴部枯痿而致阴痒、阴蚀。治宜滋肾补血，养阴清热。

(一) 内服药

方一：生地10克，麦冬10克，泽泻10克，茯苓12克，苍术10克，荆芥10克，防风10克，黄柏10克，寄生30克，补骨脂20克。水煎服，每日一剂。

方二，首乌15克，菟丝子12克，续断20克，枸杞20克，麦冬10克，丹皮10克，复盆子10克，寄生30克，地骨皮12克，益母草30克，红花10克，女贞子30克，旱莲草30克。水煎服，每日一剂。

方三：龙胆泻肝片(成药)，照说明服用。

(二)外用药

方一：土槿皮30克，蛇床子30克，白藓皮15克，苦参30克，青黛10克，仙灵脾30克，川椒10克，防风10克，荆芥10克，水煎，先熏后洗。每日熏洗两次。

方二：地肤子30克，蒲公英20克，补骨脂20克，百部20克，枯矾10克，雄黄10克，鹤虱10克，煎水外洗，每日冲洗两次。

方三：鹿含草30克，蝉蜕15克，仙灵脾30克，老鹳草60克，煎水，熏洗患处，每日熏洗两次。

方四：乳香6克，没药6克，儿茶6克，血鹤6克，蛇床子10克，枯矾10克，冰片3克，雄黄6克，仙灵脾10克，补骨脂10克，共研细末，用甘油调成软膏，先用中药煎水熏洗(可任选以上处方)，后将软膏涂敷患处。

方五：蛤粉15克，紫草15克，蟾蜍6克，白藓皮10克，鹿含草15克，复盆子15克，刺蒺藜15克，百部10克，密陀僧6克，共研细末，用鱼肝油调成软膏，先用中药熏洗(任选以上处方)，后将此软膏涂敷患处，每日换药二次。

针灸疗法治疗女阴白斑有可喜苗头。取穴：百虫窝，三阴交、曲骨、太冲、太溪。每次取穴3—4穴(交替选用)，留针20分钟，每日一次，十日为一疗程。一疗程结束后间歇二日，再作第二、第三疗程。

55. 子宫颈糜烂

子宫颈糜烂(简称宫颈糜烂)是一种常见的妇科病，是慢性子宫颈炎的表现。这种病的症状是腰酸腹痛，白带多(严

重时带有腥臭味)，粘液或血性白带，或者在性生活后有少量出血。如果作妇科检查，可见宫颈外口呈鲜红色，上面有小颗粒状的增生物，组织较脆，触之容易出血。

宫颈糜烂的发病原因尚不清楚，可能与以下情况有关：

1.炎症：由于阴道与外界相通，容易受大肠杆菌、链球菌、滴虫等感染，分娩、流产、手术过程中也容易受病原微生物的感染，以致发生子宫颈的炎性糜烂。

2.物理化学因素：当阴道分泌物增多时，子宫颈长期浸泡在碱性分泌物中，宫颈外口的表层鳞状细胞浸润、脱落，从而形成了大小不等的糜烂面。以后逐渐由子宫颈管内的表层柱状上皮细胞增生而代替，覆盖了原来的糜烂面。

3.内分泌紊乱，如体内雌激素相对地分泌过少，也可能导致宫颈糜烂的发生。

宫颈糜烂的中医治疗：

1.针灸疗法：针刺三阴交（双），留针30分钟，针后加灸，每日一次，10次为一疗程。针灸疗法能调整内分泌功能，可使宫颈糜烂的症状得到改善，可作为辅助治疗的一种方法。

2.内治法：马齿苋七斤，甘草一斤，加水煎煮，去渣，药液浓缩至300毫升后，加淀粉2000克制成颗粒，口服，每次服20克，每日服二次。服药后大多数患者白带减少，下腹坠胀及腰痛等症状减轻甚至消失，精力较旺盛，体重增加。

3.外治法：

①千里光、虎杖各50克，加水500毫升，煎煮后过滤，待温度降至35℃左右时，冲洗阴道。冲洗后将药球放入宫颈

后穹窿部位，3~4天取出（药球制法：蛇床子10克，枯矾10克，虎杖10克，冰片3克，共研细末，消毒纱布包好，扎成球状，留线可拖到阴道外）。放药一次不愈者，隔三天再放第二次，一般放药2~3次即愈。

②五倍子10克，蚤休（重楼，草河车，七叶一枝花）1克，共研细末，加甘油20克，调成软膏，备用。用时先将阴道冲洗干净，将软膏敷于单层纱布上制成阴道塞子，塞入阴道内（紧贴宫颈糜烂面），24小时后取出。三天后重复使用。放药期间，禁性生活。月经期停药。

本方简、便、验、廉，无副作用，适于城市、农村使用。

③云南白药10克，用甘油调成软膏状，将软膏涂于带线棉球上，塞入阴道，紧贴宫颈糜烂面，12小时后，牵线将棉球取出（上药前应先将阴道冲洗干净），三天上药一次，五次为一疗程。上药期间避免性生活。

④乳香15克，没药15克，儿茶15克，铜绿15克，章丹10克，轻粉6克，冰片3克，共研细末，用甘油调成软膏状，备用。用法：先用1:5000新洁尔灭灭菌棉球对宫颈进行消毒，将软膏涂于带线棉球上，塞进阴道，使药膏紧贴于宫颈糜烂面。6小时后，牵线将棉球取出，每天上药一次。一般上药5~7次后，局部似有腐烂组织脱落，可停药三天，待局部干净且有新生的上皮组织生出，再继续上药，直至痊愈。上药应在月经干净后三天开始。上药过程中，要注意无菌操作，患者要避免性生活，并保持外阴清洁。

本方适用于治疗重度宫颈糜烂（轻度糜烂：糜烂面积不超过整个子宫颈面积的1/3。中度糜烂：糜烂面积占整个子宫颈面积的1/3~2/3。重度糜烂：糜烂面积占整个子宫颈面

积的2/3以上)。

⑤金银花(研粉)、甘草粉各半混合后,用棉花球蘸药粉塞入阴道内,紧贴宫颈糜烂面,第二天早晨取出,10次为一疗程。大多数患者涂药数次,即见好转,红肿消退,出血停止,新生表皮逐渐出现,自觉症状改善。

⑥乌梅15个,放入卤水500毫升中,煮沸30分钟,即成乌梅卤水,装瓶备用。用法:清洁阴道分泌物后,用大镊子夹带线棉球蘸乌梅卤水放入阴道内,紧贴子宫颈糜烂面,8小时后取出。隔日上药一次。

⑦生黄柏、龙胆草、苦参、龙骨(份量相等)。制法:上药晒干,研细,筛去渣,取其细粉,装入“○”号胶囊备用(放于干燥处)。用法:取胶囊一颗于晚上浴后塞入阴道深处,每日一次,七天为一疗程。

56. 盆 腔 炎

盆腔炎包括子宫内膜炎、子宫肌炎、输卵管炎、盆腔腹膜炎及盆腔结缔组织炎。一般多由于处理分娩、流产或刮宫、取环、放环等手术时,消毒不严,以致细菌侵入。也可因为在月经没有干净的时候进行性交,或者因为盆浴,引起上行感染,或因阑尾炎、膀胱炎等疾病造成的细菌直接蔓延而引起盆腔炎。盆腔炎可分为急性和慢性两种。

急性盆腔炎表现症状:

体温升高,脉搏加快,怕冷,寒颤,头痛,乏力,食欲不振,腹部胀痛,腹泻。白带多而臭,白带象粘液或脓液一样。下腹部常有压痛和反跳痛,甚至可摸到包块。血液化验

检查白细胞总数升高，中性增多。

根据盆腔炎的临床表现，与中医的热入血室，症瘕、痛经、带下等所叙述的某些症状有相似之处。如《妇人良方》记载：“妇人月经痞塞不通，或产后余秽未尽，因而乘风取凉，为风冷所乘，血得冷则为瘀血也。瘀血在内，则时时体热面黄，瘀久不消，则为积聚症瘕矣。”此段描述简略地叙述了盆腔炎的病因以及包块的形成。

急性盆腔炎的中药治疗：

方一：银花30克，连翘30克，红藤30克，败酱草30克，苡仁30克，丹皮12克，栀子12克，赤芍12克，桃仁12克，延胡索10克，川楝子10克，没药10克。水煎服。

如出现昏迷、抽搐、谵语等症状，应同时用安宫牛黄丸（成药）或紫雪丹（成药）送服，或作中西医结合抢救治疗。

方二：三棱10克，莪术10克，丹参30克，赤芍12克，蒲公英30克，延胡索10克，丹皮10克，苡仁30克，败酱草30克，没药10克，红藤30克，水煎服。

急性盆腔炎患者应绝对卧床休息，取半卧位，多饮开水，必要时需补液。

急性盆腔炎应积极治疗，以免转成慢性。

现在再来谈谈慢性盆腔炎的中医治疗。

慢性盆腔炎多由急性盆腔炎治疗不当或治疗不彻底转变而成。

慢性盆腔炎的主要症状有：

下腹疼痛（隐痛或坠痛），腰骶部酸痛，（下腹痛和腰痛常在月经期、劳累、性生活后加剧），白带增多，月经失调（经量过多，经期延长），痛经。

当身体抵抗力减弱时，以上这些症状可反复发作。

作妇科检查时子宫体活动受限或固定，子宫旁一侧或两侧增厚压痛，有的可触及条索状物或包块，伴有压痛。

得了慢性盆腔炎，不容易受孕。

慢性盆腔炎比较顽固，治疗起来疗程比较长，既要控制局部炎症，又要增强患者的体质，增强治愈的信心，使病人发挥主观能动性，向疾病作顽强的斗争。

治疗上必须采用综合疗法，才能取得较好的疗效。

1. 一般治疗：

适当参加体育活动，促进血液循环。

2. 针灸疗法：

取穴肾俞、大肠俞、三阴交、曲池、中极、关元、水道、归来、上髎、中髎（每次交替选用2~3穴，留针20分钟，每日一次）。

3. 中药热敷：

方一：白花蛇舌草30克，蒲公英30克，野菊花30克，栀子15克，千里光30克，没药15克，延胡索10克。

以上药物共包入布袋中，蒸热后放在下腹部热敷，冷了又换，每次热敷30分钟。这样的热敷，能改善局部血液循环，能使组织逐步松软，炎症减退。每日热敷一次，十次为一疗程。

方二：羌活30克，花椒10克，独活30克，千年健15克，白芷15克，生川乌20克，艾叶15克，紫苏10克，石菖蒲15克，以上药物共包入布袋中，蒸热后热敷，热敷部位及方法同上。

4. 中药内服：

方一：蒲公英30克，三棱10克，皂刺10克，桃仁10克，红花10克，乳香10克，没药10克，黄柏15克，白芷12克，延胡索10克，红藤30克，水煎服。

方二：益母草15克，银花藤30克，赤芍12克，橘核30克，连翘15克，马鞭草30克，鸡血藤30克，紫花地丁30克，白花蛇舌草30克。水煎服。一剂分两日服完。

方三：桂枝茯苓丸（成药），照说明的剂量加倍服用。

5. 中药灌肠：

方一：红藤30克，败酱草30克，蒲公英30克，赤芍12克，桃仁12克，三棱10克，没药10克。加水400毫升煎至100毫升，睡前保留灌肠（2小时），灌肠结束后即卧床休息。

方二：蚤休20克，延胡索10克，黄芩12克，红藤30克，鸭跖草30克，紫花地丁30克。加水400毫升煎至100毫升，睡前保留灌肠，方法同上。

57. 子宫脱垂

子宫脱垂是指子宫从正常位置沿阴道下降，子宫颈下垂到坐骨棘水平以下，甚至脱出于阴道口外。

造成子宫脱垂的原因主要有以下几种：

1. 支持子宫的盆底肌、筋膜和韧带在分娩时受到较为严重的损伤或过度的伸展，而在产褥期内又未得到充分休息使之恢复。产妇在生产以后过早地参加体力劳动，因承受不住腹压的增加而引起子宫脱垂。

子宫脱垂多见于劳动妇女。解放前，劳动人民的生活得不到保障，分娩用老法接生，遇有盆底支持组织损伤未加修补，分娩后又因生活所迫，过早参加体力劳动，加上生育过多、过频，全身及盆底组织均得不到恢复，因此，子宫脱垂的发病率很高。解放后，由于实行了新法接生、计划生育及产后的休假制度等，使妇女健康水平不断提高，所以，子宫脱垂的发病率大大降低。

2. 产妇在产后由于经常仰卧，因盆底组织松弛，可以造成子宫后位，使子宫纵轴与阴道纵轴相一致，在腹压的影响下，子宫往往容易沿着阴道方向下垂。

3. 绝经期或长期哺乳的妇女，因卵巢功能不足，雌激素水平低落，子宫萎缩，盆底组织松弛；产妇体质虚弱，也可使子宫支持组织的张力降低，若有腹压增加的因素出现，如便秘、慢性咳嗽或长期从事蹲站劳动等，就可以引起子宫脱垂。

子宫脱垂的患者，自觉阴部下垂，阴道有块物脱出，睡觉时可缩回，劳动及行走则脱出，严重者不能自行还纳。子宫长期脱出于阴道口外，不仅妨碍走路，而且使局部循环障碍，加之内裤的摩擦，导致表面糜烂或破溃感染，局部肿胀，白带增多并有臭味，黄水淋漓，或有脓性分泌物。

子宫脱垂伴发膀胱及直肠膨出时，还可出现排尿困难，尿潴留或尿频、尿失禁、大便秘结等症状。

子宫脱垂患者，由于局部循环障碍，子宫内膜改变，还可引起月经不调。

子宫脱垂，祖国医学称之为“阴挺”、“阴茄”、“阴脱”。认为劳倦、多产，损伤脾肾，脾气不足，中气下陷，肾气亏损，以致带脉失约，冲任不固，无力维系胞宫，致子宫失去

悬吊而下降。

子宫脱垂的中医治疗：

(一) 内治法

方一：枳壳30克，菟丝子15克，棉花根30克，黄芪30克，升麻6克，柴胡6克，党参30克，白术10克，当归12克，陈皮10克，鳖头骨一个（醋炙）〔如果鳖头骨（甲鱼的头骨）不易找到，不用也可〕，水煎服。

方二：黄芪24克，麻黄24克，白芍12克，制草乌8克（先熬二小时），制川乌8克（先熬二小时），川芎12克，黄芩12克，生地15克，甘草6克，蜂蜜60毫升（冲服）。水煎服，每日一剂，分三次服。四剂为一疗程，如连服两个疗程（八剂）仍无效，则改服其他方剂。

方三：丝瓜络60克，白酒一斤。将丝瓜络烧存性，研细，分成十四包，备用。每天早晚饭前各服药一包，白酒15毫升送服。七天为一疗程。间隔五天再行第二个疗程，也可连续服用，不间隔。

方四：金樱子10斤，冷水浸泡一天，武火煮半小时，过滤取汁，再加水煎半小时，去渣，两次滤液合并，加热浓缩成5000毫升，备用。每日早晚各服60毫升，温开水送服。三天为一疗程。间隔三天再连服三天。服药期间个别患者可有便秘、腹痛等轻微反应，不需处理。

(二) 外治法

1.醋半斤，放痰孟内，另用小铁块（或小铁器）烧红后放入醋内，醋即沸腾，患者坐痰孟上熏15分钟，每天一次。并注意营养，注意休息，禁房事。

2.蛇床子30克，枳壳45克，益母草30克，乌梅30克，加水浓煎，熏洗或温浸局部，能使子宫逐渐缩小，易于纳入。

3. 先将陈艾叶烤干搓碎，装在一尺长的筒内，并另做一个喇叭形硬纸筒，剪成适合外阴部的样子，免得烟外出。将点燃的艾卷放入硬纸筒内，让患者膝胸卧式进行烟熏，每日熏二次，每次熏30分钟，熏后休息30分钟再熏第二次，连熏3~5天。

4. 枯矾30克，五倍子（炒）30克，共研细末，每次用6克，以消毒纱布紧裹纳入阴道内，24小时取出。

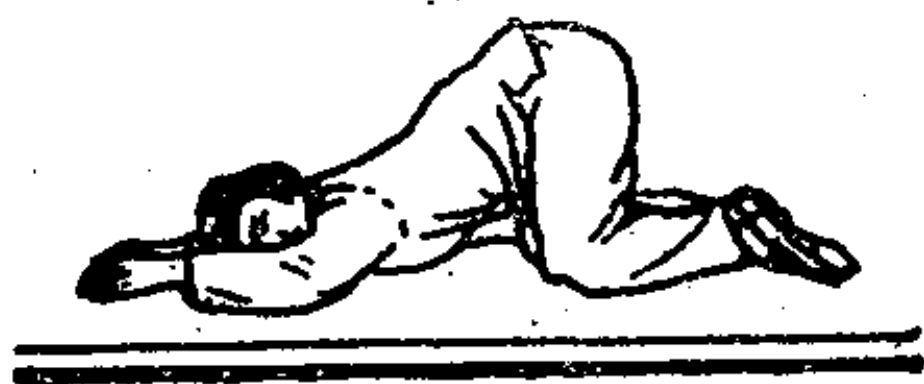
（三）针灸疗法

针刺细胞、曲泉、中极透关元、子宫、三阴交。灸百会。

子宫脱垂患者在进行治疗的同时，要加强骨盆底肌肉的锻炼，增加骨盆底组织的紧张度，以巩固疗效。锻炼的方法如下：

①患者取自然坐位，练习忍住大便或忍住小便的动作，继而放松，如此一紧一松，交替进行，一天2~3次，每次10分钟。

②膝胸卧式（如下图），一日作2次，每次作15分钟。



58. 女子不孕症

夫妇婚后同居三年，没有避孕，男方又无性和生殖系统疾病，而女方不能受孕者，称为原发不孕症。若曾经生过孩子，或者曾有过流产或宫外孕，但从那以后同居三年仍没

有怀孕的，称为继发不孕症。

怀孕必须具备以下四个条件：

1. 男方要有健全的精子。
2. 女方要有正常的卵子。
3. 男女双方要有正常的输送精子和输送卵子的系统。
4. 精子和卵子必须有碰在一起结合的机会。

上面四个条件缺一不可，不然就不可能怀孕。所以结婚后不生孩子，不一定是女方的问题，而必须男女双方都经过检查后才能确定治疗方案。现着重谈谈女性不孕症的中药治疗。

女性不孕症的原因：

①一般原因：患有慢性疾病、内分泌系统疾病和功能紊乱，营养不良，情绪过分紧张等。

②局部原因：生殖器官发育不全，生殖器官患有炎症性疾病或肿瘤。

③其他原因：如性交次数过于频繁（一周性交三次以上，精子发育不全），性交次数过少（失去受孕机会），性交时间离排卵时间太远。

排卵多在两次月经的中间的几天之内。排卵时妇女自己没有感觉，但通过测量基础体温可以了解是否在排卵。因为排卵时基础体温降低。基础体温是指早晨醒来还没有起床时，用体温表测量出来的体温。自月经干净后，每天早晨起床前，先量体温，并每日作好记录，直到下次月经来潮。这样为一周期。一般须连续测定三个周期。如平时基础体温是 36.5°C ，而当月经干净后的第九天或第十天，早晨起床以前的基础体温下降到 36°C 时，表示已经在排卵。如果在这两天之内进行性交，怀孕的机会就较多。

祖国医学认为因病理变化而造成的不孕，主要是由于肾气不足，肝郁气滞，引起冲任气血失调所致。肾虚则精血少，血海空虚，月经量少，胞宫失于温煦，致不能摄精成孕。肝郁气滞，情志不舒，肝失条达，气血失调，冲任不能相资，致成不孕。

(一) 肾气不足型：月经延后，月经量少，色淡。质稀薄，精神疲倦，腰酸腿软，小腹有冷感，性欲淡漠，小便清长，舌淡苔白，脉沉细。

处方：熟地60克，杜仲45克，枸杞60克，菟丝子45克，山萸45克，当归45克，山药30克，茯苓30克，仙灵脾60克，鹿角霜30克，紫河车60克。共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，早晚各服一丸，开水送服。

(二) 肝郁气滞型：月经提前或延后不定，经行不畅，或有痛经。月经量多少不一，色紫暗或有小血块。经前乳房胀痛，或有精神抑郁，舌质暗红，舌苔薄白，脉弦。

处方：当归12克，柴胡10克，白芍12克，茯苓10克，白术10克，香附12克，益母草20克，合欢皮12克，玫瑰花12克，花粉10克。水煎服。

治疗女子不孕症的单方验方：

①川芎30克，法半夏10克，陈皮10克，茯苓10克，白术10克，香附12克。水煎服。月经干净后每日一剂，连服6剂，连续2~3个月经周期。同时针灸关元、子宫、三阴交、足三里、天枢、中极等穴。

本方对幼稚子宫及子宫发育不良的不孕症有效。

②枸杞15克，菟丝子12克，复盆子10克，五味子20克，车前子10克，台乌10克，党参30克，黄芪30克，黄精15克，水煎服。

本方对肝肾不足的不孕症有效，但应坚持服药，有的病人需服30~50剂才能见效。

③赤芍10克，当归15克，川芎12克，桃仁10克，红花12克，枳壳10克，香附12克，三棱10克，莪术10克，甲珠15克，黄芪30克，鸡血藤30克，水煎服。

本方对输卵管不通的不孕症有一定疗效。

59. 习惯性流产

妇女怀孕在七个月以内，当胎儿在子宫内还没有发育到存活的阶段，而妊娠即中断的叫流产，又叫小产。

流产连续发生三次以上的叫习惯性流产。

习惯性流产的主要原因有：过度劳累，精神紧张，怀孕后性交，丈夫的精子有缺陷，患者的基础代谢率低，雌激素浓度降低，子宫畸形，子宫口松弛，患有严重的慢性病或生殖器官疾病等，均能导致习惯性流产。

祖国医学认为习惯性流产（“滑胎”）是气血不足或肾气虚弱，冲任不固，胎失所养而致。

（一）气血不足型：有流产史。妊娠初期，阴道流血，腰酸腹坠，或妊娠中期，胎动不安，阴道流血，神疲乏力，舌淡，脉滑无力。

处方：党参30克，白术10克，黄芪15克，白芍10克，黄芩10克，续断20克，陈皮10克，当归10克，熟地10克，砂仁6克。水煎服。

服法：从习惯性流产月份前两周开始服用，隔日一剂，连服至超过习惯性流产月份。

(二) 肾气虚弱型：有流产史。腰酸腿软，胎动不安，胎坠下血，小便频数，脉沉弱，舌淡红，少苔。

处方：菟丝子10克，寄生30克，续断20克，杜仲10克，熟地10克，阿胶12克，枸杞20克，补骨脂12克，益智仁12克，鹿角霜10克，大枣30克。服法：同上。

单方验方：

①南瓜蒂，焙焦研粉服，每次服3克，每日服二次，连服两个月。

②五味子糖浆（成药），每次服15毫升，一日两次，连服两个月。

③艾叶一把，鸡蛋一个。将艾叶和鸡蛋一同放在砂锅内煮，待鸡蛋熟后，即可服用（蛋白变为黄绿色）。习惯性流产患者，当确诊已妊娠后，即开始服用此方，防止再次流产。按上法将鸡蛋煮熟，每日吃一鸡蛋，连服四周。然后每月一次，每次服两个鸡蛋。如这个月20日服用，下个月也是20日服，服至妊娠足月为止。

④阿胶15克，莲子（去心不去皮）15克，糯米15克。将上药放碗内加清水300毫升，置锅中蒸至糯米熟为度。莲肉、糯米同汤分2次温服，每日1剂。

习惯性流产患者，若已经怀孕，应绝对避免性交，避免过度劳累，适当注意休息，坚持服药。这样，可预防习惯性流产的发生。

60. 胎位不正

胎位不正，常为引起难产的另一重要因素。胎位不正是

指胎儿于三十周后在子宫体内位置不正而言。常见于经产妇或腹壁松弛的妇女。患者多无自觉症状，经产前检查才能明确诊断（如臀位、横位、斜位等）。

祖国医学认为胎位不正系孕妇气虚下陷所致，治宜补气益血，调气活血。

方一：党参30克，黄芪30克，升麻6克，川芎10克，当归10克，白芍10克，艾叶10克，菟丝子10克。水煎服。每日一剂，连服三剂，五日后复查胎位。

方二：当归10克，白术10克，川芎6克，白芍10克，泽泻6克。水煎服，每日一剂，连服三剂，一周后复查胎位，若未转正，再服6~9剂。

方三：艾灸至阴（主穴）、窍阴（配穴），一日二次，每次灸30分钟，灸时患者的裤带要放松。胎位转正后，如腹壁松弛，可用布包扎。

胎位不正的原因很多，当详细检查，若因子宫畸形、骨盆狭窄、肿瘤或胎儿本身因素引起的，应作其他方法处理。

61. 先兆子痫·子痫

先兆子痫和子痫，往往由妊娠水肿或妊娠高血压发展而来，均属晚期妊娠中毒症的一种重症表现。妊娠后期，除出现水肿、高血压或蛋白尿外，如同时伴有头痛、目眩、胸闷、呕吐、恶心等症状者，则为先兆子痫；若未及时处理或控制，进一步发生抽搐和昏迷的，则为子痫。先兆子痫或子痫均可影响孕妇的健康和胎儿的生长，甚至威胁母子生命。

子病，祖国医学称为“子冒”、“妊娠痫症”，由于妇人平素肝肾阴虚，阳气偏亢，或脾胃虚弱，气血化源不足，孕后血养胎元，阴血亏虚，以致精不养神，血不养筋，发生神志昏瞢，手足抽搐，而成妊娠痫症。治宜养血育阴，平肝潜阳。

（一）阴虚阳亢型：妊娠后期，颜面潮红，头晕目眩，口干心烦，心悸失眠，舌红苔黄，脉弦数。治以滋肾养阴，佐以平肝潜阳。

处方：羚羊角粉3克，桑叶12克，川贝10克，生地20克，钩藤30克，菊花15克，白芍30克，甘草10克，石决明30克，桑寄生30克，杜仲12克，水煎服。

若抽搐频繁，加僵蚕10克，天麻10克，全蝎6克，地龙10克。

（二）脾虚肝阳偏亢型：妊娠后期，神倦面白少华，下肢水肿明显，头晕胀痛，心悸纳少，便溏尿短，苔白腻，脉虚弦或滑。治以健脾利水，佐以平肝。

处方：泽泻20克，白术20克，茯苓皮12克，大腹皮10克，生姜皮10克，白蒺藜15克，钩藤30克。水煎服。

若昏迷不醒，加菖蒲10克，远志10克，并吞服至宝丹或安宫牛黄丸。

62. 产后小便失禁

产妇产后小便淋漓不断，不能如意约束者，称为产后小便失禁。中医认为产后小便失禁的常见病因为气虚、肾虚和

外伤。气虚者多为平素体质虚弱，肺气不足，产后气血耗伤，肺气更虚，导致小便不能随意约束。肾虚者多为禀赋素弱，肾气不足，产后复伤气血，更使肾气不固，而致小便淋漓。外伤所致的产后小便失禁，多为产程过长，胎头压迫膀胱过久，组织坏死，形成尿瘘，或因难产而进行的手术操作也可直接损伤膀胱而致尿瘘。其治疗，外伤引起者应及时手术，气虚或肾虚引起的产后小便失禁，治宜益气补肾。

辨证分型治疗：

（一）气虚型：产后小便淋漓不断，气短神疲，面色苍白，乏力，脉细弱，舌淡苔白。

方药：黄芪60克，陈皮15克，党参30克，柴胡10克，升麻10克，台乌10克，益智仁15克，木香10克，山药30克。水煎服。

（二）肾虚型：产后小便失禁，腰酸肢软，畏寒肢冷，面色晦黯，脉沉迟，舌淡苔润。

方药：山药30克，制附片30克（先熬），菟丝子30克，补骨脂15克，熟地15克，覆盆子12克，巴戟10克，当归15克，炙甘草10克。水煎服。

63. 产后乳汁过少

产后乳汁过少，婴儿不够吃，发育就要受到影响。母乳不足的原因有：①母亲营养不良，一般健康状况较差。②过度疲劳，生活没有规律。③情绪过于紧张，精神过于激动。④哺乳的方法不对，或由于奶头内陷、奶头破裂，婴儿不能

很好地吮吸乳头，因而乳房内的乳汁经常不能排空，乳汁分泌就越来越少。

⑧中医认为产后乳汁的多少，与气血的关系极为密切。认为乳汁为血所化，而赖气以运行。然而，气血的产生，必须依靠脾胃水谷精微的生化（营养物质的吸收），若水谷精微生化不足，或肝郁气滞（精神抑郁），均可导致缺乳。

（一）气虚气弱型：产后乳汁过少，乳汁清稀，乳房柔软，无胀痛感，面色无华，心悸气短，舌质淡红，脉细弱。

处方：黄芪30克，党参30克，当归15克，麦冬15克，木通10克，桔梗10克，猪蹄两个，共炖服。

（二）肝郁气滞型：产后乳汁过少，乳房胀硬而痛，胸胁胀满，食欲减退，至则恶寒发热，舌苔薄黄，脉弦数。

处方：当归15克，白芍12克，生地15克，川芎10克，柴胡10克，漏芦12克，桔梗10克，木通10克，穿山甲12克，王不留行10克，甘草6克，水煎服。

治疗产后乳汁过少的单方验方：

- 1.猪蹄4个，黄芪60克，路路通30克，共炖服。
- 2.针刺膻中、外关、膺乳穴（攒竹穴下1.3厘米处）。
- 3.生南瓜子60克，紫河车30克，共研细末，和匀，开水吞服，每次服15克，一日三次。
- 4.金钩30克，赤小豆250克，共炖服。
- 5.活虾60克，黄酒适量。将虾洗净，捣烂，用烧开的黄酒冲服，每日1次，连服5天。
- 6.甘薯250克，新鲜狗脊髓骨500克。先将甘薯洗净，勿破薯皮，与狗骨同煮至烂熟，随意服食。

产后乳汁过少，可多吃富含维生素E的食物如植物油、水果、蔬菜、花生米等。维生素E为什么能催乳呢？维生素

E能使末梢乳腺血管扩张，使乳房血液供应充足，从而促使乳汁分泌增加。

产后乳汁过少患者宜常喝啤酒。据科学研究，乳汁分泌的多少与产妇血液内所含催乳素的浓度密切相关。而产妇适量的喝啤酒可以提高血清催乳素的浓度，可以促进乳汁分泌。这个办法简便易行。具体方法是：

产妇每天喝三次啤酒，每次喝半杯（约100毫升）。糯米甜酒煮鸡蛋也有这种发奶（催乳）的作用。

食物疗法对治疗产后乳汁过少也有较好疗效。兹介绍如下：

①猪肝50克，大米150克，猪肝切成小块，先将大米加水煮成粥，待粥煮烂熟时，再放入猪肝煮开5分钟即得。吃时加盐少许。

②猪蹄2个，花生米150克，共炖服。吃时可加盐少许。

③鲫鱼一尾（约150克）。菜油50克。鲫鱼去鳞去内脏，先把菜油倒入铁锅，用旺火把油烧开，放入鲫鱼煎炒，炒熟后加水700毫升。小火煮汤，汤熟色白，加盐少许及黄酒适量，吃鱼喝汤。

④鸡蛋2个，加水调匀，放入黄酒及盐、猪油适量，隔水蒸熟，趁热吃。

⑤瘦猪肉250克，黄花菜（干品）30克，猪肉切块，与黄花菜一同隔水炖熟，调味进食。

产后乳汁过少，产妇首先要稳定情绪，建立信心。每天要有充分的睡眠和适当的户外活动。注意营养，多吃富于蛋白质、碳水化合物和维生素的食物，如豆浆、牛奶、鱼、肉、蛋、面食、新鲜蔬菜和水果等，并多喝汤。还要做到定时给孩子喂奶，改进哺乳方法，让婴儿吸紧乳头和吸空乳

房。如有乳头凹陷或乳头破裂，应及时治疗。在乳头凹陷或乳头破裂的情况下，应定时用吸乳器将乳汁吸空或用手挤空。

乳汁缺乏的产妇，除了服中药以外，还可用针灸催奶。

附：断乳的方法

产妇由于某种原因（传染病、慢性病及婴儿夭折等原因）要求断乳（回奶）。正常婴儿吃奶已达8~12个月，也必须断乳。断乳过晚则乳汁成分已不能满足婴儿的需要，会影响婴儿的发育，也可使母亲子宫萎缩。

停止哺乳后，产妇往往因乳汁暂时不易回退，而致乳房肿胀疼痛，甚至并发乳腺炎，因此，必须用药物帮助断乳（回奶）。

中药断乳（回奶）的方法较多，疗效也好，现介绍如下：

①炒麦芽60~90克，水煎服。早晚空腹各服一次，一般三天即可回奶。剂量大回乳见效快。

②淡豆豉30克，薄荷15克，水煎服。早晚空腹各服一次。每日一剂，连服三天。

③红花10克，赤芍10克，当归尾10克，川牛膝12克，泽兰10克，水煎服。每日一剂，分三次（空腹）服。连服2~3天。

④神曲60克，蒲公英60克，水煎服，分二次服。每日一剂。同时趁热将药渣用干净纱布包好，放在乳房上热熨。一般用2~3剂，即可回乳。

⑤花椒15克，先在400毫升冷水中泡一小时，再煎至250毫升，放红糖30克，内服，每日一剂，一般服2~3剂即可回奶。

⑥芒硝250克，布包，外敷双乳，再用胸布束紧。

附：婴儿断奶的时间最好是在春秋两季，因夏季多肠胃病，冬季多呼吸道病，婴儿抵抗力一般不如春秋两季好。

婴儿从6个月开始，即可逐渐增加辅食，从8个月起，逐渐减少哺乳次数。用牛奶或其他辅助食品代替，最迟喂到一岁，要完全断奶。

64. 产后脑垂体前叶机能减退症

(席汉氏综合症)

产后脑垂体前叶机能减退症是育龄妇女因难产引起的全身性疾病。治疗难度较大。其主要症状有：未老先衰，毛发、腋毛、阴毛脱落，皮肤干燥，乳房萎缩，闭经，性欲减退甚至丧失，消瘦，畏寒，不愿饮水，不易出汗，贫血，心慌，体力下降，容易感冒，长期卧床，容易发生低血压、低血糖昏迷。1913年波兰学者席汉氏解剖尸体时发现本病是脑垂体前叶萎缩，机能低落。紧接着三个重要腺体（甲状腺、性腺、肾上腺皮质）机能低落；从而发生一系列症状。故此病又称席汉氏综合症。

产后脑垂体前叶机能减退症属于祖国医学的产后虚弱，治疗原则是益气补虚。

中药治疗产后脑垂体前叶机能减退症疗效较好，没有什么副作用。

处方：红参10克（嚼服），生甘草30克，制附片15克

(先熬)，黄芪30克。水煎服，每日或隔日一剂，连服1~3个月。

方中红参，甘草是主药。如畏寒不明显，可去附片。服药后如有浮肿，甘草可减量。

65. 急性乳腺炎

急性乳腺炎是因金黄色葡萄球菌等细菌侵入乳腺和乳管组织而引起的乳房感染。多见于初产妇。

本病的发病原因是：乳汁阻滞不得外流，使局部乳房组织活力降低，造成有利于细菌繁殖的条件。乳汁阻滞不得外流的原因有以下几种：①乳头破裂，产妇因怕痛而不让乳儿吸尽乳汁。②乳头破后外生黄痂，或乳头孔感染呈白点状突起，阻止乳汁外流。③乳母乳多，婴儿食量少，余乳未吸尽又不挤空，余乳瘀积。④初产妇产后乳络不通畅，或乳汁中含有较多的脱落上皮细胞和组织细屑，更易引起乳管阻塞。⑤断乳后乳汁壅塞。

急性乳腺炎，中医称为“乳痈”。其轻症中医称为“吹乳”或“妒乳”，发展成为脓肿则称“乳痈”。在哺乳期发生的名为“外吹乳痈”；在怀孕期发生的名为“内吹乳痈”。并认为多由吮乳吹风，或热毒蕴结，或肝气郁结，气滞血凝，以致乳络不通，乳汁壅滞，湿热结毒所致。

急性乳腺炎，开始乳房局部发生肿块，疼痛，继而皮肤发红发热，脓肿形成则触之有波动感。脓肿深的，皮肤发红及波动感不明显。同时有恶寒，发热，头痛，周身不适，同侧腋窝淋巴结肿大疼痛等症状。治宜清泄热毒，疏肝通

乳。

方一：瓜蒌皮10克，蒲公英30克，银花15克，连翘15克，黄芩10克，柴胡10克，漏芦10克，皂角刺10克。水煎服。

乳汁不畅、乳房胀甚，加炮山甲、王不留行、路路通各10克。需要回奶者，加生麦芽30克、神曲20克。

方二：银花30克，王不留行10克，鹿角霜15克，熟地20克，赤芍12克，露蜂房12克，当归12克，黄芪30克，党参30克（本方适用于乳腺炎破溃，久不收口者）。

方三：昆布30克，海藻30克，银花30克，大黄12克，王不留行10克，炮山甲15克，赤芍12克，蒲公英30克（本方适用于肿块坚硬，胀痛较甚者）。

治疗急性乳腺炎的单方验方：

（一）外用方

1.取干皂角，研成粉，用白酒调湿，用纱布一层包成小药包，塞在患乳同侧鼻孔内，12小时后取出。如为双侧乳腺炎，可以交替塞闻。塞后，病人感鼻孔内有轻微刺辣感，或收缩感，或流水感，乳头流乳增多（勿将皂角干粉塞鼻，以免不断打喷嚏）。

2.取新鲜葱白与生半夏，共捣烂如泥，捏成鼻孔大小的栓子，塞入患乳对侧鼻孔，20分钟后取掉，每日塞2次。

（以上二方适用于急性乳腺炎初起，并配合用热敷、按摩、吸出积乳）。

3.蒲公英、芙蓉花叶、银花藤、鱼腥草（均用鲜品为好）各30~60克，共捣烂外敷。敷药时应留出乳头（本方适用于脓未溃或已溃）。

4.仙人掌63克，去皮捣烂，取汁，再加面粉13克，调成

糊状涂于患处。

(二) 内服方

1. 当归15克，川芎15克，益母草30克，泽兰15克，苍耳子12克。水煎服（加黄酒适量兑服）。

2. 生甘草50克，陈皮50克，脓成加桔梗25克，收口加黄芪30克。水煎服，每日1剂。

3. 大血藤90克，水煎服。

4. 蚤休30克，槐米30克，生甘草15克，共研细末，每日1剂，用开水、黄酒各半送服。

5. 川芎10克，麻黄10克，甘草10克，加水400毫升，煎2次，药液混合，分4次服，每日1剂。

66. 乳腺增生

乳腺增生是妇女的常见病，属于祖国医学的“乳癖”范畴。患者一侧或两侧乳腺内可触及多个大小不一的结节（肿块），黄豆大乃至鸽蛋大不等，多散在或融合成不规则的团块，质韧，稍硬，有压痛，与皮肤及深部组织之间无粘连，可被推动。患侧乳腺常感坠胀不适、疼痛，多与月经周期有关。有的患者月经来潮前症状加重。有的患者乳头有溢液或溢血。

乳腺增生的发病原因可能与卵巢机能失调有关，黄体素与雌激素的比例失去平衡，黄体素分泌减少，雌激素的量就相对增多。中医认为“乳癖”的病因病理是肝气郁结，冲任失调，气滞血瘀。治疗原则是疏肝理气化瘀。

(一) 肝气郁结型：乳房内有肿块，每于月经来潮前感

乳房坠胀不适、疼痛，心烦易怒，失眠，舌红苔黄，脉弦。治宜疏肝解郁。

处方：橘叶12克，橘核30克，当归12克，柴胡15克，赤芍12克，香附12克，川楝子12克，丝瓜络15克，水煎服。

(二) 气滞血瘀型：乳房内有结节，痛如针刺，月经紫黑，舌有瘀斑或瘀点，脉涩。治宜活血化瘀。

处方：露蜂房20克，橘核30克，丹参30克，当归12克，赤芍12克，熟地12克，川芎10克，桃仁10克，红花10克，水煎服。

有人认为乳腺增生易恶变成乳腺癌，故早期治疗乳腺增生，有其重要意义。

治疗乳腺增生的单方验方：

1. 猪苦胆汁75克，冰片2克，土鳖虫100克，银花100克，大枣50克，胡桃仁50克，炙马钱子25克。先将猪胆汁煮沸一小时，加入冰片拌匀，然后把炙马钱子同其他药共研细末，与胆汁混合，炼蜜为丸，每丸重6克，每次服一丸，每日服二次，开水吞服。一个月为一疗程，可连服三个疗程。体质衰弱者慎用。

2. 露蜂房、半枝莲、山慈姑、山豆根各等量，共研细末，炼蜜为丸，每丸重6克，每次服一丸，每日服二次，三个月为一疗程。

3. 当归10克，白芍10克，柴胡10克，茯苓10克，白术10克，香附10克，枳壳12克，瓜蒌壳12克，丹参30克，郁金30克，生牡蛎30克，薄荷10克，甘草6克，赤芍30克，丝瓜络30克，穿山甲30克，浙贝15克，鹿角霜10克。水煎服，每日一剂。

儿 科

67. 麻 疹

麻疹是由麻疹病毒引起的一种发疹性传染病。绝大多数病例为直接接触，通过空气飞沫传染。六个月以内的婴儿，很少患麻疹。半岁到五岁的儿童发病率极高。麻疹的临床特点是发热，呼吸道症状，皮肤斑丘疹和颊内粘膜出现麻疹粘膜斑。

麻疹的患病过程大致如下：

1. 潜伏期：麻疹病毒侵入人体后，首先在呼吸道粘膜上皮细胞内繁殖，然后侵入血流，形成第一次病毒血症。这个从病毒侵入人体到第一次病毒血症形成的时期为潜伏期。此期没有什么症状出现，一般10天左右。

2. 前驱期：进入血内的病毒随血流广泛播散到呼吸道、口腔粘膜、眼结膜、淋巴组织和网状内皮系统，并在这些组织细胞中大量繁殖，引起呼吸道炎和结膜炎的症状。病毒从血流到达全身多种组织寄居繁殖的时期为前驱期，一般4~7天左右。此期患者可出现发热、疲倦、食欲不振、打喷嚏、流鼻涕、流眼泪、怕光、眼睑浮肿等症状，还可以在第二大白齿相对的颊粘膜上出现约1毫米直径大小的小点，小白点周围绕以红晕，小白点有时融合成小片，这就是麻疹所特有的口腔粘膜斑(麻疹斑)，可作为诊断麻疹的依据。

3.发疹期：病毒在多种组织繁殖后又进入血流，形成第二次病毒血症，并在皮肤上皮细胞及真皮浅表毛细血管周围繁殖，形成皮疹。从第二次病毒血症出现到全身发现皮疹的时期为发疹期，一般4~5天左右。此期病人可表现高烧、皮疹。皮疹一般在发烧第4天出现，先见于耳后、颈部，后见于面、肩、胸、背、腹部，最后见于四肢。皮疹大小不一，多为玫瑰色斑丘疹，疹间可见正常皮肤。在发疹期患者体温很高，可达40℃，全身中毒症状也严重，但到皮疹出全时，一切症状都趋于缓解。

4.恢复期：此期血内病毒逐渐消失，故体温下降，皮疹消退（疹退后留下色素沉着，并有糠麸状脱屑），中毒症状减轻，病情好转，逐渐痊愈。

麻疹如不合并其他疾患，预后较好，不过麻疹很容易合并细菌感染，产生合并症（如合并肺炎、喉炎、心血管机能不全、脑炎、营养不良、维生素缺乏、紫癜、结核病变播散等），对此必须高度注意。对麻疹患儿要做好医疗护理工作（护理工作很重要），以防止合并症的发生。

中医认为麻疹是感受麻毒时邪所致，麻毒时邪主要侵犯肺脾两经。肺主皮毛，脾主肌肉。入于肺则肺卫失宣，故见发热咳嗽，流涕等肺卫表证；邪伤脾胃，内则食欲不振，大便溏泄；外则由肌腠而达于肌表，故疹点红赤。

麻疹初期，病人的抵抗力还是比较强的。中医强调对麻疹初期用解表透疹的治疗方法（用紫浮萍、芫荽子、西河柳煎水外洗，用荆芥10克、牛蒡子6克、竹叶6克、薄荷10克、西河柳10克、蝉蜕6克、芦根10克煎水内服，此为5岁以内小儿用量），符合人体尚有抗病能力的情况，促进体表循环，尽快促进麻疹病毒达于外周循环，减少对内脏损害，

减轻或避免合并症，有利于机体恢复。由于麻疹初期的清凉透发药，因势利导，促进麻疹病毒早日透发故能缩短疗程，但这些药不一定都有抑制麻疹病毒的作用。

出疹期的中医治法，应以清热解毒透疹为主，并要注意避风寒，忌着凉，以防热毒内陷（麻疹合并肺炎）。

处方：葛根20克，银花10克，连翘10克，紫草10克，板蓝根20克，蝉衣6克，白茅根20克，生石膏30克，黄芩6克，菊花10克，水煎服（此为五岁小儿用量）。

高热者 兑服紫雪丹；

烦躁者加竹叶、黄连；

津液不足者加生地、玄参、石斛；

口烂者加重生石膏、生地；

鼻衄者加丹皮、生地；

咳甚者加杏仁、瓜壳；

气喘者加麻黄、葶苈子，加重生石膏；

疹出不快者加升麻；

疹密集者重用紫草，加丹皮、生地；

疹色乌黑者加皂刺、桃仁、红花；

便秘者加大黄、枳实；

声哑者加山豆根，胖大海。

恢复期的治法应以养阴、清余热或调理脾胃为主。

处方：沙参10克，麦冬10克，地骨皮10克，青蒿10克，花粉10克，山楂10克，神曲10克。

治疗麻疹的单方验方

①鲜芫荽120克（或干芫荽子15克）、浮萍15克，放白酒120毫升，放室内煎汤薰蒸，使空气潮润，药液稍冷后，用毛巾蘸药液擦头面四肢，一天二次。适用于透疹不多时（夏

天不宜用此法)。

②鲜荸荠10个，鲜白萝卜半斤，煎服，适用于恢复期。

③银花藤、芦根、白茅根、鱼腥草各30克。水煎服。初期、中期、末期均可服用。

④紫草250克，贯众500克。加水3000毫升，煎成2000毫升，沉淀取上清液，1~3岁每次服20毫升，4~6岁每次服30毫升，7~10岁每次服50毫升，每日服2次。

麻疹患者的食疗方：

1.预防麻疹，可用芹菜500克，加水500毫升，煎成250毫升，每天饮服适量。或用甘蔗、荸荠、胡萝卜等份，水煎代茶饮。

2.出疹期：

1)芫荽、荸荠煎汤饮服。

2)红苋菜250克，水煎服。

3)荔枝肉9克，水煎服。

4)鲜竹笋、鲫鱼煮汤，喝汤吃鱼，有透疹、促进麻疹早日痊愈之功效。

5)鲜虾煮汤，可助疹子透发。

3.疹后滑泻：生山药30克，研细煮粥，将熟蛋黄2~3枚，捏碎调粥服。

麻疹患儿不需“忌口”！过去有人说：麻疹患儿不准吃荤食品，不准吃肉，因为荤食品、肉类食物能“发毒”，会使病情加重。这种说法是不科学的。麻疹患儿发高烧的时候，食欲差，消化力弱，少吃些油腻食物是必要的，当麻疹患儿退烧、进入恢复期后，就应该给吃荤食品等营养食物了。因为麻疹患儿身体的消耗相当大，为了使患儿早日恢复健康和很

好地生长发育，就需要补充各种营养物质，尤其需要补充营养价值较高的蛋白质。荤食品、肉类食物含有较多的动物脂肪、蛋白质、维生素等，营养价值高，只要患儿能消化、吸收，就应当选择食用；豆类食物含有大量植物蛋白、维生素、矿物质等，容易消化、吸收，也应当适当食用；绿叶青菜含有多种维生素和矿物质，还有纤维素，可以帮助消化吸收和促进排泄，也必须给以食用。总之，麻疹患儿“忌口”是不正确的，如果“忌口”过严，可能造成营养缺乏症，影响儿童的生长发育和身体健康。

麻疹的护理极为重要。麻疹在没有合并症的情况下，只要护理得好，基本上不吃药都可以自然痊愈。如有了合并症，只要加强护理，亦有利于疾病向好的方面转化。得了严重合并症，那就要住医院治疗了。

麻疹的护理：

1. 保持环境卫生与安静。避风寒，勿使患儿着凉。室内温度最好保持在16~22℃。室内不要有煤气，室内的光线不要太强烈，室内要保持空气新鲜。对患儿要严格隔离，不要让其他儿童来串门。

2. 患儿要卧床休息。直至烧退、皮疹隐退，方可下床活动。

3. 多饮开水，在发烧的时期可给吃牛奶、菜汤、稀饭等容易消化的饮食。烧退后要多给吃高蛋白饮食，不要“忌口”。

4. 注意口、鼻、眼和皮肤的清洁。

麻疹的预防：

1. 隔离患儿，不让其他儿童与患儿接近。

2. 中草药预防；

①紫草根10克，板蓝根30克，煎水服，连服五天。

②贯众180克，放入水缸内，作饮水消毒，每周换药一次。

68. 猩 红 热

猩红热由乙型A族溶血性链球菌引起，多流行于冬、春季节，以2~10岁孩子为多见，为出疹性传染病中较为严重的疾患。

乙型A族溶血性链球菌存在于病人或带菌者的鼻咽部，通过飞沫传染给周围的易感者。也有少数病人是通过皮肤、粘膜的外伤而被传染的。

猩红热自发病前24小时至疾病高峰时期的传染性最强，到皮肤脱屑阶段则无传染性。

病菌侵入人体后，主要引起感染、中毒、变态反应三种病变。

1. 病菌的感染作用：乙型A族溶血性链球菌通过呼吸道侵入人体后，首先在咽峡部繁殖，引起咽峡炎和扁桃体炎等病变。病人有发烧、头疼、咽疼等症状。检查可见咽部充血，扁桃体红肿且可附有黄白色点状或片状渗出物，易被擦掉。此外，还可见舌质呈猩红色，舌乳头红肿突出，称为“草莓舌”或“杨梅舌”。

2. 毒素的中毒作用：在咽峡部繁殖的病菌产生红疹毒素，由局部吸收入血，又随血液循环到全身各处，引起全身中毒性病变，可致真皮充血、水肿和白细胞浸润，形成全身弥漫性小米粒大的鲜红色皮疹。这种皮疹一般在起病后24小

时出现，首先见于颈部、胸部、背部，以后见于躯干、四肢，常在皮肤皱褶处密集出现，一天内皮疹即可蔓延至全身，色鲜红，压之退色。疹间很难见到正常皮肤，疹子常为大片融合。皮疹在口周甚少，俗称环口苍白圈。

3. 变态反应：少数患者可有变态反应病变（合并症），例如引起急性肾小球肾炎、心肌炎、关节炎等。治疗及时，可减少这种合并症。

青霉素为治疗猩红热的特效药物，但对青霉素过敏或耐药的病人，怎么办呢？用中药治疗，同样能收到满意疗效。

祖国医学称猩红热为“烂喉丹痧”，认为由于外感时疫，蕴结肺胃，疫毒化火，从气入营，上熏咽喉，致局部红肿糜烂；外透肌肤，则发赤色皮疹；甚则热深毒重，内迫营血，发生神昏痉厥。

治疗猩红热的基本处方

蒲公英20克，野菊花20克，白花蛇舌草20克，紫花地丁20克，银花20克，连翘10克，玄参10克，黄芩10克。水煎服。

初起疹透不多，畏寒发热，加荆芥6克，牛蒡子6克，薄荷6克。

高热烦躁，加生石膏30克，黄连10克，黑山栀10克，或用紫雪丹，每次服1克，每日三次。

皮疹密布加生地12克，赤芍10克，丹皮10克。

咽痛剧烈加射干10克，山豆根10克，土牛膝根20克。或用锡类散吹喉。

神昏痉厥，加蝉衣6克，钩藤15克。

治疗猩红热的单方验方：

①板蓝根30克，土牛膝根30克，水煎服。

②蒲公英30克，乌敛莓30克，水煎服。

③虎杖30克，三颗针15克，蚤休20克，水煎服。

这里附带谈一谈：银花、连翘、蒲公英、紫花地丁、黄芩，均为广谱抗菌药物。所谓“广谱抗菌药物”，就是指这些药物的抗菌范围较广，对多种致病的细菌（包括猩红热的病原体乙型A族溶血性链球菌）都能起抑制作用。上面介绍的治疗猩红热的基本处方中，除用了银花、连翘、蒲公英、紫花地丁、黄芩等广谱抗菌的中药以外，还用了乙型溶血性链球菌等致病菌有抑制作用的野菊花。这些药物的联合应用，具有明显抑制乙型溶血性链球菌的作用，对猩红热具有明显的疗效。只要诊断明确，用药及时，正确掌握剂量（剂量小了达不到疗效，上面介绍的处方剂量为8~10岁儿童剂量，小于8岁的儿童的剂量可酌减），用中药治疗猩红热是能取得满意疗效的。

当然，用中药治疗猩红热，同样要对患儿进行隔离，卧床休息，室内空气要流通，但要避免冷风直吹，周围环境要安静，多给患儿吃菜汁、米汤、水果等，勿给吃辛辣饮食，对高热或咽喉炎症重的患者，须给清凉饮料和流质食品，并注意口腔清洁及皮肤清洁。

69. 百日咳

百日咳是由百日咳杆菌引起、好发于儿童的急性呼吸道传染病。这种病的病程长达2~4个月（大约100天），所以称为百日咳。这种病的传染性很强，所以祖国医学又称“疫咳”。这种病的主要特征为阵发性痉挛性咳嗽，咳后喉中有

一种特殊的吸气性吼声，如水鸡样的鸣响，所以又称“鸡咳”。祖国医学还把它称为“鹭鸶咳”、“顿咳”、“天哮呛”等。

百日咳杆菌离开人体后容易死亡，所以不易通过污染日常生活用品间接传染，主要是通过患儿咳嗽、打喷嚏、谈话时喷出的飞沫直接传染。当人体抵抗力减弱（如受凉感冒之后）的时候，百日咳杆菌就会侵入人体而发病。

细菌侵入呼吸道后，产生内毒素，引起喉头、气管、支气管粘膜发炎。粘膜粘液腺分泌大量粘液，粘液将粘膜表面的纤毛粘着在一起，因而粘液性分泌物不易被排出。大量粘液性分泌物积聚在气管、支气管内，不断刺激粘膜内神经末梢感受器，这种刺激传达到大脑，形成咳嗽中枢的兴奋，而产生强烈的连续性痉挛性咳嗽。这种咳嗽久之则成条件反射，所以有些患儿病原体早已消失，仍继续痉咳而不痊愈。

百日咳如不及时治疗，病程真能拖一百天左右；如治疗及时（早期治疗），可使病程大大缩短。

祖国医学认为百日咳发病主要原因是外感时邪疫毒之气，从口鼻犯肺，肺气不宣，上逆而为咳嗽，继则痰热壅肺，气火上逆，而致痉咳加剧。

百日咳整个病程可分三个阶段：

1. 炎症期（此期约历时7～10天，此期的传染性最强）：

此期的症状与一般的伤风咳嗽无大差别，若无明显的百日咳接触史，不易想到此病。最早的症状就是咳嗽，偶见打喷嚏和轻微发热。一般感冒症状与低热三天内即见消退，但咳嗽却逐渐加重，并逐渐出现阵发性痉挛性咳嗽。

炎症期的治疗法则是宣肺祛邪。

处方：杏仁10克，麻黄10克，橘红6克，百部10克，桑白皮10克，黄芩6克，甘草6克，水煎服。

2. 痉咳期（此期约历时 2～6 周）：咳嗽逐渐加重，一发作即出现成串的紧接不断的咳嗽，连续到十几声以至数十声后，发出一种特殊的高音调的、很象火鸡叫或鸟啼的声音。一连串紧促的咳嗽跟着来一下长出气，如此反复循环。而且一次比一次加剧，直到呼吸道积聚的痰沫一冲而出为止。胃内容物经常同时吐出。经过一次发作，常能安静一段时间，隔几分钟以至数小时再次发作。发作前一般无明显预兆。一些外因，如进食、周围空气骤变、尘土的吸入、烟熏、过分疲劳、情绪激动等都有引起发作的可能。

痉咳期的治疗法则是清肺，止咳，化痰。

处方：黄精、百部各 10 克，天冬、麦冬、射干、百合、紫菀、枳实各 6 克，甘草 3 克，水煎服。

3. 恢复期：咳嗽逐渐减轻，次数减少，吼声消失，但咳而无力，气短声弱，或易出汗、口渴、潮热，舌质红（此期约历时 2～3 周）。

恢复期的治疗法则：滋阴养肺。

处方：沙参 10 克，麦冬 10 克，花粉 10 克，紫菀 10 克，五味子 10 克，水煎服。

治疗百日咳的单方验方：

① 鸡苦胆一个，用针刺破，加白糖，分二次服，开水送服。一天服一个。最多不超过五个，即能收效。（无鸡苦胆，也可用猪胆汁 10 毫升代替）。

② 白芨 10 克，研细末，开水吞服，每日三次（一日量不超过 30 克）。

③ 大蒜 6～10 克，去皮捣烂，加白糖，冷开水送服。

④ 百部 6～15 克，水煎，加白糖，分三次服（一日量不超过 15 克）。

⑤鹅不食草15克，水煎服。

⑥麻雀二只，去毛及内脏，肚内填白糖，蒸熟，一次吃下，每日一次。一般吃4~5次即愈。

⑦蜈蚣、甘草各等分，共研细末，装瓶备用。用法：每日服三次，每次服1.5克，开水吞服，饭后服，连服7~10天。一般服三天后，痉咳即显著减少。

⑧杠板归（又名贯叶蓼、蛇倒退、猫爪刺）全草30克（鲜品则用60克），炒后加糖适量，煎水当茶喝，每日一剂。

⑨百部根50克，杏仁20克，桔梗20克。加水700毫升，煎去一半。滤出药渣，加入白糖60克，以文火将糖熔化，贮瓶备用。日服3次，1岁服2~4毫升，2~3岁每次服4~6毫升，3~6岁每次服7~9毫升，7~9岁每次服10~13毫升，10岁以上每次服15毫升。

⑩白花蛇5克，贝母10克，甘草10克，共研细末，贮瓶备用，每日服3次，每次服2~3克。饭后服。

⑪田鼠睾丸1对，白糖20克。放瓷碗内，共捣如泥，加开水调和成糜，1次顿服。

特别值得提出的是，上面介绍的痉咳期的处方（黄精、百部、天冬、麦冬、射干、百合、紫菀、枳实、甘草。此方系上海华山医院验方），不论百日咳的早期或晚期，均有良好疗效，而且价廉。并且可用于预防（服大锅汤预防百日咳，连服三天）。

这个处方，有抑制百日咳杆菌的黄精。射干、百部，有扶正治本的天冬、麦冬，有治标（止咳）的枳实、紫菀，妥善处理了细菌与人体、整体与局部的关系。实践证明，这个处方疗效高，价廉易得，值得大力推广。

70. 流行性腮腺炎

流行性腮腺炎，又称“痄腮”、“蛤蟆瘟”、“衬耳寒”，是一种病毒所致的急性传染病。儿童较多见，成年较少见。得了腮腺炎的病人主要表现为耳下腮部肿大与疼痛，或伴有怕冷、发热、全身不适及咀嚼不便等症状。

流行性腮腺炎一年四季都可发生，尤以冬春两季为多见。年龄稍大的儿童或成人患病后容易并发睾丸炎，小儿可并发脑膜脑炎。

流行性腮腺炎的病原体是流行性腮腺炎病毒。病毒存在于患者及隐性患者的唾液内，当大声谈话、咳嗽或打喷嚏时，病毒随飞沫喷出。与病人密切接触的易感者吸入带有病毒的飞沫而被传染。

多数医学专家认为，流行性腮腺炎病毒通过腮腺管口直接到达腮腺，然后进入血流。病毒侵入腮腺后在腮腺细胞内繁殖，引起腮腺的非化脓性炎症。因而腮腺肿大、疼痛。除腮腺外，颌下腺及其他腺体可同时受累，腺体周围组织也充血、水肿，致使病人面颊部及颌部明显肿胀，常呈特殊面容。

流行性腮腺炎病人在腮肿之前可有发热、头痛、呕吐等症状。病人一侧或双侧耳下部肿胀，肿块边缘不清楚，触之有压痛及弹性感，张口不利，咀嚼疼痛，腮腺管口（相当于上颌第二臼齿旁颊粘膜上）可见红肿。如见高热、嗜睡、昏迷、项强等症，应注意是否并发脑膜脑炎。如睾丸有红肿疼痛，应注意并发睾丸炎。

祖国医学认为流行性腮腺炎是由于风温病毒从口鼻而入，壅阻少阳经络，郁而不散，结于腮颊所致。治疗以清热解毒为主。

处方：柴胡10克，牛蒡子12克，连翘10克，银花10克，大青叶30克，板蓝根30克，蒲公英10克，夏枯草20克，水煎服。

腮腺漫肿而迟迟不消者，加昆布20克，海藻20克。

睾丸肿痛者，加龙胆草、荔枝核、川楝子各10克。

笔者医疗实践经验表明，在流行性腮腺炎的中药治疗过程中，一开始就在清热解毒方剂中（处方见上）加用昆布、海藻，可缩短疗程而获速效。

也有的病人患流行性腮腺炎，虽经药物治疗，但迟迟不痊愈。在这种情况下，可在清热解毒方剂中，加用活血祛瘀药物，如赤芍、丹皮、皂刺、穿山甲、三棱、莪术等，以改善局部血液循环，常能取得良效。

治疗流行性腮腺炎的单方验方：

1. 升麻30克，板蓝根30克，僵蚕10克，水煎服。

2. 鸭跖草30克，蛇蜕10克，银花15克，水煎服。

3. 青黛30克，加醋适量，调成糊状，涂患处，干了又涂。

4. 活蚯蚓、白糖等量，搅拌半小时，得出似蜂蜜伏的蚯蚓浸出液，过滤备用。用时将纱布蘸蚯蚓液贴敷患处，约2~3小时换一次，勿使干燥。

5. 蒲公英，紫花地丁各30克（鲜药为好），白矾6克，共捣烂，加鸡蛋清适量，搅匀如糊状，摊于纱布上，敷患处，每日换药一次。

6. 仙人掌捣烂，贴敷患处，每日换药二次。

7.蟾蜍一只，用清水洗净，去头及耳后腺，将皮剥下剪成膏药样，表皮向外直接贴敷于患处。8小时后可自然干燥而脱落，脱落后可浸水重贴，或更换新鲜蟾蜍皮贴敷，待肿消为止。

8.七叶一枝花根茎10克。磨食醋成浓汁状，涂布于肿胀的腮腺部，每日3次。鲜品用量加倍，捣成糊状后加食醋适量，每日敷一次。

9.季德胜蛇药片（又称南通蛇药片）8~12片，压碎，用注射用水调成糊状，涂患处，1日涂4次。

流行性腮腺炎是一种呼吸道传染病，传染性较强，易于传播和流行（特别是托儿所、幼儿园、小学）。因此，应积极作好预防工作。发现病人就要马上隔离，直到肿大的腮腺完全消退为止，一般应隔离三周。与病人有过接触的儿童要注意观察，可用板蓝根30克或鸭跖草30克，或大青叶30克煎水内服，进行预防。

71. 小儿夏季热

小儿夏季热是儿科的常见病。祖国医学称为“疰夏”、“注夏”、“夏痿”。本病有明显的季节性，每在春夏之交或夏季发病，好发于幼弱儿童。发病原因多为小儿体质娇嫩，脾胃虚弱，气阴不足，在夏季炎热的环境中，感受温热之气而致（现代医学认为系患儿体温调节机能不健全所致）。

本病特征：夏季持续发热（体温39~40℃），口渴，尿多，汗少。起病缓慢，有夜热早凉，也有早热暮凉，部分病例喜伏地而卧。每年6~8月发生于我国南方温热地带。本

病在秋凉后多能自愈，有的甚至到了第二年夏天再度发病。患儿因持久发热，机体抵抗力降低，往往容易导致合并感染，故应引起医务人员和病孩家长的重视，积极予以治疗。

辨证论治：

1.暑热挟湿挟滞型：夏季持续发热，体温常在 39°C 以上，肢体无力，胸闷不适，懒于说话，食欲差，大便溏薄，舌尖赤，苔白腻，脉滑数。治宜清暑解热，健脾化湿。

处方：荷梗6克，薄荷6克，连翘6克，大豆黄卷6克，银花10克，藿香6克，神曲6克，青蒿6克，六一散10克。水煎服。

2.暑热炽盛型：夏季持续发热，午后体温更高，常在 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 之间，心烦自汗，口渴喜冷饮，小便量多，疲乏，消瘦，舌红，苔黄，脉洪数。治宜清暑泄热。

处方：生石膏10克，知母6克，甘草6克，粳米10克，人参叶10克，滑石10克，薄荷6克，水煎服。

现代医学对小儿夏季热尚无特殊疗法，故应发挥中医中药的优势，及时予以中药治疗。患儿持续高热，切忌长期使用抗菌素，以免引起菌群失调。

小儿夏季热易误诊为暑期感冒，但小儿夏季热具有发热持续不退，口渴，多尿等特点，可与感冒相鉴别。

小儿夏季热多发生于体质娇弱的儿童，为预防本病的发生，在炎热的夏季，体弱小儿宜居住凉爽通风的地方，补充营养，增强抗病能力，并宜常饮西瓜汁或金银花露，以清暑解热。

治疗小儿夏季热的单方验方：

①薄荷10克，滑石20克，甘草6克，泡开水当茶饮。

②木瓜10克，乌梅10克，竹叶6克，石斛6克，麦冬6

克，鲜荷蒂10克，甘草6克，水煎服。

③绿豆15克，地骨皮10克，苇茎6克，白薇3克。水煎服。

④金钱草适量(鲜品)，捣烂成糊状，过滤去渣，取汁，每隔1~2小时服5汤匙。

72. 小儿营养不良

小儿营养不良是一种慢性营养障碍疾病，多见于三岁以下的小儿，其主要特点为消瘦，生长发育障碍。

小儿营养不良，祖国医学称为“疳积”、“疳疾”、“疳证”。系小儿脾胃虚损、运化失宜，以致气液耗损，外形干枯羸瘦，气血不荣，或腹部胀大，青筋暴露，缠绵难愈，影响生长发育的一种慢性疾病。其病因主要有饮食不节，脾胃损伤；喂养不当，营养失调；感染诸虫，转化成疳。治宜健脾养胃，消积驱虫。

1.脾胃损伤：面色黄暗无华，肌肤羸瘦，毛发枯槁，困倦，乳食懒进，腹胀拒按，或食则呕吐，便秘或便溏，苔腻脉细数，指纹多淡滞。治宜消积理脾。

处方：神曲3克，麦芽3克，槟榔1.5克，青皮1.5克，陈皮3克，白术3克，甘草1.5克。如病已久，虚实并见者上方加党参、山楂。

2.营养失调：面色萎黄，毛发憔悴，枯瘦如柴，食不消化，大便溏泄，腹部凹陷，哭声不扬，脉无力，指纹色淡。治宜扶脾养胃。

处方：白术6克，党参6克，茯苓6克，扁豆6克，陈

皮3克，甘草3克。

3.虫积成疳：消瘦，面色苍黄，毛发脱落，食欲失常，或嗜食无度，或不思饮食，或嗜食泥土杂物，肚腹胀大，青筋暴露，睡卧咬牙，唇口起白点，脉弦细。治宜驱虫消积。

处方：使君子6克，槟榔3克，鹤虱3克，木香3克，砂仁1.5克，党参6克，白术6克，茯苓3克，甘草3克。

治疗小儿营养不良的单方验方：

①砂仁3克，从口塞进蟾蜍肚内，用谷草包扎后，再用黄泥包好，焙干，去黄泥和谷草灰，将蟾蜍研细末，红糖水送服，每次服1~3克，每日服两次。

②山楂、鸡内金、山药（比例为1:2:3）共研细末，每次服2~4克，红糖水送服，每日两次。

蚕蛹30克，山药30克，紫河车30克，共研细末，红糖水送服，每次服6克，每日服两次。

73. 蛔虫性肠梗阻

肠梗阻种类繁多，原因复杂。蛔虫性肠梗阻是由于较多的蛔虫在肠管内扭结成团，堵塞肠腔，或因虫体及其毒素刺激肠壁引起肠痉挛，而致肠内容物不能正常通过肠道而致病。5~20岁的儿童和青少年发病率较高。

本病类似祖国医学的“关格”“肠结”等病症。

大肠、小肠等六腑以通降下行为顺，滞塞上逆为病。蛔虫内扰肠道，气机痞塞，血行瘀阻，上下不通，不通则痛。但单纯的肠蛔虫病并不引起梗塞，而是由于患者发热不适，腹部受凉，腹泻，食物刺激，肠道感染，不适当的驱虫等原

因，致肠道功能紊乱，蛔虫受到刺激而扭结成团，或由此引起肠痉挛而致病。

阵发性腹痛，腹胀不排气，便秘呕吐是本病的主症，有时还可吐出蛔虫，有的病人在腹部可摸到条索样的团块，有蛔虫钻动的感觉。治疗着重在于疏通肠道，制蛔通下。若大便通，排气畅，则症状自然缓解。

(一) 内治法

方一：木香10克，乌梅20克，苦楝根皮12克，枳实10克，生大黄（后下）10克，水煎服。

方二：生大黄10克，芒硝10克（分次冲服），槟榔10克，厚朴10克，枳实10克，水煎，顿服（本方为峻下剂，通下力宏）。

方三：花生油（或菜油）120克，花椒10克，煎油加热，倒入花椒，待花椒煎至微焦，冷却后捞出花椒，一次顿服。如一次服不完，每隔二小时又服，服完为止。

方四：生姜30克，捣烂绞汁，生姜汁加蜂蜜90克，混匀，一次顿服。如一次服不完，2小时后又服，服完为止。

(二) 外治法

皂角20克，细辛20克，共研细末。蜂蜜200克，炼成老蜜，将皂角细辛粉加入老蜜中，使成均匀可塑性软块，用手搓成圆柱状（直径1公分，长1.7公分），沾食油，插入患者肛门（侧卧屈膝体位）每次插入1~2个药栓，塞入深度不得少于10公分，并用手托住肛门，以防药栓掉出。多数患者在15分钟左右即能排便排蛔。如半小时未排者，可重复一次或多次（本方适用于体弱患者）。

74. 脱 肛

脱肛，又叫直肠脱垂，是指肛管、直肠甚至乙状结肠下段的粘膜层或全层肠壁从肛门向外脱出。这种病症多见于儿童、老年人和多次孕产的妇女。发病原因主要是直肠粘膜下层组织和肛门括约肌松弛，或直肠的发育缺陷和支持组织松弛无力，加上用力大便等，足使腹腔内压增高而引起脱肛。

祖国医学认为脱肛多由禀赋不足，久泄久痢，或老年人长期便秘，慢性咳嗽，妇女分娩过多或产程用力等原因，以致气虚下陷不能收摄，形成肛门松弛，升举无力所致。

脱肛病人大便时肠壁从肛门口脱出，轻症仅觉肛门坠胀，脱出后能自行回纳，重者必须用手推回。甚至在咳嗽、喷嚏、行路、劳动时都可以脱出。并且常有便意而排便不多，或兼下腹胀痛，腰骶部钝痛，小便次数增多等症状。

直肠脱垂而不能自行回纳者，必须及时将脱垂之粘膜推入肛门内，否则会引起感染、糜烂，甚至坏死。

脱肛病人平时要加强锻炼，增强体质，纠正腹泻、便秘，排便时不要用力努挣，解除排便困难，治疗慢性咳嗽，这些都是预防脱肛的有效措施。

针灸治疗脱肛的效果比较好。

常用穴：长强、承山。备用穴：白环俞、百会。

方法：先刺常用穴。长强直刺进针达直肠上方后，可分向左、右前方透刺，使针感扩散至整个肛门周围。承山宜强刺激。效果不满意时加备用穴。

白环俞宜向内下方斜刺，使针感扩散至肛门。百会穴宜

用灸法。每日治疗一次，十次为一疗程。

耳针疗法：常用穴：直肠下段，皮质下。方法：中强刺激，留针30分钟左右，每日一次，十次为一疗程。

脱肛的中药治疗：

(一) 内服方：黄芪30克，党参30克，炙甘草10克，白术10克，升麻6克，柴胡6克，五味子10克，诃子10克，石榴皮10克。水煎服，每日一剂（此为成人剂量，小儿酌减）。也可服补中益气丸（成药），照说明书之剂量加倍服用。

(二) 外用方：

①蜗牛诃子软膏：蜗牛30克（连壳焙干），诃子15克，共研细末，用猪油调匀，敷患处。

②新鲜曼陀罗四斤，煎取浓汁三大碗，再以其汁煎山萸肉60克，再用党参60克研细调汁中，晒干，每次用15克，水煎融化洗患处。

③五倍子、地榆、土黄连各30克，水煎坐浴20分钟，使药力直接作用于病变部位，取效甚捷。

④甲鱼头（鳖头）2只，五倍子炭18克，冰片1.5克。先将甲鱼头烧灰存性，再与五倍子炭共研极细末，将冰片研细，与上药混匀，用瓶贮存，用时先用温开水洗净患处，稍干，将药粉6克撒于药棉上，包裹患部，用手使脱肛复位，然后将棉花取下，每次脱肛，均以此法行之，直至痊愈。

⑤老枣树皮6克，石榴皮6克，明矾4.5克。煎水300毫升，待微温时，用脱脂棉球蘸药水洗脱出部分，每日2~3次。

⑥蝉蜕15克，煅龙骨30克，僵蚕10克，冰片0.5克。前3味药焙干，加入冰片，研极细末，装瓶备用。用时先用盐水洗净患处，再取上药置清洁纸上，将脱出直肠缓缓上托，压

进肛门内，纱布盖好，贴胶布，最后用丁字带固定。

以上外用方，可任选一种使用。

75. 遗 尿

遗尿是指睡中小便自遗，醒后方觉，故又称尿床，是儿童常见的一种疾病。成人身体虚弱，也可出现遗尿症。

许多疾病如先天性膀胱括约肌发育不全、隐性脊柱裂、泌尿生殖器畸形、尿道炎及尿道的其他局部刺激、寄生虫病、脊柱或颅脑损伤、大脑发育不全、营养不良、病后身体虚弱等，均能引起遗尿症。

排尿是受大脑排尿中枢控制的。当尿液在膀胱中达到一定容量时，膀胱内压力急剧升高，在大脑即产生尿意反映，这种强烈的感觉冲动到脊髓，反射中枢便传出运动冲动，引起逼尿肌收缩、外括约肌及会阴肌松弛，尿液被排出膀胱。如果先天性大脑发育不全或后天各种因素所致的大脑功能紊乱，或由于脊髓的反射弧消失，或泌尿系统及其周围组织慢性病灶的刺激，都可引起遗尿。

婴儿由于中枢神经系统尚未发育完全，还不能控制膀胱括约肌，所以，婴儿遗尿是属于正常的生理现象。有些儿童由于白天嬉戏过度，疲倦，夜晚睡得很熟，也会偶然遗尿。只有在三、四岁以后经常遗尿的，才是病态，才称作遗尿症，需要加以治疗。

中医认为遗尿症的发生，多由小儿肾气不足，下元虚冷，或病后体弱，脾肺气虚不摄，或由不良习惯所致。

针灸治疗遗尿症有较好的疗效。

针刺常用穴：关元、三阴交。备用穴：百会、气海、中极、阴陵泉、肾俞、脾俞、足三里、列缺。手法：用中等度刺激或强刺激，针刺腹部穴位时使针感（酸胀麻感）到达阴部；针刺角度宜向下斜刺；下肢穴针感最好能向上方传导。

10~15天为一疗程。

灸法常用穴：百会、命门、关元、中髎。每日取2~3穴，用艾条熏灸。

耳针疗法：常用穴：交感、脑点、肾、膀胱、枕、尿道区找敏感压痛点。每天或隔天一次，留针半小时。见效后每五天针一次，以巩固疗效。

遗尿症的中药治疗：

①属于“肾气不足”的尿床，可见面色晄白、智力迟钝、腰腿酸软、小便清长、甚至四肢冷、畏寒、脉沉迟无力。

方一：鹿茸粉2克（冲服），人参3克（嚼服），桑螵蛸20克，菖蒲10克，远志10克，当归12克，龙骨30克，牡蛎30克。水煎服，每两日内服完一剂（此为五岁小儿剂量）。

方二：黄芪30克，沙苑子12克，山萸肉10克，菟丝子10克，五味子10克，补骨脂10克，韭菜子10克。水煎服，两日内服完一剂（此为五岁小儿剂量）。

②属于“脾肺气虚”的睡中遗尿，兼见面白神疲，四肢乏力，食欲不振，大便稀溏，舌淡，脉缓。

处方：山药30克，台乌10克，益智仁10克，党参30克，白术12克，茯苓10克，五味子15克，水煎服，两日服完一剂。

③经科学研究表明，治疗遗尿症除了用扶正固本的方法外，加用活血醒脑的方法治疗，往往能收到满意的疗效。

方一（活血醒脑法，黄马九香片）：黄芪100克，马钱子75克（先用麻油炸至焦黄），九香虫125克，川芎45克，石菖

蒲35克。分别研成细末，和匀，打成片子，每片重0.5克，每晚临睡前服二片，连服一个月，同时服“黄芩三子片”。

方二（扶正固本法，黄芩三子片）：黄芪100克，芡实125克，金樱子60克，复盆子50克，菟丝子50克，山药60克，甘草25克。分别研成细末，和匀，打成片子，每片重0.5克，每次服6片，每日服三次，连服一个月，同时每晚服“黄马九香片”。

在这两个处方中，除了使用治疗夜尿症一般常用的培元补肾、健脾益气、固涩小便的药物以外，还加用了九香虫、石菖蒲、马钱子、川芎。九香虫具有较强的健脾益肾、壮元阳的作用；石菖蒲具有通九窍、止小便和轻微的兴奋精神的功能；马钱子具有主治风瘫、膀胱瘫、遗尿的功效；川芎为血中之气药，具有化瘀滞的功用。

单方验方：

(1) 生鸡蛋敲一小孔，放入白胡椒七粒，堵住蛋壳的小孔，蒸熟，每晚临睡前吃2~3个鸡蛋，不喝水。

(2) 补骨脂60克，去除杂质，放锅内炒10~20分钟，发出爆声，取出放冷，研为细末。山药120克，焙干，研末，与补骨脂粉和匀，用少量开水吞服，每次服10克，早晚各服一次。补骨脂与山药均为滋养强壮之品，费用低廉，可以久服。

(3) 鸡肠一具烧存性，紫河车一个，放瓦上用慢火焙干，共研细末，每次服6克，开水吞服，早晚各服一次。

(4) 益智仁12克，麻黄6克，桑螵蛸15克，石菖蒲10克。水煎服。

(5) 桑螵蛸15克，黄芪15克，龙骨15克，肉桂3克。水煎服，每日1剂（此为7~12岁儿童剂量）。

(6) 补骨脂5克，熟肉豆蔻5克，吴茱萸5克，五味子5克，益智仁5克，猪膀胱1具（洗净）。将以上中药加入猪膀胱内，并将其口扎好，用粗针将猪膀胱刺数孔，放入盆内，加水1.5公斤，煮沸一小时左右，去药渣，喝汤，猪膀胱切片食之。成人一次吃完，小儿分2~3次吃完。

(7) 连须葱白3支（约2寸长），硫黄30克，共捣烂如泥，待患儿睡时将上药敷于脐上，外用纱布包扎固定，8~10小时后去掉。

(8) 刺猯全皮（连毛刺）1个，加清水文火煎煮，临睡前二小时服。

(9) 新鲜鸡肠（30克）洗净，菟丝子6克，鸡内金6克，牡蛎6克，五味子6克，制附片6克，黄芪10克，党参10克。水煎服，每日一剂。

76. 小 儿 流 涎

流涎是唾液不自主地流出口外的一种症状，可因唾液分泌过多、吞咽障碍或闭口不全所引起，或因口腔炎症导致流涎。4~6个月的婴儿，多见生理性流涎，不必治疗。

小儿流涎，祖国医学称为“滞颐”（指口涎自流而留滞于颐项间）。多因脾胃积热和脾胃虚寒所致。脾之液为涎，脾胃积热，则廉泉不能制约，或脾胃虚寒不能收摄，均可发生流涎。

1. 脾胃积热：流涎，唇红舌赤，或口舌生疮，烦躁不宁，叫闹啼哭，大便干结，小便短黄，指纹紫滞。治宜清热泻脾。

处方：灯草6克，山栀3克，生石膏10克，生地6克，黄芩

3克，黄连3克，水煎服。

2.脾胃虚寒：流涎，面色苍白，四肢微冷，唇舌色淡，指纹淡红，隐而不显。治宜温中补脾。

处方：益智仁6克，木香3克，法半夏3克，陈皮6克，白术6克，干姜3克，党参10克，水煎服。

治疗小儿流涎的单方验方：

①内服利尿剂如车前草等，同时外用白矾60克化水洗脚。

②灯心3克，切细调入鸡蛋内，加盐少许，用猪油炒熟，空腹服。

③黄连1.5克，生石膏25克，豆腐适量，共煮开半小时，去药渣，吃汤吃豆腐，味苦可加白糖，适用于脾胃积热患者。

④天南星30克，用醋调，晚间敷足心涌泉穴，以布条缠扎，每次敷12小时，一般敷3~4次可愈，但对口腔炎症引起的小儿流涎无效。

⑤半夏25%，益智仁25%，陈皮20%，茯苓20%，甘草10%。共研细末，早晚各一次，每次服3~5克，加适量红糖拌和冲服。

⑥生白术10克，将药捣碎，加水和食糖适量，放锅上蒸汁，分次口服，每日一剂。

⑦吴茱萸10克，研极细末，醋调，贴敷脐中，每次敷12小时。

⑧肉桂10克，研细末。用醋调成糊饼状，每晚于小儿临睡前，将药料匀摊于两块纱布，分别贴敷于两侧涌泉穴，然后用胶布固定，次日晨取下，连敷3~5次。

77. 小儿误吞金属异物

误吞金属异物（包括缝衣针、回形针、大头针、铁钉、硬币等）在儿童中较为常见。交通不便之山区及农村，送患儿到医院手术，困难较多。用中药治疗，常能就地解救。

方一：生韭菜一斤，洗净，切细，用一般炒菜的方法略炒一下（勿炒过头），或用开水烫成半熟，多放些油，再放少许盐或酱油，让患儿一次吃下（空腹吃，尽可能一次吃完），吃后注意观察大便，如误吞之金属异物尚未随大便出，可反复吃韭菜，直到排出为止。

一般吃韭菜后，8~24小时，金属异物可随大便排出，金属异物被韭菜纤维包裹。韭菜纤维又能促进胃肠蠕动，加速误吞之金属异物的排出。

方二：生磁石（未煅）15克，新炭末（木炭末）6克，蜂蜜30克，生磁石和新炭末共研成极细粉末，用蜂蜜调服。一天服一次，直至金属异物随大便排出。

注：也可将以上两个处方同时服用。

外科·皮肤科

78. 骨质增生

骨质增生，又称增生性关节炎、老年性关节炎，是中年以后发生的一种慢性关节病。长年累月的过度使用某些关节能形成此病。木工、煅工经常用前臂作伸屈活动，其肘部易发生增生性关节炎。人到老年，体内一切组织变性，关节组织也不例外，故骨质增生多见于老年人。其病理变化为一种骨骼的退行性变化，早期从关节软骨变化开始，软骨变色、软化和碎裂，逐渐脱落，软骨消失后，关节面处骨质暴露，产生硬化，软骨的边缘、关节囊以及韧带的附着处因关节活动的刺激而骨质增生，形成骨刺。

骨质增生起病缓慢，有时因轻伤才感到疼痛，最常受累的是膝、髋、手指、腰椎和颈椎等。早期症状为关节酸痛，活动不便，这种感觉在早晨起床时或久坐起立时最为明显，经片刻活动后即行消失，但过多活动又觉不适。局部无肿胀，有轻度压痛。肌肉无痉挛，无萎缩。病情严重者关节面变形，关节活动受限，疼痛，甚至出现关节畸形，但关节不发生强直。

骨质增生也可发生在青壮年时期，其发病原因与老年人不同，多由于外伤引起。当关节内骨折整复不良，重力线不正，如膝内翻、外翻，足部畸形，脊柱侧弯等均可引起一个

关节或整个关节发生骨质增生，即谓之外伤性关节炎。

骨质增生与祖国医学的“骨痛”，“骨痹”相类似。祖国医学认为肾主骨，老年人肾虚，易出现“骨痛”症状。气滞血瘀亦为本病病因。据临床所见，本病痛点固定，痛如针刺，有的有跌仆等外伤史，当属于气滞血瘀。加以风寒湿邪，阻塞经络，久之肝肾亏损，脉络失和，致成本病。治宜补肾活血，通络止痛。

方一：熟地30克，鹿含草30克，仙灵脾30克，骨碎补12克，苁蓉15克，鸡血藤30克，当归12克。水煎服，亦可制成蜜丸服用。

方二：白芍60克，甘草15克，木瓜15克，鸡血藤30克，威灵仙15克，独活12克，没药10克，狗脊30克，鹿角胶15克，水煎服。

方三：茜草根30克，补骨脂15克，菟丝子12克，杜仲12克，怀牛膝30克，寄生30克，血竭6克，续断20克。水煎服。

骨质增生起病缓慢，疗程亦较长，故应说服病员坚持服药，同时结合推拿、按摩、运动以及其他物理治疗，收效更好。

79. 毛囊炎·疖·痈

毛囊炎、疖、痈都是皮肤化脓性感染。其病原菌大多数是金黄色葡萄球菌。

祖国医学认为是卫表不固，火(热)毒之邪乘虚侵入而发病。火毒之邪从皮肤侵入后，首先导致局部气血壅滞，经络阻塞不通，故而产生红肿热痛诸证。若火毒之邪与气血相搏，

热盛则血肉腐化而成脓，脓肿切开或自溃，毒邪随脓液排出，肿痛即逐渐消退而愈。火毒之邪轻微者，病变仅限于局部，如火毒较重，则可出现发热等全身症状。如因正气虚弱，毒邪炽盛，则可出现正虚邪实的症候，严重者可导致火毒扩散入营，内攻脏腑，而见败血症的症状。病情严重的，由于气血、津液的消耗，后期可出现虚象。

毛囊炎的病损较轻，只是在毛囊口及毛囊内发生感染。健康人一般不会发生毛囊炎，但是在天热多汗，皮肤不清洁、皮肤经常受到磨擦或刺激，或身体衰弱、抵抗力降低的时候，病原菌就有可能侵入毛囊引起感染。毛囊炎多发生于头面部、颈项、胸背部、臀部、阴部等易受磨擦刺激的皮肤处，皮损初发于毛囊口，为红色丘疹，有灼痛感，周围有炎性红晕，以后丘疹顶端形成一个小脓头，大小如针尖或绿豆，数目或多或少，但不互相融合，几天后脓头破溃，排出少量脓液而渐愈，愈后不留疤痕。

毛囊炎属于中医的“疔肿”范畴，可用具有止痒、杀菌的野菊花或芙蓉叶30—60克煮汁内服并外洗，治疗是比较容易的。对于反复发作毛囊炎的病人，可服下列中药。

处方：银花12克，花粉10克，浙贝10克，当归10克，赤芍10克，乳香10克，没药10克，炮甲珠10克，陈皮10克，防风10克，甘草10克。水煎服。

预防：注意皮肤卫生，避免搔抓。及时治疗搔抓性皮肤病或皮肤破损，预防毛囊炎的发生。

疔，是一种深毛囊炎和毛囊周围的炎症。体弱、贫血、慢性肾炎、糖尿病以及湿疹等疾病，可能与疔的发生、发展有关。

疔，好发于面、颈后发际部、背部、臀部，夏季多见。

疖，初起为高出皮肤面的圆形炎性小结节，可有痛感与压痛，发展成熟时出现脓头，破溃后流出脓血，愈后常留有疤痕。附近淋巴结常肿大和疼痛，严重者有发热等症状。

疖是外科的常见病，祖国医学称为热毒疖、发际疮等，常因感染外邪，内郁火毒炽盛而成。

疖的中药外治法：

疖初起时，可选用新鲜的蒲公英、紫花地丁、鱼腥草、芙蓉叶、马齿苋、鸭跖草、野菊花等中草药1~2种，洗净，捣烂外敷，每日换药1~2次。

疖已化脓“成熟”，可切开排脓，但切忌挤压脓液（头面部更应注意），以免病菌随淋巴、血流扩散，引起蜂窝组织炎甚至败血症（“走黄”）。

疖的脓成期也可用疔疮膏外贴，以提拔脓栓。

脓溃后，外用三黄软膏敷贴，直至痊愈。

疖的中药内治法：可内服清热解毒方剂。

处方：银花10克，连翘12克，紫花地丁20克，蒲公英10克，半枝莲20克，当归12克，黄芪30克。水煎服。

成药穿心莲片、牛黄解毒片、六神丸也可选用（照说明服）。

现在谈一谈“痈”。

痈与毛囊炎、疖不同，痈是一种严重的皮肤深部化脓性炎症，其病损面积较大，肿胀明显，许多相邻的毛囊和皮脂腺都被感染。病菌侵入毛囊后，由毛囊底部沿着抵抗力较薄弱的脂肪柱向皮下组织蔓延，沿四周扩散，侵袭更多的毛囊，使许多相邻的毛囊和皮脂腺都发生化脓性炎症。痈多发生于颈部及背部。呈现大片酱红色炎症浸润区，高出于体表1~2厘米，质坚硬。痈的中央皮肤坏死形成脓栓，出现多个蜂房状

的脓头，进一步发展，脓头溃烂，脓液排出，则炎症减退，疼痛消失，愈后留有疤痕。

痈，中医称为“有头疽”、“蜂窝蛆”、“莲蓬发”。痈好发于颈后发际部及背部。发于颈后部的俗称“脑疽”或“对口疔”、“偏对口”，发于背部的俗称“发背”或“背痈”，发于其他部位的均可统称为“毒疽”、“痈肿”或“有头疽”。

痈的发生多为外感火毒之邪，或素有湿热内蕴、脏腑蕴毒，或皮肤外损，毒邪乘隙为患，以致气血凝滞而成痈。

痈的中药外治法：

①初期可选用蒲公英、鱼腥草、马齿苋、野菊花、紫花地丁、芙蓉叶等清热解毒药1~2种，洗净，加少量食盐，捣烂外敷。

②脓成期宜适时切开排脓。

③溃后脓尽，宜祛腐生肌，撒布“生肌散”（成药），外贴“生肌玉红膏”（成药），直至痊愈。

痈的内治法：

宜服消肿散结、清热解毒、托毒透脓之剂。

处方：炮甲珠（炒穿山甲）10克，皂角刺10克，当归12克，银花12克（或银花藤30克），赤芍10克，浙贝10克，野菊花20克，紫花地丁30克，天葵子10克，黄芪30克，川芎10克。水煎服。

若出现疮厥，应加服“安宫牛黄丸”一粒（化服）或紫雪丹一克。

治疗毛囊炎、疖、痈的单方验方（通用）：

1.六神丸20粒，七厘散一支（均为成药）调成糊状，涂患部，每日涂4~6次。

2.蛇皮1张，全蝎二个，蜂房一个，一同泡入适量食醋，

中，24小时后即可使用。用法：以棉花蘸药液涂患处。每日涂4~6次。

3. 蜂蜜、生葱适量，捣烂如泥，外敷患处，每日换药1~2次。

4. 五倍子60克，用蜂蜜搅拌后炒黄，研细。鹅粪60克，阴干，用新瓦焙至冒烟，研细。将以上二药和匀，米醋调成糊状，摊油纸上约2~4毫米厚，敷于痛上，面积需大于病变范围，每日换药一次，待坏死组织脱净后，外敷生肌橡皮膏，以促进愈合。内服活血清热的中药。本方适用于痈切开引流后久不愈合者。（《中华医学杂志》1979.2.）。

5. 松香10克，研细末，加入酒精或白酒调成糊状，隔水加温，溶解后敷患处，以全部覆盖为度，上面再盖以蜡纸，胶布固定。为加强药效，可滴酒精数滴，保持松香湿润。

6. 紫花地丁30克，活蝮蛇1~2条，杀死，去骨及内脏，同泡入白酒200毫升中，密封，放阴凉处，三个月后即可应用。放置时间愈长愈好。用法：涂患处，一日涂4~8次，应保持湿润，勿使干。

如破溃流脓者，涂药后一分钟内可有灼痛，继之麻木，进而止痛，无不良反应。本方也适用于牙髓炎。

7. 陈小麦（新小麦亦可）2斤，加水泡三天（冬季泡七天），捣烂，过滤，沉淀物晒干（小麦浆），小火炒，炒时会翻泡，要不断搅动，待炒至焦黄成块状时，取出，隔纸放地上，冷却，研细末，装瓶备用。用时取干粉加醋调成糊状，外敷患处。现调现用。敷药范围须大于病灶。将出头者，留一小孔，以便排脓。

8. 苍耳虫（寄生在苍耳茎中的小虫，立秋前后采集）浸泡于麻油中备用（浸泡时间久，疗效高）。用时，取油泡的苍

耳虫1~3条，外敷患处，并在患处周围涂搽苍耳虫油（浸泡液）。有脓头者，中间应留孔，以便排脓。

本方治疗疔疮疗效显著。

80. 丹 毒

丹毒是由溶血性链球菌侵入皮肤或粘膜所引起的一种感染性疾病。

一般情况下完整无损的健康皮肤、粘膜具有天然的防御屏障作用，但是当皮肤或粘膜（如鼻粘膜、口腔粘膜等）受到擦伤、抓伤、刺伤或者昆虫螫咬等，就会使病菌乘隙侵入，引起感染。体内一些化脓性病灶如中耳炎、龋齿、鼻窦炎等也可经淋巴管蔓延到附近皮肤，引起网状淋巴管炎，导致丹毒。此外，全身抵抗力减弱、营养不良、糖尿病及慢性肾炎等也使丹毒易于发生。丹毒多见于幼童及老年人，好发于春、秋两季，这可能与幼童、老年人抵抗力低有关。

丹毒好发于面部和小腿。面部丹毒常继发于慢性鼻炎、脂溢性皮炎；小腿丹毒常继发于脚癣或小腿溃疡。

丹毒发病之初常有寒战、高热、头疼等全身感染症状，随即患部出现一片鲜红色的斑块，表面常紧张而发亮，其边缘高出于正常皮肤，形成明显的界限。病变很快向四周蔓延，中心部位的颜色常逐渐减退成棕黄色，且可有小片表皮脱屑，有的可出现水泡，一般不化脓，丹毒病损部位的局部淋巴结多肿大，并有压痛。

大部分丹毒患者经治疗后都能较快的痊愈，但是有的下肢丹毒可以转成慢性或者反复发作，以致引起淋巴管阻塞，

最后形成橡皮腿。

丹毒，祖国医学叫“赤游风”或“火丹”，依发病部位的不同，有“抱头火丹”（发生于头面部）、“内发火丹”（发于胁肋部）、“流火”（发于小腿部）等不同名称。祖国医学认为丹毒由于火邪侵犯，血分有热，郁于肌肤而发，或由皮肤粘膜破伤，毒邪乘隙侵入而成。治宜清热凉血解毒。

处方：板蓝根30克，紫花地丁20克，银花20克，山梔10克，丹皮10克，赤芍10克，元参20克，黄芩10克，黄连6克。

加减：发于头面部，加牛蒡子10克，菊花12克。

发于胁肋部，加柴胡15克，龙胆草10克。

发于下肢，加苍术10克，黄柏10克，苡仁30克，萆薢10克。

服法：水煎服，每日一剂。

局部可用蒲公英30克，野菊花30克，煎水外洗。

下肢丹毒反复发作，形成橡皮腿的，可用下列方剂治疗：

处方：黄芪30克，防己12克，苍术12克，泽泻30克。升麻15克，苡仁30克。黄柏12克，牛膝12克。水煎服。或作成丸药常服。

丹毒是完全可以预防的。平时要注意保护皮肤，避免皮肤损伤，有脚癣等皮肤病的，应积极治疗。平时不要挖鼻孔、拔鼻毛，以免损伤鼻粘膜。发生丹毒时应及时治疗（内服药物及外洗），并抬高患肢，适当休息。

81. 破 伤 风

破伤风是由破伤风杆菌侵入人体而发生的一种常见病，

病程短，症状严重。破伤风杆菌是一种厌氧菌，在自然界分布极广，存在于铁锈、土壤、粪土以及污物中，生存时间很长。凡是外伤，特别是深的伤口被铁锈、泥土和碎屑污染时，很容易得破伤风。

破伤风的潜伏期一般为7~14天，最短的十多个小时，最长的可达两年半之久。由于破伤风杆菌在体内大量生长繁殖，产生外毒素，侵袭神经系统的运动神经细胞，从而出现一系列的症状。开始，病人畏寒、嗜睡、大汗、喉痛、咀嚼困难、颈项较强硬，经1~2天后，症状明显加剧，不能张口，口角向外向上牵引，双眉举起，病人呈苦笑表情，接着发生嚼肌抽搐，牙关紧闭，吞咽食物已感困难，颈、背部肌肉抽搐，出现角弓反张，最后，病人全身肌肉抽搐（痉挛），若遇声、光的刺激，抽搐更加频繁，如不及时抢救，病人可能于一周内因心力衰竭、窒息而死亡。

破伤风患者神志始终清醒。若有高热，常提示有毒血症、肺炎等并发症。

中医认为破伤风是由于皮肤破伤之后，“风毒”入侵，流窜经络引起（新生儿断脐时感染的破伤风，则称为“脐风”）。

中医治疗破伤风的原则是祛风解痉，镇惊定搐。

方一：蜈蚣2条，钩藤10克，硃砂1克，全蝎6克，蝉衣20克，地龙10克，僵蚕10克（有条件者加麝香1克），共研细粉（一日量），分2~3次服。小儿酌减。

控制抽搐是治疗破伤风的关键，可随证加用镇静的中西药物。若病情严重，抽搐不止，可重用蝉衣治疗（见处方二）。

方二：蝉衣60克，钩藤30克，制南星10克，地龙12克，桂枝10克，全蝎6克，僵蚕15克，蜈蚣2条。水煎服。

据报道，一新生儿破伤风患者，经中西药物治疗，抽搐

未能控制，时而窒息，乃重用蝉衣30克，全蝎3个，加水浓煎，从患儿口内徐徐注入，注药后抽搐减少，未再窒息。原方又进，每日一剂，24小时内服完，症状消失，吮乳自如而停药，疗程4天，共服蝉蜕120克，服后无不良反应。随访七年未复发。

在临床上，除中药治疗外，加用针灸疗法治疗破伤风，常能提高疗效。

针灸穴位：合谷、颊车、下关、太冲、委中、曲池、腰俞、长强、大椎、风府。

注：中医治疗破伤风的传统方剂玉真散，其解痉作用不及上述处方。

破伤风发病急剧，治疗不及时可引起死亡。因此，预防显得非常重要，对较大较深的伤口，或有泥土、铁锈污染的伤口，均应进行彻底清创，并注射破伤风抗毒素1500~3000国际单位。

82. 水火烫伤

烫伤，最常见的是水火烫伤。轻度烫伤，伤区较小，浅在皮表，不需内服药物治疗。严重烫伤，烧伤，则因皮肤大面积损伤，气血津液和内脏受损，全身反应亦重，则须内治与外治并重。

烫伤、烧伤初起，因火热之邪损伤肌肤，体内津液大量外渗，而使阴血津液严重耗伤，如阴虚至极，阳气亦会随之而脱，故烧伤早期可见虚脱证候（阴虚阳脱）。以后因皮肤受损，卫外功能丧失，易受火毒侵袭而致邪热伤阴（伤津），甚至火毒陷入营血，内攻脏腑。本病在恢复期可出现气血亏虚

的证候。

(一) 内治法

1. 阴伤阳脱：烫伤（烧伤）后皮肤有水泡，水肿，津液外渗，口渴，烦躁，尿闭，气短，面色苍白，四肢发凉，出冷汗，脉微细。

处方：红参10克（嚼服），制附片（先熬）15克，生地30克，麦冬15克，五味子15克，玄参30克。水煎服。

2. 邪热伤津：壮热烦躁，口渴喜饮，便秘尿少，舌绛，苔黄，脉数。

处方：黄连10克，黄柏10克，山栀10克，银花30克，甘草10克，丹皮10克，白芍15克，生地30克，（此为基本方）水煎服。如见神昏谵语，用基本方再加服安宫牛黄丸、紫雪丹。如见痉挛动风，头摇目窜直视，用基本方加羚羊角、钩藤等。

3. 气血亏虚：热毒渐退，神疲无力，面色少华，新肉生长缓慢者，治宜补益气血。

处方：黄芪30克，党参30克，当归10克，川芎10克，白芍10克，熟地15克，茯苓10克，白术12克，甘草10克。水煎服。

(二) 外治法

1. 虎杖根研成极细粉末，用麻油调成糊剂，消毒后涂于伤面。反复涂药，干后结成痂膜，如痂下有脓，把痂膜除去后再涂药。

2. 大黄半斤。先用陈石灰1斤置锅内炒热（呈浮动状态时），加入大黄半斤，不断搅拌，等石灰炒至桃红色，大黄炒至黑灰色时，出锅，筛去石灰，大黄放冷后研粉备用。用时将大黄粉撒于伤面。如有水泡，应刺破，排净液体后再撒大黄粉。如伤处无破皮仅系红肿，则用麻油与大黄粉调成糊状，

涂患处。

3.生黄瓜数斤，用冷开水反复洗净，捣烂取汁（容器应洗净），用消毒棉签蘸黄瓜汁涂于伤面，轻者每日涂三次，重者每日涂六至九次，复原快，愈后无瘢痕。

4.紫草60克，细辛12克，冰片1克，麻油壹斤，将油煮沸，放入紫草，紫草焦黑时，放入细辛，待紫草、细辛都焦化，将药渣捞出，放入冰片，待冷，涂敷患处。

5.侧柏叶30克，地榆30克，木芙蓉叶30克，白芨30克，银花藤30克，加水连熬三次，纱布过滤，将三次滤液浓缩，放入冰片3克，搅匀放冷涂患处。每二小时涂一次，结痂后可减少涂药次数。

6.老松树皮，烧成纯炭，粉碎过筛，高压消毒备用，用时以消毒蜂蜜调敷患处。

7.大黄15克，栀子15克，黄柏15克，紫草15克，薄荷15克，石膏50克。将药放入500毫升麻油中浸泡24小时，放入锅中用文火炸至焦黄去渣，离火趁热加入蜂蜡150克，搅匀冷却成膏，瓶贮密封备用。局部清创后，涂抹本药膏。

8.石榴皮500克，用清水洗净后放入锅内，加水500毫升，文火煎至250毫升，过滤后置瓶中备用。夏天可加防腐剂。将医用纱布剪成1×1厘米大小，消毒后备用。患处清创后，根据创面大小将纱布块用中药液浸湿，一块一块贴于患处，两块纱布间可留1毫米宽的间隙。成人用暴露法。第二天观察创面，如无渗液，纱布块干燥不必换药，痊愈后纱布块可自行脱落。如纱布块被渗出液浸湿，应及时除去，重新更换浸有药液的纱布块。儿童患者用包扎法，创面按成人方法处理后再用无菌纱布予以包扎，外面用弹力绷带舒松固定。

9.蜂蜜适量。烧伤创面经一般清洁处理后，即涂以蜂蜜，

早期每日涂4~5次，涂均匀，不宜过厚或过薄。创面采用暴露疗法。待创面形成一透明胶痂后，涂蜜次数可以减少到每日1~2次。对已感染的烧伤，可用蜂蜜纱布敷于创面，外用无菌棉垫包扎。冬天不便采用暴露疗法者，也可采用此法。

83. 冻 疮

冻疮是由于寒冷、潮湿及局部皮肤血液循环障碍所引起的。人的身体功能状况与冻疮的发病有着重要的关系，同样在寒冷环境中工作，有人患冻疮，有人不患冻疮。

冻疮好发于手、足、面颊、耳壳及鼻尖等血液循环较差的暴露部位。冻疮是局限性暗红色水肿性斑片，触之有冷的感觉。用手指压之退色，压力去掉后，红色恢复很慢。重者有水疱。

冻疮患者感觉患处有肿胀感，暖热后有刺痒感和烧灼感，破溃后有痛感。病程较慢，一般到温暖季节才逐渐痊愈。

中医认为冻疮是由于寒冷而气血凝滞所致。平素气血虚弱，缺乏锻炼，耐寒性差，久坐少动，均易发生冻疮。一般采用温阳通络，活血化瘀的中药治疗。

（一）内治法

处方：桂枝10克，白芍10克，当归12克，甘草6克，大枣15克，水煎服。

（二）外治法

方一：老丝瓜，烧存性，研末，猪油调涂患处。

方二：麻雀脑浆涂患处，一日数次。方法：将活麻雀从嘴部撕开，露出脑壳，轻轻将脑壳揭开，取出脑浆涂患处。

涂后稍有清凉感。冻疮破溃者，涂麻雀脑浆，疗效更佳。

方三：甘草、芫花各20克，加水1000毫升，煎后泡洗患处，每日泡洗三次，每次泡洗20分钟（此药只能外洗，不可内服）。每剂可洗3次。有破溃者仍可泡洗，但洗后应用黄连纱条外敷。

方四：红花30克，干姜30克，黄柏30克，王不留行30克，加水500毫升，浸泡10小时，然后煎至200毫升，过滤，加等量的95%酒精混合即得。外涂患处，每日三次。

方五：马勃15克，煅明矾30克，干姜（炒黄）30克，共研细末，撒患处，包扎，每天换药一次（适用于冻疮破溃者）。

方六：樱桃适量，30~50%白酒适量。用法：在樱桃成熟季节，购买质量好、未烂的鲜樱桃（八分熟）用冷开水洗净，放入瓶中，加入30~50%的白酒至浸没樱桃为度，加盖密封，埋于背阴的地下2尺深，待天冷时取出，将樱桃和酒分别装瓶备用。轻度冻疮用樱桃酒涂搽患处，一日两次至三次。冻疮溃烂者可将樱桃去核去蒂，研成肉泥，敷于患处。

方七：十滴水，脱脂棉蘸药涂患处。

冻疮的预防：

药物预防：独头蒜数枚。方法：夏季（七月份）将独头蒜捣烂，放在太阳下晒热后趁热在冬季易生冻疮的部位揉擦，每天揉擦2次，每次揉擦15分钟。一般揉擦4~5天，到了冬季原发部位即可不生冻疮。

也可用生姜15克煎汤一碗，擦洗原发部位（可于冬季即将发生冻疮时擦洗）。

在饮食方面要注意营养。

经常参加体力劳动和体育锻炼，如打球、跑步、爬山，以增强体质，促进血液循环。

冬季做到勤活动、勤换鞋袜、勤洗脚、勤擦耳鼻，不穿潮湿或过小、过紧的鞋袜，不要用火烤和热水烫洗冻疮部位。

84. 皲裂

皲裂俗称皮肤裂口，是由于皮肤缺乏弹力所产生的断裂，发生于手足者称手足皲裂。引起皲裂的主要原因有：

1.冬天气候寒冷干燥，出汗少，手脚上的皮脂分泌亦稀少，皮肤缺乏水分和油润，弹性减低，变脆，如不注意保护皮肤，很易发生裂口。

2.洗手洗脸后不马上擦干，冷风一吹，皮肤也容易发生裂口。

3.患手癣（俗称鹅掌风）、脚癣（俗称脚湿气）的人，一到冬季，因皮肤干燥，容易裂口。

4.由于职业的关系，经常用碱性肥皂洗手，或者经常接触溶解脂肪或吸水的物质，或经常受到摩擦，使皮肤干燥变厚，失去其坚韧和弹性，皮肤排出的少量汗液和皮脂不足以发挥其应有的保护作用，皮肤就容易发生皲裂。

中医认为皲裂是由于肌肤骤受寒冷风燥，以致血脉阻滞，肤失濡养，皮肤干燥粗糙而成皲裂。

皲裂的中药治疗：

1.甘草50克，75%酒精100毫升，甘油适量，水适量。先将甘草浸于酒精内，48小时后过滤，取滤液，加入同量的甘油、同量的水，混合即成。

用法：涂患处，每日涂2~3次，一般涂3~5天后皮肤软化变薄、光滑，裂口愈合。

2.白芨研粉，植物油调涂患处。

3.黄柏，白敛等量，研细末，植物油调涂患处。

4.地骨皮15克、白矾30克，煎水，浸洗患处。（泡30分钟），洗后擦干，再用10%硼酸软膏外涂。

5.新鲜苦楝子去核，捣烂如泥，外搽患处。

6.蛇蜕30克、血余30克、植物油150克，将植物油烧开后，放入蛇蜕、血余，等这两种药完全溶解，离火冷却成糊状，涂患处。

皸裂的预防：

每到冷天预计将要发生皸裂时，常用热水浸泡手脚，搽些蛤蜊油、猪油、花生油、甘油、凡士林、市售香脂等。或用蜂蜜一份、水两份调匀涂抹，这对皮肤的营养和滋润都有良好的作用。平时少用碱性强的肥皂（或药皂）洗手、洗脸或洗衣服。做到以上这些，可收到预防皸裂的效果。

85. 毒蛇咬伤

毒蛇咬伤在山区和农村较多见。

蛇毒是一种粘性蛋白质混合物。其主要有毒成份为神经毒、血循毒和二者均有的混合毒。

被毒蛇咬伤后，毒液侵入人体，随气血运行，扩散到全身，引起局部和全身毒性反应。反应轻重，常与人体抵抗力、毒蛇种类和毒力强弱等有关。

毒蛇的毒素主要分为“风毒”（即神经毒，主要作用于神经系统，可引起神经麻痹及呼吸麻痹）与“火毒”（即血循毒，主要作用于血液及循环系统，可引起溶血、出血和中毒性休

克)两种。中医认为风毒首先侵犯肝经,出现头昏痛、复视、关节酸痛等证,影响到脾胃,可见呕吐、腹痛、吐沫流涎、瘫痪,最后侵犯心肺,可致昏迷、呼吸停止而死亡。火毒入血,可见发热、吐血、便血、鼻衄及皮下出血等症,火毒耗伤阴血,阴伤及阳,可致心阳虚脱而死亡。风火毒(混合毒)则同时具有上述两种病理变化。

治宜清热解毒为主。

(一) 内治法

1.被毒蛇咬伤后立即内服成药“蛇药片”,使毒气不随血走。或用五灵脂4.5克,雄黄1.5克研末调酒服。

2.辨证施治:

①风症(风毒为患):局部无明显红肿,无渗液,疼痛轻微,或有麻木感,全身症状轻者只见头晕、头痛、胸闷、呕吐,重者可见瞳孔散大,视力模糊,语言不清,呼吸困难等。治宜清热解毒、熄风定惊。

处方:半边莲、紫花地丁、野菊花各30克,蚤休15克,白芷、川贝(冲服)、龙胆草、甘草、僵蚕各10克,蝉衣、全蝎、蜈蚣各6克,水煎服。

②火症(火毒为患):局部伤口疼痛,肿胀,起水泡,甚则呈紫黑色,全身症状有恶寒、发热、肌肉酸痛、皮肤或内脏出血、黄疸、贫血等。严重者可发生昏厥。治宜清热解毒,凉血止血。

处方:半边莲、蚤休、白茅根、仙鹤草、生地各30克,丹皮、黄芩、赤芍、山栀各10克,水煎服。

③风火兼症(兼见风毒、火毒的症状):以上两种症状都有,治宜以上两法合用。

(二) 外治法

立即将伤部上端扎紧，立即用肥皂水或银花煎水冲洗伤口，有毒牙立即除去，用成药“蛇药片”涂伤口，或用半边莲、野菊花、紫花地丁、蚤休等新鲜草药，捣烂外敷伤口。如伤口已闭，用三棱针消毒后刺入放血，并在上部向下挤压排出毒水。

86. 下肢慢性溃疡

下肢慢性溃疡，多发生于下肢静脉曲张的病人。其特点是溃疡经久难敛，或虽经收口，每易因轻微损伤、感染而复发。

脊髓神经、周围神经疾患（包括损伤），特殊性感染（如结核、恶性肿瘤等），致下肢局部血液相对地供应不足，都可成为发生溃疡的因素。

下肢慢性溃疡，祖国医学又称“臁疮”，多因经久站立或负重，以致筋脉失畅，复因湿热下注，瘀血凝聚，经络阻滞，气血不通，肌肤失于濡养，溃破而成疮。

本病初起先痒后痛，焮红漫肿，继则破溃，滋水淋漓，渐成溃疡，日久不愈。边缘下陷，肉色灰白或暗红，渗液恶臭；溃疡周围皮肤呈黯红或紫黑，并因脓水浸淫而并发湿疹。严重者可伤筋损骨，形成化脓性骨髓炎。

本病的治疗，首先应积极防治各种原发疾病，如下肢静脉曲张、结核、恶性肿瘤，消除病因，改善全身情况，促进局部血液循环。

（一）内治法

1. 初起焮红漫肿，渗液，治宜清热利湿为主。

处方：黄柏12克，牛膝12克，苍术12克，萆薢12克，苡仁

30克，银花30克，紫草30克，黄芪30克，茯苓15克，泽泻10克。
水煎服。

2. 溃疡日久不愈，气血不足，治宜通络补虚为主。

处方：黄芪30克，当归12克，桂枝10克，大枣30克，红花10克，桃仁10克，赤芍12克，白术10克，丹参30克。水煎服。

（二）外治法

1. 乌贼骨，放火上烤干，至淡黄色为止，研细末，撒于溃疡面，包以纱布，在治疗过程中，不可被水打湿，两日换药一次，直至痊愈。

2. 绿豆60克，大黄30克，甘草15克，共研细末，用蜂蜜调敷患处。外用纱布包扎。

3. 大活蚯蚓30~50条，凉水洗净，放入杯内，加水，任其吐出泥土，约三小时后，再用水洗净，放入干净杯内，撒白糖60克，加盖静置15小时，蚯蚓全部化成淡黄色粘性液体，过滤，消毒（蒸）后放冷，即可涂于创面，外用纱布包扎固定，每日换药一次。

4. 白糖适量，满撒于创面（厚厚的一层），外用纱布包扎，每两天一洗。

注：外治下肢慢性溃疡，上药后必须用纱布包扎固定。

87. 带状疱疹

带状疱疹由带状疱疹病毒所致。疲乏、感冒、肿瘤。某些药物等均可是发病诱因。

带状疱疹多在春秋季节发生。

发病前患处多先有皮肤刺痛或灼热感，或伴有轻度发热。疲乏无力、食欲不振等全身症状。

皮疹大多发生在身体一侧，多见于腰胁部。初起皮肤发红，出现群集的丘疹和水泡，周围伴有红晕，常沿神经分布呈“条带状”，自觉疼痛和灼热。疱群之间间隔正常皮肤，疱内内容物初为透明，约三、五天后可呈浑浊。严重时可出现血疱（出血性带状疱疹）或坏死（坏死性带状疱疹）。常伴有附近淋巴结肿大疼痛。发生在眼部的带状疱疹还可引起结膜炎、溃疡性角膜炎，甚至可引起眼球炎或脑膜炎。

带状疱疹的特点是局部显著疼痛，个别病人皮疹消退后疼痛仍顽固不退。

带状疱疹祖国医学称为“缠腰火丹”、“蛇丹”、“蛇串疮”、“蜘蛛疮”。患过本病，很少有复发的病例。

本病多由肝火或脾经湿热蕴结，循经外溢所致。但当全身或局部抵抗力减低时，也可诱发本病。

治疗原则为清热利湿，凉血解毒，理气止痛。

（一）内治法

1. 板蓝根30克，煎汤代茶饮。
2. 银花15克，紫花地丁20克，虎杖30克，板蓝根20克，黄精15克，侧柏叶15克，赤芍10克。水煎服。

（二）外治法

1. 雄黄、吴茱萸、苡仁各等分，共研细末，冷开水调成糊状外搽患处。
2. 马齿苋或杠板归，洗净捣烂后外敷。
3. 雄黄，用食醋调成糊状，外搽患处。
4. 蚕休磨醋外搽患处。

预防：

1. 注意体育锻练，增强抗病能力。
2. 少吃刺激性食物。
3. 注意个人卫生，勤洗澡，勤剪指甲。

88. 寻常疣

寻常疣俗称“瘊子”，是一种由病毒传染的皮肤病。有人说弄了鱼要长“鱼瘊子”，这种说法是没有科学根据的。“瘊子”是由病毒通过接触传染所致，生长于皮肤浅表的小赘生物（凸起于皮肤表面），大小如米粒或黄豆或蚕豆，角质增生性丘疹，表面粗糙不平（好象菜花芯一样），质硬，灰褐色或污黄色。基底无炎症，不痛不痒。好发于手背、手指、甲缘、头面、足底等部位。一般没有自觉症状。最初发一个，叫做“母疣”，以后可自身传播发生多个（最多的全身可发生二百多个“瘊子”）。

中医称寻常疣为“疣目”、“枯筋箭”、“瘊子”、“竖头肉”，认为多由风热郁结，肝血失养，筋气不荣，风热血燥搏于肌肉所致，治宜软坚化结，活血通络。

疣的中药外治法：

1. 鸦胆子仁外搽患处或敷于患处24~48小时（用胶布保护周围正常皮肤），然后用刀削去已被腐烂组织，如此反复2~3次。

2. 木贼草30克，香附30克，加水三斤，煎沸后倒入盆中。寻常疣生长于手足部位者，可待药稍温后浸泡，反复淋洗揉搓。寻常疣生长于面部或身体其他部位者，可用棉花浸透药液，放在寻常疣表面轻轻揉搓，促使药液向寻常疣组织内渗透。每日早晚各一次，每次揉搓半小时，一般洗3~7天，寻

常疣可自行脱落，不留痕迹。

3.板蓝根、大青叶各30克，黄柏15克，苡仁30克，熬水擦洗患处，每天二次，每次擦洗半小时。

4.了哥王（果实）30克，捣烂，泡入95%酒精30毫升中，两周后，过滤，涂患处。涂药前先将寻常疣（特别是“母疣”）挑破，再涂药。每次涂擦五分钟。一日一次。寻常疣多者，可分批治疗。

5.生石灰250克，鸦胆子仁30克，血竭15克，将三者混合研碎，细罗过筛，粉末呈淡红色，装瓶备用。用法：取少许药粉放在疣的顶端，用拇指轻轻揉搓，边搓边加药粉，直至将疣体完全搓落为止。搓时如有血不必介意，可加少许药粉，继续揉搓。疣体搓落后，基底略出血，以药粉按压之，片刻血即止。搓时注意保护健康皮肤，用力不宜要大，应一次将全部疣体搓落，以免复发。

6.紫苏叶（最好摘下后立刻使用），用前将叶洗净，并用75%酒精拭擦紫苏叶的两面。用法：洗净患处，常规消毒，疣突出者可用消毒剪刀贴皮将疣剪去，并立刻用洗净的鲜紫苏叶擦10~15分钟，患处会自行止血。然后用纱布包扎。此后每日擦紫苏叶一次。患部的痂皮可用消毒剪刀轻轻挑去。

寻常疣的中药内治法：

方一：金钱草60克，川芎10克，红花10克，桃仁10克，生牡蛎30克，煅牡蛎30克，炮甲珠15克，大青叶30克，板蓝根30克。水煎服。

方二：生地30克，蒲公英30克，白藓皮12克，地肤子12克，当归12克，丹参15克，三棱10克，莪术10克，苦参20克，僵蚕10克，干蟾皮10克，百部10克。水煎服。

方三：鲜鸡蛋7个，煮熟，剥去蛋壳，每个蛋用竹筷刺10

个小孔，再夹成四等分，装杯内，加入食醋70毫升，拌匀，加盖放置6小时后，空腹时连蛋带醋一次服下。如胃口不好，当天内分2~3次空腹服食。服时忌用盐、酱油，更忌食碱性食物或碱性药物。

每周服食醋蛋一次，一般用1~2次即见效。

方四：(干)松花蕾10~20个，川芎10克，盐适量。水煎服，每日一剂，连服十天。如胃痛可停药2~3天，痛止后继续服药。

89. 扁平疣

扁平疣是一种病毒感染所致的慢性皮肤病，多见于青年男女，故又称“青年扁平疣”。

扁平疣好发于面部和手背，呈淡红色或褐色、针头至绿豆大小的扁平丘疹，质坚，有时沿抓痕排列成线状。大都无自觉症状，少数有轻度痒感。

患扁平疣虽不痛苦，但多发于青年人，故求治心切。

中医认为扁平疣系外感风热之毒，肝阳上行，风火上扰所致。治宜散风平肝，清热解毒。

(一) 内治法

方一：生牡蛎30克，煅牡蛎30克，黄柏10克，赤芍12克，桑叶30克，紫草30克，大青叶30克，板蓝根30克，水煎服。

方二：苡仁60克，煮粥食（空腹服用，可加白糖）以上为一日量。连服一个月。

方三：马齿苋60克，紫草30克，败酱草20克，板蓝根30

克，红花10克，水煎服，每日一剂，连服半个月。

（二）外治法

①新鲜鸡内金（或干的鸡内金泡软）揉擦患处，每次揉擦15分钟，每日1~2次。

②木贼草60克，香附60克，加水浓煎，用棉花蘸药汁淋洗患处，每次淋洗30分钟，每日二次。淋洗后皮肤可发红。连续淋洗1~2周（本方也可内服）。

③蛇床子60克，地肤子60克，白藓皮60克，明矾60克，加水浓煎，趁热擦洗患处，每次擦洗30分钟，每日2~3次，连用10天。一剂药可用6次。愈后不留痕迹。

④马齿苋30克（鲜的60克），苍术10克，蜂房10克，白芷10克，细辛6克，蛇床子15克，苦参20克，陈皮15克。水煎趁热洗患处，每日3~5次，连洗10日。

对扁平疣的治疗，最好内治法和外治法同时进行。上面介绍的內治法处方和外治法处方可各任选一种。

90. 皮肤癣病

皮肤癣病是指一些真菌（又称霉菌）侵犯表皮、毛发和指（趾）甲等而引起的浅部真菌病。

真菌（霉菌）广泛存在于自然界，其中能使人体致病的有40~50种。致病真菌乘人体抵抗力减弱或在适宜条件下（如温暖、潮湿），侵犯人的体表或内脏，引起病变。

真菌侵犯体表（浅部）引起的病变，通称为“癣”。

真菌侵犯内脏（深部）引起的病变，称为“深部真菌（霉菌）病”。如白色念珠菌病、孢子丝菌病等等。本文只谈皮

肤癣病，不谈深部真菌病。

人们所说的“癣”，有的实际上不是皮肤癣病（浅部真菌病）。如有人把银屑病称为“牛皮癣”或“松皮癣”，有人把神经性皮炎称为“牛皮癣”，这些都容易混淆，应该有统一的认识，以利治疗（银屑病和神经性皮炎的中药治疗将另文叙述）。

中医认为癣主要由“虫”所引起，同时与风、热、湿诸邪的侵袭有关。外邪袭入皮肤，与卫气津液搏结，聚而不散，发为癣病。久则导致营血不濡，出现皮肤干枯失润。若夹有湿邪郁结，则有渗液。经久气血受损，则缠绵难愈。

癣的治疗，以局部治疗为主，内服药常以祛风、清热、燥湿、杀虫等法配合运用。由于各种癣的症状不同，局部治疗方法也有所区别。

下面分别谈谈头癣、体癣、手癣、脚癣、指（趾）甲癣的中药治疗。

头 癣

头癣俗称“秃疮”、“癞痢头”，是农村的常见病。病因是真菌感染。这种真菌必须用显微镜放大才能看清楚。头癣绝大多数发生于儿童。小孩的头皮薄，分泌的油脂少，抵抗力较差，病菌通过理发工具、帽子、梳子、枕头等传染途径，从头皮进到毛囊内，随着头发的生长，再钻到头发里，形成脓疱、鳞屑或痂皮，天长日久，就变成大面积的病损，毛发丧失光泽且容易折断，或脱落而成斑秃状脱发。

头癣分为黄癣、白癣、黑癣三种类型。

各型头癣具有下列共同特点：

1. 主要发生于儿童，特别是6~8岁的男孩最多。
2. 头皮和头发均有不同程度的病变。

3. 病程缓慢，不受季节的影响。

4. 自觉瘙痒。

5. 有明显的传染性。

6. 对一般治疗不易见效。

头癣的中药外治法：

1. 雄黄30克，硫黄60克（研细末），和匀，调猪油外敷患处。

2. 苦楝子（炒黄）研细末，和猪油调敷患处，敷药时要用力揉擦，使药透入，每日换药一次。

3. 桐树花，新鲜童便。制法：将桐树花摘下，放入新瓦罐内，用手按紧，倒入新鲜童便，以淹没桐树花为度，加盖密封，将瓦罐埋入地下三尺，七天后取出，拌匀备用。用法：将头发剃光，再敷上述药物。敷药时要用力揉搓，药要敷得稍厚一些。每日换药二次。

头癣的中药内治法：

处方：蛇蛻10克，蝉蛻6克，僵蚕6克，全蝎6克，甘草6克，黄连10克，防风10克，花粉18克，大枫子12粒（连皮捣碎），生石膏45克，水煎服，每日一剂，连服10~15天。

头癣病人要每周剃头一次，连剃八次。不愿剃发者，要特别加强洗头。

头癣病人每天要用热水肥皂洗头，连洗两个月。洗后擦药，连擦三个月。

病人用过的帽子、枕巾、毛巾、理发工具等都要严格消毒。

体 癣

体癣又称钱癣或圆癣，是面、颈、躯干及四肢体表的浅部真菌（霉菌）感染，常来自足癣、手癣、甲癣的自身传染。

体癣初起为红丘疹，逐渐向外扩展，中心趋向痊愈，形成环状（圆癣）或半环状，边缘由丘疹、水疱组成，伴有细屑和结痂。发于股部的称“股癣”。

体癣好发于夏季，有不同程度的瘙痒。

多汗、糖尿病、长期用皮质类固醇激素治病的患者容易得体癣。

体癣的中药治疗：

1. 家鸽粪、食醋。方法：食醋一斤煮沸加入家鸽粪50克，边煮边搅，搅拌成糊状，即可。每晚用毛刷（或棉花）蘸涂患处1~2次，病重者白天也须涂药。

2. 密陀僧30克，乌贼骨30克，黄柏20克，硫磺15克，川椒15克，共研细末，装瓶备用。用时取生姜一块，沾药粉揉擦患处，早晚各擦一次，擦后勿用水洗。连续用药20天。

3. 土槿皮30克，泡入75%酒精30毫升中，泡七天后，外涂患处（或用成药土槿皮酊外搽）。

股癣患者可内服中药配合治疗：

处方：龙胆草10克，木通10克，柴胡12克，泽泻10克，车前草20克，生地12克，当归12克，甘草10克，山栀10克，黄芩10克。水煎服。

手癣、脚癣、甲癣

手癣俗称“鹅掌风”，脚癣俗称“脚气”或“脚湿气”，甲癣俗称“灰指甲”，都是浅部霉菌感染。

手、脚癣分三型：①指（趾）间糜烂型：常见于多汗的人，指（趾）间皮肤浸渍发白（呈乳白色），剥去表皮，露出潮红糜烂面。②水泡型：常发生于夏季，表现为成群或分散的水疱。③鳞屑角化型：表现为成片的脱屑，边缘清楚，呈环状或半环状，日久，皮肤粗厚，皮纹增宽加深，冬天裂

开、疼痛。此型最常见。

手癣和脚癣发病常两侧对称，都有不同程度的瘙痒。在夏季，常因搔痒抓破皮肤，合并细菌感染，如引起丹毒，甚至引起败血症等等。

甲癣常由手癣、脚癣的自家传染而发生，很少单独存在。初起时，指（趾）甲可出现灰白色斑点，逐渐扩大，然后指（趾）甲失去光泽，变混浊，增厚，表面粗糙不平，易碎。

手癣、脚癣和甲癣的中药外治法：

1. 风仙花（全草）60克，土槿皮60克，花椒30克，加米醋一斤，浸泡一周后取滤液备用。用此药浸泡患处，每次浸泡15分钟，每天一次。（如有甲癣，浸泡5分钟后，用刀片刮除灰指甲，再行浸泡。下面介绍的处方，如用于治疗甲癣，都要把灰指甲用刀刮去，再用药液浸泡）。

2. 大枫子仁、明矾、红花、荆芥、皂角、防风各15克，加醋二斤，浸泡三天，滤去药渣备用。用时先洗净患处，揩干，浸入上述药醋中半小时，每日浸泡一次。

3. 斑蝥0.5克，蜈蚣4条，樟脑10克，白芨10克，土槿皮10克，大黄10克，马钱子10克，共研细末，用米醋一市斤浸泡48小时即可用。用时将患肢浸入药液，初次每日浸泡10分钟，三天后每日浸泡半小时至一小时。

本品易挥发，用后密闭保存，一年左右仍有效。

91. 湿 疹

湿疹是一种变态反应性炎性皮肤病，主要特点是皮损呈多形性（皮肤潮红、浸润、流水，并有红斑，丘疹，水泡，

脓疮，皲裂，表皮剥落，但流水及潮湿是常规现象），对称发生，剧烈搔痒，反复发作。

湿疹的发病原因很复杂，与体质、神经状态、内分泌、血液循环、消化系统、代谢营养、内脏功能以及细菌、真菌、寄生虫、病灶感染、各种内外致敏病原都有关系。病因尚待进一步探讨。一般认为，湿疹是由于内在刺激因素（如病灶感染，寄生虫感染，吃某些食物，服用某些药物）或外来刺激因素（如寒冷、日光、化学药品、植物、昆虫等）作用于机体而引起的皮肤变态反应性炎症。在日常生活中人们接触各种刺激因素的机会很多，但是否发生湿疹，主要取决于机体的内在因素。机体敏感性高者易于发生湿疹，而过敏体质又与遗传、工作、生活环境等因素有关。通过加强锻炼，逐步增强身体对外界环境的适应性能力，可以减低机体的敏感性，改变过敏体质，而减少湿疹的发生。

湿疹好发于身体暴露部位，如四肢远端、肘，腘窝、面部等处，严重时可泛发于全身。

临床特点：

1. 急性湿疹：初起为红斑，皮损境界不清楚，继而在红斑及其周围出现米粒大小的丘疹或水泡，常密集成片，且可因搔抓使水泡破裂而形成糜烂面，干燥后可结痂。若有继发感染可于病损处出现脓性分泌物，并伴有局部淋巴结肿大等。

2. 慢性湿疹：由于急性湿疹反复发作，使病变波及皮肤深层，形成皮肤肥厚，并在皮肤肥厚的基础上因搔抓可见血痂、抓痕、脱屑等皮损。发生在手脚部的慢性湿疹还可形成皲裂而影响劳动。

3. 婴儿湿疹：也叫奶癣，常发生在出生后1~2个月，

好发于头部、面部，严重者可泛发全身。患儿瘙痒，病情往往时轻时重，常在发热、腹泻时皮损明显好转或消退，但病愈后又复出现。婴儿湿疹临床上分成两型：常见的一型是湿烂皮炎型，婴儿多较胖，营养发育较好，大便干秘。皮疹呈红色丘疹，渗出淡黄色液体，干燥后结成蜜黄色薄痂。另一型是干性皮炎型，婴儿皮肤干燥，发育较差，形体瘦小，消化不良，有腹泻等症状。皮疹多是干性红斑、丘疹鳞屑苔癣化片块。这两型皮疹的多少，要看病情轻重。轻者往往在头面部有散在几片皮疹，重者可遍布头面，甚至四肢、躯干均有大量皮疹，病儿有剧痒，严重时可昼夜啼哭，烦躁不安。

湿疹，祖国医学统称“湿疡”、“湿疮”、“湿癣”，依其皮损部位的不同而有许多命名，例如：发于头面部的叫“鼻翼疮”、“旋耳疮”、“燕窝疮”；发于颈胸部的叫“钮扣风”；发于四肢的叫“四弯风”；发于阴部的叫“肾囊风”、“阴疮”。此外，尚有“黄水疮”、“浸淫疮”和小儿“胎敛疮”（婴儿湿疹）等不同名称。中医认为湿疹主要是湿邪所引起，急性湿疹常是热邪、风邪相合所致，慢性湿疹多因脾胃虚弱，水湿失于运化，或由寒湿所致，或久病伤精耗液，最后成血虚、阴亏之症。换句话说，急性湿疹多系风湿热三气侵袭，慢性湿疹则与脾胃虚寒或血虚阴亏有关。

湿疹的中药治疗：

（一）外治法

1. 急性湿疹

①青黛30克，升华硫黄20克，用法：共研匀，加入麻油或菜油调成糊状，先用淡盐水洗净患处，再敷药，药不要敷得太多，每天早晚各搽一次，连搽几天。如瘙痒厉害，可在此方中加轻粉20克。

②生蒲黄粉撒布患处。方法：生蒲黄过筛，筛去杂质，研粉，将蒲黄粉直接撒在患处，渗液湿透药粉时，再继续撒药。再用药时，不要将原来已干燥的药粉去掉。

③蕃茄适量。将蕃茄洗净并用酒精消毒，去外皮用纱布压出浆汁，然后用纱布浸满浆汁，敷在患处，每3~4小时更换一次，同时患者口服蕃茄，每日一斤。

④马铃薯适量。先将马铃薯洗净，去皮，切成小块，再用冷开水冲洗，用消毒的器皿研成泥状，外敷患处，敷0.5厘米厚，每二小时更换一次，2~3次后，就有明显效果，瘙痒消失，黄水减少，敷6~8次后，糜烂面形成黑痂，自觉症状完全消失，黑痂渐脱落，有新的皮肤出现，如有个别患处不好可继续敷药，每日平均敷6~8次即可，睡前可敷厚一点，夜间不用换药。

⑤白藓皮30克，儿茶30克，乌梅30克，五倍子30克，苦楝皮30克，紫草茸10克，苦参30克另取少许冰片置瓦上烧（即放出浓烟），让其熏烤患处，俟烟放毕，离开；再用麻油少许调上药搽患处，不用包扎。1~2日按上法换药1次。

⑥地榆粉（过80目筛）800克，紫草粉（过80目筛）400克，氧化锌400克（如缺，可用炉甘石代），凡士林加至400克。地榆粉、紫草粉、氧化锌粉混合均匀。将凡士林加温熔化，待冷将凝时边搅边撒入上述混匀之粉末，并不断搅匀，直接涂敷患处。以纱布包扎，每日换药1~2次。换药前勿洗，可用无刺激性的植物油（麻油）拭净创面即可。

⑦当归16克，紫草30克，黄蜡30克，白蜡30克，麻油125克。将香油烧开加入当归、紫草共熬，待药炸枯去渣，纳入黄蜡、白蜡溶化后冷却，调成糊状，用时先用洗净患处，涂敷以上药膏，每日1次，无需包扎。

⑧硫黄15克，黄柏15克，白芨15克，白芷15克，白矾15克。将上药各研成细末后混匀备用。如湿疹未流水或未溃烂时，将药末用麻油调成糊状，涂患处。如已流水或已溃烂时，可单用药粉直接撒于患处，一般每天换药一次，严重者每天换药2次。换药前先用温开水洗净患处，但禁用肥皂水洗。流黄水或糜烂部位不大者，换药后可用纱布包扎。若病损范围大者涂药后不必包扎，保持局部清洁。

⑨雄黄10克，麻油10克。用火纸把雄黄包好，灌以香油，使渗透后，用火燃着火纸，滴下雄黄油。用温热的雄黄油涂抹患处，每天10次左右。连续涂抹约2星期。

2. 慢性湿疹

①吴茱萸30克，乌贼骨20克，硫磺6克。用法：共研细末，直接撒布患处。如患处没有渗液，可用以上药粉调“三黄软膏”（中成药）涂患处，每日换药一次。

②松香30克，轻粉30克，铜绿30克，枯矾30克，赤石脂30克，共研细末，用香油调成稠泥状（越稠越好）将药厚厚地涂于患处，待一小时许，药稍干，用纱布包裹，等其干燥结痂自己脱落而愈。顽固的慢性湿疹，须反复多次涂药。

③密陀僧10克，黄柏6克，冰片3克，研细末，用花生油调敷患处，每日1~2次。患处忌用水洗。

④干紫苏叶90克。先以苏叶30克在铁锅上炒过（以不炒焦为度），研细粉，装瓶备用。再以苏叶60克煎汤一沸，待温后熏洗患处20分钟，洗后不要擦干，立即用干紫苏粉撒布患处。每日一次（本方尤其适用于阴囊湿疹）。

⑤藁本60克，花椒60克，龙胆草60克，虎杖30克，冰片30克。前四药共研细粉，再与冰片研匀，调植物油外涂。涂药前先将患处用茶叶煎水洗干净，取新瓦一块，置火中煨至

将红，离火。将患处靠近瓦旁，以能耐受为度，然后涂药。

⑥野菊花30克，苍耳子30克，黄柏30克，紫草30克，马齿苋30克，白蒺藜30克，皂角刺30克，生甘草30克。加水5000毫升，文火煎至3000毫升，将药液浸入浴盆乘热熏洗。小面积湿疹将药液局部温热浸洗，每日1~3次。

⑦蛇床子30克，银花15克，连翘15克，黄柏15克，苦参30克，黄连15克，白矾10克。加水1000毫升，煎至700毫升，洗患处，每日2~3次。

⑧槐叶泥适量（新鲜槐叶两把，置于沸水中洗净。捣烂如泥状），用时先用温开水洗净患处，再将槐叶泥均匀地涂敷其上，并用纱布包扎，每日换药一次。

⑨鲜白杨树叶适量，加入等量水煮沸2~3小时，待液体呈黑色并有轻度粘性为止。过滤后再将滤液重新煮成粘稠性膏样物质为止，冷却后即成纯槐树叶膏。取此膏30克加凡士林至100克，外用。

3. 婴儿湿疹

①煅石膏10克，枯矾10克，白芷2克，冰片2克，雄黄10克，分别研成细末，过筛混合，再加等量凡士林调匀成膏，外敷患处，每日换药一次。

②蛇床子研为细末，调以凡士林（蛇床子粉末约为30%，凡士林约为70%），涂于患处，每日换药1~2次。

③海蛤粉20克，青黛20克，研匀，加等量凡士林调敷患处，每日数次。

（二）内治法

某些湿疹病人，单用外治法往往效果不大，宜同时内服中药。下列处方可任选一种内服。

方一：鲜苍耳草90克，白矾2克，煎浓汁500毫升，每次

服10毫升，一日三次。

方二：蝉蜕6克，防风10克，荆芥10克，白芷6克，赤芍10克，黄芩10克，黄连6克，柴胡10克，当归10克，乌梢蛇10克，甘草6克。水煎服。

方三：僵蚕10克，苍术10克，刺蒺藜10克，地肤子12克，紫草20克，夏枯草30克，丹皮10克，银花10克，白鲜皮15克，苦参20克，水煎服。

方四：生石膏30克，车前草30克，地龙15克，麻黄10克，乌梅20克，甘草10克。水煎服。

主 意 事 项：

①湿疹患者要尽量避免进食鱼、虾、蟹等海鲜类“发物”。

②湿疹患者要竭力避免搔抓、烫洗及滥用刺激性的外用药物，忌饮酒，忌饮浓茶，忌食辛辣食物。

③湿疹发病期间不应进行各种疫苗的预防接种、注射，以免诱发全身反应。

④多方寻找发病因素，设法加以去除。

⑤宜常吃含维生素B₂的食物，如动物肝、肾，牛奶，蛋类，香菇，鲜豆，花生，绿叶蔬菜。因维生素B₂易溶于水，怕碱，容易氧化，所以要注意合理烹调，避免造成过多的损失。

但是要注意，维生素B₂忌在饭前服用。因为维生素B₂只能在小肠吸收。要是饭前(空腹)吃含维生素B₂的食物，大量维生素B₂在小肠里停留时间很短，而且很快达到饱和程度，就不再吸收了。如在饭后吃含维生素B₂的食物，情况就好得多，通过小肠需要2小时左右，不易饱和，使小肠慢慢地吸收维生素B₂，吸收量比空腹时增加了3倍左右。

⑥宜常吃鱼籽（鱼卵）。因为鱼卵对阴囊等部位的湿疹有一定的治疗作用。

92. 荨 麻 疹

荨麻疹俗称“风疹块”“风团”，中医称为“痞瘤”、“风疔”、“瘾疹”，是一种常见的过敏性皮肤病。

荨麻疹可由多种原因引起，主要有：蚊、虱、臭虫、毛虫等昆虫叮咬，冷、热、风、日光等的物理性刺激，花粉、苜麻等植物性刺激，食入鱼、虾、蟹等“发物”，注射血清、青霉素等药物，病灶感染或肠寄生虫感染产生的毒性物质刺激等等。胃肠功能紊乱，内分泌功能失调，代谢障碍，神经精神创伤等也可引起荨麻疹。

荨麻疹的临床特点是皮肤上出现大小不等的鲜红色、淡红色或瓷白色的风团，这种风团常突然出现，数小时后又迅即消退，消退后不留任何痕迹。

荨麻疹可反复发作，慢性者可反复发作数周、数月甚至数年、搔痒难忍。

风团（风疔）可发生在全身皮肤上的任何部位，粘膜也可被累及。如风团发生在胃肠道粘膜上，则可有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。如风团发生在喉头粘膜则可有气闷、呼吸困难，甚至有窒息的危险。

祖国医学认为荨麻疹主要是风、湿、热邪蕴于肌肤所致，或血中有热又感外风而发病。

急性荨麻疹的中药治疗以祛风、清热、祛湿为主。

方一：荆芥10克，防风10克，紫草30克，黄芪30克，苦参20克，地肤子20克，蒲公英20克。水煎服。

方二：麻黄10克，蝉蜕10克，连翘10克，浮萍10克，丹皮10克，桃仁10克，白鲜皮20克。水煎服。

以上两方可任选一方内服。

慢性荨麻疹，反复发作导致血虚，血虚生风，形成恶性循环，治疗应加用养血滋阴的中药，即中医所说的“治风先治血，血行风自灭”。

方一：生地20克，首乌20克，当归12克，白芍12克，丹皮10克，玉竹10克，荆芥10克，大枣30克，人参叶30克，防风10克。水煎服。

方二：防风通圣丸（成药），每次服10克至15克，一天服3次，开水送服。（本方尤其适用于大便秘结的荨麻疹患者）。

方三：茵陈30克，苡仁30克，木瓜13克，防己12克，麻黄10克，桂枝10克，防风10克，地龙10克，蛇蜕6克。水煎服（本方尤其适用于兼有风湿性关节炎的慢性荨麻疹患者）。

荨麻疹的中药治疗主要采用内服法，如皮肤瘙痒难忍，也可选用紫背浮萍、葶草、苍耳草、荆芥、紫苏叶、百部等中草药（任选1~2种）各120克煎汤外洗。

也可用活蟾蜍3~4只，去其内脏，洗净后置砂罐内煮极烂，用布滤去渣，留汤外用。荨麻疹多的部位，可每日用此汤淋洗一次。荨麻疹少⁶⁶，用棉花蘸汤外搽，每日3~4次，治疗当日即能止痒，连用3~4日荨麻疹全部消失。

对荨麻疹的治疗，重要的一条是要寻找并去除致病原因及一切可疑的诱因。

临床上还有一种巨大荨麻疹（又叫血管神经性水肿），

局部皮肤大片肿胀，直径可达数厘米，明显高出皮面。光滑发亮，颜色多为淡红色，触之坚实或具有弹性，常发生在嘴唇、眼睑，外阴和四肢等处。肿胀要持续数日才消退，无其他全身症状。对这种巨大荨麻疹，可用下列方剂治疗：

处方：黄芪30克，麻黄10克，连翘10克，赤小豆30克，浮萍10克，防己12克，苡仁30克，丹皮10克。水煎服。

93. 神经性皮炎

有人称神经性皮炎为牛皮癣，也有人把银屑病称之为牛皮癣或松皮癣，往往使人混淆不清。也有的患者把市面上出售的“癣药水”买来搽神经性皮炎，结果反而使病情加重。这是由于对上述疾病缺乏认识的缘故。其实，神经性皮炎和银屑病都不是癣。

神经性皮炎是一种慢性瘙痒性皮肤病，多见于成年人。得了神经性皮炎，常见局部奇痒，搔抓后，局部出现米粒大小、不规则的丘疹，时间久了，皮肤就慢慢地变成象牛颈子的皮那样纹理粗糙，厚而坚硬。因此，祖国医学称之为“牛皮癣”。其实它并不是癣（癣是真菌所致的皮肤病）。得了神经性皮炎，皮肤不会糜烂流水，不过瘙痒相当顽固，多发生在颈项、肘部、腘窝、骶部等处。

中医认为神经性皮炎多因情志不遂，闷郁不舒，以致气血运行失调，凝滞于皮肤，郁久化热，损伤阴血，肌肤失养而致。也有因为风湿蕴阻肌肤而致者。

整体治疗：

①肝郁不舒，血虚肝旺：除皮肤奇痒、皮肤干粗、纹理

加深等以外，尚伴有失眠、头昏、头痛、胸闷、气短等症状，治宜舒肝理气，养血柔肝。

处方：当归15克，白芍15克，生地15克，丹皮10克，栀子10克，柴胡10克，夜交藤30克，龙胆草10克，水煎服。

②风湿蕴阻肌肤：局部皮肤肥厚粗糙，阵发性瘙痒，缠绵不愈。治宜祛风利湿，养血润肤。

处方：全蝎6克，皂刺10克，防风10克，苦参15克，白鲜皮15克，刺蒺藜15克，当归10克，夜交藤30克。水煎服。

局部治疗：

1. 针灸疗法：针阿是穴，足三里，百虫窝，曲池，大椎，风池，肩髃，委中。灸阿是穴。

2. 耳针疗法：取穴：心，交感，神门。

3. 局部外用疗法：

①中药天名精（鹤虱的茎叶，鹤虱是天名精的果实），洗净切碎，放入50%酒精内泡一周，外搽患处。

②天南星适量，研粉，加入煤油，调成糊状，搽患处，每日二次。

94. 银屑病

银屑病是一种原因尚未查明的慢性皮肤病。常发于头皮及四肢伸侧面，尤其是肘关节、膝关节附近，也可在全身广泛发生。银屑病的发生常左右对称。开始时往往是点滴状红色斑丘疹，以后扩大或融合成各种形态，有的好象松树皮，所以有人叫它“松皮癣”（其实它不是癣）；有的好象铜钱，有人又叫它“铜钱癣”；还有的好象地图的形状。银屑病表面覆盖

好几层象云母片一样的银白色鳞屑，所以把它称作“银屑病”是很合适的。将鳞屑刮去以后，露出鲜红色的光滑皮肤，继续轻刮，可出现点状出血现象。这是银屑病的特征。银屑病一般在冬季症状加重，夏季症状减轻。

中医认为银屑病多由情志内伤，饮食失节，过食腥发动风的食物，以致脾胃失和，内有蕴热，外受风热毒邪而致。若反复发作，阴血被耗，肌肤失去濡养，气血失和，邪热凝滞于皮肤。

中药治疗以祛风、软坚、养血、活血为原则。

方一：乌梅60克，生牡蛎、煅牡蛎各60克，红花12克，莪术10克，三棱10克，水煎服，每日一剂。

方二：商陆，洗净切片，蒸二小时后烤干，再研成细粉，也可压成片剂，成人每日口服9克，分三次服。须连服20天以上才能生效，最长疗程可达三个月。

方三：土鳖虫、全蝎、蜈蚣、蕲蛇按2:1:5:2的比例混合，烘干，研细，每次服三克，一日三次，白酒或开水吞服。

方四：黄药子50克，乌梅30克，红花15克，细辛6克，甘草15克，黄连15克，黄柏15克，附子10克，共研细末，炼蜜为丸，成人每次服10克，一日三次。

95. 痤疮（青春刺）

痤疮，俗称粉刺，或青春刺，或青春疙瘩，是常见于青年人的一种炎症性皮肤病。

痤疮主要是由于青春期内分泌改变，雄性激素比雌性激素分泌量相对的增多，皮脂腺分泌功能旺盛，皮脂分泌过多

或排泄不畅，皮脂淤积堵塞毛囊口，使毛囊营养发生障碍，外界细菌易于侵入毛囊，并大量繁殖，分解皮脂，产生游离脂肪酸而刺激毛囊，引起炎性反应，形成痤疮。

高脂肪、高糖饮食，便秘，神经功能失调，局部化学性物质（如化妆品、煤焦油）等的刺激也容易诱发痤疮。

痤疮好发于面部、上胸和背部。开始表现为皮脂分泌过多，毛囊孔扩大，随着毛囊口被皮脂堵塞，形成圆锥形突起的小丘疹，可挤出象豆腐渣一样的皮脂栓。皮脂栓在毛囊口经空气氧化及尘埃污染变色发黑而形成黑头粉刺。有时因继发感染，形成中心化脓，外围绕以红晕，高出皮肤表面的小脓疱。

痤疮病程缓慢，一般在青春发育期过后可自愈。

祖国医学认为痤疮系肺热熏蒸，血热郁滞肌肤，或过食油腻辛辣食物，脾胃积热生湿，外犯皮肤所致。治宜凉血清肺热。

（一）外治法

①硫黄、生大黄各30克，共研细末，用温水调敷患处，每日早晚各一次。每次涂药前，先用热水肥皂洗净患处。

②京红粉、轻粉、元明粉等量，研细末，用温水调涂患处。每日早晚各一次，涂药前，应先用热肥皂水洗患处。

③白果仁1~2粒。每晚睡前用温水将患部洗净。将去掉外壳的白果种仁，用刀片切出平面，频搓患部，边搓边削去用过部份，每次用白果仁1~2粒即可。用药的次日早上洗脸后，可照常搽抹雪花膏之类的护肤剂。

（二）内治法

①桑白皮15克，枇杷叶15克，黄芩10克，银花10克，连翘10克，海浮石30克，甘草6克。水煎服。

②荆芥12克，防风12克，川芎10克，白芷10克，桔梗10克，黄连6克，黄芩10克，连翘10克，栀子10克，当归12克，薄荷（后下）10克，水煎服。

③桃仁12克，桂枝10克，茯苓10克，甘草6克，赤芍10克，丹皮10克，水煎服。

④白花蛇舌草30克，水煎服，每日一剂。

⑤银花12克，花粉12克，浙贝12克，归尾12克，赤芍12克，乳香10克，没药10克，炮甲珠15克，陈皮10克，防风12克，甘草10克。水煎服。本方适用于囊肿性痤疮。

⑥地骨皮30克，丹皮15克，泽泻30克，生山查30克，夏枯草30克，红花10克，生地30克，大黄10克，荆芥10克，防风10克，昆布30克。水煎服。

⑦银花藤30克，紫花地丁30克，蒲公英30克，连翘15克，赤芍15克，当归15克，浙贝12克。水煎服

痤疮患者的注意事项：

①要早起早睡，不熬夜。皮肤细胞的新陈代谢在晚上十点钟至凌晨2点钟这段时间最旺盛。早起早睡有利于保护皮肤。

②要多吃纤维素多的蔬菜和水果，防止便秘。因为便秘会使应该排泄的毒素滞留在肠内，进而被吸收到毛孔内与汗和油脂一起排出，从而引起痤疮。

③宜消除紧张情绪。过度紧张会使激素失去平衡而使皮脂的分泌迅速增加，阻碍皮肤正常的新陈代谢。

④宜常吃含锌食物如核桃、花生、鱼、水生贝壳类食物、瘦肉、苹果、栗子等。

⑤应保持清洁卫生，多用热水肥皂洗脸，每天要洗4次，避免皮脂的淤积，防治痤疮的发生。

⑥重视食物疗法。以下食疗方，可供选用：

- 1) 马齿苋、百合各30克，共煮食。
- 2) 绿豆、百合各30克，共煮食。
- 3) 冬瓜、荸荠粉适量，煮糊服食。
- 4) 苹果、香蕉、梨、橘各30克，同时服食。

⑦忌吃辛辣食物、高糖食物（甜食、糖果、糕点）、高脂肪食物（猪油、牛油、奶油、油炸食物等）。因为这些食物会使皮脂分泌增多。

⑧忌只偏一侧睡。

⑨忌吸烟喝酒。

⑩忌用手挤压、搔抓脸部。因为手上附有大量细菌，细菌进入毛囊，可以造成继发感染甚至可引起败血症。长期不愈的毛囊炎，可致皮肤粗糙，形成黑斑，影响面部美观。

⑪忌滥用药物。痤疮患者切忌滥用雌激素、强的松、地塞米松等，这些药物长期滥用，会产生副作用。维生素A和维生素E也宜在医生指导下服用，不宜自己盲目滥用。

96. 酒 渣 鼻

酒渣鼻，俗称“红鼻子”，是一种慢性皮肤病，主要发生于成年人的鼻部。发病常与胃肠功能障碍、内分泌机能失调以及精神因素等有关。

酒渣鼻的发展一般可分为三期：1. 红斑期：开始时鼻部表面油腻发亮，红斑时隐时现，以后红斑扩大，持久不退。2. 毛细血管扩张期：在红斑的地方出现扩张的毛细血管，毛囊孔扩大，可经常出现针头大或黄豆大的红色丘疹或脓

疱。3. 肥大期：鼻部逐渐肥大变厚，呈肿瘤样改变，称为“鼻赘”。发展到第三期的少见。

酒渣鼻除了鼻子发红以外，一般无自觉症状。

祖国医学认为酒渣鼻多由肺胃积热上蒸，复遇风寒外束，血瘀凝结而成；或因长期嗜酒，酒气熏蒸而成。治宜凉血清热，活血祛瘀。

酒渣鼻的中药外治法：

方一：大枫子30克，木鳖子30克，核桃肉30克，蓖麻仁30克，樟脑15克，水银15克。将前四药去壳研烂，加入樟脑、水银研匀成糊状，用纱布裹药擦患处，每日擦三次，每次揉擦10~15分钟。

方二：大黄、硫黄各60克，研细末，用时取药粉适量，温水调涂患处。每晚用肥皂热水洗脸后将药涂在患处，并用手揉擦，擦至患处略有疼痛为止。长期应用效果较好。

方三：白果30克，捣烂，荞麦面60克烧存性，研细，二药和匀，用獾油（獾的肥肉熬油）调涂患处。每晚用热水洗净患处后涂药。

方四：绿豆250克，荷花瓣（晒干）30克，滑石10克，白芷10克，白附子10克，冰片10克，密陀僧10克，共研细末，装瓶备用，用时将患处洗净，白天用此药末揉擦，晚上则用温水将药调成糊状，厚厚地涂一层于患处。第二天早上则洗去。

方五：蛤粉15克，轻粉8克，青黛5克，黄柏5克，煅石膏15克，共研细末，加50毫升麻油调匀涂患处。涂药前先将患处洗净，早晚各涂药一次。如药过稠，临用时可加适量冷水。

酒渣鼻的中药内治法：

方一：赤芍10克，川芎10克，桃仁12克，大枣15克，老葱三根(切碎)，生姜10克，加水煎成210毫升，分三次服，每次兑服麝香0.3克。

方二：黄芪30克，肉桂6克，当归15克，川芎10克，熟地12克，赤芍10克，党参30克，白术12克，茯苓10克，甘草10克。水煎服，每日一剂，连服半个月。或服成药十全大补丸，每次服20克，每日三次，连服一个月。

注意事项：

患者要注意纠正酒渣鼻的诱发因素：避免饮酒，不吃辛辣等刺激性食物。保持消化良好，保持大便通畅。有其他慢性疾病的，应积极加以治疗，去除慢性病灶。

97. 脂溢性皮炎、脂溢性脱发

脂溢性皮炎又称脂溢性湿疹，是一种慢性皮肤炎症，多见于青壮年，其次为婴儿。男性多见。多由神经系统、内分泌系统功能障碍，细菌性的急、慢性感染。维生素B缺乏等而引起皮脂分泌过多所致。

皮损好发于皮脂较多的部位，如头皮、额、眉弓、腋窝、胸、背部、外阴等处，常先从头部开始向下蔓延，重者可泛发全身。皮损为略带黄色的红斑，有油腻性鳞屑和结痂，有时伴有渗液。

由于发病部位不同，其临床表现也略有差异，如头皮上常有二种形态，一种干性型呈糠秕脱屑，可累及整个头皮，不断产生干燥多脂的小鳞屑，易于脱落，脱后又生，脱屑后的皮肤轻度潮红，常伴有脱发(脂溢性脱发)。另有一种湿性

型呈片状油腻性粘着的黄色鳞屑痂，炎症较明显；发于面部的皮损常覆以灰白色、黄色鳞屑或结痂，有时可有渗液。

皮损部位有不同程发的瘙痒感，病程较长，常反复发作。可伴有胸闷，口苦，食欲不振，大便秘结，小便短赤等症状。

脂溢性皮炎，祖国医学称为白屑风、面油风等，其病因病理为：肌热当风，风邪侵入毛孔，郁久化燥，肌肤失养，或肺燥血热郁滞肌肤；或因过食肥甘、辛辣、酒类等，以致脾胃运化失常，生湿积热，外蕴肌肤而成。治宜补益气血，清热凉血解毒。

(一)内治法

方一：首乌30克，山楂30克，女贞子30克，旱莲草30克，大枣30克，生地30克，熟地30克，当归10克，川芎10克，泽泻10克，水煎服，两天服一剂。或加工成蜜丸，每次服10克，每日服三次。

方二：桑椹30克，菟丝子12克，夜交藤30克，茵陈30克，白藓皮20克，生地30克，当归12克，马齿苋30克，首乌20克，水煎服，两天服完一剂，或加工成蜜丸，每次服10克，每日服三次。

(二)外治法

方一：花椒（略炒）60克，轻粉30克，枯矾30克，铜绿（炒）30克，共研细末，香油调搽患处，日二次。

方二：王不留行60克，苍耳子30克，明矾12克，煎水洗头，每次洗15分钟，三天洗一次。

方三：苦参60克，百部30克，透骨草30克，白藓皮30克，蛇床子30克，艾叶30克，煎水洗头。

方四：猪苦胆一个，将猪胆汁倒入半面盆温水中，搅拌

后洗头或洗患处，把油脂状鳞屑清除干净，再用清水冲洗。每天一次，本方特别适宜于小儿脂溢性皮炎。

预防：注意寻找发病原因，健全胃肠机能，少食脂肪、甜食及刺激性食物，多吃蔬菜、瓜果，并注意月经情况，避免热水及碱性过强的肥皂洗擦等。

98. 白 癜 风

白癜风是一种局限性黑色素脱失的皮肤病。患者一般没有任何自觉症状，只是皮肤上出现大小形状不一、数目不定、境界清楚的白斑，白斑可以发生在任何部位，若发生在头皮、眉毛、睫毛等处，还可使该处的毛发变白。

白癜风发展缓慢，发展到一定阶段时，可静止不变。

患处皮肤的知觉、分泌或排泄功能都正常，但对紫外线照射的耐受性较正常皮肤为差。

白癜风的病因还不十分清楚，一般认为是由于表皮色素细胞缺乏酪氨酸酶，影响了皮肤色素代谢，使表皮色素细胞不能产生黑色素所致。此外，神经功能障碍，内分泌失调或某些化学品（如橡胶工业中的氢醌-苯甲基醚）也可诱发白癜风。

白癜风对身体健康没有多大影响，但是往往造成患者精神上的负担。

白癜风刚刚发病时治疗比较容易，病情发展，白斑蔓延到全身时，往往治疗比较困难。

中医认为白癜风是由于风湿郁于皮毛，气血失和，肤失濡养所致。治宜祛风利湿为主。

(一)外治法

方一：补骨脂30克，研细，浸于95%酒精100毫升中，七天后，用三层纱布滤去药渣，煮沸浓缩，涂患处，每天涂二次，涂药后患处晒太阳30分钟。

方二：蛇床子30克，土大黄30克，密陀僧30克，雄黄15克，硫黄15克，苦参15克，轻粉10克，醋300毫升。将以上药物共研细末，泡入醋中，浸泡五天，外搽患处。

方三：炮甲珠30克，轻粉1克，共研细末，加水银30克调匀，再加麻油适量，外搽患处，每日搽2~4次。

方四：耳针，取穴：皮质下，内分泌、肾上腺、交感，每周三次，每次选用2~3穴。

(二)内治法

方一：白蒺藜600克，研细末，水泛为丸，早晚各服10克，连服两个月。

方二：补骨脂60克，紫草60克，黄芪60克，首乌60克，旱莲草60克，龟版60克，炮甲珠60克，红花60克，丹参60克，桃仁60克，川芎60克，当归60克，共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，早晚各服二丸，开水送服。

方三：龙胆草60克，黑芝麻120克，首乌90克，白蒺藜120克，熟地120克，白藓皮60克，当归60克，赤芍60克，川芎60克，防风60克，共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，早晚各服二丸，开水送服。

方四：紫草50克，降香50克，瓜蒌50克，白药子50克，白薇50克，苍术20克，海螵蛸35克，红花50克，桃仁50克，首乌50克，龙胆草20克，刺蒺藜750克，甘草35克。共研细末，成人每次服10克，每日三次，白开水送服。小儿酌减量。

以上四方可任选一方内服。

白癜风患者平时应多晒太阳，多吃猪肝，多吃富含维生素B类的食物，有条件的，可将乌龟、鳖(甲鱼，团鱼)连壳炖服(炖时可加醋适量。喝汤吃肉)。日常生活中，也可用铜壶烧开水喝(白癜风致病因素与体内铜素缺乏有关)。患者平时要保持乐观情绪。能做到以上几点，对预防和治疗白癜风有很大好处。

99. 斑 秃

有的人患“斑秃”，往往一夜之间头发脱落几片。因此有人叫它做“鬼剃头”。其实，“斑秃”是一种局限性斑块脱发，又名“圆形脱发”。病因尚不明，可能与精神因素、内分泌障碍和头皮部压迫等有关。

斑秃没有自觉症状。脱发部头皮较光亮，仍可见毛孔。进展期病人的皮肤损害可逐渐扩大，甚至有的人发展成“全秃”，即头皮部头发大部脱落，眉毛、胡须、腋毛、阴毛均可脱落。得了这种病不必害怕，大部分病人可以自愈。所有病人通过治疗，都可获得痊愈，只是有的病人病程较长。

有一种类型的病人，精神抑郁，多忧虑，精神上受过刺激，病人感到疲乏、嗜睡、多梦、头皮有麻木发胀的感觉。另一种类型的病人则相反，精神兴奋，易激动，失眠，头皮有刺痒的感觉。

中医认为斑秃的发生是由于肝肾不足，气血虚弱，血不荣肤，风邪乘虚袭入，风胜血燥，发失所养所致。治宜养血补肾祛风。

对于斑秃的治疗，首先应解除思想顾虑。可内服十全大

补丸、归脾丸、杞菊地黄丸(均系成药,可照说明服用),或用黄精、熟地、补骨脂各10克,咬碎后用开水冲服。外用药物可用鲜生姜涂擦患处,或用补骨脂泡酒涂患处,或用鸡蛋黄油涂擦患处(蛋黄油的制法:鸡蛋带壳煮熟,取出蛋黄,放在铁锅中煎熬,煎至焦黑,即可熬出蛋黄油)。这些方法都有效,而且简便、安全。

有的病人病程较长,无论用内服药治疗或用药物外擦,疗程也较长,一定要坚持治疗,要有耐心,才能收到良好的效果。

100. 腋 臭 (狐臭、汗臭症)

腋臭(狐臭),医学上称为局限性臭汗症,这种病人的腋下汗液有一种使人恶心的、难闻的特殊臭味,很象狐狸身上的那股气味,故俗称“狐臭”。实际上,患者不仅是腋窝的汗液有臭味,而且在外生殖器、肚脐和乳头周围的汗液都有臭味,但以腋窝的汗臭最厉害。

人的汗腺分大汗腺和小汗腺两种。小汗腺分布于全身皮下,小汗腺分泌普通的汗液,普通汗液主要是水分,几乎没有臭味。大汗腺分布于腋下、外生殖器、肚脐和乳头周围,在青春发育期才逐渐具有分泌汗液的能力。大汗腺分泌的汗液里边含有较多的脂类物质及水分,象牛奶一样。这些分泌物在正常情况下都没有臭味,但这些分泌物经皮肤表面的细菌(生腐杆菌)的酵解而产生臭味。尤其在夏天,臭气更为厉害。由于这种大汗腺在腋窝下面分布得多而广,所以狐臭往往在这里发生。

臭汗症患者的汗腺分泌功能较正常人旺盛，多与遗传有关。

狐臭以年轻女性占多数，在月经期前后、怀孕期间臭气更厉害。到了老年，由于汗腺逐渐萎缩，狐臭也就渐渐减轻，终于自愈。

狐臭虽然不影响身体健康，但周围的人不愿接近，因此患者要求治疗的心情比较迫切。

狐臭，中医又称“胡臭”、“体气”、“腋气”。为湿热内郁或遗传所致。治疗多采用外治疗法。

方一：朝天辣椒（越辣越好）15个，切碎，泡入50毫升碘酒中，密封摇荡。泡两天后即可应用。用棉球蘸药液充分抹擦腋窝。每次擦10~15分钟，每天擦3~4次，连擦七天为一疗程。擦药前应将患部用肥皂水洗净。如擦药后腋窝辣痛得厉害，可加碘酒稀释药液。药液用完后要重新配制，泡入新切的辣椒和加入新的碘酒。

方二：雄黄、煅石膏各120克，白矾240克，共研细末，密闭保存。用时用水将药粉5克调成糊状，涂于患处。每日二次。（涂药前应将患处洗净）。

方三：密陀僧40克，寒水石30克，轻粉30克，滑石粉40克，共和匀研细末。用法：用一块热馒头蘸满药粉趁热夹在腋下约15分钟，或在劳动后趁有汗时把药粉撒在患处。每隔两天治疗一次，10次为一疗程（注意：密陀僧、轻粉不可入口）。

方四：生姜适量，碘酒适量。先用热水洗净腋窝，接着用生姜擦腋窝，擦至皮肤轻度充血，后涂碘酒。每天两次，连擦15天为一疗程。

方五：大蜘蛛（越大越好）一个（或小蜘蛛数个），黄

泥包好，火内烧红，取出，放冷后，去泥，加轻粉3克，共研细末，揉擦两腋下（每次揉擦15分钟）。每天揉擦两次。

狐臭病人，平时应戒烟酒，不吃强烈刺激性的饮食，因为这些东西会促使汗腺分泌机能旺盛。并应注意患处的清洁卫生，经常保持干燥。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=百病良方 第一集（增订本）

作者=贾河先编著

页数= 2 5 5

S S 号= 1 0 2 9 7 9 6 9

出版日期= 1 9 8 9 年 0 5 月第 3 版